

Questão 1 Profilaxia Antibiótica

Homem, 62 anos, com diagnóstico de cirrose hepática por álcool, chegou ao pronto socorro referindo um episódio de hematêmese. Exame físico: consciente, orientado, icterico (+2/4+), descorado (+/4+), presença de ginecomastia e de aranhas vasculares em tórax e dorso, edema de membros inferiores (+2/4+); sem sinais de ascite. Endoscopia digestiva alta evidenciou varizes esofágicas de médio calibre com "white nipple". Realizada ligadura elástica sem intercorrências. Qual é a conduta mais adequada?

- A Vitamina K.
- B Norfloxacin.
- C Furosemida.
- D Omeprazol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114982](https://t.me/medicinalivre)

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina**Questão 2** Avaliação dos pacientes com monoartrite Artrite séptica Artropatias infecciosas

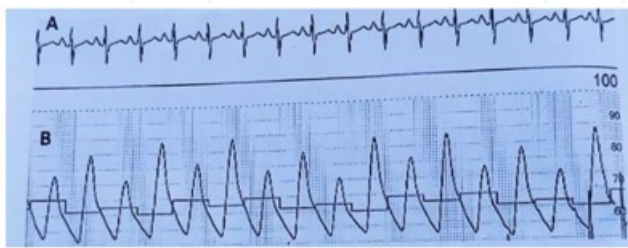
Homem, 38 anos, refere dor e edema em joelho esquerdo, inéditos, de início há dois dias e com progressão rápida até impedir a deambulação. Não sabe se teve febre. Nega doenças e tratamentos. Ao exame: temperatura axilar: 37,6 °C; edema, hiperemia e calor em joelho esquerdo, com sinal da tecia e aumento de volume de bolsa suprapatelar. Qual tipo celular mais contribui para o quadro clínico descrito?

- A Neutrófilo.
- B Fibroblasto sinovial.
- C Macrófago sinovial.
- D Condrócito.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivreEssa questão possui comentário do professor no site [4000114957](https://t.me/medicinalivre)**Questão 3** Diagnóstico

Homem, 20 anos, previamente assintomático. Há 20 dias refere dispneia que progrediu em poucos dias para aos mínimos esforços, acompanhada de fadiga e edema que evoluiu para anasarca. Refere quadro "gripal" há 30 dias, tratado com sintomáticos. Exame físico: edema depressível, indolor, ++/++++ bilateralmente, em membros inferiores até joelhos; jugulares distendidas até 8 cm acima do manúbrio esternal, em decúbito a 45 graus, com variação respiratória normal. Temperatura axilar = 36,5 °C; FC = 98 bpm, rítmico, precórdio sem anormalidades, estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares posteriormente. ECG com alterações difusas de repolarização ventricular. RX de tórax com ICT = 0,65 e congestão para-hilar bilateral. ECG (DII) (figura A) e registro invasivo de pressão arterial sistêmica (mmHg) no gráfico (figura B). Qual é a alteração fisiopatológica mais provável?



- A Derrame pericárdico de grande volume.
- B Hipertensão pulmonar emboligênica.
- C Aumento do fluxo pulmonar por cardiopatia congênita.
- D Disfunção biventricular sistólica grave.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114935](#)

Questão 4 Suporte Nutricional Parenteral Cirurgia

Homem, 55 anos, apresentou obstrução intestinal, por inúmeras bridas decorrentes de tumor desmoide. Submetido à extensa ressecção do intestino delgado. Em pós-operatório, evoluiu com vômitos de difícil controle. No serviço de origem, foi feita a nutrição parenteral pronta para uso contendo glicose e aminoácidos, sem adição de solução de vitaminas e minerais. Após 2 meses recebendo apenas essa terapia nutricional, apresentou diplopia, nistagmo, perda da memória, confusão mental e confabulação. Qual a deficiência nutricional mais provável?

- A Niacina.
- B Vitamina B12.
- C Tiamina.
- D Piridoxina.

4000114903

Questão 5 Diagnóstico

Mulher, 75 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus bem controlados. Queixa-se de urgência miccional há 6 meses, associada a perdas urinárias frequentes, com necessidade do uso de absorvente e redução da ingestão hídrica. Ao exame: BEG, consciente e orientada. PA: 128 x 62 mmHg, FC: 80 bpm. Abdome sem massas palpáveis. Exame neurológico sem alterações. Qual é a avaliação diagnóstica inicial mais adequada?

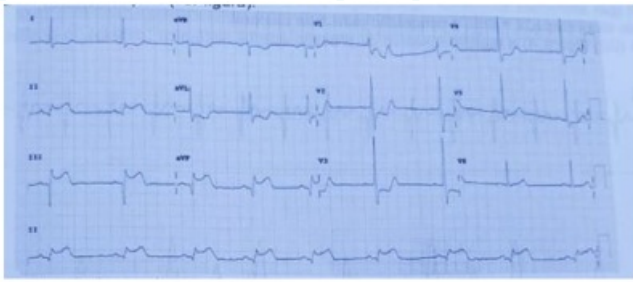
- A Resíduo pós-miccional.
- B Ultrassonografia de vias urinárias.
- C Estudo urodinâmico.
- D Urina tipo I.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114879](#)

Questão 6 Diagnóstico eletrocardiografico da parede do infarto

Homem, 45 anos, professor universitário, maratonista competidor frequente e sem fatores de risco para doença arterial coronária, muito estressado no trabalho, perdeu a esposa há poucos dias em acidente automobilístico. Refere dor intensa

(8/10) retroesternal, sem irradiação, que persiste há duas horas. Recebeu de vizinho por via sublingual 1 comprimido de dinitrato de isossorbida há cerca de uma hora. Exame físico: FC = 50 bpm, rítmico, PA = 80/60 mmHg. Precórdio sem frêmitos ou sopros e sem estertores crepitantes pulmonares. ECG da entrada no hospital (ver figura). Qual é o diagnóstico mais provável ?



- A Infarto agudo do miocárdio com oclusão da coronária direita.
- B Síndrome de "takotsubo" ("coração partido") com coronárias normais.
- C "Coração de atleta" com repolarização ventricular precoce.
- D Pericardite aguda com derrame pericárdico.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114857](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 7 **Demências** **Clínica Médica** **Síndrome Demencial**

Homem, 75 anos, professor universitário aposentado. Veio na consulta acompanhado do filho, queixando-se de esquecimento progressivo há um ano. Esquece de dar recados, pagar contas e senhas dos cartões de crédito e se perdeu na rua há uma semana quando foi pegar a neta na escola. Exame físico: BEG, consciente e orientado no tempo e no espaço. Neurológico: sem alterações. Mini-exame do estado mental: 29/30. Escala de depressão geriátrica: 2/15. Exames laboratoriais: TSH = 2,5 µU/mL (VN: 0,4-4,5); vitamina B12 = 756 pg/mL (VN: 174,0-878,0), VDRL não reagente, anti-HIV não reagente. Hemograma, função renal, eletrólitos e transaminases normais. Tomografia de crânio: redução difusa do volume encefálico, proporcionada para a faixa etária. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Transtorno depressivo.
- B Comprometimento cognitivo leve.
- C Queixa subjetiva de memória.
- D Síndrome demencial.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000114811

Questão 8 **Manejo das crises algícas**

Homem 18 anos, com anemia falciforme, apresenta diarreia aquosa há 2 dias, sem sangue ou muco. Hoje iniciou quadro de dor em membros inferiores. Nega febre, dispneia ou outras queixas. Exame físico: desidratado +/4+, consciente e orientado, icterico +/4+ FC: 104 bpm. PA: 120 x 80 mmHg. Ap. respiratório sem alterações, saturação de O₂ em ar ambiente 93%. Abdome: sem alterações. Extremidades: dor à palpação dos membros inferiores, sem sinais flogísticos. Exame laboratoriais: Hb: 9,8 g/dL, Ht: 30%, bilirrubina total: 4 mg/dL, bilirrubina direta: 2,1 mg/dL. Além da hidratação endovenosa, qual é a conduta inicial mais adequada?

- A Morfina.
- B Suplementação de oxigênio.
- C Hidroxiureia.
- D Concentrado de hemácias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114781](#)

Questão 9 Doença de von Willebrand

Mulher, 19 anos, em avaliação pré-operatória de rinoplastia evidenciou-se tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) prolongado. Refere epistaxes frequentes e equimoses espontâneas desde a infância, e sangramento uterino anormal (ciclos menstruais com duração de mais de 10 dias, com coágulos e necessidade de absorvente noturno contínuo). Mãe com sintomas menstruais semelhantes. Nega outros familiares com história de sangramentos. Nega hemartroses. Nega procedimentos cirúrgicos prévios. Exame físico sem alterações. Exames laboratoriais: Hb: 11,9 g/dL; VCM: 79 fL; GB: 6.100/μL; plaquetas: 280.000/μL; TTPa: 54 segundos (VN < 44,6); TP (Tempo de protrombina): 12,5 segundos (VN < 17,3). Qual elemento do sistema hemostático da paciente mais provavelmente está disfuncionante?

- A Fator de von Willebrand.
- B Plaquetas.
- C Fibrinogênio.
- D Fator VIII da coagulação.

Medicina Livre
Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114756](#)

Questão 10 Síndrome de veia cava superior

Homem, 50 anos, com dispneia progressiva, edema e hiperemia facial há 10 dias. Refere tosse produtiva com estrias de sangue e perda ponderal. Nega febre. É tabagista, 60 maços/ano. Exame físico: REG, dispneia leve em repouso; PA = 100 x 60 mmHg; FC = 100 bpm; FR = 20 ipm; saturação de O₂=90% em ar ambiente. Pletora e edema de face e andar superior de tronco. Distensão de veias do pescoço. MV globalmente diminuído, com roncos difusos. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Tromboembolismo pulmonar.
- B Tamponamento pericárdico.
- C Síndrome da veia cava superior.
- D Pericardite constrictiva.

4000114730

Questão 11 Tratamento Diagnóstico Sinais de alarme

Mulher, 19 anos, refere febre, mialgia, cefaleia e náuseas há 6 dias. Exame físico: BEG, corada. Aparelho cardiovascular: 2 bulhas rítmicas e normofonéticas, sem sopros; FC: 96 bpm; PA: 98x62 mmHg. Aparelho respiratório: MV reduzido no 1/3 inferior do hemitórax direito; FR: 26 ipm. Abdome: RHA presentes; dor moderada à palpação profunda em mesogástrico, sem visceromegalias. Edema +/- depressível em MMII. Pele: petéquias em ambas as pernas. Exames laboratoriais: Hemograma: Hb = 14,2 g/dL; Ht: 42%; glóbulos brancos: 2.900/mm³ (segmentados: 34%; linfócitos: 61%); plaquetas: 18.000/mm³. AST: 122 (VR < 32 U/L); ALT: 62 (VR < 31 U/L). Pesquisa do antígeno NS1 para dengue negativo. Radiografia de

tórax: (ver figura). Ultrassonografia de abdome: ascite de moderado volume. Qual é a conduta mais adequada?



- A Esfregaço do sangue periférico e corticoide.
- B Paracentese e diurético.
- C Sorologia para dengue e hidratação.
- D Toracocentese e antibiótico.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114700](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 12 Erupção acneiforme

Homem, 16 anos, em tratamento para pênfigo foliáceo há 6 meses com corticoterapia sistêmica oral e pulsoterapia com dexametasona. Há 1 mês notou lesões na face e no tronco (figuras), sem outras alterações no exame físico. Qual é o diagnóstico mais provável das lesões apresentadas?

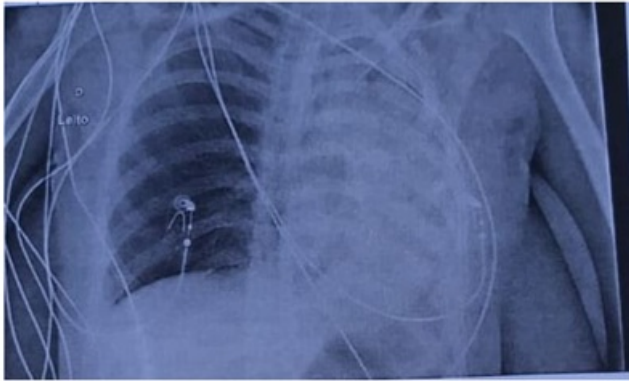


Acesse t.me/medicinalivre

- A Sífilis secundária.
- B Púrpura medicamentosa.
- C Erupção acneiforme.
- D Impetigo bolhoso.

Questão 13 Radiografia de tórax Manejo da exacerbação em unidade de terapia intensiva UTI

Mulher, 19 anos, asmática, refere chiado no peito, febre e dispneia há 3 dias com piora progressiva, mesmo com uso de corticoide e aerossol. Exame físico na admissão: murmúrio vesicular abolido bilateralmente, com saturação de O₂ de 90% em ar ambiente. Após a administração de corticoide, salbutamol e magnésio, passou a apresentar sibilos e som claro pulmonar bilateralmente. Mantinha taquipneia, sendo submetida a intubação orotraqueal. Evoluiu com queda da saturação e a radiografia abaixo. Qual é a condição clínica mais provável neste momento?



- A Pneumonia.
- B Derrame pleural.
- C Atelectasia.
- D Pneumotórax.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000114573

Questão 14 Exame dermatoneurológico Diagnóstico Apresentação clínica

Mulher, 56 anos, sem comorbidades e em uso de vitaminas para formigamento em mãos e pés, apresentou as lesões de pele há 7 meses (figura). Qual é a conduta diagnóstica mais adequada?



- A Biópsia de pele.
- B Eletroneuromiografia.
- C Estesiometria.
- D Micológico direto.

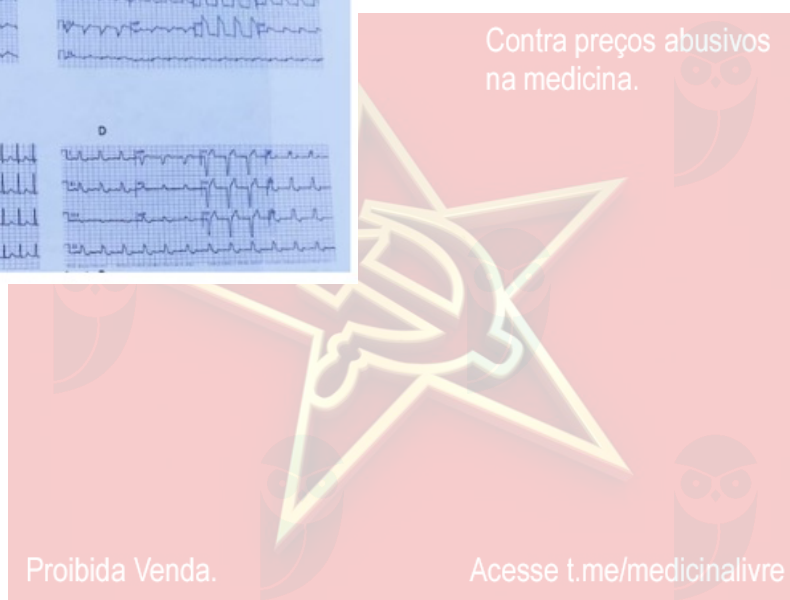
Essa questão possui comentário do professor no site [4000114523](https://www.4000114523.com)

Questão 15 Distúrbios eletrolíticos

Homem, 35 anos, etilista (1 litro de destilado por dia), internado há 2 dias devido à queda da própria altura com fratura de ulna direita. Apresenta quadro de agitação psicomotora, evoluindo com diaforese, tremores, vômitos, crise convulsiva e urina escurecida. Exame físico: REG, desidratado, agitação psicomotora intensa, tremores de extremidades, sudoreico, sem sinais meníngeos ou déficits focais. Tomografia de crânio sem alterações. Qual é o eletrocardiograma esperado deste paciente?



- A Figura A.
- B Figura B.
- C Figura C.
- D Figura D.



4000114479

Questão 16 Manometria Esofágica Acalásia Megaesôfago

Mulher, 55 anos, procedente do Vale do Jequitinhonha, refere disfagia baixa há 2 anos, ora para alimentos sólidos, ora para líquidos, associada a emagrecimento de 6 kg no período. Informa morte súbita em dois irmãos e pai. Endoscopia digestiva alta sem alterações. Qual alteração manométrica é mais provável?

- A Relaxamento transitório de esfíncter esofágico.
- B Aumento da amplitude das contrações no corpo do esôfago.
- C Aperistalse do corpo do esôfago.
- D Hipotonia do esfíncter inferior esofágico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114427](https://www.4000114427.com)

Questão 17 Diagnóstico Lúpus Eritematoso Sistêmico LES

Mulher, 24 anos, há dois meses apresenta dor, edema e rigidez maior que uma hora em mãos, punhos, ombros e joelhos. Relata sono não reparador, fadiga e alguns episódios de temperatura entre 37,0 e 37,8 °C. Exame físico: bom estado geral. Temperatura axilar: 37,5 °C. Edema, calor e dor em cotovelos, punhos, segunda a quarta metacarpofalangeanas bilateralmente, joelhos e tornozelos; pontos dolorosos (tender points): 14/18. Qual dos diagnósticos abaixo é o mais provável?

- A Lúpus eritematoso sistêmico.
- B Síndrome da fibromialgia.
- C Espondiloartrite não-axial.
- D Artrite reacional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114408](#)

Questão 18 Tratamento medicamentoso Biguanida metformina Sulfonilureias

Mulher, 66 anos, com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2 há 20 anos, relata vários episódios de hipoglicemia no último mês. Está em uso de losartana, metformina e gliclazida. Nega poliúria, polidipsia ou alteração do peso. Exame físico sem alterações. Glicemia de jejum = 142 mg/dL e hemoglobina glicada = 6,2% (VR: 4,3-6,1). Qual é o principal exame para diagnóstico do quadro clínico atual?

- A Creatinina sérica.
- B Potássio sérico.
- C Proteinúria.
- D Transaminases.

4000114381

Questão 19 Espirometria

Homem, 74 anos, refere tosse com expectoração clara matutina há 8 anos. Há 5 anos com dispnéia aos esforços em progressão; atualmente tem dispnéia para andar 100 metros em terreno plano. Por vezes o sintoma é acompanhado de chiado no peito. Tabagista de 1 maço de cigarros por dia há 60 anos. Exame físico sem alterações. Qual achado é suficiente para o diagnóstico da doença mais provável?

- A Hipoxemia na gasometria arterial em ar ambiente.
- B Redução de capacidade de difusão de monóxido de carbono.
- C Enfisema centrolobular na tomografia de tórax.
- D Padrão obstrutivo na espirometria pós-broncodilatador.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114358](#)

Questão 20 Doença Inflamatória Pélvica

Mulher 25 anos, nulípara, tabagista, última menstruação há 13 dias, procura serviço de urgência com queixa de dor em região inguinal esquerda e hipogástrio há 5 dias com piora significativa há 3h, associada a náusea, fraqueza e tontura. O exame clínico geral mostra regular estado geral, descorada, FC = 100 bpm, PA = 105 x 65 mmHg, T = 37,8°C. O abdome apresenta-se bastante sensível à palpação no andar inferior. Observa-se pequena quantidade de material vaginal amarelado sem odor característico. O toque vaginal é muito doloroso e não é possível fazer uma boa avaliação da região da pelve.

Exames laboratoriais: 1) β -HCG: negativo; 2) hemograma: leucócitos = 10.500/mL, Hb = 10,1g/dL, Ht = 37%. A imagem mais representativa da ultrassonografia transvaginal está mostrada abaixo. A descrição dos achados principais está na legenda da imagem. Com base nas informações descritas, assinale a alternativa que contemple o diagnóstico mais provável e a melhor opção terapêutica.



- A Abcesso tubo-ovariano; antibiótico terapia endovenosa hospitalar.
- B Corpo lúteo hemorrágico; analgesia e observação hospitalar.
- C Torção de ovário; laparoscopia com preservação do anexo.
- D Tumor anexial provavelmente maligno; ooforectomia e estadiamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114333](https://www.4000114333.com)

Questão 21 **Descarga papilar**

Paciente com 37 anos de idade com queixa de saída de secreção avermelhada pelo mamilo esquerdo há 2 meses. Refere que o fluxo é espontâneo. Ao exame, as mamas são simétricas, sem abaulamento ou retração e sem nódulos palpáveis. À expressão mamilar notamos um fluxo papilar (ver imagem). Foi realizado ultrassonografia e mamografia com BIRADS® 1. Qual a conduta mais adequada para a elucidação diagnóstica?



- A Coleta de citologia do fluido papilar.
- B Biópsia cirúrgica da unidade mamária.
- C Realizar ductografia mamária.
- D Realizar ressonância magnética.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114288](https://www.4000114288.com)

Questão 22 **Roteiro diagnóstico**

Adolescente, 13 anos, queixa-se que ainda não menstruou. Relata que a irmã menstruou aos 12 anos. Nega sexarca. Não

apresenta outras queixas. Exame físico: apresenta-se em bom estado geral, estatura no percentil 50, IMC 21 Kg/m², mamas estadiamento de Tanner M1 e pelos P4. Genitália externa com pequenos lábios com extensão até a metade da vulva, clitóris de 1 cm até a base, mucosa vulvar avermelhada, hímen íntegro, vaginometria de 7 cm. Considerando as recomendações da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, qual a melhor opção para abordagem inicial deste caso?

- A Dosar hormônio folículo estimulante.
- B Conduta expectante por mais 2 anos.
- C Realizar ultrassonografia pélvica.
- D Colher cariótipo de sangue periférico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114246](https://www.4000114246.com)

Questão 23 **Climatério**

Mulher de 57 anos queixa-se de ondas de calor intensas, dor em queimação e prurido na região genital, e dor intensa nas relações sexuais. Encontra-se em seguimento de câncer de mama tratado há 3 anos e faz uso de tamoxifeno. Assinale a alternativa correta em relação ao esquema terapêutico correto para esta mulher.

- A Venlafaxina, hidratante vaginal e lubrificante.
- B Hidratante vaginal, laser e lubrificante.
- C Paroxetina, estriol local e laser.
- D Fluoxetina, promestrieno e laser.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114220](https://www.4000114220.com)

Questão 24 **Quimioprofilaxia**

Nuligesta, 19 anos, menarca aos 11 anos, DUM: não recorda, usa anticoncepcional hormonal oral, procura atendimento na urgência referindo ter sofrido estupro há 4 horas atrás. Em relação as profilaxias que esta mulher deve receber, a melhor opção é?

- A Levonorgestrel; tenofovir, lamivudina e dolutegravir, azitromicina e ceftriaxona.
- B Acetato de medroxiprogesterona, zidovudina e efavirenz, penicilina cristalina e ceftriaxone.
- C O tempo decorrido da violência contraindica anticoncepção de emergência e profilaxia para HIV.
- D DIU de cobre, zidovudina, lamivudina e lopinavir com ritonavir, azitromicina e penicilina cristalina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114200](https://www.4000114200.com)

Questão 25 **Definição**

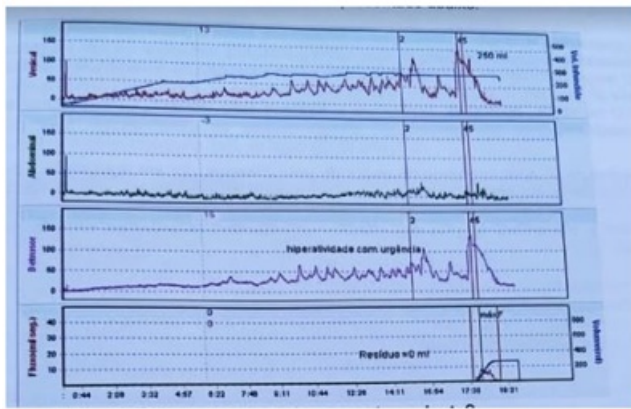
Mulher, 21 anos, G0, procura a Unidade Básica de Saúde, pois refere que seus ciclos estão irregulares e o número de dias de sangramento está aumentado. Você pediu um calendário menstrual para avaliação no retorno. Abaixo está o histórico menstrual dos últimos 6 meses. 1º ciclo: 30 dias - 7 dias de sangramento; 2º ciclo: 28 dias - 5 dias de sangramento; 3º ciclo: 33 dias - 6 dias de sangramento; 4º ciclo: 31 dias - 8 dias de sangramento; 5º ciclo: 29 dias - 5 dias de sangramento; 6º ciclo: 36 dias - 8 dias de sangramento; Observando o calendário, qual alternativa apresenta a melhor conduta (de acordo com os critérios de normalidade de ciclo menstrual da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetria, FIGO, 2018)?

- A Orienta que o ciclo está regular e que a duração do sangramento está normal.
- B Confirma o diagnóstico de irregularidade menstrual e prescreve contraceptivo oral combinado.
- C Orienta que o ciclo está regular, mas a duração está aumentada. Solicita ultrassonografia pélvica.
- D Confirma o diagnóstico de irregularidade menstrual e solicita FSH, prolactina e TSH.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114177](https://www.4000114177.com)

Questão 26 Tratamento

Paciente encaminhada a hospital terciário para avaliação e conduta. No encaminhamento está descrito que a paciente tem perda urinária involuntária e exames de urina tipo I normal e urocultura negativa. Solicitado estudo urodinâmico apresentado abaixo. Qual a conduta terapêutica mais adequada para esta paciente?



- A Solifenacina.
- B Imipramina.
- C Cirurgia com sling.
- D Cirurgia de Burch.



Essa questão possui comentário do professor no site [4000114162](https://www.4000114162.com)

Questão 27 Prolapsos de órgãos pélvicos

Paciente com 48 anos procura atendimento médico referindo que há 6 meses notou aparecimento de uma "bola" na vagina que tem atrapalhado nas relações sexuais. Nega perdas urinárias ou outras doenças sistêmicas. Após exame físico o ginecologista descreve os achados da seguinte maneira: Qual a melhor opção terapêutica para esta paciente?

Ant	Pos	CVT
+1	+3	+4
HG	CP	CVT
4	2	8
Ap	80	D
+1	+3	+3

Qual a melhor opção terapêutica para esta paciente?

HG: HIATO GENITAL
CP: CORPO PERINEAL
CVT: COMPRIMENTO VAGINAL
TOTAL
POP-Q: PELVIC ORGAN PROLAPSE
QUANTIFICATION SYSTEM

- A Colpoperineoplastia anterior e posterior.
- B Colpocleise.
- C Histerectomia vaginal com correção de prolapso.
- D Fisioterapia de assoalho pélvico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114129](#)

Questão 28 BIRADS 3

Mulher com 41 anos, G2P2, lactou duas vezes por até um ano, refere que fez a primeira mamografia de rastreamento há quinze dias. Como o laudo mostrou BI- RADS®3, veio à consulta para esclarecer algumas dúvidas. Deseja nova gestação e gostaria de engravidar novamente o mais breve possível, pois teme ter dificuldades e está preocupada com possível gestação de risco. Qual orientação dar a esta paciente?

- A Pede para retornar em um ano com nova mamografia e, também, ultrassonografia mamária.
- B Prossegue a investigação com novos exames de imagens e até biópsia se necessário, antes da gravidez
- C Pede para a paciente aguardar dois anos, mantendo seguimento semestral com mamografia.
- D Tentar engravidar, pois na classificação BI-RADS®3 o risco malignidade é baixo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114100](#)

Questão 29 DIU de cobre

Mulher, 26 anos, G0, comparece à Unidade Básica de Saúde com desejo de uso de DIU de cobre. Última menstruação há 8 dias. Refere que tem neoplasia intraepitelial cervical 1 (NIC 1) diagnosticada há 6 meses e faz seguimento clínico. Nega outras doenças. Não tem vícios. Não está usando nenhum método contraceptivo. Ao exame: PA: 110 x 70 mmHg, IMC: 23 Kg/m², exame físico geral e segmentar normal. Exame ginecológico apresentando candidíase vulvovaginal (primeiro episódio), sem outras anormalidades. Além de prescrever o tratamento de candidíase nesta consulta, quais condutas devem ser tomadas em relação ao caso clínico considerando os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde (2015)?

- A Orientar outro contraceptivo até normalizar a citologia pois a presença de NIC 1 contraindica a inserção do DIU.
- B Inserir o DIU nesta consulta e orientar usar método contraceptivo adicional por 7 dias.
- C Orientar preservativo e marcar para inserir o DIU no próximo ciclo menstrual quando estiver menstruada.
- D Inserir o DIU nesta consulta sem a necessidade de orientação de método contraceptivo adicional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114084](#)

Questão 30 Tireotoxicose gestacional transitória Alterações na fisiologia tireoidiana durante a gestação

Paciente de 21 anos, secundigesta (um parto normal anterior), com idade gestacional de 11 semanas, retorna trazendo os exames complementares solicitados em consulta de pré-natal anterior. Refere náuseas matinais, que melhoram com uso de antieméticos. Nega outras queixas clínicas e obstétricas. Antecedentes pessoais: história pregressa de tireoidite pós-parto com resolução completa após 3 meses. Exame físico: dentro dos padrões de normalidade para o período gestacional. Exames complementares: dentre os exames laboratoriais, observa-se resultado de hormônio estimulador da tireoide com valor de 0,07 μ UI/mL e tiroxina livre de 0,9 ng/dL; Qual a conduta mais adequada para o caso clínico apresentado?

- A Encerrar investigação e manter seguimento de pré-natal de risco habitual.
- B Prescrever metimazol e solicitar dosagem de função tireoidiana após seis semanas.
- C Prescrever propiltiouracil e solicitar dosagem de função tireoidiana após seis semanas.
- D Solicitar dosagem de hormônio estimulador da tireoide no segundo trimestre de gestação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114068](#)

Questão 31 Medicamentoso

Paciente de 20 anos, primigesta, com 22 semanas de idade gestacional, portadora de diabetes mellitus tipo 1, sem outras comorbidades, retorna à consulta de pré-natal sem queixas clínicas ou obstétricas. Em tratamento regular com atividade física, controle dietético e insulinoterapia com múltiplas doses diárias de insulina Neutral Protamine Hagedom e insulina regular. Exame físico geral e obstétrico dentro dos padrões de normalidade para o período gestacional. Ganho de peso de 300 g em uma semana. A análise do perfil glicêmico da última semana está demonstrada na tabela a seguir. Qual a conduta mais adequada para este caso clínico?

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
Glicemia de Jejum	92	94	72	93	71	94	83
Glicemia pré-prandial	98	99	73	88	77	98	100
Glicemia duas horas pós-prandial	123	125	80	131	121	134	128

- A Aumentar dose de insulina NPH e manter dose de insulina regular conforme prescrição anterior.
- B Reduzir dose de insulina NPH ao deitar e manter dose de insulina regular em relação à prescrição previa.
- C Manter dose de insulina NPH e regular de acordo com a última prescrição do pré- natal.
- D Manter dose de insulina NPH e aumentar dose de insulina regular em relação à última prescrição.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000114042](#)

Questão 32 Complicações

26 anos, G2P1A0 (1 parto normal anterior a termo sem intercorrências) 14 semanas de gestação gemelar dicoriônica, comparece à consulta para iniciar pré-natal. Antecedentes pessoais nega patologias e refere gravidez espontânea. Ao exame: peso: 92 kg, estatura 1,65 cm, bom estado geral com pressão arterial: 105 x 72 mmHg. Altura uterina de 16 cm, ausculta fetal do feto A de 142 bpm e do feto B de 156 bpm. Qual a conduta medicamentosa adequada?

- A AAS e enoxaparina.
- B AAS isoladamente.
- C Enoxaparina e cálcio.
- D AAS e cálcio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113989](#)

Questão 33 Artéria cerebral média ACM Conduta obstétrica

Secundigesta (G2P0A1), 29 anos, 33 semanas, portadora de hipertensão arterial crônica, em uso de anti-hipertensivos com bom controle. Comparece para consulta de pré-natal, sem queixas. Exames laboratoriais normais. Exame físico: pressão arterial 140x90 mmHg, restante do exame físico geral normal, altura uterina 30 cm, sem contrações, frequência cardíaca fetal 130 bpm. A cardiocografia realizada hoje está demonstrada abaixo (figura). A ultrassonografia obstétrica de hoje mostrou feto único, anatomia normal, peso estimado de 1793 gramas (percentil 4), placenta grau I, maior bolsão de líquido

amniótico de 3,2 cm, perfil biofísico fetal de 8/8. Doppler da artéria umbilical: IP = 1,12 (percentil 85). Qual alternativa possui a melhor conduta para o caso?



- A Realizar estudo Doppler da artéria cerebral média fetal.
- B Realizar nova cardiotocografia em 6 horas.
- C Resolver a gestação após um ciclo de corticosteroide.
- D Avaliar índices de impedância das artérias uterinas maternas.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113970](https://www.4000113970.com.br)

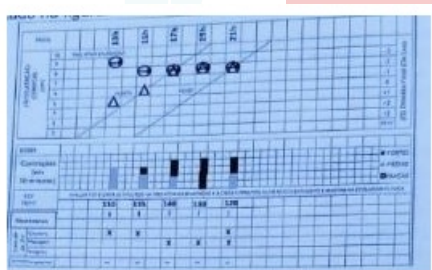
Questão 34

Distocia de dilatação

Distocia de dilatação

Primeiro período dilatação

Primigesta, 30 anos, com 40 semanas, é internada na fase ativa do trabalho de parto, com boa vitalidade fetal na admissão. Pré-natal sem intercorrências. Ela traz um plano de parto no qual rejeita o uso de ocitócicos, analgesia farmacológica e episiotomia. A parturiente se mantém bastante ativa, com alternância de posturas. As 21 horas, ela é reavaliada, apresentando sinais vitais normais, altura uterina de 37 cm, atividade uterina de 4 contrações de 50 segundos/10 minutos e batimentos cardíacos fetais sem desacelerações. O registro gráfico do trabalho de parto está representado na figura. Escolha a alternativa com a melhor conduta nesse caso.



- A Indicar resolução de gestação por parto cesárea.
- B Promover corioamniorrexe artificial imediatamente.
- C Convencer a paciente a aceitar analgesia farmacológica.
- D Explicar sobre a necessidade de ocitocina endovenosa.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113938](https://www.4000113938.com.br)

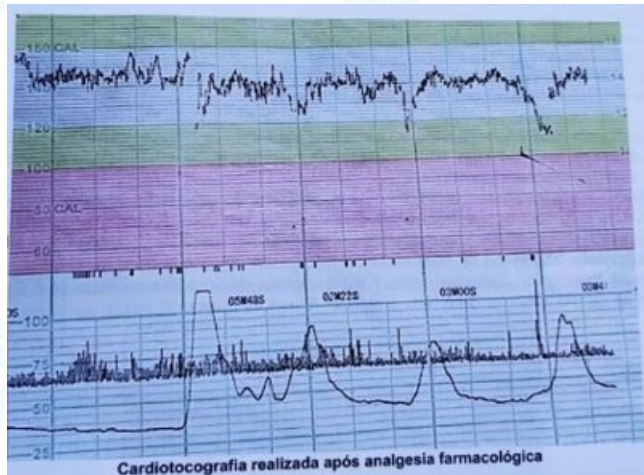
Questão 35

Cardiotocografia intraparto

Primeiro período dilatação

Primigesta, 22 anos, com 41 semanas, internou no início da fase ativa da dilatação com contrações moderadas e perda de

tampão mucoso. Sem outras queixas. Pré-natal sem intercorrências. Há 30 minutos, queixou-se de muita dor e solicitou analgesia farmacológica. Foi submetida à bloqueio combinado raqui-peridural. Reavaliação após analgesia: sinais vitais maternos normais, atividade uterina de 4 contrações moderadas de 40 segundos em 10 minutos. A avaliação da vitalidade fetal está demonstrada na cardiotocografia exibida abaixo (figura). Toque: colo fino, centrado, dilatado 8 cm, feto cefálico, em zero de DeLee, bolsa íntegra. Escolha a melhor conduta na assistência a este trabalho de parto.



- A Realizar ausculta intermitente da frequência cardíaca fetal.
- B Promover corioamniorrexe artificial.
- C Indicar resolução da gestação por cesárea.
- D Instituir manobras de reanimação fetal.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113900](https://www.4000113900.com.br)

Questão 36 Parto

Primigesta, 23 anos, não realizou pré-natal, 39 semanas, moradora de rua, é trazida a maternidade pelo SAMU com queixa de dor no baixo ventre. Ao exame está normotensa, atividade uterina: 2 contrações fracas de 30 segundos em 10 minutos, BCF 148 bpm, sem desacelerações. Toque vaginal apresenta 3 cm de dilatação. O teste rápido para HIV apresenta resultado positivo, teste para sífilis é não reagente. Qual a conduta mais adequada para esta paciente?

- A Iniciar AZT intravenoso e recomendar parto por via obstétrica.
- B Iniciar AZT intravenoso e indicar cesárea após 3 horas.
- C Iniciar raltegravir e indicar cesárea após 3 horas.
- D Indicar parto cesárea imediatamente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113857](https://www.4000113857.com.br)

Questão 37 Tratamento

Paciente de 29 anos, secundigesta (parto normal anterior há 3 anos), idade gestacional de 33 semanas, chega ao pronto atendimento da maternidade com história de contrações uterinas há três horas, dilatação cervical de 4 cm e polo cefálico em 1+ De Lee, evoluindo há 10 minutos com dor abdominal importante contínua e com aumento súbito de tônus uterino e alteração de vitalidade fetal durante a avaliação clínica. Ao exame físico: pressão arterial 80 x 50 mmHg, frequência cardíaca 115 bpm, frequência respiratória 24 irpm, Aparelhos respiratório e cardiovascular: dentro dos padrões de normalidade. Exame obstétrico: altura uterina = 35 cm, tônus uterino aumentado, ausculta fetal = 114 bpm com desacelerações até 97 bpm,

movimentação fetal ausente. Toque vagina: colo uterino grosso, posterior, consistência firme, cérvix 2 cm, apresentação fetal cefálica. Em associação aos cuidados de estabilização clínica, qual a conduta imediata mais adequada?

- A Parto cesárea.
- B Amniotomia.
- C Ácido tranexâmico.
- D Corticosteroide.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113837](#)

Questão 38 Monitorização pós tratamento

Gestante G3P1A1, 27 anos, 16 semanas de gravidez, veio encaminhada de unidade básica por diagnóstico de sífilis. Referia início recente de uma nova parceria sexual e história de que há dois meses apresentou lesão genital única, ulcerada e indolor (pequeno lábio), a qual desapareceu sem tratamento. Há duas semanas iniciou o pré-natal, verificando-se que a quimioluminescência para sífilis era positiva e o Rapid Plasma Reagin (RPR) era de 1:128. Demais exames da rotina laboratorial pré-natal sem alterações. Ela e o parceiro foram tratados corretamente com penicilina benzatina e receberam todas as orientações para evitar novas infecções. Qual é a dinâmica prevista para a redução dos anticorpos reagínicos da sífilis no controle deste tratamento?

- A Duas diluições em 90 dias.
- B Três diluições em 120 dias.
- C Cinco diluições em 180 dias.
- D Uma diluição em 60 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113818](#)

Questão 39 Conduta na RPM entre 24 a 33 67 semanas

Primigesta, 24 anos, 33 semanas, apresenta-se ao centro obstétrico com queixa de perda líquida genital em grande quantidade há 18 horas. Refere contrações esporádicas. Relata pré-natal sem intercorrências até o momento. Exame físico geral normal. Altura uterina de 28 cm, atividade uterina ausente e ao exame especular observou-se grande quantidade de líquido em fundo de saco vaginal. Toque vaginal mostrou colo dilatado 2 cm. O resultado do exame de cristalização foi positivo. Cardiotocografia com feto reativo. No manejo desse caso, qual prescrição é a mais adequada?

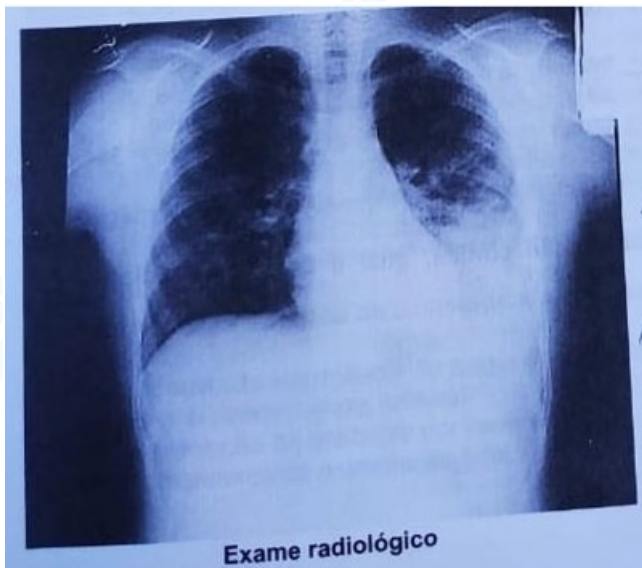
- A Betametasona e penicilina cristalina.
- B Ocitocina e penicilina cristalina.
- C Betametasona e sulfato de magnésio.
- D Misoprostol e sulfato de magnésio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000113794](#)

Questão 40 Síndrome torácica aguda

Menino, 4 anos, há 4 dias apresenta coriza nasal e tosse com piora progressiva. Há 2 dias apresenta febre 3 vezes por dia, 38,5 °C. Hoje está mais cansado com esforço respiratório e foi levado à emergência. AP: alteração do teste do pezinho para hemoglobinopatias (FSC) e faz seguimento em serviço de saúde. Ao exame: REG-MEG, descorado, cianose de extremidades, anictérico, afebril no momento, hidratado. Tórax com retrações intercostais e subdiafrágica. Pulmão: MV

diminuído a E, com estertores crepitantes em base E. FR 45 ipm. Saturação 85%. Coração: 2 BRNF sem sopros FC 130 bpm, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar 2 segundos, PA 90 x 50 mmHg. Abdome: semigloboso, normotenso, indolor, fígado a 2 cm do RCD, baço com a ponta palpável. SN: sem sinais meníngeos ou outras alterações. Exames laboratoriais: Hemograma - Hb 9,5 g/dl, Ht 29%, GB 15000 (bastonetes 11%, segmentados 45%, linfócitos 35%, eosinófilos 5%, mono 4%). Neutrófilos com microvacúolos. Após posicionar via aérea, dar oxigênio e iniciar antibioticoterapia, qual seria outra conduta apropriada neste caso?



Contra preços abusivos na medicina.

- A Transfusão de concentrado de hemácias 10 ml/kg.
- B Transfusão de troca (sangria + transfusão).
- C Não há indicação de transfusão.
- D Transfusão de concentrado de hemácias 6 ml/kg.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000112748

Questão 41 Neutropenia febril

Paciente com 3 anos de idade em tratamento de rabdomiossarcoma embrionário há 6 meses. Há 6 horas apresentou quadro de febre 38,5 °C, um pico isolado, que cedeu com uso de dipirona. Sem outras queixas. Último ciclo de quimioterapia há 9 dias (vincristina, actinomicina e ciclofosfamida). Ao exame: BEG, descorado (+/++++), acianótico, anictérico, sem edemas, boa perfusão periférica. Boca e ouvido: s/alterações. AR: FR: 26 irpm. Murmúrio vesicular simétrico, sem ruídos adventícios. ACV: FC: 108 bpm. Bulhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros. SGI: Abdome normotenso, sem visceromegalias. Ruídos hidroaéreos presentes e normoativos. Presença de hiperemia perineal. SN: sem sinais meníngeos. Solicitado hemograma, que evidenciou: Hb: 8,6 g/dl, GB: 1.200/mm³ (8% segmentados e 92% linfócitos), Plaquetas: 68.000/mm³. A conduta para o paciente acima é?

- A Internação para investigação e iniciar fluconazol.
- B Investigação ambulatorial e iniciar amoxicilina + clavulanato de potássio.
- C Internação para investigação e iniciar cefepime e metronidazol.
- D Investigação ambulatorial com reavaliações e iniciar pomada com nistatina e óxido de zinco.

Questão 42 Perfil de ferro na anemia ferropriva Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas

Menina, 6 meses, está internada na enfermaria para tratamento de pneumonia, em uso de antibioticoterapia com ampicilina há 3 dias. Está afebril há 12 horas. Ao exame físico: bom estado geral, com palidez cutânea, sem desconforto respiratório, FR 30 ipm. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular diminuído em base a D. Ausculta cardíaca: 2 BRNF sem sopros, FC 150 bpm, pulsos cheios, perfusão 2 segundos. PA 90 x 50 mmHg. Abdomen: fígado e baço não palpáveis, RH+. AP: fez o uso de leite materno exclusivo e atualmente está na introdução de papa de frutas e legumes. Hemograma: Hb 8 g/dl, Ht 25%, HCM 18 pg, VCM 50 fL, RDW 20%, GB 10000, neutrófilos 65% (predomínio de segmentados), linfócitos 30%, monócitos 2%, eosinófilos 3%. Plaquetas 300.000. Qual o melhor exame para elucidar o diagnóstico nesta situação?

- A VHS.
- B Ferritina.
- C Saturação de transferrina.
- D Reticulócitos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112684](#)

Questão 43 Cardiopediatria e Cardiopatias congênitas

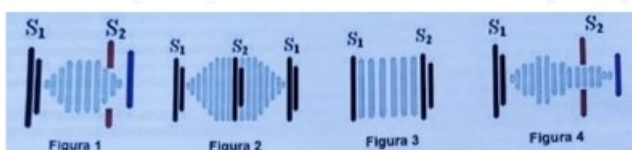
Uma criança de 6 meses de idade foi submetida a um cateterismo cardíaco, que evidenciou as seguintes saturações de oxigênio: Veia cava superior: 75%; Átrio direito: 75%; Ventrículo direito: 85%; Artéria pulmonar: 85%; Veias pulmonares: 95%; Átrio esquerdo: 95%; Ventrículo esquerdo: 95%; Artéria aorta: 95%. Baseado nestes dados, a criança provavelmente é portadora de

- A defeito do septo atrioventricular.
- B persistência do canal arterial.
- C comunicação interventricular.
- D comunicação interatrial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112666](#)

Questão 44 Cardiopediatria e Cardiopatias congênitas

Você está examinando uma criança de 2 meses de vida com história de sudorese profusa, taquipneia e cansaço às mamadas, com intensificação dos sintomas há 3 semanas. A saturação de oxigênio é de 95% em ar ambiente. A radiografia de tórax evidencia cardiomegalia global, com aumento da trama vascular pulmonar, e o eletrocardiograma evidencia sobrecarga biventricular. Na ausculta, há a presença de sopro. Baseado nestes dados, qual a representação esquemática mais provável do sopro encontrado? S1- primeira bulha; S2 - segunda bulha.



- A Figura 1.
- B Figura 2.
- C Figura 3.
- D Figura 4.

4000112640

Questão 45 Diagnóstico

Paciente masculino, 4 anos, portador da síndrome de Down, apresenta distensão abdominal observada há 2 anos. Na investigação, a antitransglutaminase IgA foi fortemente reagente. Qual é a conduta imediata mais correta?

- A Pesquisa de HLA DR13 e DQ6.
- B Endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno.
- C Prescrever dieta de exclusão de glúten.
- D Colonoscopia com biópsias seriadas.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112595](https://www.4000112595.com.br)

Questão 46 Síndrome HemolíticoUrêmica SHU

Menina, 2 anos e 6 meses, com 13 kg, previamente saudável. Há 10 dias teve quadro de diarreia e vômitos com resolução espontânea dos vômitos em 48 horas, mas manutenção das fezes líquidas com presença de pequena quantidade de sangue escuro a partir do terceiro dia. Procurou atendimento médico sendo prescrita solução oral para hidratação e ceftriaxone IM, 1 vez ao dia, que a criança utilizou até ontem com resolução do quadro de diarreia no final da primeira semana. Hoje a mãe notou a criança pálida, muito prostrada e sem urinar há 12 horas. Exame físico: criança irritada, chorando com lágrimas, edema bipalpebral. Ausculta pulmonar: MV presente e simétrico com roncos; FR 25 irpm; ausculta cardíaca: 2 BRNF sem sopros, FC 153 bpm; PA 112 x 50 mmHg. Abdome globoso sem alterações. Saturação de oxigênio em oximetria de pulso = 95%. Exames laboratoriais: hemoglobina = 6,5 g/dL, hematócrito = 20%, leucócitos = 14.000, plaquetas = 70.000, ureia = 66 g/dL, creatinina = 3,2 mg/dL, sódio sérico = 130 mEq/L e potássio sérico = 6,0 mEq/L. O comprometimento da função renal, nesse cenário diagnóstico, pode ser atribuído a:

- A Necrose tubular aguda.
- B Glomerulonefrite aguda pós infecciosa.
- C Nefrite túbulo intersticial por droga.
- D Microangiopatia trombótica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112563](https://www.4000112563.com.br)

Questão 47 Pediatria Quadro clínico

Menina, branca, previamente hígida com 15 meses de idade atendida em Unidade Básica de Saúde há 3 semanas com a seguinte história: há um dia com quadro de irritabilidade, recusa alimentar, febre de 38 °C que cedia com antitérmico, diminuição da diurese e urina mais escurecida. Exame físico: criança em bom estado geral, sem alterações, exceto obstrução nasal e presença de roncos de transmissão na ausculta pulmonar. Colhido exames e orientado retorno no dia seguinte, quando foi diagnosticada otite média serosa e foram prescritos soro fisiológico nasal e antitérmico. Devido a alterações encontradas nos exames laboratoriais do dia anterior, o médico orientou a mãe a repetir o exame de urina e

procurar o pediatra que segue a puericultura da criança. Na consulta de rotina, a mãe relata que a febre durou apenas 3 dias. A criança está bem no momento e ela trouxe os exames realizados para avaliação. Exames iniciais (urina colhida por sondagem vesical transuretral). Urina tipo 1: densidade 1,021, pH 5, nitrito negativo, proteína 1+, leucócitos 4-5 por campo e hemácias 4-5 por campo. Urocultura: > 100.000 UFC/mL de E coli. Repetição dos exames (2 semanas após o quadro inicial). Urina tipo 1: densidade 1,013, pH 5, nitrito negativo, proteína negativa, leucócitos 1-2 por campo e hemácias 0-1 por campo. Urocultura: > 100000 UFC/mL de E coli. Qual o provável diagnóstico?

- A Infecção do trato urinário inferior.
- B Bacteriúria assintomática.
- C Vulvovaginite.
- D Malformação do trato urinário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112539](#)

Questão 48 **Síndrome Klinefelter** **Causas**

Adolescente do sexo masculino com 14 anos apresenta aumento do volume mamário bilateralmente. Refere que isso ocorreu há cerca de 2 anos junto com o desenvolvimento dos pelos e do pênis. Ao exame físico: altura 176 cm, M3 bilateral, P4, pênis com 6 cm de comprimento esticado e testículos com 3 mL de volume bilateralmente. Quais exames devem ser solicitados?

- A Ultrassonografia da mama e cariótipo.
- B Dosagem de LH, FSH e cariótipo.
- C Dosagem de testosterona, estradiol e prolactina.
- D Idade óssea e ultrassonografia testicular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112517](#)

Questão 49 **Diagnóstico diferencial Resistência aos hormônios tireoidianos**

Menina com 3 anos e 4 meses, é trazida à consulta pela mãe que refere agitação psicomotora e dificuldade para dormir e ganhar peso desde os primeiros meses de vida. Nega outras queixas, doenças prévias e uso de medicações. DNPM adequado. Tem antecedentes de pai e avô paterno com bócio. Exame físico: peso = 10,9 kg. Estatura = 90 cm. FC = 140 bpm. Discreto bócio difuso, parenquimatoso, móvel e indolor. Sem outras alterações. Exames laboratoriais: T3 total = 210 ng/dL (VR: 84 a 172); T4 livre = 2,3 ng/dL (VR: 0,9 a 1,8); TSH = 8,2 mIU/L (VR: 0,4 a 4,5); anticorpo anti-TPO = 34 IU/L (VR: menor que 35). Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Tireoidite de Hashimoto.
- B Hipotireoidismo.
- C Resistência aos hormônios tireoidianos.
- D Doença de Graves.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112496](#)

Questão 50 **Calendários vacinais** **Imunizações** **Vacinação**

Paciente de 2 meses de vida, apresenta diagnóstico confirmado de imunodeficiência combinada grave. Encontra-se em boas condições clínicas e com evolução pondero-estatural adequada. É levado ao posto de saúde para iniciar vacinação. A

conduta adequada é

- A fazer todas as vacinas, exceto BCG.
- B fazer somente vacinas atenuadas.
- C fazer todas as vacinas indicadas para a idade.
- D fazer somente vacinas inativadas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112474](#)

Questão 51 **Pediatria** **Diagnóstico**

Escolar de 8 anos, previamente hígido, há 4 dias apresenta febre 38,5 °C, uma vez ao dia, associado à dor e inchaço nos tornozelos e joelho esquerdo. Após dois dias houve melhora dos sintomas nessas articulações, porém, iniciou com dor no punho direito. Ao procurar o pronto socorro, apresentava-se em REG, hipoativo, corado, hidratado, afebril, frequência cardíaca de 132 bpm, frequência respiratória de 28 ipm, com edema em joelho esquerdo e dor e limitação no punho direito. A velocidade de hemossedimentação era de 80 mm na primeira hora e o hemograma e o raio-X das articulações acometidas não apresentam alterações. Qual a abordagem diagnóstica inicial seria adequada para esse paciente?

- A Aspirado de medula óssea e LDH.
- B Artrocentese do joelho esquerdo e hemocultura.
- C Anticorpo antinúcleo e urina rotina.
- D Antiestreptolisina O e ecocardiograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112437](#)

Questão 52 **Manifestações clínicas**

Menino, 3 anos, proveniente da zona urbana. Há 2 meses apresentando lesões em membros inferiores, inicialmente eram pruriginosas e eritematosas e ao passar do tempo, aumentaram e ficaram ulceradas como demonstrada na foto. Nega perda de apetite, perda de peso ou febre durante o período. Em sua cidade, algumas crianças tiveram as mesmas lesões. Qual o agente etiológico provável?



Foto do enunciado

- A Fusarium oxyspora.
- B Paracoccidoides brasiliensis.
- C Leishmania braziliensis.
- D Bacilo de Koch.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112408](#)

Questão 53 Modos convencionais de Ventilação Mecânica

Você decide pela intubação traqueal de um paciente de 1 ano, que está em insuficiência respiratória devido laringite. Após intubação, há melhora imediata do desconforto respiratório. Qual é a configuração inicial adequada do ventilador mecânico em modo SIMV (ventilação mandatória intermitente sincronizada), controlado a pressão de suporte?

- A Fração inspirada de oxigênio 21%, pressão inspiratória 25 cmH₂O (ajustada para volume corrente exalado de 12ml/kg), frequência respiratória 15/min, tempo inspiratório 0,8 s (relação I/E 1:4), PEEP 10 cmH₂O, pressão de suporte 15 cmH₂O acima da PEEP, sensibilidade -2 cmH₂O.
- B Fração inspirada de oxigênio 100%, pressão inspiratória 15 cmH₂O (ajustada para volume corrente exalado de 8 ml/kg), frequência respiratória 25/min, tempo inspiratório 0,6 s (relação I/E 1:3), pressão positiva no final da inspiração (PEEP) 5 cmH₂O, pressão de suporte 10 cmH₂O acima da PEEP, sensibilidade -1 cmH₂O.
- C Fração inspirada de oxigênio 100%, pressão inspiratória 15 cmH₂O (ajustada para volume corrente exalado de 4 ml/kg), frequência respiratória 40/min, tempo inspiratório 0,6 s (relação I/E 1:2), PEEP 5 cmH₂O, pressão de suporte 10 cmH₂O acima da PEEP, sensibilidade -2 cmH₂O.
- D Fração inspirada de oxigênio 21%, pressão inspiratória 25 cmH₂O (ajustada para volume corrente exalado de 12ml/kg), frequência respiratória 20/min, tempo inspiratório 1 s (relação I/E 1:2), PEEP 5 cmH₂O, pressão de suporte 20 cmH₂O acima da PEEP, sensibilidade -1 cmH₂O.

4000112371

Questão 54 Manifestações clínicas

Menino, 5 anos, procedente da zona rural chega na emergência com história de picada por animal não identificado. Logo em seguida apresentou vômitos, sudorese e sonolência. Ao exame físico: MEG, descorado, acianótico, hidratado. Olhos: ptose palpebral. Boca: seca. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, FR 30 ipm, FC 130 bpm, pulsos cheios. Tempo de enchimento capilar 2 segundos. PA: 100 x 60 mmHg. Abdome: plano, normotenso, indolor, fígado e baço não palpáveis. SN hipotonia de musculatura e midríase. Diante deste quadro clínico qual o soro antiveneno você optaria?

- A Soro antibotrópico.
- B Soro antiloxosceles.
- C Soro anticrotálico.
- D Soro antiescorpiônico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112346](#)

Questão 55 Quadro clínico

Menino, 4 anos, previamente hígido, está no 3º dia de pós-operatório de uma correção de fratura supracondiliana em braço direito. A cirurgia foi sem intercorrência, mas ele não aceitou bem a dieta e está em jejum há 48 horas. Está com soro de manutenção com 100% Holliday, Na: 30 mEq/L, K: 30 mEq/L, Mg: 0,5 mEq/Kg/dia, gluconato de cálcio 10%: 2 ml/kg/dia e

glicose: 2 gramas/kg/dia. Hoje apresentou crise convulsiva, inédita, tônica clônica generalizada com duração de 5 minutos. Qual é o provável diagnóstico?

- A Hiponatremia.
- B Hipopotassemia.
- C Hipomagnesemia.
- D Hipocalcemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112324](#)

Questão 56 Doença de Hirschsprung

Pré-escolar com 4 anos, apresenta dificuldade para evacuar desde os primeiros meses de vida, havendo piora progressiva do quadro há um ano quando passou a frequentar a creche. Atualmente só evacua com lavagem intestinal, que é realizada quando a criança fica 1 semana sem evacuar e tem muita dor abdominal, resultando em saída de fezes empedradas em grande quantidade. É uma criança retraída, não gosta de ir à escola, prefere ficar com a mãe. Já realizou diversos tratamentos, incluindo laxativos, aumento de fibras na dieta, sem sucesso. Ao exame, apresenta discreta distensão abdominal, fezes endurecidas palpáveis em hipogástrio, peso e estatura no percentil 25. Com base nesse caso clínico, qual o melhor exame para firmar o diagnóstico?

- A Enema contrastado.
- B Trânsito intestinal.
- C Colonoscopia com biópsia.
- D Exame de bioimpedância.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112298](#)

Questão 57 Diagnóstico

Menino de 15 dias, com história de diminuição da movimentação do membro superior direito e irritabilidade há uma semana. O exame físico mostra, adicionalmente, icterícia, discreto rash maculopapular, petéquias isoladas e hepatoesplenomegalia. O menino nasceu de parto cesárea a termo, apresentação pélvica, com 3000 g, Apgar 9/10 e recebeu alta hospitalar no terceiro dia de vida. A mãe relata acompanhamento de pré-natal, mas não trouxe cartão. Qual é o mais provável agente infeccioso causador do quadro?

- A Treponema pallidum.
- B Citomegalovírus.
- C Toxoplasma gondii.
- D Vírus da rubéola.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000112277](#)

Questão 58 Ventilação com pressão positiva

Durante o atendimento em sala de parto a um recém-nascido a termo, parto vaginal, com líquido amniótico meconiado, espesso, você nota que o bebê está cianótico, flácido e não apresenta movimentos torácicos. Você o leva imediatamente à mesa de reanimação sob fonte de calor radiante e realiza os passos iniciais do cuidado ao recém-nascido, sem melhora. A frequência cardíaca é < 60 bpm. Qual é a conduta imediata mais indicada neste momento?

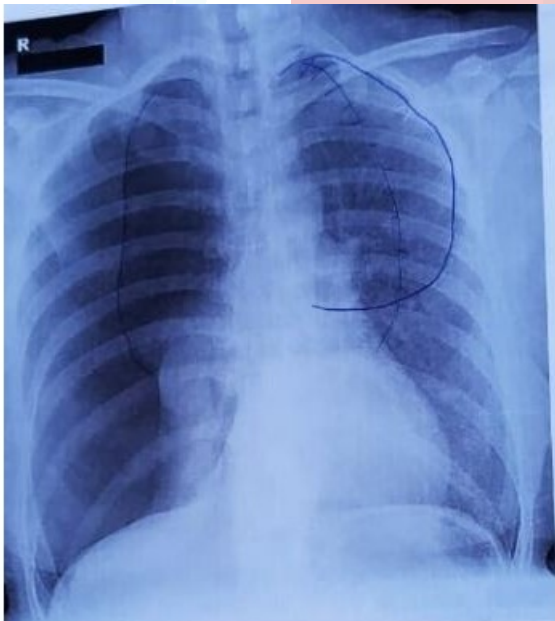
Recém-nascido de 2500 g está com obstrução intestinal e foi indicada cirurgia. Durante a cirurgia a temperatura do paciente manteve-se entre 35,5 °C e 36°C, com duração total de tempo anestésico de 3 horas e 40 minutos. Ao término da cirurgia o bebê estava completamente molhado. No retorno à Unidade de Terapia Intensiva neonatal a temperatura foi 35,8 °C. Tendo em vista a evolução da temperatura em todo o ato operatório, qual o risco de complicação metabólica esperado em pós-operatório imediato?

- A Acidose respiratória.
- B Alcalose metabólica.
- C Acidose metabólica.
- D Alcalose respiratória.

4000112170

Questão 62 Tratamento História Clínica Cirurgia

Homem, 18 anos, procura atendimento médico por dor pleurítica súbita à direita e dispneia aos moderados/grandes esforços. Não há antecedentes pessoais de comorbidades e não é tabagista. Ao exame físico, saturação 92% em ar ambiente, afebril, FC = 90 bpm e PA = 118 x 82 mmHg. Hipertimpanismo à percussão e ausência de murmúrio vesicular à direita. Uma radiografia de tórax é solicitada (figura). Qual o diagnóstico e conduta adequados?



- A Colapso pulmonar completo por pneumotórax extenso e com quadro descrito há o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. Indicação de toracocentese descompressiva seguida de drenagem pleural.
- B Pneumotórax completo à direita indica drenagem pleural tubular, seguida de investigação com tomografia de tórax.
- C Atelectasia completa do pulmão direito levando a pneumotórax extenso, inicialmente indicaria broncofibroscopia para excluir causa endobrônquica.
- D Pneumotórax importante, porém, em paciente sem insuficiência respiratória, indicaria drenagem pleural aberta e investigação com ressonância magnética.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000112124

Questão 63 Infecções Necrotizantes Cirurgia

Homem, 62 anos, diabético e hipertenso não controlado, sofreu trauma na região perineal (quando caiu sentado) há cerca de 5 dias. No dia seguinte, passou a apresentar abaulamento na região perianal, acompanhado de hiperemia e saída de secreção amarelada. Relata também que passou a apresentar edema da bolsa escrotal, descamação e enegrecimento em alguns pontos da pele há 3 dias, além de odor fétido no local. Há 2 dias está apresentando febre. Ao exame físico da bolsa escrotal observa-se os achados conforme figura. Qual a principal hipótese diagnóstica?



- A Fratura peniana.
- B Hematoma pós-trauma.
- C Trombose venosa profunda de vasos pélvicos.
- D Gangrena de Fournier.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Proibida venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000112055

Questão 64 Doença de Hirschsprung Doença de Hirschsprung

Menina, 3 anos. Informante refere constipação intestinal desde o período neonatal evacuando apenas com medidas (estímulo com supositórios). Evoluiu, quando lactente, com episódios de impactação de fezes com necessidades de lavagem intestinal. Condição atual: evacua apenas com lavagem intestinal e apresenta escape fecal. Refere 4 internações com ""diarreia"", segundo mãe. A foto ilustra o paciente durante o momento de sua avaliação. Considerando o diagnóstico mais provável, qual a causa possível para estes episódios de ""diarreia""?



- A Rotavírus.
- B Alergia alimentar.
- C Enterocolite.
- D Reação as lavagens.

400012008

Questão 65 **Abdome Agudo Perfurativo** **Cirurgia**

Homem, 68 anos, com dor abdominal intensa no epigástro, iniciada subitamente há 2 horas. Refere náuseas, mas nega vômitos ou qualquer outro sintoma. Refere hipertensão arterial sistêmica com bom controle medicamentosa, além de cervicgia crônica devido à hérnia discal, com necessidade de uso frequente de medicação para dor. Ao exame físico: bom estado geral, frequência cardíaca de 60 bpm, pressão arterial de 160 x 110 mmHg, abdome difusamente doloroso à palpação e tenso. Solicitados exames laboratoriais e radiografia de abdome e tórax (vide figuras). Qual a principal hipótese diagnóstica?



- A Úlcera gástrica perforada.
- B Isquemia mesentérica.
- C Neoplasia de cólon com obstrução intestinal.
- D Dissecção aguda de aorta.

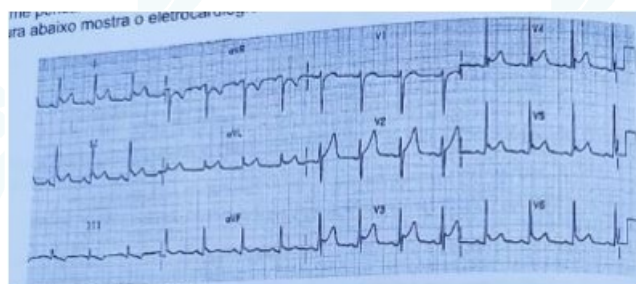
Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [400011961](https://t.me/medicinalivre)

Questão 66 **Tratamento**

Homem de 56 anos apresenta desconforto na região precordial e hemitórax esquerdo uma semana após ser submetido a operação para revascularização do miocárdio, sem outras queixas. Ao exame físico apresenta pressão arterial 140 x 95 mmHg e bulhas hipofonéticas, frequência cardíaca de 100 bpm e temperatura de 37,7 °C. O ecocardiograma revelou dissinergia septal, derrame pericárdico leve, sem sinais de tamponamento, e fração de ejeção de 55%. A figura abaixo mostra o eletrocardiograma deste paciente. Qual a conduta mais adequada?



- A Heparinização plena.
- B Betabloqueador e nitrato.
- C Anti-inflamatório não-esteroidal.
- D Dupla antiagregação plaquetária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111872](#)

Questão 67 Tórax Instável e Contusão Pulmonar

Homem, 66 anos, anticoagulado, vítima de colisão de carro x poste é transferido para um Centro de Trauma após 12 horas de observação em Unidade de Pronto Atendimento, com dor em hemitórax direito. Exame físico: consciente, saturação de 94%, FR = 22 ipm, murmúrio vesicular diminuído à direita, FC = 74 bpm, PA = 100 x 70 mmHg. Devido ao mecanismo de trauma, realizou tomografia de tórax que mostrou fratura única de 4°, 5° e 6° arcos costais à direita, com fraturas alinhadas e sem hemotórax ou pneumotórax. Realizou espirometria com capacidade vital forçada < 1000 ml. Com a analgesia endovenosa, teve bom controle da dor. Qual a conduta?

- A Alta hospitalar com analgesia e consulta de retorno com pneumologista.
- B Alta hospitalar com analgesia e orientação de retorno se dispneia.
- C Internar doente para cirurgia de fixação de arcos costais fraturados.
- D Internar doente em leito de terapia intensiva com monitorização e analgesia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111824](#)

Questão 68 Manifestações Clínicas Medidas Iniciais Cirurgia

Homem, 78 anos, com queixa de dor à deambulação bilateral, porém mais intensa em membro inferior esquerdo há 20 anos. Há 4 horas apresentou dor súbita em pé direito, frialdade e parestesia. É portador de hipertensão arterial sistêmica e tabagismo ativo. Ao exame físico: bom estado geral, corado e hidratado. Ritmo cardíaco regular, sem sopros, PA: 180 x 100 mmHg e frequência cardíaca de 67 bpm. Exame físico vascular: presença de pulsos femorais bilaterais, porém ausência de pulsos poplíteos ou mais distais bilateralmente. O pé direito está frio, com perda sensitiva, porém sem fraqueza muscular e sinal doppler arterial ausente neste pé. Apresenta ainda cianose não fixa de pododáctilos em pé direito. Não há lesões tróficas. Qual o diagnóstico e a melhor conduta?

- A Obstrução arterial crônica agudizada. Deve-se iniciar anticoagulação e, se não houver melhora em 24 horas, está indicada exploração arterial.
- B Obstrução arterial crônica com isquemia crítica. Paciente deve ser internado e solicitado inicialmente um ultrassom arterial que auxiliará na estratégia cirúrgica.
- C Obstrução arterial aguda de provável origem trombótica em paciente com doença arterial crônica subjacente. Deve ser iniciado antiagregação e anticoagulação imediatas e realizado um exame de imagem inicialmente.
- D Doença arterial obstrutiva periférica com claudicação limitante e embolia aguda sobrejacente em membro mais sadio. Está indicado trombolise e exploração cirúrgica para realização de tromboembolectomia à Fogarty.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111797](#)

Questão 69 Conduta nos Aneurismas de Aorta Abdominal Confirmação Diagnóstica Cirurgia

Homem, 80 anos, assintomático, com achado em ultrassom de rotina de aneurisma de aorta abdominal infra-renal de 4,2 x 4,1 cm de diâmetros e 9,0 cm de extensão. Realizou então angiotomografia que confirmou achados do ultrassom

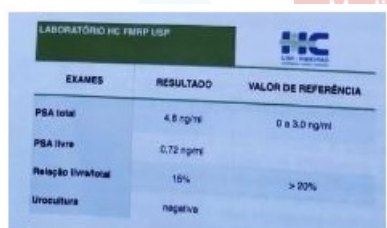
mostrando ainda colo de 2,0 cm de extensão, lumem de 2,5 cm de diâmetro e saco aneurismático com trombos até próximo a bifurcação das ilíacas. Qual a conduta atual mais adequada para este caso?

- A Tratamento endovascular minimamente invasivo.
- B Cirurgia aberta convencional.
- C Seguimento com exames de imagem a cada 6 meses.
- D Cirurgia robótica transperitoneal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111617](#)

Questão 70 **Biópsia** **Escore de Sintomas IPSS** **Cirurgia**

Homem negro de 54 anos procurou atendimento para rastreamento e detecção precoce do câncer de próstata, concordando com avaliação após exposição dos seus riscos e benefícios. Apresenta sintomas do trato urinário inferior com International Prostate Symptoms Score (I-PSS) de 7/35, satisfeito com sua qualidade de vida. Relata antecedente de neoplasia de próstata na família. Exame digital demonstrou próstata com 40 cm³ e consistência fibroelástica, sem nódulos, indolor. Foram solicitados exames, reproduzidos abaixo. Qual a conduta mais apropriada?



EXAMES	RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
PSA total	4,8 ng/ml	0 a 3,0 ng/ml
PSA livre	0,72 ng/ml	
Relação livre/total	15%	> 20%
Urocultura	negativa	

- A Fluxometria e ultrassom transretal de próstata.
- B Biópsia de próstata.
- C Retorno em 6 meses com novo PSA total e livre.
- D Alfa-bloqueador associado a inibidor da 5alfa-redutase.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111594](#)

Questão 71 **Quadro clínico diagnóstico e sinais de alarme**

Mulher de 35 anos com quadro de dor lombar esquerda aos esforços e com irradiação para a região glútea e membro inferior esquerdo há 5 dias. Nega antecedente pessoal de litíase urinária e refere história familiar (irmão do avô paterno). Refere parestesia intermitente. Procurou UPA onde solicitaram exame de urina e ultrassom. O exame de urina evidenciou densidade de 1030, pH de 8,0, leucócitos de 5 por campo, hemácias de 5 por campo e presença de cristais. Ultrassom evidenciou imagem de 0,3 cm no cálice inferior, sem sombra acústica posterior, interrogando cálculo urinário e ausência de dilatação no trato urinário. Após prescrever analgesia adequada, qual a melhor conduta?

- A Referenciar para ortopedia para tratamento da lombalgia.
- B Referenciar para urologia para tratamento da litíase.
- C Regulação para realização de ressonância nuclear magnética.
- D Regulação para internação hospitalar para realização de litotripsia.

Questão 72 Tratamento e conduta

Mulher, 43 anos, com diagnóstico de melanoma nodular em antebraço esquerdo, Breslow de 2,1 mm. Foi submetida à cirurgia de ampliação de margens seguida de pesquisa do linfonodo sentinela em axila esquerda, cujo resultado histopatológico foi positivo para presença de melanoma. Foi então indicado cirurgia para linfadenectomia axilar esquerda, que demonstrou acometimento de 2 linfonodos dos 9 encontrados. Como deverá prosseguir o tratamento dessa paciente?

- A Seguimento clínico com exames de imagem.
- B Linfadenectomia axilar direita.
- C Radioterapia em axila esquerda.
- D Quimioterapia com dacarbazina.

Essa questão possui comentário do professor no site [400011324](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 73 Úlcera diabética Debridamento Classificação do risco de ulceração e seguimento

Mulher, 57 anos, hipertensa, diabética e portadora de varizes de membros inferiores. Notou surgimento de ferida em região de tornozelo esquerdo há 9 meses. A ferida aumentou progressivamente de tamanho, com presença de tecido desvitalizado no leito, muita exsudação e sem exposição óssea. Há 4 meses foi submetida a desbridamento e 3 ciclos de terapia por pressão negativa até obtenção de tecido de granulação exuberante, seguida de cobertura cutânea com enxerto de pele parcial. Houve integração adequada do enxerto e a ferida fechou por completo. Há 1 mês, paciente notou surgimento de nova ferida na mesma localização, que aumentou de tamanho e com perda de todo enxerto de pele. Não apresentava sinais de infecção local. Qual das causas melhor explica a recidiva da ferida?

- A Localização da ferida no tornozelo.
- B Cobertura cutânea da ferida inadequada para o local.
- C Preparo inadequado do leito da ferida.
- D Falta de controle das comorbidades causadoras da ferida.

Essa questão possui comentário do professor no site [400011289](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 74 Abdome Agudo Obstrutivo Cirurgia

Mulher, 40 anos, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva após queimadura de 3º grau de 40% da superfície corporal. Antecedentes pessoais: previamente hígida. Apresenta distensão abdominal importante e parada de eliminação de fezes. Ao exame: intubada, hipocorada e afebril. FC = 88 bpm. PA: 110 x 70 mmHg, sem drogas vasoativas. Abdome tenso e com distensão importante. Toque retal com fezes sólidas. Hemograma, lactato, função renal e eletrólitos normais. Radiografia de abdome apresenta colograma aéreo difuso e importante (vide figura). Tomografia do abdome sem ponto de obstrução. Qual a melhor hipótese e conduta?



Colograma aéreo, sem obstrução mecânica

- A Isquemia mesentérica; arteriografia de urgência.
- B Megacólon tóxico; colectomia de urgência.
- C Pseudo-obstrução colônica; sondagem descompressiva.
- D Volvo do sigmoide; descompressão endoscópica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111246](https://www.t.me/medicinalivre)

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Questão 75

Apresentação Clínica e Diagnóstico

Tratamento

Cirurgia

Mulher, 30 anos, há 2 dias com dor anal importante, após evacuação com esforço e fezes endurecidas. Refere eliminação de sangue vivo pelo ânus, que pinga no vaso sanitário após a passagem das fezes. Como antecedentes, informou que o hábito intestinal era a cada 2 dias, com fezes macias e que, na última semana, após viagem a trabalho, modificou sua rotina alimentar. Nega câncer na família. Mãe foi operada de hemorroidas. Ao exame físico da região anal, observou-se o achado da figura. Qual a melhor conduta?



Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Diltiazem tópico.
- B Nifedipina tópica.
- C Colonoscopia.
- D Orientação higienodietética.

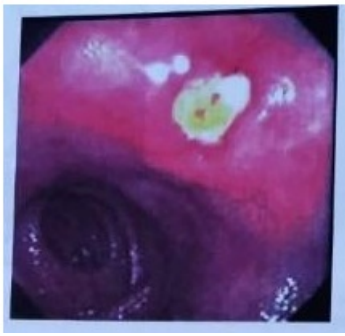
Essa questão possui comentário do professor no site [4000111171](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 76

Classificação de Forrest

Diagnóstico e Tratamento

Homem, 42 anos, em tratamento de tendinite do calcâneo foi admitido em Unidade de Pronto Atendimento com melena há dois dias, frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 x 70 mmHg, hemoglobina de 12 g%. Após as medidas iniciais foi encaminhado para hospital de média complexidade para realização de endoscopia digestiva alta que revelou úlcera péptica coberta por fibrina (vide figura). Qual é a melhor orientação?



- A Hemostasia endoscópica, dieta líquida sem resíduos, tratamento com inibidor de bomba de prótons e observação em leito de enfermaria por 12 horas para monitorar ressangramento.
- B Iniciar dieta, alta hospitalar e tratamento com inibidor de bomba de prótons e para *Helicobacter pylori*.
- C Hemostasia endoscópica, jejum, inibidor de bomba de prótons e observação em leito de estabilização clínica e repetir a endoscopia em 24 horas para comprovar a hemostasia.
- D Jejum, inibidor de bomba de prótons em dose dobrada, observação em leito de enfermaria até completar 72 horas sem sinais hemodinâmicos e de exteriorização de sangramento.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111106](https://www.4000111106.com)

Questão 77 Síndrome Dispéptica

Mulher, 58 anos, sem comorbidades, foi encaminhada para ambulatório médico especializado por apresentar, esporadicamente, há dois anos, após aposentadoria, quatro episódios de dor em queimação epigástrica e retroesternal desencadeada pela ingestão concomitante de macarronada vermelha e vinho durante as viagens de férias. Anteriormente havia sido avaliada na atenção básica em função dos sintomas e do ganho de peso, onde os exames laboratoriais solicitados estavam dentro da normalidade. A ultrassonografia de abdômen (vide figura) identificou litíase biliar. Qual o plano terapêutico mais apropriado neste momento?



Acesse t.me/medicinalivre

- A Inibidor da bomba de prótons, endoscopia, seguida de colecistectomia.
- B Orientação comportamental e acompanhamento na atenção básica.
- C Endoscopia, inibidor da bomba de prótons e fundoplicatura.
- D Endoscopia, colecistectomia e fundoplicatura de oportunidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111063](#)

Questão 78 **Complicações** **Cirurgia**

Homem, 53 anos de idade, apresentou episódio de pancreatite aguda com aumento progressivo do abdome e no oitavo dia de internação evoluiu com desconforto respiratório, hipotensão, oligúria e a pressão intra-abdominal atingiu 23 mmHg, com adoção de suporte cardiovascular, respiratório e renal. Com base nas alterações fisiológicas, nos achados físicos e de imagem (vide figura), qual o procedimento mais efetivo para melhorar as alterações observadas?



- A Drenagem percutânea.
- B Sondagem gástrica e retal.
- C Laparotomia com peritoneostomia.
- D Drenagem endoscópica.

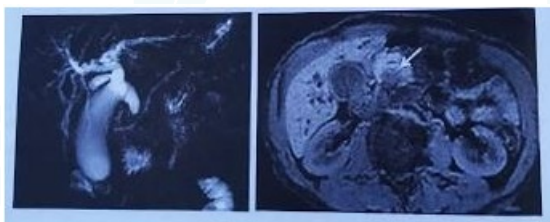
Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111008](#)

Questão 79 **Avaliação PréOperatória** **Manifestações Clínicas** **Diagnóstico**

Homem, 38 anos, previamente hígido, com icterícia indolor, prurido, colúria e acolia fecal há 3 semanas. No período, perdeu cerca de 6% da massa corporal. Exame físico: icterícia de ++++/4, e sinais de escoriação. Risco anestésico-cirúrgico classificado de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologia como ASA I. A colangiopancreatografia por ressonância magnética (vide figura) revelou lesão sólida na confluência biliopancreática de 1,4 centímetros e está em programação de ressecção duodenopancreática. Dentre os exames solicitados no pré-operatório desta cirurgia, considera-se essencial:



- A Avaliação da coagulação.
- B Dosagem de aminotransferases e bilirrubinas.
- C Biópsia por ecoendoscopia.
- D Eletrocardiograma e radiografia de tórax.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110960](#)

Questão 80 Exames complementares Cardiologia

Você é médico(a) de família e comunidade em uma Unidade de Saúde da Família e seu primeiro paciente do dia é um homem. Ele vem sem queixas para uma consulta de rotina agendada previamente. Ele tem 56 anos, é hipertenso (de longa data) controlado e dislipidêmico. Faz uso de enalapril 20 mg/dia, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/dia e sinvastatina 20 mg/dia. Nunca fumou, nem bebeu. Apresenta exame físico normal. PA: 128 x 86 mmHg. Você checa o prontuário e encontra os seguintes exames complementares: glicose 94 mg/dL, colesterol total 185 mg/dL, colesterol HDL 61 mg/dL, triglicérides 132 mg/dL, creatinina 1,2 mg/dL, potássio 4,3 mEq/L. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que cita exames obrigatórios e que estão faltando no prontuário do paciente citado.

- A Ureia e TSH.
- B Colesterol LDL e TSH.
- C Colesterol LDL e sódio.
- D Ácido úrico e urina rotina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110920](#)

Questão 81 Prevenção Quaternária

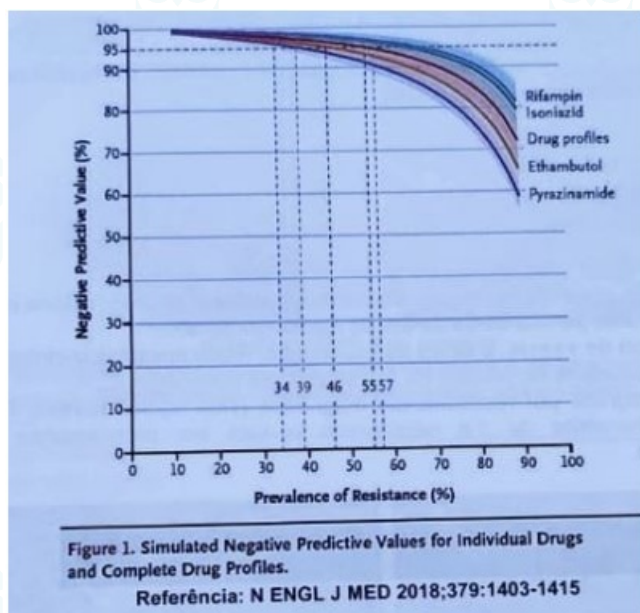
Um adolescente de 17 anos procura a Unidade de Saúde da Família buscando um atestado de saúde para realização de prática esportiva. Com finalidade de identificar condições que poderiam levar à morte súbita durante a prática esportiva, a avaliação médica deve incluir a obtenção de uma história pessoal e familiar para a ocorrência de cardiopatias e um exame físico detalhado, com ênfase na identificação de sopros e outras alterações cardíacas. Em relação a realização de exames subsidiários:

- A Deve ser solicitado um teste de esforço.
- B Deve ser solicitado um ecocardiograma.
- C Não devem ser solicitados exames subsidiários.
- D Deve ser solicitado um eletrocardiograma de 12 derivações.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110895](#)

Questão 82 Valor Preditivo Negativo

O gráfico abaixo foi extraído de um estudo em que os autores avaliaram um novo teste de biologia molecular que detecta mutações genéticas no *M. tuberculosis* potencialmente associadas ao fenótipo de resistência aos tuberculostáticos. Posteriormente, os autores fizeram uma simulação, abaixo ilustrada, para estimar a performance do teste em locais com diferentes prevalências de resistência. O gráfico ilustra um importante conceito em epidemiologia que é



- A o valor preditivo negativo de um teste se correlaciona de maneira inversa com o valor preditivo positivo do mesmo teste, na população estudada.
- B o valor preditivo negativo de um teste se correlaciona de maneira direta com a prevalência da doença na população estudada.
- C o valor preditivo negativo de um teste se correlaciona com a especificidade do teste, na população estudada.
- D o valor preditivo negativo de um teste se correlaciona de maneira inversa com a prevalência da doença na população estudada.

4000110865

Questão 83 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Os agentes comunitários de saúde finalizaram o cadastro da população da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família (USF) e identificaram que 33% tinha plano de saúde suplementar. Na reunião de equipe discutiram essa característica do território e decidiram planejar as ações de saúde da USF para atender a população que possuía apenas a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta decisão da equipe de saúde pode ferir, principalmente, que princípio doutrinário do SUS?

- A Resolutividade.
- B Universalidade.
- C Equidade.
- D Integralidade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000110833

Questão 84 Manejo da Nefropatia diabética

Você atua como médico de família e comunidade em uma Unidade de Saúde da Família e atende uma paciente do sexo masculino, de cor branca, com 62 anos de idade e história de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, que vem para uma consulta de rotina e não apresenta queixas. Ele usa enalapril 20 mg/dia, anlodipino 5 mg/dia, metformina XR 500 mg/dia. No exame físico, você identifica paciente em bom estado geral, pesando 72 Kg, FC = 80 bpm, PA = 126 x 80 mmHg. Ele lhe traz os resultados de exames laboratoriais que você pediu na última consulta. Glicemia de jejum: 110 mg/dL,

HbA1C: 7%, creatinina: 2,0 mg/dL, sódio: 137 mEq/L, potássio: 4,2 mEq/L, relação albuminúria/creatinúria: 350 mg/g. Nessa situação, além de orientar alimentação adequada e exercícios físicos regulares, qual seria a sua conduta?

- A Suspende o anlodipino e eleva a dose do enalapril para 20 mg de 12/12h.
- B Manter as medicações prescritas nas mesmas doses, repetir os exames e reavaliar em 1 mês.
- C Substituir a metformina por glibenclamida e manter as demais medicações prescritas.
- D Suspende o enalapril e eleva a dose do anlodipino para 5 mg de 12/12h.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110810](https://www.4000110810.com.br)

Questão 85 Violência

Você é médico em uma Unidade de Saúde da Família (USF) e durante a reunião para discutir o seguimento das famílias uma ACS informa que está preocupada, pois tem dificuldades para acessar os membros que moram em um domicílio, uma vez que só é recebida no portão e a família mostra-se muito fechada. Nos contatos que a equipe teve com os membros da família, percebeu uma dinâmica familiar conflituosa, clima hostil e pouca adesão às orientações feitas pela equipe: Você então realiza uma visita domiciliar e é recebida pela mulher, que não se mostra confortável com a sua presença, diz que quando precisar buscará a USF e pede para que você seja breve na sua visita. Você então suspeita de violência doméstica e convida a paciente a buscar a USF, caso necessite. Diante do quadro você deverá

- A notificar a suspeita de violência doméstica na ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal e Autoprovocada.
- B comunicar o caso à Delegacia de Defesa da Mulher da cidade ou região, com intuito de proteger a mulher de uma possível agressão física.
- C influenciar a mulher na tomada de decisões, uma vez que ela está em situação de alta vulnerabilidade e apresenta-se pouco reativa.
- D convocar a família para realizar uma entrevista familiar, uma vez que é papel do Médico de Família e Comunidade tratar todos os membros da família.

4000110687

Questão 86 Avaliação em Saúde

Em sua reunião com a equipe técnica o Secretário Municipal da Saúde demonstrou preocupação, pois ao analisar os indicadores hospitalares, notou o aumento de internações por diabetes, no município. Na discussão sobre as prováveis causas deste evento, a equipe justificou que a atenção primária em saúde (APS) não está bem organizada, há falta de profissionais e pouca resolutividade, tendo em vista que a taxa de encaminhamentos das unidades de APS está acima de 25%. Diante dessa explicação, o secretário solicitou à equipe a elaboração emergencial de uma proposta de reorganização da APS para tentar intervir nesse problema de saúde. Na situação acima podemos afirmar que o secretário usou um indicador de condições sensíveis à APS para medir

- A efetividade.
- B produtividade.
- C eficiência.
- D eficácia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110666](https://www.4000110666.com.br)

Questão 87 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

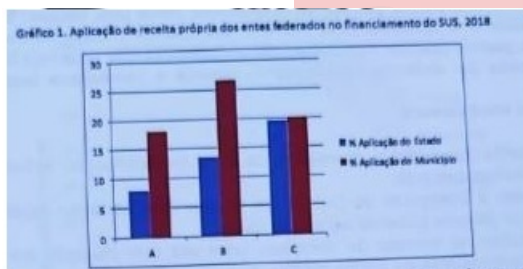
O cuidado domiciliar amplia o espectro da atenção das equipes que cuidam dos pacientes no domicílio, incorporando aspectos de prevenção, promoção e reabilitação. Segundo a Portaria 2.527, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, pode se afirmar que:

- A as modalidades A2 e A3 exigem maior complexidade tecnológica e deverão ficar sob responsabilidade do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD), nos municípios com menos de 40 mil habitantes.
- B deve ser estruturada na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, tendo a atenção hospitalar como ordenadora do cuidado.
- C é uma modalidade de atenção à saúde que substitui e complementa o cuidado prestado em outro ponto da Rede de Atenção à Saúde.
- D o Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) deverá estar integrado ao Sistema de Regulação Médica, sem ser referência para a Rede de Atenção às Urgências.

4000110646

Questão 88 Financiamento na Lei complementar n 1412012

A Lei Complementar 141/2012 definiu os percentuais mínimos de aplicação da receita própria dos entes federados (município, estado e união), no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa vinculação das receitas das três esferas de governo para os gastos em ações e serviços de saúde foi importante, porque comprometeu a participação tripartite, no financiamento da política pública de saúde. A análise das três situações hipotéticas apresentada no gráfico 1 permite afirmar que



- A na situação C os entes federados aplicaram o exigido pela legislação.
- B na situação B o estado não aplicou o exigido pela legislação.
- C nas três situações os estados aplicaram o exigido pela legislação.
- D nas situações A e C os municípios não aplicaram o exigido pela legislação.

4000110622

Questão 89 Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

O médico de família e comunidade comentou com a sua equipe que, nos últimos 10 anos ele vem trabalhando com o crescimento e com as mudanças que ocorreram na vida da população adscritiva à sua Unidade de Saúde da Família (USF). Referiu ainda que ao andar pelo território da USF é abordado por vários membros da comunidade que querem discutir com eles as suas condições de saúde. O atributo-chave da APS relacionado ao relato do médico de família e comunidade é

- A longitudinalidade.
- B integralidade.
- C competência cultural.
- D coordenação.

4 000110514

Questão 90 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

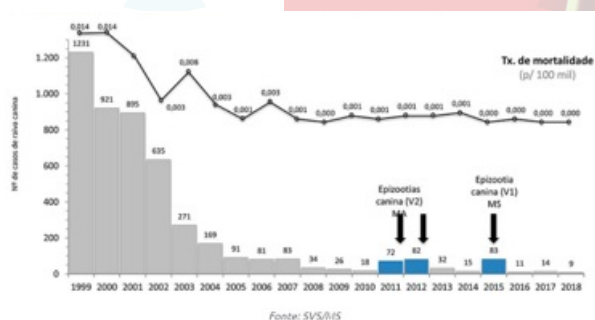
Você é médico(a) de família e comunidade e faz parte de uma equipe da Estratégia Saúde da Família. Semanalmente, um psiquiatra vêm até sua unidade para discutir casos complexos e realizar ações de educação permanente em saúde mental. Eventualmente, você também entra em contato, por telefone, com o psiquiatra sobre o manejo de pacientes com quadros agudos. O processo de trabalho descrito acima e a estratégia criada pelo Ministério da Saúde em 2008 são, respectivamente:

- A matriciamento e Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.
- B telessaúde e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
- C telessaúde e Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.
- D matriciamento e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

4 000110481

Questão 91 Epidemiologia

A figura abaixo representa a situação da raiva canina e da mortalidade em humanos decorrente de raiva em uma série de 20 anos, no Brasil. A observação da figura permite concluir que em relação ao Brasil:



- A embora com baixos valores de mortalidade nos últimos anos, a raiva humana adquirida a partir de cães permanece como grave problema de saúde.
- B o número de casos de raiva humana adquirida a partir de cães vinha caindo desde 1999, porém sofreu elevação em alguns anos recentes.
- C epizootias de raiva ocorridas entre cães em anos recentes não impactaram significativamente o número de casos em humanos.
- D o ano de 2018 mostrou o número mais reduzido de casos de raiva humana adquirida a partir de cães.

4 000110449

Questão 92 Imunidade de rebanho

Você trabalha como médico(a) em uma Unidade de Saúde da Família e está fazendo uma visita domiciliar a uma família composta pelo pai, a mãe e 1 filho de 11 anos. Você observa que a criança não recebeu o reforço da vacina dT, que deveria ter sido dada aos 10 anos, e pergunta aos pais por quê. Eles lhe respondem que acreditam que, se as demais crianças da escola forem todas vacinadas, indiretamente, o seu filho estará protegido. Sendo assim, preferem não expor a criança à dor e ao desconforto causados por essa vacina. Com base nos seus conhecimentos sobre imunização, assinale a resposta mais adequada a ser dada a esse casal.

- A Você concorda com a observação do casal sobre o fenômeno "imunidade de rebanho", mas alerta-os que a criança poderá encontrar pessoas doentes fora do ambiente da escola.
- B Você discorda da observação do casal sobre o fenômeno "imunidade de rebanho", mas aceita a opinião dos pais e a sua liberdade de escolher o que acreditam ser melhor para seus filhos.
- C Você concorda com a observação do casal sobre o fenômeno "imunidade de rebanho", mas os esclarece que se muitos pensarem da mesma forma, a proteção pode deixar de existir.
- D Você discorda da observação do casal sobre o fenômeno "imunidade de rebanho" e os esclarece que se a criança não for vacinada, ela não estará protegida contra as doenças alvo dessa vacina.

4000110389

Questão 93 Tipos de Estudos Epidemiológicos

O gráfico abaixo foi extraído de um estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA) para investigar a possível associação entre o escore Brady de 50 estados americanos em 2014 e a taxa de mortalidade infantil por acidentes com arma de fogo em 2014-2015. O escore em questão avalia quão restritiva é a legislação estadual a respeito do acesso e porte de armas de fogo e varia de -100 (menos restritiva) a +100 (mais restritiva). Com base nos seus conhecimentos sobre epidemiologia, assinale a alternativa correta.

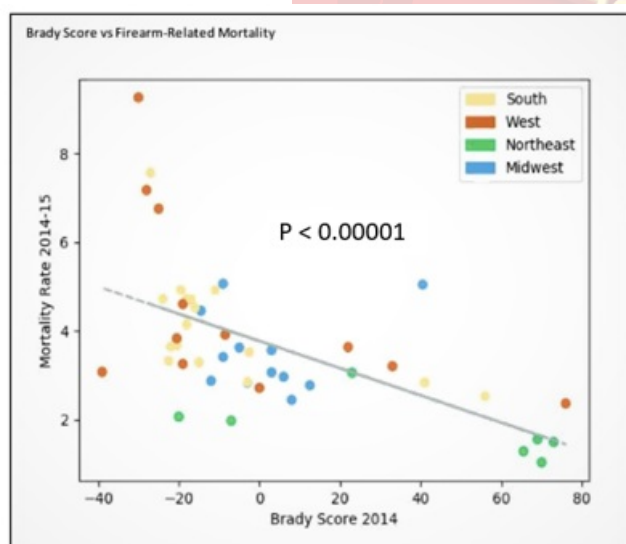


Figure 3. Relationship between Brady score (2014) and firearm-related mortality rate by state and region.

- A Nesse estudo ecológico, detecta-se uma relação direta entre a restrição ao acesso de armas e a mortalidade infantil por armas de fogo.
- B Nesse estudo ecológico, detecta-se uma relação inversa entre a restrição ao acesso de armas e a mortalidade infantil por armas de fogo.
- C Nesse estudo de coorte retrospectivo, detecta-se uma relação direta entre a restrição ao acesso de armas e a mortalidade infantil por armas de fogo.
- D Nesse estudo de coorte retrospectivo, detecta-se uma relação inversa entre a restrição ao acesso de armas e a mortalidade infantil por armas de fogo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110280](https://www.4000110280.com.br)

Questão 94 **Pediatria** **Imunoglobulina antisarampo**

Uma gestante de 22 anos, no segundo trimestre de gravidez, trabalha como babá de uma criança de 2 anos. Todos os dias a criança vai para escola de manhã e fica com essa babá, no período da tarde. Na segunda-feira, a babá chega para trabalhar e os pais da criança informam que a criança está com sarampo. Entretanto, eles precisam trabalhar e pedem para a babá ficar cuidando da criança. A babá com receio de perder o emprego decide ficar. No dia seguinte, conversando com uma vizinha, a babá fica preocupada de ter se infectado com o vírus do sarampo. Ela mora na cidade há apenas 2 anos. Sempre morou na "roça" e não se lembra se tomou vacina contra o sarampo. Ela também não tem cartão de vacinas. No cartão de pré-natal consta apenas a vacina de tétano, que tomou no início da gestação. Decide, então, procurar seu médico de família e comunidade na unidade próxima de sua casa. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que descreve a melhor conduta a ser tomada pelo médico de família e comunidade.

- A Prescrição de imunoglobulina.
- B Observação clínica e tratamento de suporte.
- C Prescrição de vacina tríplice viral e imunoglobulina.
- D Prescrição de vacina tríplice viral.

4000110225

Questão 95 **Aspectos Clínicos** **Quadro clínico**

Criança com 5 anos de idade vem à Unidade de Saúde da Família acompanhada pela mãe que informa que a criança iniciou com quadro de febre alta há 2 dias e inapetência. Foi ao pronto atendimento, onde informaram que a criança estava com infecção de vias aéreas superiores e foi prescrito apenas antitérmico e soro fisiológico nasal. Hoje, a mãe informa que a criança começou com manchas vermelhas no corpo que irradiaram para os braços e pernas. Ao exame apresenta bom estado geral, temperatura de 38,5 °C e eupneico. Otoscopia sem alterações. Na cavidade bucal observa-se hiperemia lingual e orofaringe com presença de exsudato purulento. Ao exame da pele, apresenta um exantema micropapular no tronco e membros com textura de lixa. Não apresenta sinais meníngeos e demais órgãos e sistemas estão preservados. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A Doença de Kawasaki.
- B Sarampo.
- C Eritema infeccioso.
- D Escarlatina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110190](https://www.4000110190.com.br)

Questão 96 **Política Nacional de Atenção Básica PNAB** **Política Nacional de Humanização**

Uma paciente jovem procurou a Unidade da Saúde da Família (USF), perto do final do expediente, com uma queixa de dor lombar que se iniciou há, aproximadamente, um mês. Ao chegar, percebeu que a USF estava lotada. Esperou alguns minutos e foi atendida por um membro da equipe que checkou os seus dados, perguntou sobre o seu problema, se apresentava outras queixas e avaliou seus sinais vitais (pressão arterial, pulso e temperatura), que estavam dentro dos padrões normais. O membro da equipe explicou à jovem que a agenda do médico estava sem vagas, naquele momento, mas que ele poderia agendar uma consulta para o próximo dia, tendo em vista, as características de seu problema e ela pertencer ao território da USF. A ação específica do membro da equipe de saúde nesta situação denomina-se

- A trabalho em equipe multiprofissional.
- B adscrição de clientela.
- C acolhimento com classificação de risco.
- D acesso avançado em saúde.

4000110152

Questão 97 **Acidentes por lagartas** **Manifestações clínicas** **Contra preços abusivos**

Você atende um paciente de 20 anos que estava caminhando na beira do rio, quando encostou em um galho de árvore e sentiu uma ardência e dor em queimação no braço direito. A pele ficou com eritema e edema na região de contato, evoluindo com lesões puntiformes eritematosas nos pontos de inoculação das cerdas. O paciente apresentou apenas lesões locais e foi orientado a lavar o local com água corrente e colocar compressas geladas. Qual a principal complicação causada pelo envenenamento das cerdas das lagartas deste gênero?



- A Agitação psicomotora.
- B Contraturas musculares intermitentes.
- C Arritmia cardíaca.
- D Manifestações hemorrágicas.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000110110

Questão 98 **Estratificação do risco cardiovascular global e metas terapêuticas**

Você é médico(a) de família e comunidade em uma Unidade de Saúde da Família e seu primeiro paciente do dia é um homem. Ele vem sem queixas para uma consulta de rotina agendada previamente. Ele tem 59 anos, é hipertenso controlado e nunca teve eventos cardiovasculares. Faz uso de losartana 50 mg/dia e ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/dia. É ex-tabagista, parou há 16 anos. Apresenta exame físico normal. Você como médico(a) de família e comunidade calculou o risco para eventos cardiovasculares em 10 anos e o resultado foi de 9,4% (risco intermediário). Neste contexto, qual a melhor

conduta em relação ao uso do AAS?

- A Retirar, pois o paciente não apresenta alto risco cardiovascular.
- B Retirar, pois o uso de AAS profilático é apenas para prevenção secundária.
- C Manter, pois todo homem hipertenso acima de 50 anos deve fazer uso.
- D Manter, pois todo homem acima de 50 anos deve fazer uso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110048](#)

Questão 99 Doença do Refluxo Gastroesofágico DRGE

Você atua como médico(a) de família e comunidade em uma Unidade de Saúde da Família e atende um paciente do sexo masculino de 45 anos, que apresenta queixa de dor de garganta há 4 semanas. Relata que a dor é mais intensa do lado esquerdo da garganta e tem caráter intermitente, sendo mais pronunciada no período da noite e mais branda durante o dia. Relata também que, eventualmente, tem sofrido de rouquidão, no mesmo período. Nega outras queixas. Refere o consumo de 3 latas de cerveja por dia e tabagismo de ½ maço dia há 25 anos. No exame físico, você identifica um paciente em bom estado geral e obeso, com índice de massa corporal de 32 kg/m². No exame da cavidade oral, você observa discreta hiperemia na orofaringe, mais pronunciada à esquerda, sem outras alterações. Qual seria então a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso?

- A Angina de Plaut Vincent.
- B Carcinoma espinocelular de orofaringe.
- C Mononucleose infecciosa.
- D Doença do refluxo gastresofágico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109990](#)

Questão 100 Hiperaldosteronismo

Homem, 29 anos, refere ganho de peso progressivo e diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica e apneia obstrutiva do sono há 6 meses. Em uso de hidroclorotiazida, anlodipina e enalapril. Exame físico: peso = 79 Kg; estatura = 162 cm; IMC = 30kg/m²; PA = 160 x 100 mmHg; FC = 72 bpm. Demais sem alterações. Exames laboratoriais: Na = 141 mmol/L; K = 2,9 mmol/L; creatinina = 0,9 mg/dL; urina rotina normal; cortisol pós 1 mg de dexametasona = 1,8 mcg/dL (VR < 2); IGF-1 = 150 ng/mL (VR 83-259). Qual é a investigação diagnóstica mais indicada?

- A Metanefrinas urinárias fracionadas.
- B Aldosterona e renina plasmáticas.
- C GH no teste de tolerância à glicose.
- D Cortisol livre urinário em 24 horas

Essa questão possui comentário do professor no site [4000042588](#)

Respostas:

1	B	2	A	3	D	4	C	5	D	6	A	7	D	8	A	9	A	10	C	11	C
12	C	13	C	14	C	15	A	16	C	17	A	18	A	19	D	20	A	21	B	22	A
23	A	24	A	25	A	26	A	27	C	28	B	29	D	30	D	31	D	32	D	33	A
34	B	35	A	36	B	37	B	38	A	39	A	40	A	41	C	42	C	43	C	44	C
45	B	46	D	47	B	48	B	49	C	50	D	51	D	52	C	53	B	54	C	55	A
56	A	57	A	58	A	59	B	60	A	61	C	62	B	63	D	64	C	65	A	66	C
67	D	68	C	69	C	70	B	71	A	72	A	73	D	74	C	75	D	76	B	77	B
78	A	79	A	80	D	81	C	82	D	83	B	84	A	85	A	86	A	87	C	88	A
89	A	90	D	91	C	92	D	93	B	94	A	95	D	96	C	97	D	98	A	99	D
100	B																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.



Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 **Síndrome do Túnel do Carpo**

Mulher de 52 anos, costureira, há 6 meses com dor e parestesias nos dedos mediais da mão direita, especialmente ao realizar atividades manuais, chegando inclusive a deixar cair objetos. Ao exame físico, apresenta perda de sensibilidade tátil dolorosa do 1º ao 3º dedos desta mão, com preservação da força e sem atrofia muscular. Os reflexos tendíneos dos membros superiores encontram-se simétricos, com sinal de Phalen e sinal de Tinel presentes à direita. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Síndrome do túnel do carpo.
- B Síndrome do canal de Guyon (mononeuropatia ulnar).
- C Radiculopatia cervical.
- D Síndrome do desfiladeiro torácico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144329

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.**Questão 2** **Medicina Preventiva** **Epidemiologia**

Quando se compara a distribuição de malária no Brasil de acordo com a região de ocorrência, verifica-se que aproximadamente 99% dos casos localizam-se na Amazônia. Entretanto, o coeficiente de letalidade na região extra amazônica chega a ser 128 vezes mais elevado. A explicação para isso repousa no seguinte fato:

- A Subnotificação acentuada de óbitos por malária na região amazônica.
- B Menos recursos para diagnóstico e tratamento da doença fora da Amazônia.
- C Casos mais graves são vistos com mais frequência na área fora da Amazônia.
- D Maior probabilidade de retardo no diagnóstico fora da Amazônia.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144328

Questão 3 **Semiologia do joelho**

Um homem de 35 anos, vem à Unidade de Saúde da Família queixando-se de dor no joelho direito ao deambular e sem irradiação. Nega trauma prévio e relata algumas crepitações. O exame não mostrou derrame articular, edema, rubor ou calor. A força e mobilidade estavam preservadas. Você então resolve realizar algumas manobras para investigar a presença de lesões nas estruturas do joelho. Ao exame físico você decide realizar a manobra representada pela figura abaixo. Este teste é mais sensível para avaliar qual estrutura anatômica descrita abaixo?



Figura da manobra realizada no exame físico

- A Tendão poplíteo.
- B Ligamento cruzado anterior.
- C Menisco medial.
- D Ligamento colateral lateral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144327](#)

Questão 4 Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

A médica de família e comunidade (MFC) foi transferida para uma Unidade de Saúde da Família (USF) e após ter sido apresentada à equipe, manifestou interesse em conhecer o território vinculado à USF. Durante o deslocamento pelo território, observou as suas características geográficas, ambientais, os equipamentos sociais disponíveis (creches, escolas, igrejas, associações, organizações não governamentais), a situação de saneamento do bairro e a disponibilidade de transporte público e de energia elétrica. Solicitou também à enfermeira da equipe os dados demográficos, de morbidade e de mortalidade da população adscrita. Ainda, decidiu participar de uma reunião do Conselho Local de Saúde para se apresentar à comunidade. Na reunião semanal da equipe ela propôs, a partir da análise das informações levantadas, a elaboração do planejamento das ações voltado às principais necessidades de saúde daquela população. A atitude da MFC está relacionada ao atributo da Atenção Primária à Saúde denominado

- A competência cultural.
- B planejamento estratégico.
- C primeiro contato.
- D orientação comunitária.

4000144326

Questão 5 Diagnóstico Pediatria Constipação funcional

Paciente, sexo feminino, 5 anos de idade, apresenta história de constipação intestinal desde 2 anos de idade. No início evacuava a cada 3 dias, mas este intervalo foi aumentando, atualmente evacua a cada 15 dias, fezes calibrosas, dolorosas, às vezes com estrias de sangue. Nega febre e perda de peso. Apresenta escape fecal diário, há 6 meses. Ao exame físico: peso e estatura no percentil 25. Não apresenta distensão abdominal importante, mas palpa se uma massa em hipogástrio, móvel, chegando a 3 cm abaixo da cicatriz umbilical, não dolorosa. A inspeção do ânus, observou-se pequena fissura anal a 6 horas. Qual sua hipótese diagnóstica?

- A Constipação intestinal crônica funcional.
- B Constipação orgânica secundária a tumor de cólon.
- C Constipação intestinal crônica não retentiva.
- D Pseudo obstrução intestinal crônica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144325](#)

Questão 6 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Na última reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) os secretários de saúde discutiram sobre o modelo de organização da Atenção Primária à Saúde (APS) a ser implantado na região de saúde. Um dos gestores defendeu a

implantação de um modelo dirigido à atenção materno infantil e às doenças infecciosas, com foco em populações em situação de vulnerabilidade. O modelo proposto por um dos gestores trata-se de uma abordagem de APS:

- A Seletiva, com uma oferta restrita de intervenções custo efetivas.
- B Hierarquizada, um nível para o acesso aos demais pontos da rede.
- C Resolutiva, com amplo espectro de serviços clínicos e preventivos.
- D Integral, com a perspectiva de atender às necessidades de saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144324](https://www.4000144324.com.br)

Questão 7 Medidas de saúde coletiva COVID 19

Um inquérito soro epidemiológico domiciliar sobre a infecção por SARS-CoV-2 foi implementado em uma amostra de 709 pessoas representativa da população de um município de grande porte, em junho de 2020. Os números obtidos nesse inquérito foram então confrontados com os dados oficiais da Vigilância Epidemiológica municipal sobre a Covid-19, o que deu origem à figura de um iceberg ilustrada abaixo. Considerando essas informações epidemiológicas, assinale a alternativa correta.



- A A figura indica que os profissionais da saúde da cidade não estão notificando adequadamente os casos de Covid-19, ocasionando a subnotificação e o subdimensionamento da pandemia.
- B A mortalidade estimada pelo gráfico deve ser superior aquela estimada pelos dados oficiais da vigilância epidemiológica, uma vez que o inquérito incluiu casos não identificados pela mesma.
- C A letalidade estimada pelo gráfico deve ser superior àquela estimada pelos dados oficiais da vigilância epidemiológica, uma vez que o inquérito incluiu casos não identificados pela mesma.
- D A figura explica em parte o sucesso da propagação do vírus, uma vez que a grande maioria dos infectados não é detectada pelos serviços de saúde, continuando a disseminá-lo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144324](https://www.4000144324.com.br)

Questão 8 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

A agente comunitária de saúde durante a visita domiciliar orienta que a usuária da Unidade de Saúde da Família (USF) beneficiária do Programa Bolsa Família, a levar as suas filhas de 6 meses e 4 anos à USF, para a avaliação da situação vacinal e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, pela equipe de saúde. A mãe confirma que irá à USF e comenta que a filha mais nova perdeu peso neste último mês. A ação da equipe de Saúde da Família no Programa Bolsa Família está relacionada, principalmente, a que princípio do Sistema Único de Saúde?

- A Universalidade.
- B Igualdade.
- C Integralidade.
- D Equidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144322](#)

Questão 9 **Pediatria** **Programa Nacional de Imunizações**

Criança de 15 meses de idade comparece à sala de vacinas da unidade básica de saúde para atualizar a sua situação vacinal. Antecedentes: saudável, porém há dois meses apresentou reação anafilática após a ingestão de alimento contendo ovo. Recebeu todas as vacinas previstas pelo calendário do Programa Nacional de Imunizações até um ano de idade. Legenda: VOP: vacina oral poliomielite VIP: vacina inativada poliomielite. As vacinas que a criança deverá receber hoje são:

- A Tríplice bacteriana acelular, hepatite B, H. influenzae tipo B, VOP, hepatite A e tetra virai.
- B Pentavalente, VOP, hepatite A.
- C Tríplice bacteriana acelular, hepatite B, H. influenzae tipo B, VIP, hepatite A e tríplice virai.
- D Pentavalente, VOP, hepatite A e tetra virai.

4000144321

Questão 10 **Psicofarmacologia** **Antidepressivos**

D.E.S, 34 anos, sexo feminino, apresenta história de dois episódios depressivos graves há mais de 10 anos, conforme a Classificação Internacional das Doenças-10 (CID 10). Esses episódios depressivos anteriores só melhoram com o uso de medicação psicotrópica, que nem a paciente, nem seus pais, nem a sua companheira sabem quais foram. Atualmente, está amamentando o seu filho de 3 meses e começou a apresentar humor deprimido e anedonia diariamente, diminuição do apetite, diminuição da motricidade, sonolência excessiva, dificuldade de concentração para realizar as atividades cotidianas e diminuição da autoestima. Nega ideação suicida ou ideias de morte. Está com diminuição da sua capacidade de cuidar da casa e da criança. Qual é a conduta medicamentosa mais adequada para essa paciente?

- A Amitríptilina 75 mg/dia.
- B Lítio 900 mg/dia
- C Sertralina 50 mg/dia.
- D Mirtazapina 60 mg/dia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144320](#)

Questão 11 **Hiperaldosteronismo** **Hiperaldosteronismo** **Hiperaldosteronismo primário**

Você trabalha como médico em uma unidade de saúde da família e atende um paciente caucasiano de 35 anos, previamente hígido, e que vem sofrendo episódios semanais de cefaleia occipital associados a níveis pressóricos elevados (PAS entre 160 e 180 mmHg, PAD entre 100 e 120 mmHg) nos últimos 3 meses. Vem em uso de losartana 50 mg 1x ao dia regularmente há 1 mês, tendo obtido discreta redução dos níveis pressóricos. No exame físico, você identifica paciente em bom estado geral, com índice de massa corporal = 25, FC = 72bpm, PA = 182 x 122 mmHg, sem outras alterações. O paciente lhe traz os seguintes exames laboratoriais, colhidos na mesma semana da consulta. Resultados laboratoriais do paciente. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que indica a melhor conduta para esse paciente.

Resultado Laboratoriais do Paciente Valores de Referência

Creatinina: 0,95 mg/dL	0,7-1,3 mg/dL
Sódio: 145 mEq/L	135-145 mEq/L
Potássio: 3,4 mEq/L	3,5-5,0 mEq/L
Glicemia de jejum: 95 mg/dL	70-99 mg/dL
Colesterol total: 220 mg/dL	< 200 mg/dL
Colesterol HDL: 35 mg/dL	> 45 mg/dL
Triglicérides: 145 mg/dL	< 150 mg/dL

Urina rotina: pH 6,0; proteína negativa pH 5-7, proteína negativa

- A Troca da losartana por amlodipina 10 mg/dia e solicitação de ultrassom doppler de artérias renais.
- B Aumento da losartana para 100 mg/dia, associação de hidroclortiazida 25 mg/dia e solicitação de curva pressórica.
- C Aumento da losartana para 100 mg/dia, solicitação de eletrocardiograma e ecocardiograma.
- D Troca da losartana por amlodipina 10 mg/dia, solicitação de aldosterona e atividade de renina plasmáticas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144319](#)

Medicina Livre

Contra preços abusivos

na medicina

Questão 12 Financiamento em Saúde Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Na última reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) foi discutido o novo modelo de financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS). O Secretário Municipal de Saúde e os demais conselheiros estavam preocupados com a possibilidade de redução de recebimento dos recursos financeiros federais, caso o município não atendesse às exigências do Ministério da Saúde. Assim, pensando na estrutura de financiamento deste novo Programa, o CMS deliberou que o gestor municipal da saúde deveria agir, rapidamente, reorganizando a APS. Considerando o novo programa de incentivos financeiros federais, a principal medida que o gestor de saúde deve implementar em seu município é:

- A Cadastrar a população para atingir o limite de pessoas por equipe de saúde.
- B Implantar a estratégia consultório na rua para atender a população vulnerável.
- C Avaliar o desempenho de suas equipes por meio de indicadores de saúde.
- D Aumentar a cobertura da Estratégia Saúde da Família em seus municípios.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144318](#)

Questão 13 Estudos de Caso Controle

Em um estudo buscou-se analisar a associação entre a infecção/doença pelo Zika vírus e a ocorrência de microcefalia em recém-nascidos de mães que apresentaram a doença durante a gestação. Os pesquisadores selecionaram um grupo de crianças com microcefalia e um grupo de crianças sem microcefalia, submetendo todos à realização de sorologia (IgG) contra o Zika vírus. Os resultados são mostrados na tabela a seguir: Tabela crianças que foram submetidas a sorologia (IgG) contra o Zika vírus. Diante dos resultados, pode se concluir que:

	Microcefalia		
IgG contra Zika vírus	Sim	Não	Total
Positivo	170	55	225
Negativo	100	215	315
Total	270	270	540

Odds Ratio = 6,65 (IC95%: 4,52 – 9,77).

- A Trata-se de um estudo caso controle e houve associação significativa entre a sorologia positiva contra o Zika vírus e a microcefalia.
- B Trata-se de um estudo ecológico e não houve associação significativa entre a sorologia positiva contra o Zika vírus e a microcefalia.
- C Trata-se de um estudo de coorte e houve associação significativa entre a sorologia positiva contra o Zika vírus e a microcefalia.
- D Trata-se de um estudo transversal e não houve associação significativa entre a sorologia positiva contra o Zika vírus e a microcefalia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144317](https://www.4000144317.com.br)

Questão 14 Infecções das Vias Aéreas Superiores Pediatria

Menina de 2 anos vem ao consultório do pediatra com queixa de apresentar episódios de coriza, febre, odinofagia e vômitos, diagnosticados como faringites, com frequência de 6 vezes ao ano desde os 8 meses de vida. Refere obstrução nasal, espirros e tosse seca ocasionalmente. Apresenta bom ganho de peso. Nega necessidade de antimicrobianos para tratamento das infecções. Entrou na escola com 6 meses de idade. Calendário vacinal: atualizado, com exceção da vacina contra meningococos ACWY. Baseado neste caso clínico, assinale a alternativa correta. Trata-se de uma paciente com infecções de repetição, provavelmente devido.

- A à doença do refluxo gastroesofágico.
- B à rinite alérgica.
- C ao atraso vacinal.
- D à exposição escolar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144317](https://www.4000144317.com.br)

Questão 15 Vigilância em Saúde

Paciente com 35 anos de idade, lavrador, feriu-se com uma enxada durante o trabalho. Ao exame verificou-se ferimento cortante profundo na perna direita. Foi feita a limpeza do local do ferimento e realizado curativo oclusivo. Ao ser verificada a carteira de vacinação, viu-se que o paciente tinha sido vacinado contra o tétano com 2 doses de vacina dT (dupla adulto, difteria e tétano) há 12 anos. Com essas informações qual seria a conduta profilática recomendada em relação ao paciente, diante de sua situação vacinal?

- A dT três doses.
- B dT uma dose e soro antitetânico (SAT).
- C dT uma dose.
- D Soro antitetânico (SAT) uma dose.

4000144315

Questão 16 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Paciente com 60 anos de idade apresentava hipertensão arterial sistêmica há cerca de 30 anos, com tratamento irregular. Há cerca de dois anos, devido a um diagnóstico de cardiopatia hipertensiva, iniciou tratamento. Há dois anos tinha diagnóstico de câncer de próstata e fazia tratamento e acompanhamento regulares. Há dois meses, após exames, foi diagnosticado insuficiência cardíaca congestiva e, hoje, veio ao pronto socorro com quadro de edema agudo de pulmão, vindo a óbito. Ao preencher o atestado de óbito você assinalaria como Causa Básica do Óbito:

- A Neoplasia maligna de próstata.
- B Hipertensão arterial sistêmica.
- C Insuficiência cardíaca congestiva.
- D Edema agudo de pulmão.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144314](#)

Questão 17 Infecção de pele e partes moles Piodermites

Você trabalha como médico em uma Unidade de Saúde da Família e atende uma paciente de 45 anos, previamente hígida, que procura atendimento queixando-se de uma unha encravada no pé esquerdo há 1 semana. Você observa paciente em bom estado geral, afebril, com supuração no canto interno do hálux direito, flogose local intensa, estendendo-se até a região do metatarso correspondente. Não há outras alterações no exame físico. A paciente relata vacinação completa segundo calendário do Programa Nacional de Imunização, na infância. Legenda: PVP-1 Polivinil pirrolidona lodo. Diante desse quadro clínico, além da limpeza local, assinale a alternativa que contém a melhor conduta para esse caso:

- A Antissepsia com solução de PVP 1, prescrição de cefalexina via oral por 7 dias e 1 dose de reforço da vacina DPT.
- B Antissepsia com solução de clorexidina, prescrição de clindamicina via oral por 7 dias e 1 dose de reforço da vacina DPT.
- C Antissepsia com solução de clorexidina, prescrição de sulfametoxazol-trimetoprim via oral por 7 dias e 1 dose de reforço da vacina dT.
- D Antissepsia com solução de PVP 1, prescrição de amoxicilina + clavulanato via oral por 7 dias e 1 dose de reforço da vacina dT.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144313](#)

Questão 18 Obstetrícia Imunização na gestação

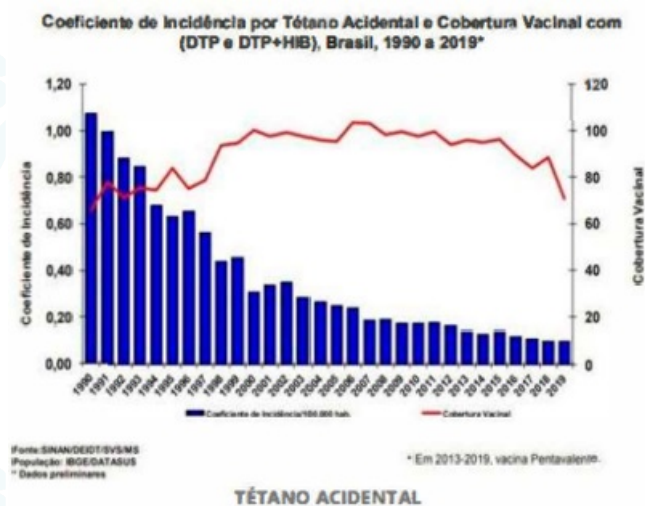
Paciente com 28 anos de idade, gestante com quatro meses de idade gestacional, procura unidade de saúde para completar seu esquema vacinal. Observando-se sua carteira de vacinação, verifica-se que a paciente nunca tomou vacina contra febre amarela, sendo que reside em uma área urbana, com alto índice de infestação predial por *Aedes aegypti* (10%), mas sem casos de febre amarela em humanos documentados nos últimos 12 meses. Com essas informações, qual seria a melhor conduta recomendada para a profilaxia da febre amarela?

- A Aguardar o término da gestação e o desmame da criança para indicar a vacina anti-tetânica.
- B Indicar a vacinação anti-tetânica imediatamente.
- C Aguardar o término da gestação e indicar a vacina anti-tetânica.
- D Aguardar o último trimestre da gestação e indicar a vacina anti-tetânica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144312](#)

Questão 19 Vigilância em Saúde

Considere a figura abaixo. A observação da figura permite concluir que:



- A Os elevados índices de cobertura vacinal a partir do final do século XX produziram uma grande imunidade de rebanho, que fez cair a ocorrência da doença no Brasil.
- B A manutenção de altos níveis de cobertura vacinal, no final do século XX e início do século XXI, produziu grande impacto na incidência do tétano acidental no Brasil.
- C Como o tétano é fortemente associado às condições de vida da população, o coeficiente de incidência independe da cobertura vacinal.
- D O aumento dos níveis de cobertura vacinal nos últimos anos da série poderá se refletir numa volta do número de casos no mesmo nível observado no início da década de 1990.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144311](#)

Questão 20 Rastreamento mamográfico

Mulher com 43 anos, G2P2, em consulta na Unidade de Saúde da Família, informa estar bem e que veio apenas pegar pedido para realizar um exame de mamografia para rastreamento do câncer de mama. Nega quaisquer antecedentes pessoais e familiares de alterações mamárias benignas ou malignas. Informa ter engravidado aos 27 e aos 30 anos e ter amamentado seus filhos por 15 meses cada um. Nega uso de qualquer medicação no momento ou no passado. O exame clínico das mamas é normal. Como você orientaria esta mulher de acordo com as diretrizes do SUS?

- A Forneceria os pedidos de mamografia seguindo a estratégia breast awareness (consciência da mama), uma vez que a mulher demonstra estar consciente para a saúde das mamas.
- B Forneceria o pedido de mamografia, considerando o rastreamento oportunístico, que oferece o exame a quem busca a unidade de saúde.
- C Orientaria que, neste momento, o rastreamento mamográfico não estaria indicado para sua faixa etária e seu perfil.
- D Orientaria que com 45 anos seria ofertado o rastreamento na modalidade organizado que convida formalmente as mulheres para o rastreamento.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144310

Questão 21 Medicina Preventiva Diferença entre sensibilidade e valor preditivo positivo

Probabilidade préteste e valor preditivo negativo

Rapidamente após o surgimento da Covid-19, testes de biologia molecular (RT-PCR) foram desenvolvidos para o diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2, em pacientes com sintomas clínicos sugestivos da doença. A sensibilidade desses testes oscila ao redor de 60-70% e sua especificidade ao redor de 99%. Com a evolução da pandemia, esses testes passaram a ser usados também para rastreias populacionais, com o intuito de identificar indivíduos com infecção assintomática e isolá-los para conter o avanço da doença. Considerando aspectos epidemiológicos dessa doença, assinale a alternativa que melhor comenta a conduta acima descrita.

- A A conduta tende a ser inefetiva, pois a especificidade do teste é muito alta para uso em rastreio populacional, ocasionando muitos resultados falsos positivos.
- B A conduta tende a ser efetiva, uma vez que o percentual de infectados assintomáticos é elevado e esses indivíduos também podem disseminar o vírus.
- C A conduta tende a ser inefetiva, pois a sensibilidade do teste é baixa para uso em rastreio populacional, ocasionando muitos resultados falsos negativos.
- D A conduta tende a ser efetiva, pois o potencial de disseminação interpessoal do vírus é muito elevado e sua letalidade é relativamente alta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144309

Questão 22 Transtorno Psicóticos Esquizofrenia

Há cerca de quatro meses, segundo descrição de sua esposa. B., 24 anos, começou a apresentar-se mais preocupado e nervoso, com frequência andando de um lado para o outro em casa, sem conseguir ficar parado muito tempo, falando que algo de ruim ia acontecer, sem saber explicar o que era essa coisa ruim; também começou a ter dificuldade para dormir (tanto para iniciar o sono, como acordando no meio da noite com frequência). Depois de cerca de 2 meses com esse quadro, começou a dizer que via e ouvia uma sombra ruim que queria fazer mal para as pessoas da casa e ter dificuldade para fazer suas tarefas profissionais, por que não conseguia se concentrar nessas atividades devido ao medo que ficava na cabeça o tempo todo. Depois de 3 meses, começou a descuidar de sua higiene, passando dias sem tomar banho e ficando trancado em seu quarto às vezes só aceitando comida por uma fresta da porta e comendo dentro dele. Há 1 semana falou, em um momento, que a esposa queria matá-lo, para ficar sozinha com a casa que tinha comprado. Não apresentou episódios de auto e/ou heteroagressividade. Nunca tinha tido nada parecido antes. O médico do serviço de Atenção Primária à Saúde realizou uma visita domiciliar e, como acompanhava B. desde a infância e ele confiava muito nele. B. aceitou iniciar algum tratamento para ver se conseguia se sentir melhor. Afora estar com a roupa desarrumada e higiene pessoal não muito boa, não foi contatado nenhuma alteração significativa no exame físico, nem descreveu outros sintomas além dos já descritos, Qual conduta medicamentosa mais adequada para esse paciente?

- A Clorpromazina 400 mg/dia e lítio 900 mg/dia.
- B Prometazina 50 mg/dia e fluoxetina 20 mg/dia
- C Clorpromazina 400 mg/dia e fluozetina 20 mg/dia
- D Haloperidol 2,5 mg/dia e diazepam 10 mg/dia

4000144308

Questão 23 Sensibilidade Especificidade

Diante da atual pandemia denominada COVID-19, há grande preocupação em diagnosticar com precisão casos da doença. Surgiu então a necessidade de se avaliar a acurácia de um teste rápido, realizado em amostras de sangue para detecção de IgM e IgG. Alguns pesquisadores ingleses realizaram um estudo (ver tabela a seguir), onde selecionaram 3.000 pessoas para serem testadas, sendo 1.500 com RT PCR (o teste padrão ouro) positivo e com sinais/sintomas da doença, e outras 1.500 com RT PCR negativo, esta assintomáticas. Diante dos resultados obtidos, a sensibilidade e especificidade do teste rápido fração IgM e IgG são, respectivamente: (OBS: calculadora disponível no canto superior direito da tela)

Teste rápido (IgM)	Positivo	Negativo	Total
Negativo	650	1250	1.900
RT-PCR (Padrão-ouro)			
Positivo	500	100	600
Total	1500	1500	3000

Tabela dos resultados do teste rápido e do RT-PCR.

- A 43,3% e 16,6%; 66,6% e 6,6%
- B 22,7% e 65,7%; 16,6% e 58,3%
- C 56,6% e 83,3%; 33,3% e 93,3%
- D 77,2% e 65,7%; 83,3% e 58,3%

4000144307

Questão 24 Pterígio

Um senhor de 56 anos, viúvo, trabalhador rural, vem à Unidade de Saúde da Família queixando-se que vem sentindo o olho direito (OD) mais irritado, vermelho e com a sensação de corpo estranho. Nega traumas no olho ou presença de prurido ou secreções. Ao exame, o paciente não apresenta alteração da acuidade visual, nem presença de corpo estranho. A figura abaixo ilustra o olho direito do paciente. Qual a hipótese diagnóstica mais provável para o caso clínico apresentado?

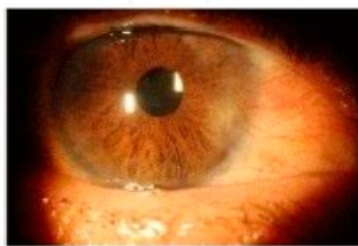


Figura do olho direito

- A Pterígio.
- B Hemorragia subconjuntival.
- C Esclerite.
- D Pinguécula.

4000144306

Questão 25 **Pediatria** **Erros inatos do metabolismo**

Recém-nascido de 15 dias de vida foi internado em uma UTI neonatal com quadro de icterícia, convulsões e insuficiência hepática. Vinha em uso de leite materno exclusivo. Exame físico: mau estado geral, icterícia ++/4, hepatoesplenomegalia, ascite e catarata. Os exames laboratoriais demonstraram: ALT (alanina aminotransferase) = 380 U/L (Valor de referência < 31 U/L); AST (aspartato aminotransferase) = 690 U/L (Valor de referência < 30U/L); Gama GT = 200 U/L (Valor de referência = 50U/L); INR (tempo de protombina) = 2,0; Bilirrubina total = 18,3 mg/dl; Bilirrubina direta (BD) = 10,0 mg/dl; Proteína total = 6,5 g/dl e albumina = 2,8 g/dl; Hemocultura: positiva para E. coli. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Colestase familiar intra-hepática progressiva (PFIC).
- B Atresia de vias biliares.
- C Galactosemia.
- D Colestase secundária a sepse por E.coli.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144305](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 26 **Higiene oral** **Pediatria** **Puericultura**

Mãe de lactente de seis meses vem para consulta de puericultura e pergunta como deve cuidar dos dentinhos do bebê que estão nascendo, pois o irmão mais velho teve várias cáries antes dos dois anos de idade. Qual orientação é a mais adequada?

- A Profilaxia com fluoreto tópico pelo dentista a partir da erupção do primeiro dente.
- B Suspender oferta de leite materno durante a noite para evitar cáries.
- C Escovação com dentífrico fluoretado a partir da erupção do primeiro dente.
- D Iniciar oferta de água de abastecimento público, que é fluoretada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144304](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 27 **Reumatologia Pediátrica** **Pediatria** **AIJ Artrite Idiopática Juvenil**

Menino branco, 7 anos, queixa-se de aumento de volume e dificuldade para mover o joelho direito, principalmente pela

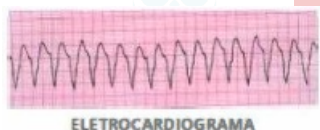
manhã, há 7 semanas. Ao exame, o médico nota que criança manca e observa presença de edema e limitação de movimentos em joelho direito. Não há outras queixas, nem outras alterações ao exame físico. Os únicos exames laboratoriais alterados são: FAN positivo (1 :160) e ASLO = 600U Todd (normal até 300U). A hipótese diagnóstica mais provável para esse menino é:

- A Artrite idiopática juvenil.
- B Febre reumática.
- C Lúpus eritematoso sistêmico.
- D Artrite séptica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144303](https://www.4000144303.com)

Questão 28 Emergências Pediátricas Parada Cardiorrespiratória PCR e Arritmias na Emergência **Pediatria**

Criança de 1 ano, vítima de acidente por submersão, é admitida na sala de emergência inconsciente, em apneia e sem pulso central. É iniciada massagem cardíaca imediatamente, colocado coxim sob o ombro, feita aspiração de vias aéreas superiores e fornecidas ventilações com bolsa-valva e máscara. A monitorização cardíaca mostra o seguinte: Qual é a conduta indicada?



ELETROCARDIOGRAMA

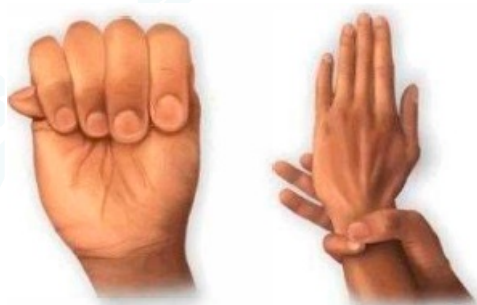
- A Administrar lidocaína 1 mg/kg endovenosa.
- B Realizar cardioversão sincronizada com 1 J/kg.
- C Administrar amiodarona 5 mg/kg endovenosa.
- D Realizar desfibrilação com 2 J/kg.



Essa questão possui comentário do professor no site [4000144302](https://www.4000144302.com)

Questão 29 Dissecção aórtica aguda **Síndrome de Marfan** **Síndrome de Marfan**

Mãe traz menino de 15 anos de idade ao consultório para solicitar atestado médico para a prática intensiva de basquete (5 vezes por semana; 2 horas por treino). Refere que ele é assintomático, e sempre foi alto e magro. No exame físico geral você detecta que o paciente tem pé chato, mede 190 cm, com envergadura de 200 cm e tem sinal de polegar e punhos, conforme figura anexa. O exame físico cardiovascular demonstra frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, pressão arterial em repouso de 110 x 70 mmHg e a ausculta evidencia 2 bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros. Baseado nestas informações, a conduta mais adequada seria:



SINAL DE POLEGAR E PUNHOS

- A Não liberação pelo risco de hipertensão pulmonar.
- B Liberação para atividade física.
- C Não liberação pelo risco de arritmia.
- D Não liberação pelo risco de dissecção de aorta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144301](#)

Questão 30 **Glomerulonefrite pósestreptocócica**

Menino de 9 anos de idade, com história de edema palpebral há 3 dias e urina avermelhada há 1 dia. Mãe refere que há 2 semanas seu filho utilizou amoxicilina, para dor de garganta, por 5 dias. Exame físico: peso 27 kg, estatura 129 cm, edema palpebral e de membros inferiores ++/4+, frequência cardíaca 70 bpm, pressão arterial 120 x 80 mmHg. Exames laboratoriais: ureia 60 mg/dl, creatinina 1,0 mg/dl. Hemograma: hemoglobina 10 g/dl, hematócrito 30%, leucócitos 12.000/ μ L e plaquetas 200.000/ μ L. Urina tipo1: densidade 1,018 e pH 5, proteína +++, campo tomado por hemácias e leucócitos. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa.
- B Nefrite intersticial aguda.
- C Síndrome nefrótica idiopática.
- D Infecção do trato urinário.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144300](#)

Questão 31 **Pediatria** **Corpo EstranhoEngasgo**

Criança de 4 anos ingeriu um prego por volta das 14 horas. Foi atendida em Unidade de Pronto Atendimento e submetida à radiografia simples (vide figura). Em seguida, foi encaminhada com o exame para tratamento definitivo em hospital terciário, onde foi admitida assintomática às 22 horas. Qual a próxima conduta?



RADIOGRAFIA SIMPLES

- A Observação por 24 a 48 horas.
- B Repetir a radiografia simples.
- C Endoscopia digestiva de urgência (em até 12 horas).
- D Endoscopia digestiva de emergência (em 2 a 6 horas).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144299](#)

Questão 32 PneumoniasBroncopneumonias BCP na Infância

Lactente, 6 meses, chega no pronto atendimento com queixa de quadro febril há 5 dias. Inicialmente apresentou temperatura de 38-38,5° (a cada 6 horas, que cedia com antitérmico, sem prostração. A febre passou a ocorrer a cada 8 horas e há 1 dia criança está com tosse seca e rinorreia hialina; sem outras queixas. Vacinação em dia, nega contato com pessoas doentes. Ao exame físico: temperatura axilar = 37,8° C; peso = 7 kg (escore-z O); comprimento = 61 cm (escore-z-2). Sem alterações cardíacas ou na ausculta pulmonar. Exames complementares: hemograma com hemoglobina = 9,9 g/dl; 27.000/μL glóbulos brancos (11 % bastões, 55% segmentados e 35% linfócitos) e proteína C reativa de 12 mg/dl (VR = até 0,5 mg/dl). Abaixo está o exame radiológico de tórax. Frente a esse caso, qual conduta a ser tomada?



RADIOGRAFIA DE TÓRAX

- A Internar e tratar por 48 horas com associação de amoxicilina + clavulanato endovenoso na dose de 50 mg/kg/dia cada 12 horas e completar 10 dias por via oral.
- B Tratar ambulatoriamente com amoxicilina oral na dose 50 mg/kg/dia fracionada em duas tomadas, por 10 dias completos.
- C Tratar ambulatorialmente com nebulizações, oseltamivir e azitromicina via oral por 5 dias e retornar para controle.
- D Internar e tratar por 48 horas com ampicilina endovenosa na dose 150 mg/kg/dia em 4 aplicações; depois completar 10 dias por via oral

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144298](#)

Questão 33 Transtornos Específicos de Aprendizagem

A escola solicitou à família de um aluno de oito anos uma avaliação médica por dificuldade de aprendizagem. A criança, desde a alfabetização, apresentava dificuldades na leitura e na escrita. Filho único, família nega problemas pré ou perinatais, genéticos ou médicos pregressos; teve marcos do desenvolvimento adequados. Dois tios e um primo maternos apresentaram histórico escolar semelhante. Atualmente, mesmo com reforço escolar há mais de 1 ano, permanece com leitura lenta, pausada, com esforço e dificuldade para compreensão de texto, inclusive de frases simples. Copia, mas escreve apenas letras ou sílabas, com erros. Não apresenta dificuldade para aprendizagem de matemática, artes ou para prática de atividade física. A avaliação do comportamento adaptativo estava dentro da normalidade. Na avaliação pela escala SNAP IV: pela professora pontuou 3 para desatenção e 1 para hiperatividade; pelos pais, 2 para desatenção e 1 para hiperatividade. Baseado nos dados acima, qual o diagnóstico inicial mais provável?

- A Transtorno do déficit de atenção e impulsividade.
- B Transtorno específico de aprendizagem.
- C Transtorno do desenvolvimento da coordenação.
- D Deficiência intelectual ligada ao X.

4000144297

Questão 34 Comunicação interatrial Pediatria

Paciente de 6 meses de idade, sexo masculino, vem à consulta de puericultura sem queixas no momento. Durante o exame físico você percebe sopro cardíaco sistólico de 2+/6 em bordo esternal esquerdo alto, sem irradiações e desdobramento fixo de B2. Ganho de peso limítrofe e restante do exame físico sem alterações. Qual a hipótese diagnóstica mais adequada a este caso?

- A Persistência do canal arterial.
- B Sopro inocente.
- C Comunicação interventricular.
- D Comunicação interatrial.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144296](https://www.4000144296.com)

Questão 35 Tratamento e Condutas Apresentação Clínica Pediatria

Avó materna refere que criança de 8 anos de idade iniciou, há 3 dias, com disúria, sem febre. Notou que nos últimos meses criança vem apresentando mudanças no comportamento, choro frequente, recusa-se a brincar com os amigos e por várias noites tem acordado com medo e assustada. Há 1 ano pais se separaram. Avó refere que nos últimos 6 meses criança já recebeu orientação para tratamento de infecção urinária por 3 vezes. Ao exame, nota-se hiperemia vulvar, com presença de lesão ulcerada em região de pequenos lábios à direita, aparentemente indolor, sem fissura anal ou outras lesões. Qual alternativa apresenta a melhor conduta?

- A Orientar banho de assento com permanganato de potássio para tratamento da vulvovaginite e, após o tratamento, colher exames de urina.
- B Solicitar exame de urina rotina e cultura de urina e agendar retorno para checar exames.
- C Encaminhar para atendimento multidisciplinar para avaliação de profilaxia e/ou tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e coleta de sorologias.
- D Coletar swab da secreção vaginal, iniciar antibioticoterapia para tratamento de infecção urinária e encaminhar para avaliação psicológica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144295](https://www.4000144295.com)

Questão 36 Tratamento nas crianças e adolescentes

Menino, 13 anos, apresenta dor abdominal, náuseas e vômitos há 6 horas. Tem poliúria, polidipsia e perda ponderal há 3 semanas. Ao exame: regular estado geral, desidratado, afebril, agitado, frequência respiratória 22 ipm, frequência cardíaca 102 bpm, pressão arterial 108 x 62 mmHg (adequada para idade e estatura), tempo de enchimento capilar de 2 segundos, pulsos amplos, sem alterações na ausculta pulmonar e cardíaca ou no exame do abdome e da genitália. Exames laboratoriais: Exames laboratoriais: Hemoglobina 15 g/dl; hematócrito 45%; leucócitos 13.000/μL; plaquetas 250.000/μL pH venoso: 7,29; pO₂ 38; pCO₂ 29; HCO₃ 14; base excess 6; Sat O₂ 68% Sódio: 136 mmol/L Potássio: 3,6 mmol/L Cloro: 102

mmol/L; Glicemia: 495 mg/dl; Cetonemia: 4,8 mmol/L (valor normal < 3); Ureia: 37 mg/dl; Creatinina: 0,72 mg/dl. Qual é a conduta inicial mais adequada para esse paciente?

- A Reposição de bicarbonato.
- B Aplicação de insulina.
- C Administração de antibiótico.
- D Hidratação endovenosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144294](https://www.4000144294.com)

Questão 37 Classificação **Pediatria**

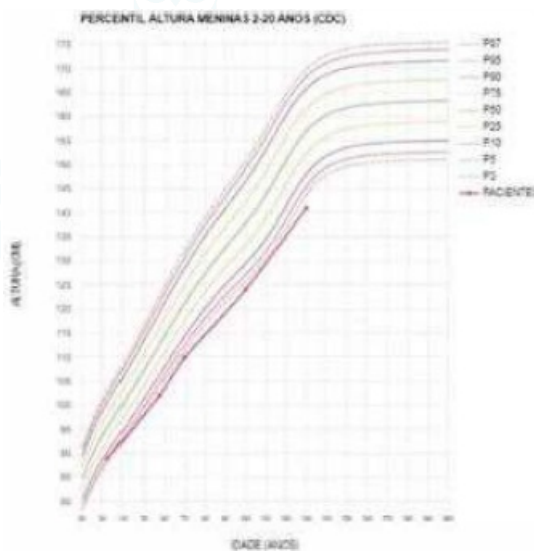
Criança de 5 anos de idade com peso estimado de 20 kg, foi atropelada por uma moto. Segundo equipe do resgate, criança foi encontrada no cenário, inconsciente, com escala de coma de Glasgow de 7, com múltiplas escoriações no corpo e hematoma subgaleal temporal à esquerda, sendo então prontamente intubada e transferida para sala de urgência de hospital terciário. Ao exame: criança intubada, sedada, pupilas mióticas e bradifotorreagentes, ventilada com bolsa valva-máscara com fluxo de 1 O litros de oxigênio/min. Subitamente, durante a monitorização, nota-se frequência cardíaca 160 bpm, pressão arterial 70 x 40 mmHg, saturação de O₂ 85%, pulsos periféricos finos e centrais palpáveis, tempo de enchimento capilar de 4-5 segundos. Na ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular está reduzido em hemitórax direito e hipertimpânico à percussão. Escolha qual das alternativas abaixo define melhor a condição de deterioração constatada na sala de urgência:

- A Choque distributivo.
- B Choque obstrutivo.
- C Choque hipovolêmico hemorrágico.
- D Choque neurogênico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144293](https://www.4000144294.com)

Questão 38 Baixa Estatura Patológica **Pediatria**

Uma paciente com 13 anos e 6 meses procura atendimento para avaliar seu desenvolvimento. Estuda no 7º ano com bom rendimento. Nega tratamento atual. Nega internações hospitalares ou cirurgias prévias. Refere alergia respiratória controlada e diversos episódios de otite média prévios. Desde os 9 anos de idade apresenta frequentes episódios de cefaleia bi-temporal intensa. Nega menarca e sua pubarca ocorreu há 2 anos. Tem uma irmã de 16 anos que é saudável, assim como seus pais, que não são consanguíneos e medem 164 cm (mãe) e 176 cm (pai). Apresenta peso de 39 kg (P1 O), estatura total de 144 cm, estatura sentada de 87 cm e seu estágio puberal (Tanner) é M1 P2. Trouxe dados de sua curva de crescimento (abaixo). Em avaliação em UBS haviam sido solicitados os exames complementares com seus resultados demonstrados abaixo (observação: VR = valor de referência normal para a idade): Idade óssea = 11 anos; TSH = 5,6 mUI/mL (VR = 0,5 a 4,5); LH = 16 mUI/mL (VR = 0,4 a 8); FSH = 35 mUI/mL (VR = 4,5 a 10). Além de anamnese e exame físico mais detalhado, diante dos dados apresentados acima, qual a conduta mais adequada para esta paciente nesse momento?



- A Solicitar dosagem de IGF 1, T4L, cortisol, prolactina e exame de ressonância magnética do encéfalo.
- B Observar a evolução clínica nos próximos 4 a 6 meses e reavaliá-la com novo exame de TSH e idade óssea.
- C Solicitar exame ultrassonográfico da tireoide.
- D Solicitar exame citogenético (cariótipo).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144292](https://www.4000144292.com.br)

Questão 39 Introdução às anemias microangiopáticas Pediatria Anemias Microangiopáticas

Criança eutrófica, negra, com 9 meses de idade e quadro de diarreia com sangue há 7 dias. Fez uso de ceftriaxona por 4 dias. Mãe refere que apesar da melhora da diarreia a criança está urinando menos e está mais irritada há um dia. Exames colhidos no pronto socorro: Hemograma: hemoglobina 6,8 g/dl, hematócrito 21%, leucócitos 17.000/ μ L, plaquetas 750.000/ μ L, reticulócitos 4%. Ureia 52 mg/dl e creatinina 1,2 mg/dl. Haptoglobina: 10 mg/dl (valor normal: 40-280 mg/dl). Urina tipo 1: densidade 1,011; pH 8,0; proteínas 150 mg/ml; nitrito negativo; hemácias 4 a 6 por campo; leucócitos 10 a 15 por campo; presença de heme pigmento. Com relação a etiologia da anemia, ela pode ser classificada como:

- A Ferropriva.
- B Hemolítica autoimune.
- C Microangiopática.
- D Falciforme.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144292](https://www.4000144292.com.br)

Questão 40 Pediatria Classificação e Tratamento da Crise

Menina de 12 anos de idade com diagnóstico de asma desde os 2 anos de idade, sem uso de medicações de forma contínua. Chega ao pronto socorro com tosse, chiado, dispneia e vômitos há 1 dia. Exame físico: temperatura axilar: 36,7° C; frequência respiratória: 38 rpm; frequência cardíaca: 118 bpm; Sat O₂ 91 %; pico de fluxo expiratório 40% do predito. Dispneia moderada com tiragens intercostais, de fúrcula e sibilos expiratórios. Consciente e acianótica. O tratamento inicial ideal para essa paciente seria o B2 agonista de ação curta inalatório

- A em doses elevadas e repetidas e, caso não haja resposta na primeira hora, corticoide endovenoso.
- B em doses elevadas e repetidas associado ao brometo de ipratropium e corticoide endovenoso.
- C em doses habituais e repetidas e, caso não haja resposta na primeira hora, corticoide endovenoso.
- D em doses habituais e repetidas associado à aminofilina endovenosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144290](#)

Questão 41 Transtorno do Espectro Autista TEA

Uma criança de três anos foi avaliada com queixa de atraso na fala. Ainda não falava, compreendia comandos verbais simples e, pouco frequentemente, apontava ou conduzia o responsável pela mão para ter suas solicitações atendidas. Marcos motores grosseiros foram adquiridos dentro da normalidade. Na escola, nos espaços públicos, tendia ao isolamento. Apresentava ainda hipersensibilidade aos estímulos auditivos, agitação, irritabilidade, dificuldades com mudanças na rotina e rompantes de comportamento e estereotípias motoras. Qual a principal hipótese diagnóstica para esse paciente?

- A Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
- B Deficiência auditiva.
- C Transtorno da linguagem.
- D Transtorno do espectro autista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144289](#)

Questão 42 Pediatria Tumores do Sistema Nervoso Central

Menino com 4 anos de idade, chega ao pronto socorro acompanhado da mãe que refere que o mesmo acorda queixando-se de dor de cabeça seguida de vômitos, há 20 dias. Há dois dias com piora importante. Ao exame físico: regular estado geral, sonolento, abertura ocular apenas quando solicitado, resposta verbal confusa, localiza dor (escala de coma de Glasgow de 12). Frequência cardíaca 56 bpm, pressão arterial sistêmica 123 x 82 mmHg (braço esquerdo, manguito apropriado para idade, valor acima do percentil 95+12 para idade e estatura). Sem outras alterações ao exame físico. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Meningoencefalite.
- B Síndrome da criança espancada.
- C Tumor em fossa posterior.
- D Intoxicação exógena.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144288](#)

Questão 43 Pediatria Doença de Kawasaki

Menina de 15 meses apresenta febre alta há uma semana, dois picos diários de até 39° C. Nesse período fez uso de ibuprofeno e amoxicilina por conta própria. Há dois dias refere conjuntivite bilateral não purulenta e edema de mãos. Nega alterações urinárias ou digestivas. Durante o exame físico você nota criança irritada, apesar de bom estado geral, com língua avermelhada, lesões de pele (foto abaixo) e gânglio fibroelástico de 2 cm cervical à direita. Pai trabalha em uma metalúrgica, na qual já tinham sido afastados dois funcionários com suspeita da Covid-19. Qual o tratamento imediato de escolha para essa paciente?



- A Pulso de metilprednisolona 30 mg/kg dose única.
- B Imunoglobulina humana 2 g/kg dose única.
- C Tocilizumabe 12 mg/kg dose única.
- D Vancomicina e ceftriaxona em doses habituais, empiricamente.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144287](https://www.4000144287.com)

Questão 44 **Massagem cardíaca** **Reanimação neonatal** **Neonatologia**

Gestação de 36 semanas evoluiu com trabalho de parto. Após amniorrexe espontânea foi observado hemoâmnio e indicado parto cesárea. Recém-nascido (RN) trazido ao berço devido hipotonia e apneia. Após os passos iniciais foi realizada ventilação com balão e máscara com ar ambiente por 30 segundos e com oxigênio titulado até 60%, além de revisada a técnica de ventilação. Como não houve melhora da frequência cardíaca e da respiração, optado por intubação orotraqueal. Após 30 segundos, foi revisada a técnica de ventilação e confirmada a posição correta da cânula, entretanto o RN permanecia em apneia e com frequência cardíaca de 50 bpm. Segundo as recomendações atuais, assinale a conduta imediata mais adequada.

- A Iniciar massagem cardíaca sincronizada com ventilação, com FiO_2 de 100%, por 60 segundos.
- B Aumentar a FiO_2 para 100% e realizar 40 a 60 ventilações por minuto por mais 30 segundos.
- C Aguardar a leitura da oximetria de pulso para reavaliar a frequência cardíaca.
- D Administrar adrenalina endovenosa na dose de 0,01 mg/kg.

Proibida Venda.

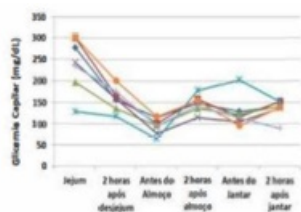
Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144286](https://www.4000144286.com)

Questão 45 **Insulinoterapia no tratamento do diabetes mellitus tipo 1**

Você avalia ambulatoriamente uma adolescente com 12 anos de idade, estatura de 151 cm (P50) e peso de 42 kg (P50), estágio de Tanner M3P2 e diagnóstico de diabetes melito tipo 1 há 5 anos. Seu esquema de insulinização está demonstrado na tabela abaixo. Sua concentração atual de HbA 1c é 8,9% e seu perfil glicêmico da última semana está demonstrado no gráfico abaixo. Com base nas metas glicêmicas e de HbA 1c, qual é a conduta terapêutica mais indicada nessa consulta para essa paciente nesse momento?

Insulina Horário	NPH	Regular
Desjejum	12	10
Almoço	8	10
Jantar	-	10
Antes de dormir	12	-



ESQUEMA DE INSULINIZAÇÃO E PERFIL GLICÊMICO DA ÚLTIMA SEMANA

- A Reduzir a dose insulina NPH noturna.
- B Aumentar a dose insulina NPH noturna.
- C Aumentar a dose de insulina NPH e de insulina regular da manhã.
- D Manter esse esquema de insulina e orientar importância da adesão ao tratamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [400014285](https://www.400014285.com.br)

Questão 46 Tratamento de Dor na Criança

Uma menina de 9 anos de idade, foi submetida no dia anterior à cirurgia para redução de fratura traumática em tíbia esquerda. Ela se queixa de dor intensa no local da cirurgia. Nas últimas 12 horas não recebeu nenhum medicamento, e há 1 hora recebeu uma dose endovenosa de dipirona (15 mg/kg). Ao exame físico, não há anormalidades na ferida cirúrgica ou no membro acometido, ou em qualquer outro sistema. Assinale a alternativa que contém a conduta imediata mais adequada para este caso.

- A Administrar uma dose de analgésico opioide.
- B Solicitar avaliação imediata do ortopedista.
- C Solicitar uma radiografia do membro acometido.
- D Administrar uma dose de anti-inflamatório não esteroidal.

Essa questão possui comentário do professor no site [400014284](https://www.400014284.com.br)

Questão 47 Sífilis congênita Pediatria

Menina de 5 dias de vida, pesando 3100 g, é trazida pela mãe com queixa que, desde há dois dias, notou que a mesma está com a cor da pele mais esbranquiçada e com manchas avermelhadas nas palmas das mãos e pés, além de olhos amarelados. Também, está recusando as mamadas no peito e parece que tem dores. Ao exame encontra-se em regular estado geral, pálida, hidratada, eupneica, chorosa ao toque, com lesões maculobolhosas em palmas das mãos e plantas dos pés. Percebe-se a presença de sopro sistólico ++/++++ no mesocárdio, hepatimetria de 8 cm, fígado endurecido e doloroso, baço palpável a 2 cm do rebordo costal esquerdo. Considerando a hipótese diagnóstica prioritária para esse caso, assinale a alternativa que contenha a ação que deve ser tomada inicialmente.

- A Perguntar se a mãe possui gatos em casa, se faz jardinagem ou se come carnes malcozidas.
- B Fazer o teste do coraçãozinho.
- C Verificar os resultados dos testes VDRL feitos durante o pré-natal.
- D Verificar o tipo sanguíneo e o resultado do teste de Coombs indireto da mãe.

Essa questão possui comentário do professor no site [400014283](https://www.400014283.com.br)

Questão 48 Fórmulas infantis Pediatría

Uma menina de 5 meses de idade foi amamentada exclusivamente ao seio até 15 dias atrás, pois a mãe voltou a trabalhar em tempo integral, inclusive ficando 3 dias por semana fora da cidade. No momento a criança fica com a avó e está recebendo leite de vaca pasteurizado sem diluição, cerca de 120 ml por mamada, a cada 3 horas, também de madrugada. A criança pesa 6 Kg, tem desenvolvimento adequado e não tem queixas. Você orienta a mãe que a fórmula infantil é mais adequada do que o leite de vaca, na falta do leite materno. Como você orientaria o preparo da fórmula infantil para esta lactente?

- A Preparar 120 ml de fórmula infantil diluindo 3 medidas do pó nesse volume de água.
- B Preparar 150 a 180 ml de fórmula infantil diluindo 5 medidas do pó em 150 ml ou 6 medidas em 180 ml de água.
- C Preparar 150 a 180 ml de fórmula infantil diluindo 3 medidas do pó em 150 ml ou 4 medidas em 180 ml de água.
- D Preparar 120 ml de fórmula infantil diluindo 4 medidas do pó nesse volume de água.

4000144282

Questão 49 Desnutrição Pediatría Diagnóstico Nutricional

Lactente, masculino, 7 meses de idade, vem à consulta no Posto de Saúde com queixa de recusa de alimentos e dificuldade de ganhar peso há 4 meses, logo após o desmame. Mãe trabalha na lavoura e criança é cuidada por uma vizinha. Aceita pequenos volumes da mamadeira, em torno de 2 vezes ao dia, bebendo várias mamadeiras de chá e 2 a 3 colheres de papa de arroz com caldo de feijão, uma vez ao dia. Gestaçāo e parto sem intercorrências. Peso de nascimento: 3280 gramas. Ao exame: pálido, ativo, hidratado. Subcutâneo escasso, musculatura hipotrófica, sem edema. Peso: 5950 gramas (peso esperado: 8450 g). Comprimento: 64 cm (comp. esperado: 70 cm). Estatura/idade = 91,5%: Peso/estatura para idade = 87,5%. Faça a avaliação do estado nutricional dessa criança.

- A Desnutrição proteico-calórica de IIº grau, kwashiorkor, secundária, crônica.
- B Desnutrição proteico-calórica de Iº grau, marasmo, primária, aguda.
- C Desnutrição proteico-calórica de Iº grau, marasmo, secundária, aguda.
- D Desnutrição proteico-calórica de IIº grau, marasmo, primária, crônica.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144281

Questão 50 Cardiotocografia intraparto Obstetrícia

Multigesta (G4P2A 1), 37 anos, interna na fase ativa do trabalho de parto espontâneo, com 37,5 semanas. Exame físico geral normal, altura uterina 37 cm. A evolução do trabalho de parto, até às 20h, está demonstrada no partograma (Figura 1). Nesse momento, a equipe decidiu por monitorizar o feto continuamente devido à ausculta de desacelerações de sua frequência cardíaca (Figura 2). Qual alternativa tem diagnósticos nesse cenário clínico?

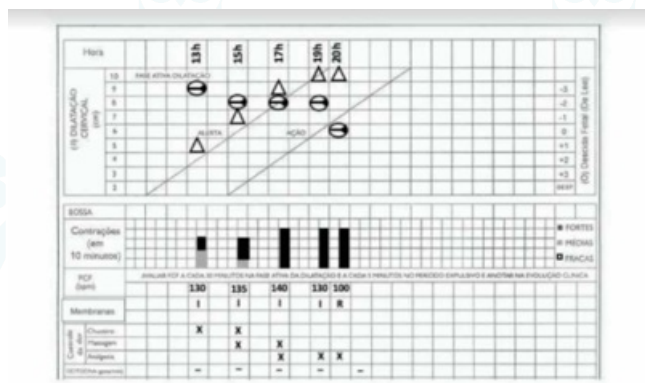


FIGURA 1: REGISTRO GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO

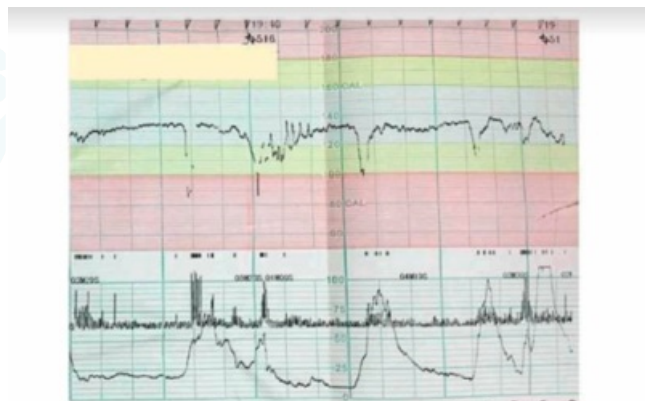


FIGURA 2: CARDIOTOCOGRAFIA INTRAPARTO OBTIDA ÀS 20 HORAS

- A Período expulsivo prolongado com asfixia fetal.
- B Trabalho de parto eutócico com suspeita de sofrimento fetal.
- C Distocia funcional com vitalidade fetal esperada para expulsivo.
- D Evolução normal do trabalho de parto com boa vitalidade fetal.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida venda. Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144280

Questão 51 Câncer de ovário

Mulher de 69 anos, queixando-se de discreto aumento do volume abdominal há quatro meses. Ao exame ginecológico palpa-se massa endurecida e aderida de 7 cm de diâmetro em região anexial esquerda. OCA 125 é de 380 UI/ml e a ultrassonografia transvaginal está representada na figura. Qual é a melhor conduta?



ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL

- A Complementar com ressonância da pelve.
- B Indicar avaliação cirúrgica.
- C Repetir a avaliação em três meses.
- D Realizar biópsia da lesão com agulha grossa.

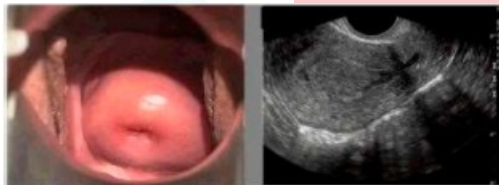
Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [400014279](https://www.400014279.com)

Questão 52 Sangramento uterino anormal Pólipos uterinos
Hiperplasia Endometrial Câncer de endométrio e outros tumores do corpo do útero

Mulher de 58 anos, menopausa há 5 anos. Há 3 meses com queixa de sangramento vaginal de discreta intensidade em episódios irregulares que duram um a dois dias. O exame especular e a ultrassonografia estão representados nas figuras. Qual a melhor conduta?



EXAME ESPECULAR E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL

- A Histerectomia total.
- B Biópsia ambulatorial.
- C Citologia cervical.
- D Terapêutica progestagênica.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [400014279](https://www.400014279.com)

Questão 53 Conduta obstétrica Tratamento farmacológico

Multigesta (G4P3A0), 28 anos, 36 semanas e 4 dias de gestação, segue em pré-natal de alto risco por hipertensão arterial crônica e retorna para consulta. Refere boa movimentação fetal, nega queixas de qualquer natureza. Está em uso de alfametildopa 1,5 grama/dia. Ao exame: bom estado geral, corada, hidratada, afebril, pressão arterial de 150/100 mmHg. Exame obstétrico: altura uterina de 34 cm e frequência cardíaca fetal de 144 bpm, com movimentos fetais. Exames laboratoriais: relação proteína/creatinina de 580 mg, creatinina 0,56 mg/dl, AST (aspartato aminotransferase) 37 U/L,

concentração de hemoglobina de 12,5 g/dl, plaquetas: 180.000/mm³, bilirrubinas totais de 0,34 mg/dl. Cardiotocografia: feto ativo. Nesse caso, escolha a alternativa com as melhores condutas.

- A Associar nifedipina retard e agendar indução com 39 semanas.
- B Manter metildopa e induzir trabalho de parto com 37 semanas.
- C Prescrever hidralazina endovenosa e parto cesárea.
- D Orientar curva de pressão arterial e agendar retorno para 1 semana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144277](#)

Questão 54 Trabalho de parto prematuro TPP Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica Obstetrícia

Primigesta, 18 anos, 29 semanas de gestação, internada no centro obstétrico para inibir trabalho de parto com terbutalina e anti-inflamatório. Exame físico geral normal. Apesar da medicação, a paciente mantém atividade uterina de 4 contrações moderadas/10 minutos, frequência cardíaca fetal de 160 bpm, com movimentos fetais. Toque vaginal: colo fino, centrado, 6 cm dilatado, pélvico, bolsa íntegra. Há 3 dias, foi iniciada betametasona, em dose única diária, repetida por dois dias consecutivos. Quais são as melhores condutas nesse momento?

- A Penicilina cristalina, sulfato de magnésio e cesárea.
- B Novo ciclo de corticosteroides e parto cesárea.
- C Atosiban, penicilina cristalina e cerclagem de urgência.
- D Analgesia de parto, ocitocina endovenosa e assistência ao parto vaginal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144276](#)

Questão 55 Planejamento familiar

Você está atendendo por telemedicina duas mulheres que desejam orientação para iniciar um método contraceptivo. Mulher 1: 19 anos, nuligesta, sem doenças e vícios. Sem antecedentes mórbidos na família. Deseja iniciar anel vaginal. Data da última menstruação: há 3 dias. Mulher 2: 23 anos, G1 P1A0, sem doenças e vícios. Sem antecedentes mórbidos na família. Deseja iniciar implante de etonogestrel. Data da última menstruação: há 6 dias. Assinale a alternativa que contém o que deve ser realizado (de exame físico e/ou complementar considerados essenciais) em cada mulher, antes de iniciar o método desejado, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (2018).

- A Mulher 1: exame ginecológico; Mulher 2: aferir a pressão arterial.
- B Mulher 1: nada; Mulher 2: exame ginecológico.
- C Mulher 1: aferir a pressão arterial; Mulher 2: nada.
- D Mulher 1: teste urinário de gravidez; Mulher 2: teste urinário de gravidez.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144275](#)

Questão 56 Gravidez em usuárias de DIU

Mulher, 27 anos, está em uso do sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU-LNG) há 2 anos. Não tem comorbidades e nem gestação anterior. Comparece à unidade básica de saúde pois apresentou teste de gestação positivo e fez ultrassonografia transvaginal que mostrou gestação tópica de 7 semanas e presença de SIU-LNG intrauterino. Está preocupada sobre o que deve ser feito diante do fato de estar grávida com um SIU-LNG intrauterino. Além de encaminhar a paciente para pré-natal, orientar sinais de alerta de infecção e abortamento, qual alternativa contém a(s) conduta(s) mais adequada(s) baseada(s) nas

evidências mais atualizadas?

- A Manter o SIU-LNG, sem necessidade de associar medicação.
- B Retirada do SIU-LNG imediatamente independente do fio estar visível.
- C Retirada do SIU-LNG imediatamente se o fio estiver visível.
- D Manter o SIU-LNG e prescrever progesterona micronizada oral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144274](#)

Questão 57 Avaliação do risco gestacional Assistência pré-natal Antecedentes pessoais

Tercigesta, 37 anos, com 10 semanas de gravidez, sem doenças, apresenta a você um motivo de grande apreensão em consulta pré-natal. Ela sente muita fome e não quer ganhar muito peso nessa gestação. Mas, se preocupa em colocar seu filho em risco se engordar pouco. Não lembra o peso pré-gestacional. Hoje, ela pesa 68kg e tem índice de massa corpórea de $25,6 \text{ kg/m}^2$. Para que essa mulher ganhe o mínimo peso necessário, qual é a recomendação de ganho de peso semanal e total permitido, respectivamente, nessa gestação?

- A 440 gramas e 12,5 kg
- B 230 gramas e 7,0 kg
- C 300 gramas e 9,0 kg
- D 400 gramas e 11,5 kg

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144273](#)

Questão 58 Doenças associadas à gestação Diabetes na gestação DMG Obstetrícia

Secundigesta, 23 anos, com 35 semanas e 3 dias de idade gestacional, portadora de diabetes mellitus tipo 1 e nefropatia diabética, retorna à consulta de pré-natal sem queixas clínicas ou obstétricas. Em tratamento regular com controle nutricional e insulino-terapia em esquema basal / bolus de múltiplas doses diárias. Exame físico: bom estado geral, hipocorada (+/++++), hidratada, pressão arterial 110/70 mmHg, frequência cardíaca 82 bpm, frequência respiratória 16 irpm, afebril. Exame obstétrico: feto único, longitudinal, cefálico, altura uterina de 31 cm, atividade uterina ausente, frequência cardíaca fetal de 130 bpm, sem desacelerações, movimentação fetal presente. A avaliação ultrassonográfica do momento evidencia feto único, cefálico, dorso a direita, perfil biofísica fetal 8/8, peso fetal no percentil 6 para idade gestacional, medida de maior bolsão amniótico de 1,6 cm, Dopplervelocimetria evidenciando diástole zero de artéria umbilical e índice de pulsatilidade na artéria cerebral média no percentil 3 para idade gestacional. A análise do perfil glicêmico da última semana está demonstrada no quadro a seguir: Considerando-se este caso clínico, a conduta mais adequada no momento é:

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
Glicemia de jejum	112	107	96	42	78	56	78
Glicemia pré-prandial	115	113	45	52	94	63	85
Glicemia duas horas pós-prandial	155	173	78	69	100	74	92

- A Programação da resolução da gestação com 37 semanas de idade gestacional.
- B Internação hospitalar para ajuste das doses de insulina e reavaliação do perfil glicêmico.
- C Indicação imediata de resolução da gravidez e controle glicêmico intraparto.
- D Dopplervelocimetria diária de artérias umbilicais, cerebral média fetal e dueto venoso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144272](#)

Questão 59 Abordagem sindrômica

Mulher de 23 anos, G3P1A2, procura unidade básica de saúde com história de lesão na vulva, sensação de dor leve no local e corrimento associado. Mantém atividade sexual regular sem uso de preservativo, apenas contraceptivo hormonal combinado. Refere que as lesões surgiram há pouco mais de um mês. Não sabe referir se houveram vesículas em qualquer momento do quadro. Durante o exame físico, foi visto a seguinte lesão. Com base nas informações descritas e na imagem, assinale a alternativa que contenha a opção mais adequada neste momento, conforme o Ministério da Saúde.



IMAGEM DA LESÃO

- A Aciclovir, azitromicina, penicilina.
- B Ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol.
- C Aciclovir, ceftriaxona, metronidazol.
- D Doxiciclina, penicilina, ciprofloxacina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144271](#)

Questão 60 Radioterapia Tratamento cirúrgico

Paciente de 68 anos, tratada de câncer de mama esquerda há 8 anos. Foi submetida à cirurgia conservadora, radioterapia adjuvante e utilizou tamoxifeno por 60 meses. Em mamografia de rotina foi encontrado uma lesão nodular de 0,5 cm de diâmetro B1- RADS® 5 no quadrante superolateral da mama direita. A biópsia percutânea confirmou carcinoma ductal invasor grau 2 do subtipo triplo negativo. A axila e fossa supraclavicular estão livres. Ultrassonografia da axila direita sem alterações. Não há sinais radiológicos ou clínicos de recorrência local na mama esquerda. Qual o tratamento local mais adequado?

- A Quadrantectomia + linfadenectomia axilar + radioterapia.
- B Mastectomia radical modificada + linfadenectomia axilar.
- C Setorectomia + biópsia do linfonodo sentinela + radioterapia.
- D Mastectomia radical modificada + biópsia do linfonodo sentinela.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144270](https://www.4000144270.com)

Questão 61 Pielonefrite

Primigesta, 24 anos, com gestação de 27 semanas, procura pronto atendimento devido urgência miccional, disúria e "cheiro forte na urina" há 5 dias e dor lombar à direita há 1 dia. A gestante relata episódios prévios de "cistite" tratados com antibióticos variados. Ela procurou unidade básica de saúde há 2 dias, quando recebeu a prescrição de norfloxacin. Relata que não apresentou melhora do quadro. Exame físico: temperatura 37,8° C, descorada (+/4+), Giordano positivo à direita. Restante do exame físico geral e obstétrico normal. Qual alternativa é mais adequada após internação dessa paciente?

- A Prescrever cefuroxima e solicitar ultrassonografia renal e de vias urinárias.
- B Continuar o tratamento e solicitar urina tipo 1 e urocultura com antibiograma.
- C Solicitar urocultura com antibiograma para reiniciar tratamento orientado por cultura.
- D Encaminhar imediatamente a paciente para avaliação por urologista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144269](https://www.4000144269.com)

Questão 62 Incontinência urinária Prolapsos de órgãos pélvicos

Paciente com 44 anos, G3P3A0 (3PN), refere ciclos menstruais regulares, procura atendimento ginecológico referindo que há 4 meses iniciou com polaciúria, noctúria, sensação de esvaziamento vesical incompleto, além de urgência miccional associado. Ao exame físico foi observado o descrito abaixo. Após descartar infecção urinária qual a melhor conduta para esta paciente neste momento?

Aa	Ba	C
-3	-2	-6
Hg	Cp	Cvt
4	3	8
Ap	Bp	D
-3	-1	-8

Hg: HIATO GENITAL; Cp: CORPO PERINEAL; Cvt: COMPRIMENTO DA VAGINA TOTAL; POP-Q: PELVIC ORGAN PROLAPSE QUANTIFICATION SYSTEM

- A Colporrafia anterior e posterior e imipramina 25 mg oral por dia.
- B Cirurgia de sling e solifenacina 5 mg oral por dia.
- C Eletroestimulação transcutânea e oxibutinina 5 mg oral por dia.
- D Treinamento vesical e perineal com cones vaginais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144268](https://www.4000144268.com)

Questão 63 Roteiro diagnóstico

Adolescente de 13 anos e 6 meses procurou atendimento ginecológico porque nunca menstruou. Paciente refere ausência do desenvolvimento das mamas e apresenta pilificação em axilas e vulva desde os 9 anos. Nega sangramento vaginal. Não teve sexarca e nega outras queixas. Exame físico: mucosas coradas, Pressão arterial: 100/70 mmHg, estatura no percentil 50, índice de massa corporal: 21 kg/m², Tanner M1 P3, genitália externa feminina e pré-púbere. Qual(is) possível(is) causa(s) justificariam o desenvolvimento puberal desta paciente?

- A Hiperplasia adrenal congênita ou hiperprolactinemia.
- B Trata-se de desenvolvimento puberal normal.
- C Disgenesia gonadal ou hipogonadismo hipogonadotrófico.
- D Malformação mulleriana ou feminilização testicular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144267](#)

Questão 64 Doenças infecciosas na gestação HIV sífilis hepatites herpes

Secundigesta, 26 anos, 26 semanas de gestação, índice de massa corpórea de 39 kg/m², pré-natal sem intercorrências. Há dois dias iniciou com mialgia, coriza e dor de garganta e hoje teve febre de 38° (e "falta de ar"). Ao exame está com pressão arterial de 140/90 mmHg, pulso de 110 bpm, frequência respiratória de 35 irpm, saturação O₂ em ar ambiente de 93%, ausculta pulmonar: diminuição do murmúrio vesicular em bases pulmonares. Exame obstétrico: altura uterina de 30 cm, dinâmica uterina ausente, frequência cardíaca fetal de 146 bpm. Após a internação, coleta de exames e cateter nasal com O₂, esta gestante deve ser tratada com:

- A Oseltamivir, heparina profilática e antibiótico endovenoso.
- B Corticoide via oral, heparina terapêutica e antibiótico via oral.
- C Anticoagulante via oral, heparina profilática e corticoide endovenoso.
- D Antibiótico via oral, heparina terapêutica e oseltamivir.

Proibida Venda

Acesse t.me/medicinalivre

4000144266

Questão 65 Processos inflamatórios mastites

Primípara, 4º dia de puerpério após cesárea por feto pélvico na 36ª de gestação, está no alojamento conjunto. O recém-nascido pesou 2400 gramas, nasceu em boas condições e está com a mãe. Hoje, a paciente reclamou de muita dor mamária. Sem outras queixas. A paciente fez mamoplastia de aumento há dois anos. Exame físico: temperatura 38,0° C (oral), dor, hiperemia leve e aumento de volume em ambas as mamas. Fissuras em complexo aréola mamilar à esquerda (Figura abaixo). Palpação: mamas endurecidas em ambos os quadrantes externos, expressão láctea positiva bilateral. O restante do exame físico está normal. Quais são as melhores condutas para o caso?



- A Analgésico e ordenha mamária.
- B Clindamicina oral e compressas mornas.
- C Cabergolina e enfaixamento mamário.
- D Oxacilina endovenosa e compressas frias.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144265](https://www.4000144265.com)

Questão 66 Tempos da apresentação cefálica Obstetrícia Parto

Secundigesta (1 parto vaginal prévio), com 39 semanas, chega para avaliação em trabalho de parto na fase ativa da dilatação. O toque vaginal revela colo centrado, curto, dilatado 7 cm, feto em ODP (occipito direita posterior), em -1, bolsa íntegra. Escolha a alternativa que contém tempos do mecanismo de parto mais provável, nesse caso.

- A Rotação interna de 135 graus no sentido horário, hipomóclio por deflexão e rotação externa anti-horária.
- B Rotação interna de 225 graus no sentido anti-horário, hipomóclio em deflexão e rotação externa-horária.
- C Insinuação por flexão, rotação interna de 45 graus no sentido anti-horário e hipomóclio por deflexão.
- D Insinuação por assinclitismo, rotação interna de 135 graus no sentido-horário e hipomóclio em flexão.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144265](https://www.4000144265.com)

Questão 67 Tratamento Roteiro diagnóstico

Mulher de 28 anos, nuligesta, parou o uso de anticoncepcional há 2 anos para engravidar após 10 anos de uso, mas desde então está em amenorreia. Refere menarca aos 12 anos, com ciclos regulares, sem dismenorreia. Ao Exame físico: índice de massa corporal = 22 Kg/m² ; exame ginecológico com mucosa pálida e com redução do pregoamento vaginal. Foram solicitados exames complementares: FSH (hormônio folículo-estimulante) = 76 mIU/ml (VN = 2,8 a 10,5 mIU/ml); TSH (hormônio estimulador da tireoide) = 1,2 mIU/ml (VN = 0,4 a 4,0mIU/ml);PRL (prolactina) = 12,0 ng/dl (VN < 25ng/dl). Espermograma do parceiro: normal. Histerossalpingografia: trompas pérvias bilateralmente. Ultrassonografia transvaginal: útero com 12 cm³ de volume, espessura endometrial com 3 mm, ovário direito = 2,3 cm³ e ovário esquerdo = 1,8 cm³ . Cariótipo: 46XX (60%), 45X0 (40%). Rastreio para outras doenças negativo. Qual a conduta mais adequada?

- A Indução de ovulação com indutores orais para coito programado.
- B Estimulação de ovulação com gonadotrofinas para fertilização in vitro.
- C Fertilização in vitro com oócitos de doadora anônima.
- D A gestação deve ser contraindicada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144263](#)

Questão 68 Conduta Obstetrícia

Nuligesta, 25 anos, procura pronto atendimento com cólicas intensas em hipogástrio há 1 dia e sangramento vaginal moderado há 2 horas. A última menstruação da paciente foi há cerca de 2 meses. Nega doenças e tem usado preservativo em suas relações sexuais. Exame físico: descorada (+), pressão arterial 90/50 mmHg, frequência cardíaca 100 bpm. Exame especular: moderada quantidade de sangue em vagina. Toque vaginal: útero aumentado compatível com 9 semanas e colo pálido 1 polpa. O teste imunológico para o diagnóstico da gravidez está mostrado abaixo (Figura). Qual é a conduta mais adequada?



- A Ultrassonografia transvaginal.
- B Aspiração manual intrauterina.
- C Prescrição de progesterona via oral.
- D Repouso físico relativo e abstinência sexual.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144262](#)

Questão 69 Avaliação da vitalidade fetal Obstetrícia

Primigesta, 18 anos, com 34 semanas de gestação, retorna em consulta pré-natal, em Unidade Básica de Saúde, com resultado de ultrassonografia obstétrica realizada há 3 dias. É tabagista e tem índice de massa corporal no primeiro trimestre de 17 kg/m². Está assintomática, com exames da rotina laboratorial normais. A ultrassonografia mostrou peso fetal estimado no percentil 12, índice de pulsatilidade (IP) na artéria umbilical no percentil 91 e IP na artéria cerebral média no percentil 15, maior bolsão de líquido amniótico no percentil 25. Na consulta de hoje não foram percebidos movimentos fetais. O exame físico geral e restante do exame obstétrico são normais. Qual é a conduta imediata mais adequada neste momento?

- A Auscultar o feto após estímulo mecânico ou vibroacústico.
- B Solicitar nova ultrassonografia obstétrica com Doppler em uma semana.
- C Encaminhar a paciente ao serviço de referência de urgência.
- D Agendar avaliação dessa gestante em pré-natal de alto risco.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144261](#)

Questão 70 Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau

Paciente de 22 anos iniciou atividade sexual há 6 meses e veio à consulta ginecológica para iniciar contracepção. Foi

colhida a citologia para rastreio de câncer do colo uterino e o resultado apontou amostra satisfatória com células escamosas e metaplásicas e anormalidades em células escamosas compatíveis com lesão intraepitelial de baixo grau. O manejo adequado para esta paciente deve incluir:

- A Prescrever a vacina para HPV (papilomavírus humano) e realizar colposcopia.
- B Encaminhar parceiro para exame e repetir citologia em seis meses.
- C Orientações de uso de preservativo e nova citologia em três anos.
- D Solicitar sorologias para Infecções sexualmente transmissíveis e realizar biópsia no colo uterino.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144260](#)

Questão 71 Doenças associadas à gestação Doenças infecciosas na gestação HIV sífilis hepatites herpes

Sífilis na gestação

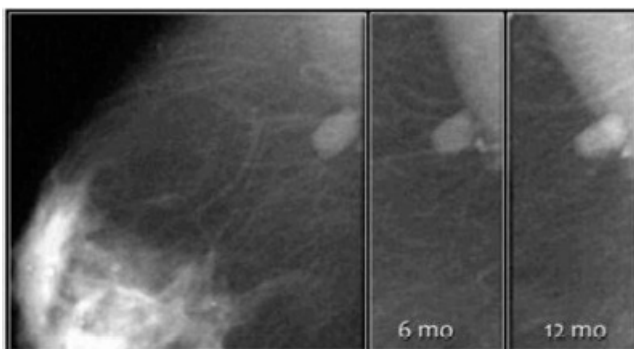
Multigesta, 27 anos, G4P2A 1 (parto há 18 meses), com 22 semanas e 3 dias de gestação, veio encaminhada da rede básica por apresentar exames positivos para sífilis. Durante a anamnese, disse que não se lembrava de ter apresentado lesões tegumentares típicas da sífilis. Seu exame treponêmico foi reagente e o VDRL de 1/16. Por sua vez, o parceiro também negou lesões tegumentares compatíveis com sífilis e sua sorologia para sífilis foi negativa. Considerando o parceiro desta gestante, qual é a melhor conduta?

- A Não tratar o parceiro visto que sua sorologia foi negativa.
- B Não tratar o parceiro e observar o aparecimento de lesões da sífilis.
- C Tratar o parceiro como se fosse sífilis latente tardia.
- D Tratar o parceiro com a mesma dose indicada para tratar sífilis recente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144259](#)

Questão 72 BIRADS

Mulher de 51 anos, nulípara, menopausa há 1 ano, retorna à consulta na unidade básica de saúde para checar mamografia de rastreamento. Tem como antecedente uma tia avó com história de câncer de mama e fez uso de contraceptivo hormonal combinado por 20 anos. Há um ano retirou o sistema intrauterino de levonorgestrel que vinha usando como método contraceptivo nos últimos 5 anos. Não apresenta alteração detectável no exame físico. O laudo da mamografia vem descrito como B1-RADS® 3 e apresenta a imagem abaixo. Considerando a história clínica e a imagem, assinale a alternativa que contenha a conduta mais adequada, segundo orientações do Ministério da Saúde.



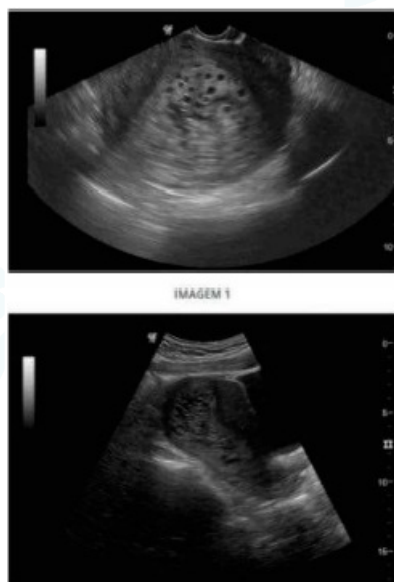
Mamografia no tempo zero, 6 e 12 meses

- A Manter seguimento rotineiro com mamografia anual.
- B Solicitar ultrassonografia mamária complementar.
- C Encaminhar para realização de análise histopatológica.
- D Realizar nova mamografia em seis meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144258](https://www.4000144258.com.br)

Questão 73 Tratamento Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica Doença trofoblástica gestacional

Paciente 22 anos, G1 POA0, tempo de amenorreia de 8 semanas e 2 dias, dá entrada na unidade de emergência com queixa de sangramento vaginal há 4 horas. Ao exame a paciente está em bom estado geral, descorada +/4+, afebril, pressão arterial = 110/50 mmHg, frequência cardíaca = 90 bpm. Especular: presença de sangue em fundo de saco com saída ativa pelo orifício externo do colo em pequena quantidade. Ao toque, o colo está amolecido, fechado. O útero é globoso, amolecido e palpável 2 centímetros acima da sínfise púbica. Foi realizado exame ultrassonográfico transvaginal (imagem abaixo). Qual a conduta terapêutica mais adequada no momento?



- A Dilatação cervical seguida de vácuo-aspiração uterina.
- B Dilatação cervical seguida de curetagem uterina fracionada.
- C Misoprostol e vácuo-aspiração uterina.
- D Repouso físico e sexual e antiespasmódicos.

4000144257

Questão 74 Fisiopatologia

Homem, 80 anos, em acompanhamento irregular por DPOC muito grave. Refere piora da dispneia aos esforços e edema de membros inferiores há 1 ano. Exame físico: BEG; murmúrio vesicular reduzido globalmente sem ruídos adventícios à ausculta pulmonar. FR: 24 ipm. Saturação O₂: 85%. Edema de membros inferiores (3+/4+) frio e depressível. Estase jugular a 90 graus. Qual o elemento fisiopatológico responsável pela piora recente?

- A Alta resistência vascular pulmonar.
- B Hiperinsuflação pulmonar.
- C Hipervolemia.
- D Disfunção de ventrículo esquerdo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144256](#)

Questão 75 Clínica Médica Hepatologia Peritonite bacteriana espontânea PBE

Homem, 62 anos, com cirrose hepática associada ao álcool, refere ganho ponderal de 8 Kg nos últimos 3 meses. Na última semana, apresentou redução do volume urinário e dor abdominal difusa, que associa ao aumento do volume do abdome. Evacuação uma vez ao dia. Ao exame, abdome globoso, com sinal do piparote positivo. Edema de membros inferiores ++/4+. Exames laboratoriais: creatinina: 1,1 mg/dl (VR: 0,7-1,5); sódio: 136 mEq/L (VR: 135-145); potássio: 4,8 mEq/L (VR: 3,5-5,0); albumina: 3,1 g/dl (VR: 3,5-4,8); bilirrubina total: 4,5 mg/dl (VR: 0,8-1,2 mg/dl); bilirrubina direta: 3,2 mg/dl (VR: até 0,4 mg/dl); INR: 1,4 (VR: até 1,3). Paracentese diagnóstica: glóbulos brancos: 530/mm³, com 85% de neutrófilos. Além do tratamento com antibiótico, qual a conduta mais adequada neste momento?

- A Furosemida.
- B Espironolactona.
- C Albumina.
- D Lactulose.

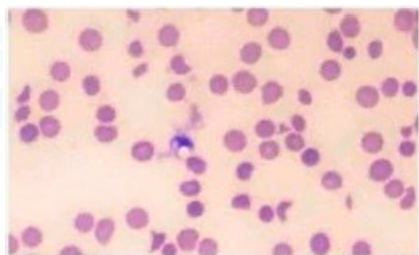
Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144256](#)

Questão 76 Tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica PTT Hematologia

Mulher, 40 anos, encaminhada devido a febre, confusão mental e petéquias. Informa quadro de diarreia e faringite há 03 meses, com resolução espontânea. Hemograma: Hb: 7,0 g/dl, Ht: 20%, VCM: 92 fL, leucócitos: 8.000/ul, plaquetas: 9.000/ul (esfregaço do sangue periférico abaixo), contagem de reticulócitos: 140.000/ul (VR: 30.000-95.000), creatinina: 1,1 mg/dl (VR: <1,3), ureia: 36 mg/dl (VR < 37). Qual é o tratamento mais adequado?



ESFREGAÇO DO SANGUE PERIFÉRICO

- A Plasmaférese.
- B Transfusão de plaquetas.
- C Prednisona e Imunoglobulina.
- D Eculizumabe.

Questão 77 Hemorragia Subaracnoidea HSA Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico**Acidentes Vasculares Cerebrais AVC**

Paciente de 35 anos previamente hígido apresenta quadro súbito de cefaleia intensa e explosiva durante um jogo de futebol com os amigos, sendo imediatamente levado ao pronto socorro. Está sonolento mas responde ao ser questionado. Refere ter a dor de cabeça mais forte de sua vida e que está enxergando dobrado. Ao exame apresenta pressão arterial de 190 x 120 mmHg, está sonolento e apresenta oftalmoparesia e midríase no olho esquerdo. A tomografia (sem contraste) inicial é mostrada na figura. Qual a conduta imediata mais adequada?



- A Dexametasona endovenosa.
- B Manitol endovenoso.
- C Angiografia cerebral.
- D Punção diagnóstica do líquido cefalorraquidiano.

Proibida Venda.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144253

Questão 78 Reação do tipo 1

Homem, 52 anos, em tratamento para hanseníase (poliquimioterapia multibacilar) há 2 meses. Buscou atendimento queixando-se de que há 5 dias houve piora aguda das lesões cutâneas pré-existentes (foto), perda de sensibilidade em 4º e 5º quirodáctilos da mão direita e dor em choque irradiando do cotovelo até a mão direita. Qual a conduta terapêutica imediata mais adequada para este caso?



- A Iniciar talidomida via oral.
- B Suspende a poliquimioterapia multibacilar.
- C Iniciar prednisona via oral.
- D Instaurar poliquimioterapia substitutiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144252](https://www.4000144252.com)

Questão 79 Definição Tratamento

Homem, 65 anos, tabagista 50 anos maço, queixa de dispneia aos esforços há 3 anos, com piora intensa há 3 dias. Exame físico: MEG, corado, consciente e orientado; MV presente, sibilos difusos, Saturação de O₂ de 80% ar ambiente, FR: 30 ipm. Instalado oxigênio suplementar através do dispositivo abaixo (foto) a 15 L/min, com aumento da saturação de O₂ para 97%. O paciente evoluiu com piora do nível de consciência, acordando apenas aos estímulos dolorosos. Qual é a alteração gasométrica esperada nesse momento?



- A pCO₂: 90 mmHg
- B HCO₃: 15 mEq/L
- C pO₂: 60 mmHg
- D pH: 7,45

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144251](https://www.4000144251.com)

Questão 80 Encefalopatia de WernickeKorsakoff

Homem, 55 anos, etilista crônico de 1 litro de destilado/dia, apresenta perda da memória e quedas frequentes. Exame físico: ataxia de marcha e nistagmo, sem alterações de sensibilidade periférica. Exames laboratoriais: hemograma [Hb: 12 g/dl, Ht: 36%, VCM: 93 fl (VN: 80-95), HCM: 32 pg (VN: 27-33), plaquetas: 160.000/mm³], bilirrubina total 1,2 mg/dl (VN: 0,2-1,2). Qual é a deficiência vitamínica mais provável?

- A Niacina.
- B Piridoxina.
- C Tiamina.
- D Cianocobalamina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144250](https://www.4000144250.com)

Questão 81 Polimialgia reumática

Mulher, 70 anos, queixa-se de dor muscular difusa há 4 meses, mais importante na região cervical, ombros e quadris, associada a rigidez matinal superior a 45 minutos. Refere que no último mês evoluiu com limitação da amplitude de movimentos do quadril e dificuldade para realizar suas atividades domésticas habituais. Refere ainda hiporexia e perda ponderal de 2 kg nesse período. Ao exame físico, apresenta força muscular apendicular preservada. Exames laboratoriais: VHS: 70 mm/1ª hora (VR: até 15), Fator reumatoide: 7,1 IU/ml (VR: < 10,8). Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Artrite reumatoide.
- B Polimiosite.
- C Polimialgia reumática.
- D Fibromialgia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144249](#)

Questão 82 Demências Diagnóstico Diferencial Demência com Corpos de Lewy

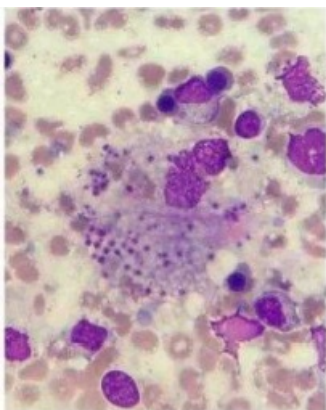
Homem, 82 anos. A esposa relata que o paciente, há dois anos, vem apresentando distúrbio de atenção e alucinações visuais bem detalhadas, episódios de esquecimento, especialmente para informações recentes, chegando a se perder em trajeto usual. Ao exame físico observa-se bradicinesia, tremores de extremidades e rigidez muscular. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Demência fronto temporal.
- B Demência vascular.
- C Demência por corpúsculos de Lewy.
- D Demência da doença de Parkinson.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144248](#)

Questão 83 Tratamento

Homem, 19 anos, informa febre diária de 38° (, associada a astenia e fadiga há 2 meses. Exame físico: baço palpável a 4 cm do rebordo costal esquerdo. Hemograma: Hb: 9,6 g/dl, Ht: 28%; VCM: 82 fl, leucócitos: 3.000/ul, plaquetas: 100.000/ul. Mielograma demonstra pequenas estruturas ovaladas dentro do macrófago (figura). Qual é o tratamento inicial mais adequado?



- A Esquema RIPE.
- B Sulfametoxazol + trimetoprima.
- C Itraconazol.
- D Anfotericina B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144247](https://www.facebook.com/4000144247)

Questão 84 **Biópsia renal**

Mulher, 25 anos, previamente sem comorbidades e com exames recentes normais, refere diminuição de volume urinário, alteração do aspecto da urina e edema em membros. Exame físico: PA = 156 x 90 mmHg; edema de membros inferiores 2+/4+, sem outras alterações. Exames: creatinina: 2,3mg/dl, ureia: 68 mg/dl, albumina: 3, 1 g/dl, urina 1: proteína 150 mg/dl, hemácias 300 por campo. Entre as opções abaixo, qual exame seria mais importante na elucidação diagnóstica?

- A Ultrassonografia renal com doppler.
- B Fração de excreção de sódio.
- C Hemograma completo.
- D Biópsia renal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144246](https://www.facebook.com/4000144246)

Questão 85 **Tratamento Apresentação clínica**

Mulher, 56 anos, relata que há 4 semanas surgiram lesões nodulares, eritematosas e levemente dolorosas em membro superior direito (fotografia). As lesões surgiram após trauma com espinho na mão direita, enquanto trabalhava com jardinagem. Nega doenças e uso de medicamentos. Habita a zona urbana e nega viagens recentes. Considerando o diagnóstico mais provável, qual o tratamento mais adequado?



à Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Sulfametoxazol + trimetoprim.
- B Cefalotina.
- C Itraconazol.
- D Antimoniato de N metilglucamina.

4000144245

Questão 86 Apresentação clínica

Mulher, 17 anos, apresenta desde os 6 meses de idade lesões de pele recidivantes e pruriginosas. Há 1 ano as lesões estão menos frequentes, porém ainda se intensificam no inverno. O quadro atual é o mostrado na figura: Qual é a condição médica mais associada ao diagnóstico desta paciente?



- A Síndrome metabólica.
- B Doença celíaca.
- C Hipotireoidismo.
- D Rinite alérgica.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144244

Questão 87 Espondilite Anquilosante

Homem, 28 anos, há seis meses apresenta lombalgia de ritmo inflamatório e há três meses apresenta dor em joelho direito e calcanhares. Exame: bom estado geral; edema, hiperemia e calor em calcanhares e tuberosidade tibial direita; teste de Patrick positivo bilateralmente. Qual destas manifestações é mais provável ocorrer nesse paciente?

- A Nefrite intersticial.
- B Dor testicular.
- C Uveíte anterior.
- D Livedo reticular.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144243

Questão 88 Fisiopatologia e Fatores de Risco

Homem, 45 anos, obeso e tabagista, queixa-se de pirose pós prandial associada a regurgitações amargas há 3 meses. Atribui piora dos sintomas a ingestão de alimentos gordurosos, refrigerantes e bebidas alcóolicas. Alívio parcial com uso de

antiácidos. Qual o principal mecanismo fisiopatológico considerando a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Aperistalse do corpo do esôfago.
- B Hipersecreção gástrica.
- C Aceleração no esvaziamento gástrico.
- D Relaxamento transitório de esfíncter esofágico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144242](#)

Questão 89 Fisiologia do Envelhecimento

Mulher, 78 anos, portadora de fibromialgia há 2 anos, com bom controle dos sintomas com o uso de amitriptilina 50 mg ao dia. Há uma semana teve queda da própria altura e traumatismo no joelho direito, quando foi prescrito tramado! 100 mg ao dia. Há cinco dias vem apresentando visão turva, rubor facial, taquicardia, boca seca e estado confusional. Qual é a alteração fisiológica do envelhecimento que melhor explica estes sintomas?

- A Diminuição do número de receptores dopaminérgicos.
- B Diminuição do número de receptores colinérgicos.
- C Aumento da sensibilidade dos receptores adrenérgicos.
- D Aumento da sensibilidade dos receptores serotoninérgicos.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144241](#)

Questão 90 Nefropatia diabética x Nefropatia não diabética

Homem de 45 anos, com diagnóstico recente de diabetes mellitus, refere história familiar positiva para doença renal crônica dialítica na família (pais e irmãos, também diabéticos). Encontra-se assintomático e sem alterações no exame físico. Exames laboratoriais: creatinina 0,6 mg/dl (taxa de filtração glomerular estimada = 141 ml/min/1,73m²) e ultrassonografia com discreto aumento de dimensões de ambos os rins. Entre os exames abaixo, qual é o exame mais importante no momento?

- A Relação albumina/creatinina urinária.
- B Urina rotina.
- C Proteinúria de 24 horas.
- D Dismorfismo eritrocitário.

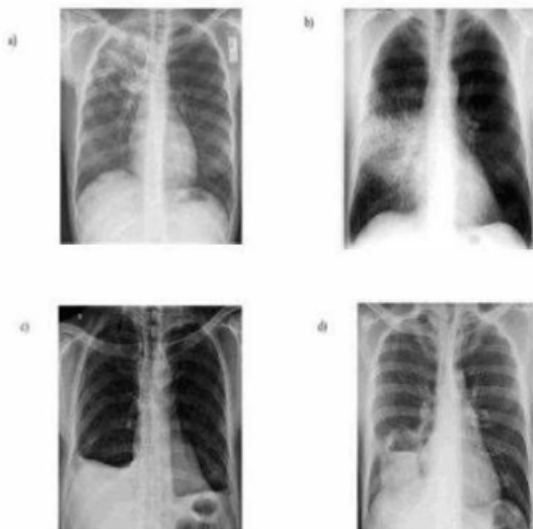
Acesse t.me/medicinalivre

4000144240

Questão 91 Quadro clínico

Homem, 42 anos, etilista, refere tosse produtiva com expectoração amarela escura há 18 dias. Há 15 dias com febre diária aferida (38,5° C). Há 2 dias teve um acesso de tosse que culminou em expectoração de grande volume de secreção amarela escura de odor pútrido. Qual radiografia de tórax é mais compatível com essa história clínica?

FIGURAS



- A Figura A
- B Figura B
- C Figura C
- D Figura D

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144239](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 92

Diagnóstico da síndrome de Cushing

Hipercortisolismo

Endocrinologia

Mulher, 25 anos, queixa-se de ganho de peso, fraqueza e apresentou fratura em coluna vertebral após queda da própria altura há 2 meses. Está em amenorreia há 6 meses. Exame físico: peso: 90 kg, estatura: 1,65 m, índice de massa corporal: 33 kg/m², plethora facial, preenchimento da fossa supraclavicular, PA = 170 x 100 mmHg. FC = 92 bpm. Abdome globoso com estrias violáceas medindo 1,5 cm, equimoses em membros inferiores. Qual é a investigação inicial para a principal hipótese diagnóstica?

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Dosagem sérica de cálcio e 25 OH vitamina D.
- B Tomografia computadorizada de abdome.
- C Cortisol plasmático após 1 mg de dexametasona.
- D Ressonância magnética de sela túrcica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144238](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 93

Doença de Graves

Endocrinologia

Mulher, 32 anos, refere taquicardia, tremor em extremidades, perda de peso, agitação psicomotora, hiperdefecação há 4 meses. Exame físico: PA = 150 x 80 mmHg, FC = 110 bpm, pele quente e úmida, tireoide difusamente aumentada em cerca de 4 vezes, sem nódulos delimitados. Vide fotos: Qual é a fisiopatologia da doença neste caso?

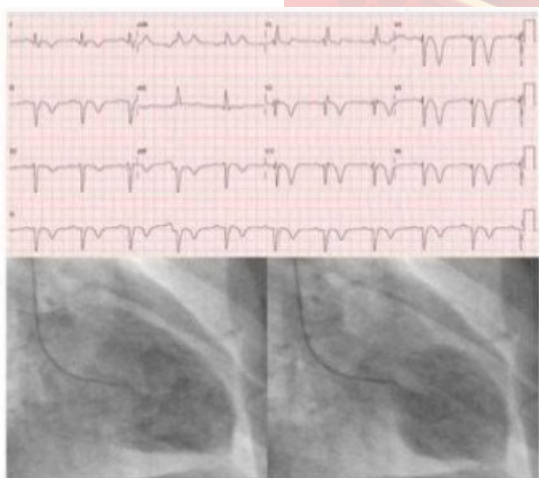


- A Secreção autônoma de TSH.
- B Resistência ao hormônio tireoidiano.
- C Mutaç o som tica no receptor de TSH.
- D Anticorpo anti receptor de TSH.

Essa quest o possui coment rio do professor no site [4000144237](https://www.t.me/medicinalivre)

Quest o 94 **Cardiomiopatia de Takotsubo**

Mulher, 67 anos, previamente hipertensa e diab tica em tratamento regular, refere dor precordial em aperto de forte intensidade com irradia  o para bra o esquerdo com dura  o de 30 minutos ap s ser informada do falecimento do filho. Atendida 24 horas ap s o in cio do quadro, mantendo epis dios recorrentes de dor. Exame f sico: BEG, chorosa; FC = 53 bpm, PA = 96 x 74 mmHg; estertores pulmonares at  ter o m dio bilateralmente, FR = 24 irpm, satO₂ = 94%. R tmo card aco regular em 2 tempos com sopro holossist lico mitral 3+/6+. Eletrocardiograma abaixo. Submetida a cateterismo card aco com coronarografia sem les es obstrutivas e ventriculografia apresentada abaixo. Qual a fisiopatologia da hip tese diagn stica mais prov vel?



ECG E VENTRICULOGRAFIA

- A Infiltra  o inflamat ria mioc rdica difusa.
- B Libera  o de catecolaminas em paciente suscet vel.
- C Ulcera  o de placa ateroscler tica em art ria descendente anterior.
- D Vasoespasmo coronariano difuso.

Essa quest o possui coment rio do professor no site [4000144236](https://www.t.me/medicinalivre)

Quest o 95 **Tratamento**

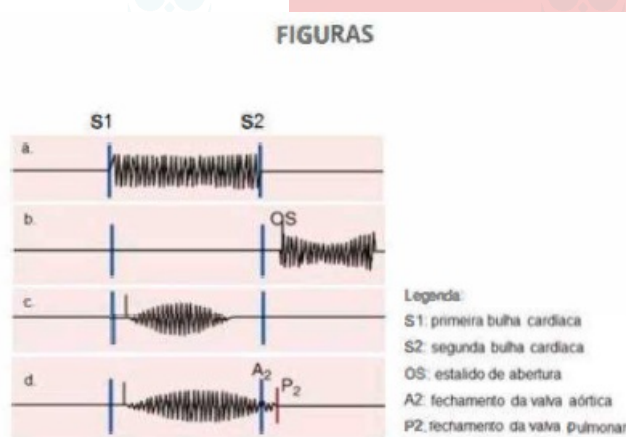
Homem, 32 anos, inicia tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol (RIPE), 5 comprimidos em jejum, associado a vitamina B6. Após 3 semanas de tratamento, retorna com dor em hipocôndrio direito, contínua, de intensidade 6 em 10, náusea e um episódio de vômito. Relata também astenia e artralgia nos últimos 5 dias. Exame físico: peso 72 Kg; dor à palpação profunda de hipocôndrio direito, sem outras alterações. Qual a conduta mais adequada?

- A Diminuir a dose das medicações.
- B Orientar tomada de RIPE com refeição e observar.
- C Associar inibidor de bomba de prótons.
- D Suspender RIPE e dosar aminotranferases.

4000144235

Questão 96 Estenose mitral Sopros diastólicos

Mulher, 36 anos, apresenta dispnéia aos moderados esforços há 4 meses com palpitações taquicárdicas há 2 meses. Refere reumatismo na infância, sem outras comorbidades. Não faz uso de medicações contínuas. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual figura representa a ausculta cardíaca esperada para esta paciente?

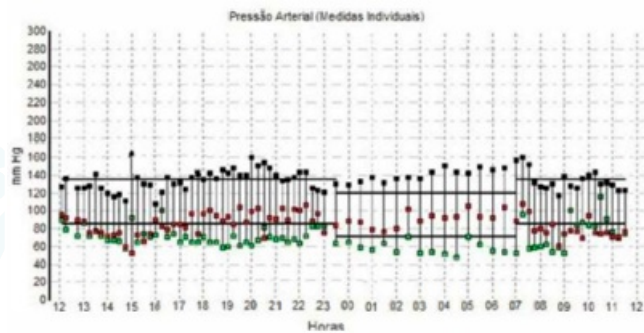


- A Figura a
- B Figura b
- C Figura c
- D Figura d

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144234

Questão 97 Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono Síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono SAHOS

Homem, 45 anos, portador de hipertensão arterial há 5 anos em tratamento com hidroclorotiazida, enalapril e anlodipino em doses máximas retorna para seguimento com monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Queixa-se de episódios de elevação de pressão arterial em domicílio, apesar da aderência ao tratamento farmacológico e não farmacológico, e nega uso de outras medicações. Exame físico sem alterações, PA: 143 x 91 mmHg, FC 73 bpm, peso de 80 kg, altura 1,6 m. MAPA (figura) com média das pressões em 24 horas de 135 x 86 mmHg. Qual a condição clínica mais provável neste caso?



- A Síndrome da apneia obstrutiva do sono.
- B Feocromocitoma.
- C Estenose de artéria renal.
- D Hipertireoidismo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144233](#)

Questão 98 ITU no portador de sonda vesical de demora SVD

Homem de 31 anos vítima de ferimento por arma de fogo há 3 anos com destruição de L5 evoluindo com bexiga neurogênica e dificuldade para promover o esvaziamento vesical. Faz uso de sonda vesical de demora (SVD) com sistema aberto (sem extensão e bolsa coletora acoplados) e ocluído, que é aberto a cada 6 horas para promover o esvaziamento vesical. No último ano, apresentou 5 episódios de infecção urinária febril, tendo sido dois deles tratados em ambiente hospitalar para antibioticoterapia endovenosa. Há 6 meses, começou a apresentar perda urinária adjacente a SVD antes de promover o esvaziamento vesical, necessitando utilizar forro ou fralda. A ultrassonografia do aparelho urinário evidenciou rins sem dilatação e bexiga de boa capacidade com paredes finas, creatinina de 0,8 mg/dl, proteína C reativa de 2,5 mg/L e cultura de urina positiva para E. coli. Preocupado com as infecções e perdas urinárias, o paciente deseja orientação. Qual a melhor conduta?

- A Retirar a sonda vesical de demora e iniciar cateterismo intermitente limpo.
- B Trocar a sonda vesical de demora e reduzir o intervalo para promover o esvaziamento vesical para 4 horas (ao invés de 6 horas).
- C Trocar a sonda vesical de demora e instalar o sistema fechado, utilizando bolsa coletora com extensão de sonda.
- D Retirar a sonda vesical e passar a promover o esvaziamento vesical por manobra de Credé a cada 4 horas.

4000144232

Questão 99 Diagnóstico

Lactente de 6 meses, sexo masculino, foi admitido na unidade de pronto-atendimento com história de dor abdominal em cólicas, intensa, com período de acalmia. Nega antecedentes mórbidos. Associado à dor, refere vômitos, palidez e sudorese fria de extremidades. Ao exame físico: regular estado geral, com dor na ocasião do exame, afebril. Abdome globoso, discreto timpanismo à percussão, ruídos hídricos com timbre metálico, sem sinais de irritação peritoneal. Sinal de Dance positivo. Na fralda, há evacuações com muco e sangue (vide figura). Qual a conduta mais adequada?



EVACUAÇÕES COM MUCO E SANGUE.

- A Enema opaco.
- B Colonoscopia.
- C Laparotomia.
- D Observação.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144231](https://www.4000144231.com)

Questão 100 **Medidas Iniciais** **Cardiologia**

Homem com quadro de dor de início súbito associado a parestesia, frialdade e cianose de membro inferior esquerdo há cerca de 2 horas. Ao exame, apresenta-se levemente sudoreico, em bom estado geral, com ritmo cardíaco irregular, hemodinamicamente estável (FC: 100 bpm e PA: 130 x 80 mmHg), porém com cianose não fixa do joelho para baixo, frialdade de todo o membro e ausência de pulsos femoral, poplíteo e distais. Quais medidas clínicas devem ser realizadas até tratamento cirúrgico definitivo?

- A Fibrinólise sistêmica por via endovenosa periférica associado a vasodilatador periférico e analgesia.
- B Antiagregação plaquetária, analgesia, estatinas e uso de terapia hiperbárica com oxigênio.
- C Anticoagulação plena, analgesia e manter membros em proclive enfaixados sem compressão.
- D Anticoagulação profilática, analgesia, meias elásticas compressivas e elevação dos membros.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144230](https://www.4000144230.com)

Questão 101 **Punção transtorácica guiada por tomografia**

Homem, 67 anos, tabagista (70 anos-maço) e com tosse crônica. Radiografia de tórax atual com nódulo pulmonar de 2,5 cm no lobo superior esquerdo. Queixa-se de aumento na intensidade da tosse e hemoptóicos. Broncoscopia foi normal com biópsia transbrônquica negativa e citologia do lavado broncoalveolar negativo para células neoplásicas (aguarda cultura para microbactérias e fungos). Seguindo o planejamento diagnóstico, qual a conduta mais adequada?



RADIOGRAFIA DE TÓRAX

- A Punção biópsia aspirativa do nódulo ou biópsia tecidual transtorácica, pois é necessário o diagnóstico definitivo.
- B Aguardar as culturas finais para o bacilo da tuberculose, porém iniciar imediatamente esquema de tratamento específico.
- C Toracotomia com lobectomia pulmonar pela possível malignidade do nódulo, evitando os riscos de implantes tumorais na tentativa de biópsia transtorácica.
- D Iniciar prova terapêutica para tuberculose, pois os indícios clínicos são fortes bem como os achados radiológicos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144229](https://www.4000144229.com)

Questão 102 Hipertensão Intracraniana

Mulher de 62 anos vítima de traumatismo crânio-encefálico por queda há cerca de uma hora, foi intubada na cena do trauma. À chegada no pronto-socorro, encontra-se com Glasgow de 8T e apresenta anisocoria com pupila esquerda midriática. Realizada tomografia computadorizada de crânio (vide figura). Além de elevação da cabeceira a 30 graus, qual a medida clínica mais adequada a ser tomada antes do tratamento cirúrgico definitivo?



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO

- A Hiperventilação.
- B Administração de solução hiperosmolar.
- C Hipotermia controlada.
- D Corticoterapia com dexametasona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144228](#)

Questão 103 Hemotórax Cirurgia

Homem, 18 anos, vítima de trauma torácico fechado (colisão carro com ônibus), com fratura costal única (oitavo arco costal direito), foi tratado com drenagem pleural fechada por pneumotórax. Apresentou boa resolução e expansão pulmonar, e o dreno foi retirado após 24 horas, seguida de alta hospitalar. Retornou ao serviço de emergência após 5 dias da alta com queixa de dor pleurítica e picos febris (não medidos). A radiografia de tórax mostra nível hidroaéreo à direita. A tomografia de tórax é compatível com hemotórax coagulado. Qual a conduta mais adequada?

- A Videotoroscopia ou VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery).
- B Toracotomia póstero-lateral com decorticação pulmonar e pleurectomia para controle de sangramento.
- C Dreno pleural calibroso (36F) utilizando o mesmo orifício da drenagem prévia e colocado em irrigação contínua e aspiração à vácuo.
- D D) Passagem de dreno pleural tipo "pigtail" para realização de terapia com trombolíticos na cavidade pleural, e irrigação contínua por 48 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144227](#)

Questão 104 Avaliação da Gravidade

Homem, 49 anos, com dor no andar superior do abdome, amilaseia de admissão de 2.460 U/dl (valor de referência até 160 U/dl), há 72 horas em tratamento com jejum, hidratação e analgesia em hospital de média complexidade, sem Unidade de Terapia Intensiva. As frequências cardíacas e respiratória estão em 106 batimentos e 26 incursões respiratórias por minuto, a amilaseia elevou-se para 4.280 U/dl, o hematócrito está em 55% (valor de referência de 36 a 46%), os glóbulos brancos de 16.000/ml (valor de referência de 4.000 a 10.000/ml), a ureia e creatinina, respectivamente, de 150 (valor de referência de 16 a 40 mg/dl) e 2,8 (valor de referência de 0,6 a 1,2 mg/dl), as bilirrubinas totais de 6,4 mg/dl (valor de referência de 0,2 a 1,0 mg/dl) e bilirrubina direta de 4,4 mg/dl. Após tomografia de abdome (que mostrou coleções peripancreáticas), foi solicitada a transferência para hospital terciário. Quais os achados que podem justificar o encaminhamento para o hospital terciário?



TOMOGRAFIA DE ABDOME

- A A leucocitose, a hiperbilirrubinemia e a amilaseemia.
- B As coleções peripancreáticas, a amilaseemia e a leucocitose.
- C As coleções peripancreáticas e a hiperbilirrubinemia.
- D A hemoconcentração e a azotemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144226](https://www.4000144226.com)

Questão 105 Via Aérea Cirurgia

Homem de 62 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do segundo andar de um prédio em chamas e levado para o setor de emergência de um hospital. Um familiar relatou que o paciente ficou preso por alguns minutos no cômodo que pegou fogo. Ao exame, apresentava queimaduras em face e outras características que podem ser vistas na figura. Qual a conduta que deve ser tomada mais precocemente?



- A Máscara de oxigênio com FiO_2 a 80%.
- B Intubação orotraqueal e ventilação com FiO_2 a 100%.
- C Reposição volêmica com cristaloides e curativo com sulfadiazina de prata.
- D Reposição volêmica com coloides e curativo com nitrato de cério.

4000144225

Questão 106 Carcinoma espinocelular invasivo

Mulher de 81 anos portadora de um tumor cutâneo doloroso e de crescimento progressivo na região do punho há 1 ano, conforme visto na figura. Qual o diagnóstico mais provável?



TUMOR NO PUNHO

- A Carcinoma basocelular.
- B Verruga vulgar.
- C Melanoma.
- D Carcinoma espinocelular.

4000144224

Questão 107 Tratamento Cirurgia

Homem de 68 anos com queixa de dor em membro inferior direito ao deambular há 10 anos. Relata que a distância que conseguia andar está diminuindo progressivamente e, há 1 mês, relata "escurecimento" progressivo em extremidade do hálux direito e piora da dor no pé que ocorre, agora, mesmo em repouso. Ao exame vascular, apresenta cianose fixa em extremidade do hálux direito e cianose não fixa dos demais artelhos deste pé, sem saída de secreção ou outros sinais flogísticos. Pulsos femorais presentes, porém pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso ausentes à direita e diminuídos à esquerda. Qual a conduta?



PÉ DIREITO



- A Amputação do hálux, antibioticoterapia e revascularização em segundo tempo se não houver cicatrização.
- B Amputação do hálux seguido de arteriografia para programar revascularização.
- C Cirurgia de urgência para realização de tromboembolectomia à Fogarty.
- D Arteriografia para programação de revascularização.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144223

Questão 108 Cirurgia Tratamento

Mulher de 74 anos, hipertensa, obesa e diabética, apresenta queixa de dor em peso e edema vespertino em membros inferiores. Ao exame físico vascular, apresenta varizes tronculares de membros inferiores, edema discreto perimaleolar e dermite ocre bilateral. Possui pequena úlcera (1 x 1 cm) em face maleolar medial em perna direita sem sinais flogísticos. Pulsos em membros inferiores amplos e simétricos. Quais as medidas terapêuticas recomendadas neste caso?

- A Meias elásticas, tratamento cirúrgico de varizes, perda de peso.
- B Cilostazol, ácido acetil-salicílico, tratamento cirúrgico de varizes, perda de peso.
- C Revascularização de membros inferiores, meias elásticas e venotônicos.
- D Venotônicos, posição de Trendelenburg e cilostazol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144222](#)

Questão 109 Diagnóstico Topográfico Avaliação Clínica Neurologia

Mulher de 68 anos, hipertensa e diabética, com quadro de perda súbita de consciência, foi trazida diretamente ao pronto-socorro. Apresentava pressão arterial de 240 x 160 mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm e frequência respiratória de 20 ipm. Ao exame neurológico, não esboçava mobilização de nenhum dos quatro membros. Suas pupilas estavam puntiformes, fracamente reagentes à luz e apresentava ausência dos reflexos córneo-palpebrais e óculo-cefálico, porém com reflexo de tosse presente. Evoluiu rapidamente para respiração apneustica, necessitando de intubação. Sua tomografia de crânio mostrou acidente vascular cerebral hemorrágico. Qual a localização mais provável desta hemorragia?

- A Bulbo.
- B Ponte.
- C Putame.
- D Tálamo.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144221](#)

Questão 110 Cirurgia Vias Aéreas Definitivas Não Cirúrgicas

Paciente de 25 anos foi trazido à sala de urgência após ter sido vítima de espancamento há cerca de 8 horas. Sua avaliação inicial confirmou diagnóstico de traumatismo raquimedular cervical, sem outras lesões traumáticas. Após 2 horas de internação, passou a apresentar quadro clínico compatível com insuficiência respiratória. Qual a conduta?

- A Somente cricotireoidostomia, intubação contraindicada.
- B Intubação orotraqueal ou nasotraqueal.
- C Traqueostomia de emergência.
- D Ventilação não invasiva até realização de tratamento cirúrgico definitivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144220](#)

Questão 111 Tratamento Diagnóstico Gastrologia Pediátrica

Lactente masculino de 9 meses, foi admitido na unidade de pronto atendimento com história de distensão abdominal e febre há 4 dias. Associado ao quadro, refere parada da eliminação de gases e fezes. Antecedentes: nascido a termo, sem comorbidades. Refere atraso na eliminação do mecônio e constipação intestinal desde o período neonatal. Ao exame físico: regular estado geral, desidratado + 1/+4, febril. Abdome: distendido, timpânico à percussão e tenso à palpação. A radiografia de abdome é mostrada na figura. Qual a conduta imediata mais adequada neste momento?



RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME

- A Lavagem intestinal.
- B Laparotomia (abaixamento de cólon).
- C Laparotomia (colostomia).
- D Colonoscopia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144219

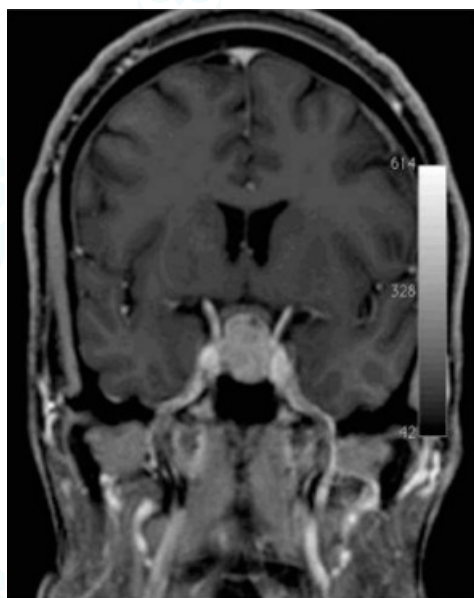
Questão 112

Hiperprolactinemia

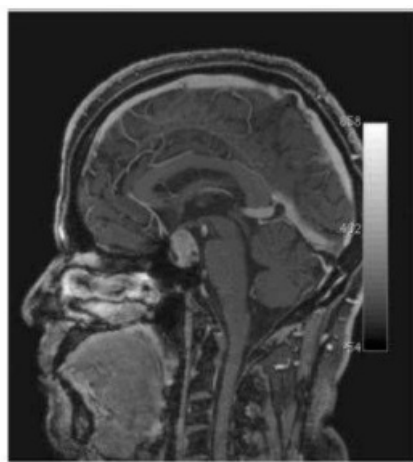
Investigação etiológica

Endocrinologia

Mulher de 28 anos, nuligesta, procura atendimento médico com queixas de cefaleia, perda visual gradual e ganho de peso progressivo sem resposta a dietas. Sua última menstruação foi há 4 meses, e referia ter apresentado alguns episódios de galactorreia espontânea. Exame físico: peso de 99,2 Kg, altura de 1,75 m, índice de massa corporal: 32,4 Kg/m², PA: 120x70 mmHg (deitada e em ortostase), FC: 72 bpm, fossa supraclavicular preenchida, ausência de giba ou pletora facial, ausculta pulmonar e cardíaca normais, abdome globoso e sem estrias violáceas, sem galactorreia à expressão mamária. Investigação laboratorial trouxe os seguintes resultados: hemoglobina: 11,3; hematócrito: 35%; plaquetas: 396.000; glicemia: 85,77 mg/dL; colesterol total: 176,26; triglicérides: 95,03; HDL: 39,93; LDL: 117; ureia: 28; creatinina: 0,79; sódio: 140; potássio: 3,99; prolactina: 78 ng/mL (VR: de 5 a 26) normal e diluída; FSH: 3,49 mUI/mL (VR: de 3,0 a 8,0), T4 livre: 0,82 ng/dL (VR: 0,7 a 1,48); TSH: 1,81 (VR: 0,35 a 4,94). Sua ressonância magnética de sela túrcica é mostrada na figura. Qual o diagnóstico provável e o tratamento inicial?



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CORONAL



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SAGITAL



- A Prolactinoma - antagonista dopaminérgico.
- B Prolactinoma - cirurgia transefenoidal.
- C Macroadenoma não secretor - radioterapia.
- D Macroadenoma não secretor - cirurgia transesfenoidal.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000144218

Questão 113

Profílatia do Tromboembolismo Venoso

Trombose Venosa Profunda TVP

Cirurgia

Homem, 65 anos, em pós-operatório de cirurgia de colocação de prótese total de quadril, evoluindo com boa recuperação clínica, iniciando fisioterapia e deambulação assistida já no primeiro dia de pós-operatório. Qual a conduta mais adequada em relação à profilaxia do tromboembolismo venoso?

- A Medidas mecânicas com fisioterapia assistida e uso de meias elásticas compressivas por 3 meses.
- B Heparina não fracionada em doses profiláticas por 7 a 10 dias.
- C Anticoagulação profilática com warfarina por 30 dias.
- D Heparinas de baixo peso molecular ou anticoagulantes orais diretos por 4 a 6 semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144217](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 114 Deiscência de Ferida Operatória Cirurgia

Homem de 26 anos, previamente hígido, vítima de trauma abdominal fechado, foi admitido em choque hipovolêmico e tratado mediante laparotomia mediana com esplenectomia, enterorrafia de lesão jejunal e síntese fascial de parede abdominal com sutura contínua. Durante visita beira leito de enfermaria, no sétimo dia de pós-operatório, já em boas condições gerais, apresentou saída de grande quantidade de líquido pela incisão cirúrgica ao se levantar. Qual é o diagnóstico e a abordagem com melhor resultado para o paciente e menor custo para o sistema de saúde?



- A Seroma de pele e subcutâneo; retirada de alguns pontos e curativos oclusivos e absorvíveis.
- B Hematoma da loja esplênica; exame de imagem e drenagem percutânea.
- C Infecção de ferida operatória; remoção dos pontos da pele e aplicação de terapia por pressão negativa.
- D Deiscência da ferida operatória; palpação, exploração digital e ressutura da parede abdominal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144216](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 115 Pé Plano

Criança de 2 anos é levado à consulta com queixa de pé chato (sic). A mãe nega que a criança se queixe de dor ou tenha diminuição da atividade. Ao exame, o pé é flexível e não existem outras deformidades ou doenças associadas. Qual a melhor conduta?

- A Indicar o uso de palmilha específica com elevação do arco plantar longitudinal.
- B Acompanhar a criança semestralmente e indicar o tratamento caso comecem a aparecer sintomas como dor e cansaço do pé.
- C Indicar o uso de calçado tipo "botinha" com elevação do arco longitudinal durante pelo menos 10 horas por dia.
- D Orientar a mãe quanto a tendência de melhora espontânea e sugerir uma reavaliação após os 6 anos de idade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144215](#)

Questão 116 Malformações Anorretais Hidronefrose Antenatal Cirurgia Infantil

Recém-nascido de 2 dias de vida, sexo aparentemente feminino (anomalia anorretal complexa), encaminhado de outro serviço. Na admissão: bom estado geral, hidratado (com soro de manutenção via endovenosa), corado, eupneico, afebril. Ao exame físico: genitália de fenótipo feminino, porém com orifício perineal único, anterior, próximo ao clitóris, com saída de urina em gotejamento. Ausência de orifício anal. Abdome globoso, indolor e sem resistência à palpação. Presença de massa palpável em hipogástrio e flanco esquerdo. Considerando o provável diagnóstico, como podemos interpretar o achado de massa palpável?

- A Metrocolpos.
- B Hidronefrose.
- C Bexigoma.
- D Fecaloma.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

4000144214

Questão 117 Complicações

Homem, 33 anos, politraumatizado grave e com trauma contuso em laringe. Está em terapia intensiva e em ventilação mecânica há 4 semanas através de cânula de traqueostomia com balonete (a traqueostomia foi realizada no quinto dia de ventilação mecânica). Nas últimas 24 horas, apresentou dois episódios de sangramento vivo quando realizada a aspiração pela cânula de traqueostomia e desinsuflado o balonete (estimados em 50 ml de volume de sangue vivo em cada episódio). Qual a causa provável do sangramento observado?

- A Doença pulmonar associada à ventilação mecânica ($FiO_2 = 100\%$).
- B Erosão da artéria inominada (fístula tráqueo-inominada).
- C Tecido de granulação no óstio do traqueostoma associado ao trauma de laringe.
- D Erosão da veia jugular interna ou de ramo arterial carotídeo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144213](#)

Questão 118 Temas Gerais em Cirurgia

No período de preparo para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, houve priorização para tratamento cirúrgico dos pacientes com necessidades que configurassem urgência ou emergência, visando garantir a capacidade hospitalar adequada para atender a um fluxo antecipado de pacientes com Covid-19. Dentre os quatro casos apresentados, nas circunstâncias da pandemia de Covid 19, qual seria incluído como alta priorização para tratamento cirúrgico, com disponibilidade de anestesia geral, nos próximos 7 dias?

- A Mulher, 34 anos, para reconstrução do trânsito intestinal após peritonite por trauma fechado, ressecção parcial de jejuno e íleo, há 2 meses, estável, em nutrição parenteral total hospitalar.
- B Mulher, 25 anos, disfagia progressiva de líquidos para sólidos com acalasia idiopática do esôfago e megaesôfago grau 111, emagrecida, atendida mediante encaixe de urgência no ambulatório.
- C Homem, 61 anos, dor epigástrica, plenitude pós prandial, síndrome consumptiva há 1 mês com vômitos alimentares, desidratado, oligúrico, admitido há 8 horas na sala de urgência.
- D Homem, 63 anos, síndrome consumptiva há 2 meses, colestase há 15 dias com neoplasia de confluência biliopancreática localmente avançada, aguardando início de quimioterapia.

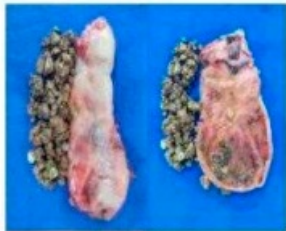
4 000144 212

Questão 119 **Cirurgia** **Colecistite Aguda**

Mulher de 33 anos, há 4 meses apresenta dor do tipo contínua-intermitente (duração de cerca de 1 hora) no hipocôndrio direito e epigástrico. No último mês, passou por 2 atendimentos em Unidade Básica de Saúde e uma passagem em Unidade de Pronto Atendimento com diagnóstico clínico e de imagem de colelitíase. Há 16 horas apresenta dor contínua no mesmo local, defesa involuntária à palpação superficial e profunda, sem febre e disfunções orgânicas. Foi encaminhada para hospital de urgência na vigência da pandemia de Covid-19. O hemograma, a amilase, as aminotransferases e as bilirrubinas estavam normais. A ultrassonografia abdominal foi repetida e iniciou-se jejum, hidratação, antibiótico e procedeu-se à colecistectomia por videolaparoscopia. Com base na conduta adotada, qual a alternativa correta?



ULTRASSOM



PEÇA CIRÚRGICA

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A A repetição da ultrassonografia foi desnecessária, o tratamento indicado foi oportuno, mas o acesso por laparotomia ou percutâneo seriam mais adequados em função da pandemia.
- B Tratava-se de cólica ou dor biliar mantida sem infecção aguda e o tratamento com dieta hipogordurosa, anti-inflamatórios e antiespasmódicos seriam mais adequados.
- C As necessidades de atendimento pela pandemia e os riscos de disseminação do vírus pela videolaparoscopia justificariam a opção pelo tratamento com analgésicos e antibioticoterapia.
- D Tratava-se de colecistite aguda branda, o tratamento indicado foi oportuno, bem como o acesso por videolaparoscopia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144212](https://4000144212.com)

Questão 120 **Manejo PósOperatório**

Homem, 70 anos, desenvolveu quadro pneumônico e insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica e

cuidados de terapia intensiva. Após 7 dias foi submetido à traqueostomia em segundo anel traqueal. Com relação à traqueostomia, qual a alternativa correta?

- A Durante a ventilação mecânica, é preferível manter a cânula plástica com ""cuff"" de alta pressão a fim de se evitar o escape aéreo.
- B Quando houver condições de alta hospitalar, a cânula plástica com ""cuff"" é mais confortável ao paciente e de mais fácil manuseio (pelo paciente e cuidadores) em comparação com a cânula metálica.
- C Para decanulação, realiza-se a retirada da cânula e fechamento da fístula com microporagem, desde que o paciente tenha mantido a cânula ocluída por 24h.
- D A traqueostomia em segundo anel traqueal não é o mais adequado. Sempre que possível, deve ser realizada em anéis mais inferiores, especialmente em crianças, a fim de se evitar a estenose subglótica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000144210](https://www.4000144210.com.br)

Respostas:

1	A	2	D	3	B	4	D	5	A	6	A	7	D	8	D	9	D	10	C	11	D
12	A	13	A	14	D	15	B	16	B	17	C	18	A	19	B	20	C	21	C	22	D
23	D	24	A	25	C	26	C	27	A	28	D	29	D	30	A	31	B	32	B	33	B
34	D	35	C	36	D	37	B	38	D	39	C	40	B	41	D	42	C	43	B	44	A
45	B	46	A	47	C	48	B	49	D	50	B	51	B	52	B	53	B	54	A	55	C
56	C	57	B	58	C	59	D	60	C	61	A	62	C	63	C	64	A	65	A	66	A
67	C	68	B	69	A	70	C	71	D	72	D	73	A	74	A	75	C	76	A	77	C
78	C	79	A	80	C	81	C	82	C	83	D	84	D	85	C	86	D	87	C	88	D
89	B	90	A	91	D	92	C	93	D	94	B	95	D	96	B	97	A	98	A	99	A
100	C	101	A	102	B	103	A	104	D	105	B	106	D	107	D	108	A	109	B	110	B
111	A	112	D	113	D	114	D	115	D	116	B	117	B	118	A	119	D	120	C		

Questão 1 Diagnóstico Infectologia

Lactente com 1 ano e 8 meses de vida está em consulta de rotina em UBS, após ter mudado de cidade. Mãe relata que possui a infecção pelo vírus HIV, tendo descoberto no dia do parto da criança. Recebeu as medicações durante o parto e a criança tomou as medicações de prevenção da infecção, além de ter seguido todas as orientações dadas, tendo recebido medicação para bloquear o aleitamento. Realizou o acompanhamento médico da criança, mas acabou perdendo a última consulta. Possuía o resultado dos exames realizados pela criança:

Exame 1: Quantificação da carga viral do HIV (idade: 1d) não detectável

Exame 2: Quantificação da carga viral do HIV (idade: 1m15d): não detectável

Exame 3: Quantificação da carga viral do HIV (idade: 3m15d) não detectável

Você resolve solicitar um ELISA para HIV, último exame a ser feito pelo bebê exposto, tendo em vista que a criança já possui mais de 18 meses de vida e estava bem. O resultado deste exame é o seguinte:

Elisa para Anti-HIV:

Cut-off: 1,00

Título: 5,00

Resultado: REAGENTE

Considerando as informações acima, qual a conduta adequada nesta situação?

- ☐ A Orientar a mãe que a criança está infectada e iniciar tratamento precocemente.
- ☐ B Solicitar Western Blot para confirmar a infecção da criança e planejar seguimento.
- ☐ C Verificar a imunidade da criança e encaminhar para seguimento especializado.
- ☐ D Repetir a sorologia após 1 mês, considerando possível resultado falso positivo.

4000164322

Questão 2 Critérios diagnósticos Maturity Onset Diabetes of the Young MODY

Durante a realização de exames pré-operatórios para uma cirurgia eletiva em uma adolescente com 13 anos de idade é detectada uma glicemia em jejum de 138 mg/dL. Esta paciente não apresenta poliúria, polidipsia ou perda de peso recente. Tem uma irmã com 8 anos hígida. A mãe tem 40 anos, é obesa, porém não tem diabetes. O pai apresenta diabetes melito diagnosticado aos 34 anos e em tratamento com sulfonilreia no presente. Esta paciente teve menarca há 2 anos e apresenta ciclos regulares. Sua estatura está no percentil 75, seu peso no percentil 50 e não apresenta lesões cutâneas. A avaliação laboratorial subsequente evidenciou: HbA1c = 6,7%; glicemia = 142 mg/dL; exame de urina rotina (EAS) = ausência de glicosúria, proteinúria e cetonúria; anticorpo anti-GAD = indetectável; anticorpo anti-ICA 5112 = indetectável.

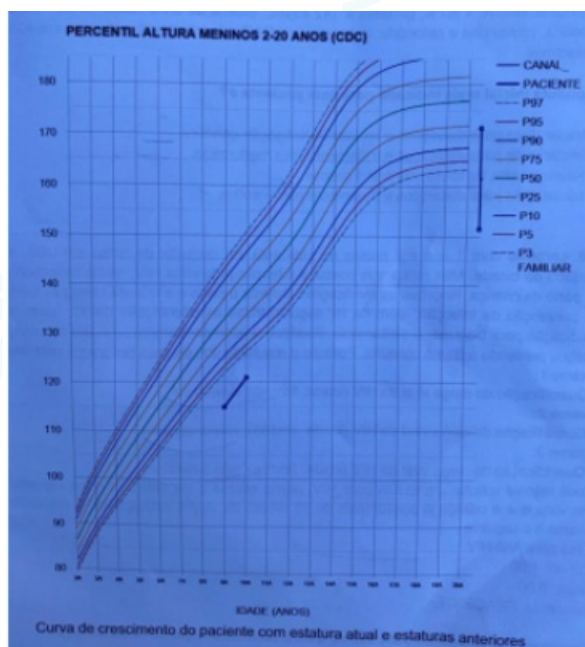
A conduta inicial mais indicada para esta paciente é?

- A Iniciar dieta para diabéticos e realizar investigação genética.
- B Iniciar dieta para diabéticos e tratamento com metformina.
- C Realizar teste de tolerância oral à glicose.
- D Iniciar dieta para diabéticos e tratamento com insulina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164321](https://www.4000164321.com)

Questão 3 Doenças Esqueléticas Pediatria

Um paciente com 13 anos é avaliado por apresentar problemas no crescimento. Nasceu a termo, peso adequado para a idade gestacional, DNPM adequado, não tem histórico de doenças prolongadas, cirurgias ou uso prolongado de medicações. É o único filho. Seu pai mede 167 cm; sua mãe mede 145 cm e teve menarca aos 12 anos. Atualmente o paciente mede 140 cm (ver curva abaixo, onde estaturas anteriores são apresentadas), seu IMC está no percentil 25, sua envergadura é 134 cm, seu segmento inferior (púbis-pé) mede 66 cm, sua estatura sentado é de 84 cm e a relação estatura total pela estatura sentada é de 0,6. Encontra-se impúbere (G1P1). Sua idade óssea é de 12 anos.



De acordo com os dados clínicos apresentados, a causa mais provável da baixa estatura deste paciente é?

- A Deficiência isolada de hormônio do crescimento.
- B Hipopituitarismo.
- C Displasia esquelética.
- D Variante da normalidade: baixa estatura constitucional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164320](https://www.4000164320.com)

Questão 4 Imunodeficiências primárias Vacinas inativadas Vacinas vivas atenuadas

Lactente, 15 dias de vida, apresenta teste do pezinho ampliado com identificação de imunodeficiência combinada grave (SCID). A criança se encontra assintomática. Os pais estão muito preocupados com o diagnóstico e questionam sobre os cuidados que precisam ter com o filho.

Com relação a vacinação, qual a sua orientação?

- A Contraindicar as vacinas de vírus vivos atenuados sem restrições com relação às demais vacinas do calendário.
- B A aplicação das vacinas apenas deverá ser adiada nas situações em que a criança apresentar alguma infecção ativa.
- C Até que confirme o diagnóstico a criança pode receber as imunizações do calendário nacional sem restrições.
- D Contraindicar todas as vacinas vivas atenuadas e orientar que seja feita a aplicação das demais vacinas do calendário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164319](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 5 Definição das síndromes talassêmicas Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas

Pré-escolar do sexo masculino, de 4 anos de idade, compareceu a consulta rotina de puericultura. Pais não relatavam queixas clínicas neste atendimento. Descrevem boa alimentação e bom desenvolvimento global. Peso e estatura ambos nos percentis 50 (P50) para idade e gênero. Pediatra observou mucosas levemente descoradas (+/4+) ao exame clínico, e sem outros achados de importância no exame físico. O paciente retorna hoje (1 semana após) para avaliação de resultado de exame hematológico solicitado na consulta prévia. Traz o seguinte laudo de exame hematemétrico: eritrócitos 5,55 milhões/mm³ (VN: 3,6 a 5,2); hemoglobina 10,40 g/dL (VN: 11 a 13,1 g/dL); hematócrito 32,10% (VN: 35,0 - 43,0%); VCM 57,83 fL (VN: 74,0 a 102,0 fL); HCM 18,73 pg (VN: 23,0 a 31,0 pg); CHCM 32,39 g/dL (VN: 26,0 a 34,0 g/dL) RDW 13,6 % (VN: 11,5 a 14,5%). Série vermelha: microcitose e hipocromia discretas; ausência de anisocitose.

Com base nos dados clínicos e laboratoriais apresentados, qual a alternativa que corresponde a melhor conduta a ser adotada para o caso?

- A Solicitar exame de eletroforese de hemoglobina.
- B Melhorar o aporte de ferro com alimentos ricos em ferro.
- C Prescrever ferro elementar (4 mg/k/dia) por 3 meses.
- D Pesquisar perda de sangue oculto nas fezes.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164318](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 6 Infecção de Trato Urinário ITU Pediatria

Em uma consulta de rotina a mãe refere que sua filha de 5 anos teve disúria e polaciúria, sem febre, por 3 dias, há 10 dias atrás. Foi atendida na UPA sendo solicitado exame de urina, que foi coletado por jato médio. Após avaliação do exame de urina tipo 1 foi prescrito sulfametoxazol + trimetoprima (SMZ+T) VO e marcado retorno em 2 dias para checagem do resultado de urocultura. A mãe refere que a criança está bem e que a sintomatologia desapareceu com 48 horas de tratamento medicamentoso. Por isso resolveu aguardar a consulta de puericultura para avaliação do resultado da cultura de urina. Antecedentes da criança: asma brônquica e constipação intestinal funcional. Nega quadro semelhante anteriormente.

Exames trazidos pela mãe:

- Urina tipo 1: densidade 1,012; pH 5, nitrito positivo, proteína 50 mg/L, leucócitos 200-250 por campo, hemácias 20-30 por campo;
- Urocultura: 300.000 UFC/mL de E coli, sensível a sulfametoxazol + trimetoprima.

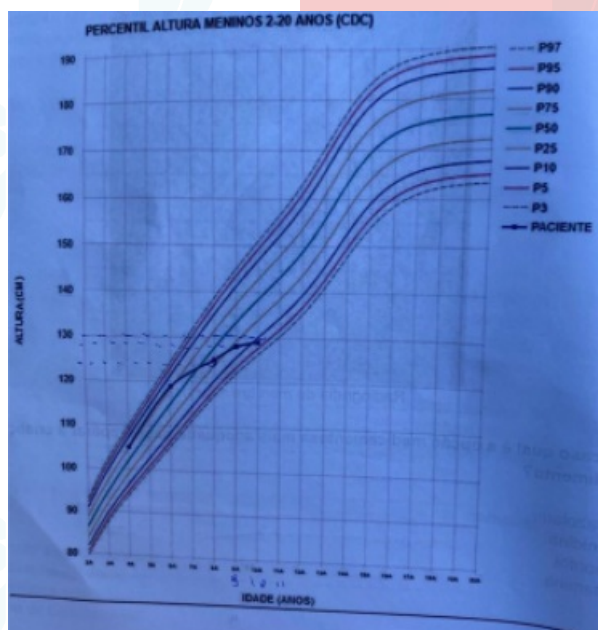
Qual a conduta mais adequada para esse caso?

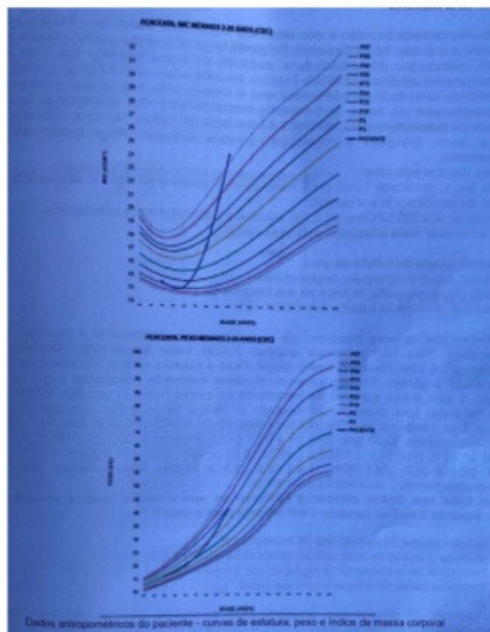
- A Repetir exame de cultura de urina.
- B Manter seguimento regular de puericultura.
- C Pedir ultrassonografia de rins e de vias urinárias.
- D Realizar cintilografia estática com DMSA.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164317](https://www.4000164317.com)

Questão 7 Curvas de Crescimento Pediatria

Os pais de um paciente com 10 anos de idade estão preocupados com a estatura e seu ganho de peso nos últimos 2 a 3 anos (ver dados nas curvas abaixo) e com o escurecimento importante da pele do pescoço e axilas, que no exame físico é confirmado ser acantose nigricans. No último ano ele já recebeu orientação da dieta hipocalórica, porém ainda ingere sucos industrializados, doces e guloseimas diariamente. Há cerca de três anos os pais se separaram e houve necessidade de mudança de escola e do círculo de amigos do paciente, em função de mudança de cidade. Mãe acha que o paciente se sente triste e isolado na escola, não participando das brincadeiras. Não pratica atividade física regular, pois está referindo ficar muito cansado. Passa a maior tempo fora da escola dentro do apartamento e gosta muito de jogos eletrônicos. Mãe refere que ela também ganhou peso excessivamente nos últimos anos. Para a consulta atual traz exames recentes que evidenciaram: glicemia = 97 mg/dL; HbA1c = 6,2%; colesterol total = 233 mg/dL; colesterol HDL = 38 mg/dL; triglicérides = 206 mg/dL.





Considerando os dados apresentados, qual a conduta mais indicada para este paciente, neste momento?

- A Orientar dieta equilibrada normocalórica e realização de 60 minutos diários de atividade física leve.
- B Realizar investigação bioquímica adicional buscando a causa do ganho de peso, antes de qualquer medida terapêutica.
- C Orientar dieta equilibrada normocalórica e realização de 60 minutos diários de atividade física moderada a intensa.
- D Orientar dieta equilibrada com leve restrição calórica, realização de 60 minutos diários de atividade física moderada a intensa e iniciar tratamento com metformina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164316

Questão 8 Agentes Intravenosos Cirurgia

Menino, 6 anos de idade, apresentou queda da própria altura sobre o membro superior esquerdo, evoluindo com dor e edema no cotovelo. Realizada radiografia ilustrada na figura abaixo que evidenciou luxação do cotovelo esquerdo. Mãe refere que criança tem asma, mas que está controlada com uso de beclometasona via inalatória. Nega internações prévias e última refeição foi há 8 horas.



Neste caso qual é a opção medicamentosa mais adequada para preparar a criança para o procedimento?

- A Midazolam.
- B Clonidina.
- C Propofol.
- D Cetamina.

4000164315

Questão 9 **Cardiopediatria e Cardiopatias congênicas** **Pediatria**

Menina de 4 anos é trazida para consulta em unidade básica de saúde. Pais percebem que criança respira rápido e forte durante as atividades físicas e para de brincar com pouco tempo de exercícios. Durante o exame físico observa-se: bom estado geral, corada, hidratada, acianótica (sat O₂ 96% em membro superior esquerdo). Aparelho respiratório: murmúrio vesicular audível difusamente, sem ruídos adventícios, sem esforço, FR: 20 irpm. Aparelho cardiovascular: ritmo regular com 2 bulhas normofonéticas, sem sopros audíveis, FC: 90 bpm; pulsos cheios em membros superiores e de difícil palpação em membros inferiores. Abdome flácido, indolor e sem massas palpáveis; extremidades sem edema, mãos aquecidas e pés frios.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual seria a complicação mais frequente?

- A Hipertensão arterial sistêmica.
- B Enterocolite necrotizante.
- C Crise asmática grave.
- D Síndrome de Eisenmenger.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164315](#)

Questão 10 **Diarreia Crônica**

Menina, 2 anos, apresenta quadro de diarreia, sem muco ou sangue, 3 vezes ao dia, aumento de volume abdominal e déficit pondero-estatural há cerca de 1 ano. Concomitantemente apresenta edema de membros inferiores, mais acentuado à direita, que segundo a mãe, surgiu desde o nascimento. Mantém bom apetite, família de classe média. Nega outras comorbidades. Pais hígidos, sem história de consanguinidade.

Exames laboratoriais:

Albumina = 2,0 g/dL (Valor de referência 3,0 a 4,8 g/dL);

Hemograma: Hb = 10,0 g/dL; GB = 7000 (linfócitos <2 x 10⁹/L = linfopenia), plaquetas normais;

Gama-globulina = 0,3 g/dL (valor de referência 0,6 a 1,79);

Urina rotina normal;

Ureia e creatina normais.

Alfa-1-Antitripsina fecal = 0,9 mg/g fezes (valor de referência <0,30);

Esteatócrito = 5% (VR <2).

Qual a principal hipótese diagnóstica para esta criança?

- A Deficiência congênita de IgA.
- B Linfangiectasia intestinal.
- C Deficiência de alfa-1-antripsina.
- D Fibrose cística.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164313](https://www.4000164313.com.br)

Questão 11 **Pediatria** **Diagnóstico**

Menino de 5 anos é trazido à consulta de puericultura sem queixas. Peso: 19 kg (P50), altura: 109 cm, PA: 106 x 64 mmHg (repetida e confirmada), restante do exame físico sem alterações.

Tabela 1. Percentis de Pressão Arterial Sistêmica para Meninos por Idade e Percentis de Estatura

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistêmica (mmHg)								Pressão Arterial Diastólica (mmHg)							
		Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)								Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	
5	Estatura (cm)	104,4	106,2	109,3	112,4	115,7	118,6	120,3	104,4	106,2	109,3	112,4	115,7	118,6	120,3		
	P50	91	92	93	94	95	96	96	51	51	52	53	54	55	55		
	P90	103	104	105	106	107	108	108	63	64	65	66	67	67			
	P95	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71		
	P95 + 12 mmHg	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83		

Fragmento da tabela da diretriz brasileira de hipertensão arterial na infância

Consultando a tabela abaixo, como se classifica a pressão aferida nesta consulta?

- A Pressão arterial elevada.
- B Hipertensão estágio 2.
- C Hipertensão estágio 1.
- D Pressão arterial normal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164313](https://www.4000164313.com.br)

Questão 12 **Miopatias autoimunes sistêmicas juvenis** **Dermatomiosite** [t.me/medicinalivre](https://www.t.me/medicinalivre)

Mãe refere que seu filho de 8 anos está apresentando quedas frequentes ao solo há 3 semanas. Refere dificuldades em subir escadas e de se levantar da posição sentada, necessitando de ajuda. Criança está deprimida e irritada. Ao exame físico você nota sua pele avermelhada (foto abaixo), dificuldade de manter os braços elevados e de subir a escada para sentar-se na maca.



Qual a hipótese diagnóstica principal?

- A Dermatomiosite juvenil.
- B Síndrome de Guillain-Barré.
- C Lupus eritematoso sistêmico juvenil.
- D Miosite viral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164311](#)

Questão 13 Imunodeficiências do sistema complemento

Menino com 4 anos, foi atendido no pronto atendimento com febre, cefaleia, queda do estado geral e vômitos, iniciados há 1 dia. Internado para investigação. Pais relatam que a criança já apresentou dois episódios prévios de meningite (aos 12 e 18 meses de vida), ambos confirmados por cultura de líquido como sendo meningocócicas, requerendo internação hospitalar e tratamento com antibiótico endovenoso. Ao exame: TA 39°C; prostração; FC 140 bpm; FR 50 mrpm; demais aspectos do exame físico normais. Exames laboratoriais: Hemograma: Hb 11,7 Ht 34% GB 15.900 Neutrófilos 14.110 (20% de bastonetes, 80% segmentados) Plaquetas 345.000. Líquor: aspecto turvo, proteínas aumentadas, glicose consumida, presença de células em grande quantidade e cocos gram negativos.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Deficiência do sistema complemento.
- B Agamaglobulinemia congênita.
- C Doença granulomatosa crônica.
- D Imunodeficiência combinada grave.

Contra preços abusivos na medicina.

4000164310

Questão 14 Pediatria Doença hemolítica ABO Hiperbilirrubinemia não fisiológica

Recém-nascido (RN) do sexo masculino, nascido de parto normal com 38 semanas de gestação, pesando 2900g. Apgar 7/9. Mãe de 30 anos, G2P2A0, sem comorbidades, recebeu imunoglobulina anti-D com 28 semanas de gestação; tem história de que o filho anterior recebeu fototerapia ao nascimento. Doze horas após o nascimento, a mãe se queixou que não tinha produção láctea, e que o RN estava sonolento e não sugava o seio. No exame físico, o RN estava em bom estado geral, sonolento, reativo à manipulação, com tônus preservado e reflexos primitivos presentes. Apresentava cefalohematoma parietal à direita, icterícia em face e tronco, sem outras anormalidades no exame físico.

Foram realizados os seguintes exames:

Tipo sanguíneo da mãe: O negativo, Coombs indireto negativo;
Tipo sanguíneo do RN: A positivo, Coombs direto negativo;
Glicemia capilar 58 mg/dl;
Sódio 138,2 mmol/L;
Bilirrubina total 8 mg/dL, bilirrubina direta 0,24 mg/dl;
Hemoglobina total 17,0 g/dL, hematócrito 52%.

O RN foi colocado em fototerapia.

Qual a causa mais provável de icterícia neste paciente?

- A Oferta inadequada de leite materno.
- B Incompatibilidade RH.
- C Incompatibilidade ABO.
- D Secundária à absorção de cefalohematoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164309](#)

Questão 15 Tratamento

Paciente de 4 anos de idade, vítima de picada por escorpião, chega à sala de emergência pediátrica uma hora após o acidente apresentando sudorese profusa, piloereção, vômitos incoercíveis, frequência cardíaca 150 bpm, frequência respiratória 40 ipm, pressão arterial 85/50 mmHg, pulsos centrais finos e tempo de enchimento capilar 5 segundos. À ausculta pulmonar, há estertores finos difusos e a saturação periférica de oxigênio (SpO₂) é de 90% em ar ambiente. Logo após a admissão, é colocado coxim abaixo do occipício, feita aspiração de vias aéreas superiores, administrado oxigênio por máscara não reinalante e administradas 6 ampolas de soro antiescorpiônico via endovenosa. A SpO₂ após início da oxigenoterapia é de 94%, mas o quadro hemodinâmico se mantém inalterado.

O próximo passo do tratamento é iniciar por infusão EV contínua:

- A Norepinefrina.
- B Dobutamina.
- C Epinefrina.
- D Vasopressina.

Contra preços abusivos na medicina.

4000164308

Questão 16 Reanimação neonatal Recepção do neonato com boa vitalidade

Em relação à avaliação da vitalidade imediatamente após o nascimento, quando o neonato ainda está ligado ao cordão, ainda em campo obstétrico.

- A Cianose.
- B Frequência cardíaca diminuída.
- C Frequência respiratória aumentada ou diminuída.
- D Hipotonia.

4000164307

Questão 17 Tratamento da síndrome hemolítico urêmica SHU Quadro clínico da síndrome hemolítico urêmica SHU

Criança eutrófica, da raça negra, com 9 meses de idade e quadro de diarreia com sangue há 5 dias. Está fazendo uso de ceftriaxona IM há 4 dias. Mãe refere que apesar da melhora da diarreia a criança está urinando menos, com edema palpebral discreto e está mais irritada há 1 dia. Exame físico: criança hidratada, pálida +++/4+; edema palpebral bilateral, FR 40 ipm FC 140 bpm, 2 bulhas rítmicas e normofonéticas com sopro sistólico suave, PA 120 x 80 mmHg. Exames colhidos

no pronto socorro. Hemograma: Hb 6,0 g/dL, Ht 17,9 %, GB 18.500 e plaquetas 75.000. Reticulocitose. Ureia 70 e creatinina 2,5 mg/Dl. Urina tipo 1: densidade 1,012; pH 5,5; proteinúria ++, leucócitos 10 por campo e hemácias 15 por campo de grande aumento.

Com relação a anemia, qual o tratamento mais indicado nesse momento?

- A Eritropoetina subcutânea.
- B Reposição de ferro.
- C Corticoterapia.
- D Concentrado de hemácias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164306](https://www.4000164306.com.br)

Questão 18 Tratamento Pediatria

Lactente de 1 ano de idade, apresenta diarreia há 6 meses, caracterizada por fezes líquidas, moderada quantidade, 4 vezes por dia, odor fétido, distensão abdominal, sem sangue ou muco. Mãe refere que simultaneamente apresenta dificuldade de ganho de peso e de estatura. Os exames laboratoriais revelaram:

Hemoglobina = 9,0 g/dl;

Albumina = 2,5 g/dL (valor de referência 2,9 a 4,8 g/dL);

Anti-tranglutaminase IgA = positivo;

Dosagem de imunoglobulinas: IgA = normal para a idade.

Para esta criança, além do trigo, qual outro componente você excluiria da dieta?

- A Linhaça e aveia.
- B Tapioca e polvilho.
- C Maisena e trigo de sarraceno.
- D Centeio e cevada.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164306](https://www.4000164306.com.br)

Questão 19 Tumores Sólidos Abdominais da Infância Cirurgia

Criança de 2 anos e 11 meses de idade é trazida a consulta de puericultura pela mãe. Relata que ela percebeu caroço na barriga (sic) ao dar banho na criança, há 1 semana. Diz também que há cerca de um mês criança tem queixado-se de dores abdominais em cólica, quase que diárias, de curta duração e resolução espontânea. Criança permanece bem, sem queda do estado geral, sem alterações do apetite ou das atividades diárias. Pais negam queixas digestivas ou gênito-urinárias. Não há história de constipação intestinal. Ao exame físico a criança apresentava-se em bom estado geral, afebril, corada, eupneica, com massa palpável no flanco direito, endurecida, fixa, indolor, medindo aproximadamente 8 cm no seu maior eixo.

Com base nos achados acima descritos, qual a hipótese diagnóstica mais provável para este caso?

- A Tumor de Wilms.
- B Neuroblastoma.
- C Hepatoblastoma.
- D Linfoma não-Hodgkin.

Questão 20 Crises de Início Generalizado Neurologia Crises Epiléticas

Uma menina de quatro anos, previamente hígida, foi atendida em pronto atendimento com crise epilética do tipo tônico-clônico generalizada, com duração inferior a um minuto, em vigência de febre aferida em 39°C. Encontrava-se em tratamento de infecção de via aérea superior há 2 dias. Havia relato de crise febril no irmão mais velho. À família foi pontuada a principal hipótese diagnóstica e foram esclarecidos riscos para recorrência de evento similar.

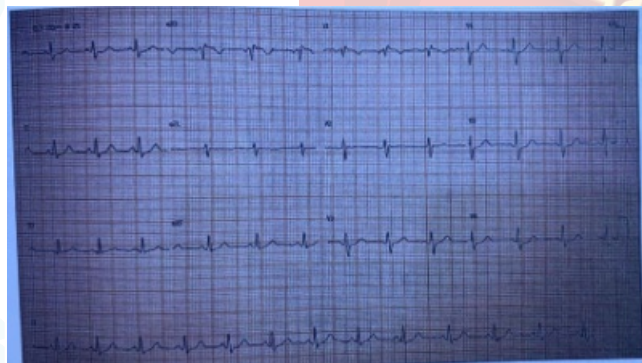
Qual dos fatores abaixo se apresenta como risco de recorrência nesse caso clínico?

- A Pico de temperatura elevado.
- B Intervalo curto entre doença febril e evento.
- C Idade precoce para o primeiro evento.
- D História familiar de crise febril.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164304](https://www.4000164304.com)

Questão 21 Indicações de cateterismo Cardiologia

Homem, 67 anos, hipertenso, diabético tipo 2, dislipidêmico, obeso e tabagista ativo. Previamente assintomático, procura atendimento médico devido a quadro de dor torácica, em queimação, de intensidade 5/10, sem irradiação ou outros sintomas associados e que se inicia após realização de moderados esforços. Refere início da dor há 2 semanas, sendo que há 1 semana tem sido mais frequente e de maior intensidade. Exame físico: sem alterações significativas. Eletrocardiograma abaixo.



Qual é o método de avaliação mais indicado para investigação do quadro clínico?

- A Angiotomografia de coronária.
- B Cintilografia miocárdica com dipiridamol.
- C Cateterismo cardíaco.
- D Teste ergométrico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164302](https://www.4000164302.com)

Questão 22 Clínica Médica Hepatologia Icterícia não Obstrutiva

Homem, 72 anos, relata olhos e pele amarelos há duas semanas, acompanhados de prurido cutâneo difuso, principalmente à noite. Sem outros sintomas. Alguns dias antes do início do quadro, percebeu sua urina mais escura. Não observou as

características das fezes. Exame físico: icterício, com escoriações no tronco e nos membros. Sem outras alterações.

Qual é a alteração do metabolismo da bilirrubina mais provável?

- A Deficiência de produção da fração conjugada.
- B Deficiência da captação da fração indireta.
- C Prejuízo da excreção da fração conjugada.
- D Aumento da produção da fração indireta.

4000164301

Questão 23 Definição Nefrologia

Homem, 65 anos, hipertenso há 30 anos, refere poliúria, sem outras queixas. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial com valor médio de PA = 170 x 100 mmHg, em uso de anlodipina, carvedilol e furosemida. Exame físico sem alterações. Ultra-sonografia: rins de dimensões reduzidas, 7,5 cm na maior dimensão bilateralmente, com perda da diferenciação entre córtex e medula.

Considerando o diagnóstico sindrômico renal, quais parâmetros são utilizados para o estadiamento?

- A Creatinina plasmática e urina rotina.
- B Relação ureia/creatinina plasmática e fração de excreção de sódio.
- C Proteinúria de 24hs e clearance de creatinina.
- D Taxa de filtração glomerular e relação albumina/creatinina urinária.

4000164300

Questão 24 Gota

Homem, 48 anos, tabagista e etilista, há 20 anos apresenta dor articular. O quadro teve início nos membros inferiores e ocorria como surto-remissão. Após alguns anos, os membros superiores foram acometidos, quando passou a ter sintomas articulares persistentes. Exame físico: BEG, corado. Edema, calor, dor e limitação de movimentos em tornozelos, joelhos, punhos e metacarpofalangeanas. Foto de sua mão esquerda é mostrada abaixo.



De qual alteração fisiopatológica resultam as lesões?

- A Calcificação de tecidos moles.
- B Necrose caseosa da derme.
- C Coleções de pus na derme.
- D Depósito subcutâneo de cristais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164299](#)

Questão 25 Artrite reumatoide AR

Mulher, 52 anos, há três anos tem o diagnóstico de artrite reumatoide, cujo tratamento não atingiu remissão da inflamação articular, a despeito do uso de diversos esquemas terapêuticos. Ao exame: hipotrofia de musculatura intrínseca das mãos, com edema de punhos, desvio ulnar dos quirodáctilos e hiperextensão de interfalangeanas proximais das mãos.

Na radiografia das mãos, qual é a alteração esperada nas articulações acometidas?

- A Calcificação periarticular.
- B Esclerose óssea subcondral.
- C Erosões ósseas justa-articulares.
- D Osteófitos marginais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164298](#)

Questão 26 Exacerbação Aguda da DPOC EADPOC Pneumologia

Mulher, 72 anos, tabagista (80 anos-maço), refere dispneia progressiva e tosse com expectoração amarelada pela manhã há 10 anos. Há 4 dias com aumento do volume de expectoração (que se tornou mais escura) e piora da dispneia. Exame físico: REG, consciente, Glasgow 15. Ausculta respiratória: murmúrio vesicular reduzido bilateralmente, com sibilos difusos. FR: 30 ipm. FC: 110 bpm; PA: 112 x 72 mmHg. Gasometria arterial em ar ambiente pH: 7,28; pO₂: 50 mmHg; pCO₂: 54 mmHg; HCO₃: 28 mEq/L; saturação O₂: 84%.

Qual intervenção mais adequada neste momento?

- A Intubação e ventilação mecânica.
- B Ventilação não-invasiva.
- C Cateter nasal de alto fluxo.
- D Máscara de Venturi.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164297](#)

Questão 27 Síndrome nefrótica Nefrologia

Mulher, 60 anos, procura atendimento por ganho de peso (10kg), urina espumosa e edema, em face e extremidades nos últimos 3 meses.

Exame físico: BEG, corada, hidratada, eupneica, afebril. Edema 4+/4+. PA = 106 x 70 mmHg, sem outras alterações. Exames laboratoriais: creatinina = 0,7 mg/dL; ureia = 30 mg/dL; sódio = 131 mmol/L; potássio = 4,2 mmol/L; albumina = 2,1 g/dL; proteinúria = 6.500 mg/24h.

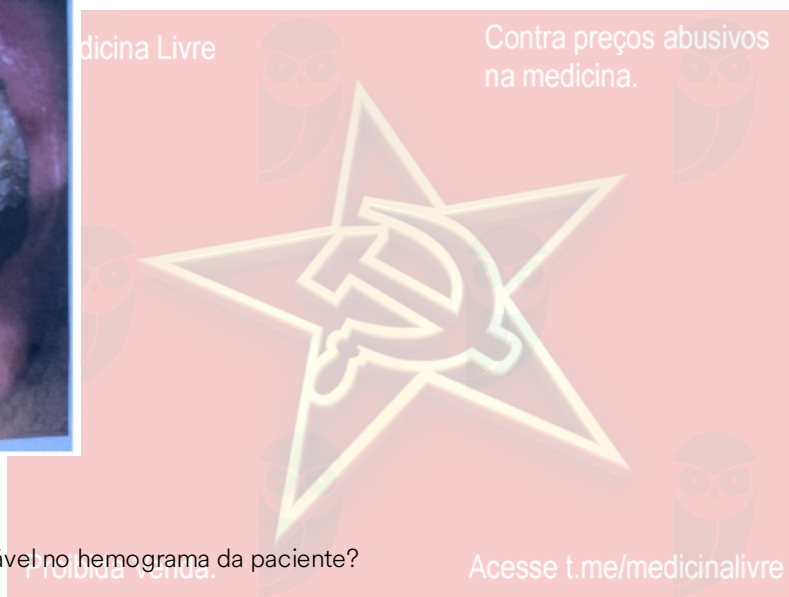
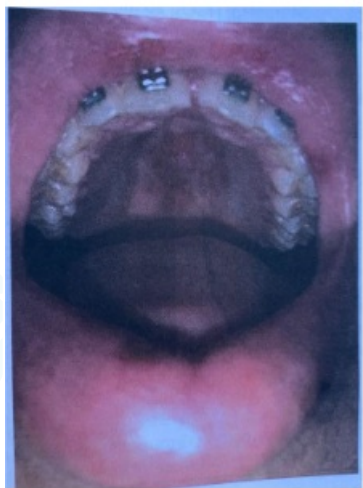
Qual achado mais provável na urina, além de proteína?

- A Cilindros granulosos.
- B Lipídios.
- C Leucócitos.
- D Cilindros eritrocitários.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164295](https://www.4000164295.com)

Questão 28 Lúpus Eritematoso Sistêmico LES

Mulher, 20 anos, queixa-se de fadiga e queda de cabelos, iniciadas há dois meses. Refere dor em articulações das mãos e nos punhos. Exame físico: BEG, corada, eupneica; edema, calor e dor à palpação de punhos e segunda a quarta metacarpofalangeanas de ambas as mãos; lesões numulares com bordas hipercrômicas e centro eritematoso e atrófico na fronte. Foto da oroscopia abaixo.



Qual alteração mais provável no hemograma da paciente?

- A Monocitose.
- B Plaquetose.
- C Linfopenia.
- D Hipocromia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164295](https://www.4000164295.com)

Questão 29 Clínica Médica Hepatologia Colestase

Homem, 52 anos, apresenta fadiga e icterícia progressiva nos últimos 15 dias. Etilista há mais de 10 anos (90g de álcool/dia), com última ingestão alcoólica na véspera do início dos sintomas.

Exame físico: ictérico, presença de aranhas vasculares no tórax e sinal do semicírculo de Skoda. Laboratório: bilirrubina total: 16 mg/dL (VR $\leq 1,2$), bilirrubina direta: 12 mg/dL (VR $\leq 0,8$); AST: 105 U/L (VR ≤ 32); ALT: 48 U/L (VR ≤ 38); gama-GT: 280 U/L (VR ≤ 70); INR: 1,6. Investigação laboratorial do quadro descartou etiologias viral, autoimune, metabólica e tóxica por medicamento.

Qual é a conduta inicial mais adequada?

- A Endoscopia digestiva alta para avaliação de hipertensão portal.
- B Elastografia hepática para avaliação de fibrose.
- C Dosagem sérica de alfafetoproteína para avaliação de neoplasia.
- D Ultrassonografia de abdome para avaliação das vias biliares

4000164294

Questão 30 Tinea corporis

Homem, 44 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 há 5 anos, em insulinoterapia, sem outras comorbidades. Há 2 meses, relata aparecimento da lesão no antebraço com prurido associado (figura). Baseado na principal hipótese diagnóstica, realizou-se um exame complementar.



Qual é o achado mais provável?

- A Dermatite psoriasiforme.
- B Elevação da imunoglobulina E.
- C Hifas septadas ramificadas.
- D Epidermotropismo de linfócitos.

4000164293

Questão 31 Pericardite constrictiva

Mulher, 25 anos, sem comorbidades, relata dispneia progressiva, atualmente classe funcional III da NYHA, associada a palpitações taquicárdicas aos esforços. Exame físico: FC = 85 bpm, PA = 112 x 70 mmHg, FR = 18 irpm, elevação do pulso venoso jugular na inspiração, hepatomegalia com ascite moderada e edema 1+/4+ de membros inferiores. Radiografia de tórax (PA) e eletrocardiograma abaixo.



Contra preços abusivos
na medicina.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Endomiocardiofibrose.
- B Pericardite constrictiva.
- C Tamponamento cardíaco.
- D Amiloidose cardíaca.

4000164292

Proibida Venda.

Acesso t.me/medicinalivre

Questão 32 Manifestações clínicas

Homem, 20 anos, trabalhador rural, sofreu acidente no tornozelo esquerdo, por animal não visualizado. Queixa-se de pouca dor no tornozelo esquerdo, mialgia difusa e dificuldade para deglutir. Apresenta alteração da coloração da urina (foto).



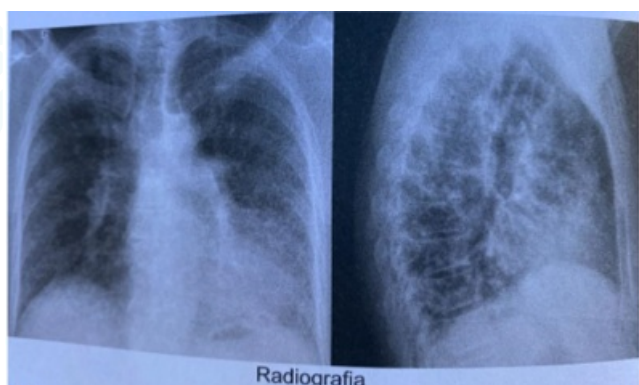
Qual é a alteração clínica/laboratorial esperada?

- A Troponina elevada.
- B Rinorreia.
- C Hipercalcemia.
- D Diplopia.

4000164291

Questão 33 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC Introdução à Pneumologia Pneumologia

Homem, 72 anos, tabagista. Refere dispneia progressiva (atualmente a mínimos esforços) e tosse seca esporádica há 2 anos. Exame físico: BEG, corado, cianótico, com baqueteamento digital. FR: 28 ipm. Sat O₂: 87% em ar ambiente.



Qual ruído adventício mais provável na ausculta respiratória?

- A Estertor em velcro.
- B Grasnido.
- C Estertor grosso.
- D Ronco.



4000164290

Questão 34 Diagnóstico

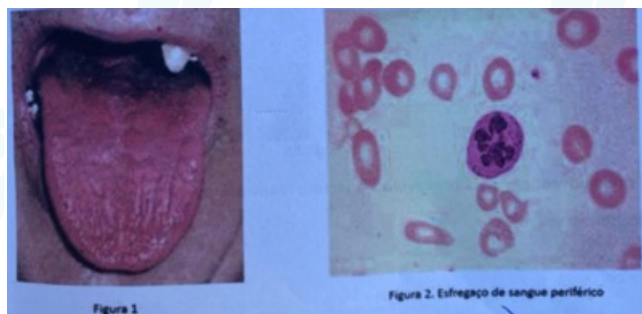
Homem, 42 anos, há 5 meses com tosse produtiva, febre esporádica e dispneia progressiva, atualmente aos médios esforços. Concomitantemente, apresenta lesão úlcero-vegetante, dolorosa, de crescimento progressivo, com pontilhado hemorrágico em gengiva. Antecedentes pessoais: agricultor em fazenda de café. Nega tabagismo e etilismo. Nega contato com sintomáticos respiratórios. Radiografia de tórax com infiltrado intersticial peri-hilar simétrico.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o achado mais provável no exame do escarro do paciente?

- A Hifas septadas finas com macroconídios tuberculados e microconídios de parede lisa.
- B Hifas finas de ramificação septada, com conídios em grupos em forma de margarida.
- C Leveduras em brotamento rodeadas de halo transparente na coloração com nanquim.
- D Leveduras grandes de parede celular birrefringente, com brotamentos em roda de leme.

Questão 35 Quadro clínico da anemia megaloblástica

Homem, 76 anos, refere "pele amarelada", parestesia progressiva em membros inferiores e ardência na língua (Figura 1). Faz uso de metformina, para diabetes mellitus tipo 2, e omeprazol para gastrite. Nega alteração do hábito intestinal e mantém ingesta alimentar sem restrições. Exames laboratoriais: hemograma: Hb: 8,8 g/dL, Ht: 26%, VCM: 112 fL (VN: 80-95 fL), leucócitos: 3.200/uL, plaquetas: 124.000/uL (esfregaço na Figura 2); Contagem absoluta de reticulócitos: 23.000/uL (VN: 25.000-105.000/uL); ferro sérico: 96 ug /dL (VN: 40-160 ug/dL); TIBC: 320 ug/dL (VN: 300-360 ug/dL); saturação da transferrina: 30%; ferritina: 118 ng/mL (VN: 6-159 ng/mL); LDH: 5.460 U/L (VN < 460 U/L); bilirrubinas totais: 1,8 mg/dL (VN <1,0 mg/dL); Coombs direto: negativo; TSH: 4,0 mU/L (VN: 0,5 -5,0 mU/L).



Qual é a etiologia mais provável das alterações clínico-laboratoriais?

- A Deficiência de vitamina B12.
- B Deficiência de ferro.
- C Doença autoimune.
- D Hipotireoidismo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164288

Questão 36 Saúde do Idoso geriatria Antipsicóticos Estado Confusional Agudo Delirium

Mulher, 85 anos, portadora de síndrome da fragilidade e hipertensão arterial sistêmica. Interna devido a pneumonia e evolui, no segundo dia de internação, com agitação e confusão mental. Ao exame físico: REG, confusa, desidratada 1+/4+. PA: 149 x 68 mmHg, FC 92 bpm, FR: 18 irpm, satO₂: 94% com cateter nasal a 2 L/min. Ausculta pulmonar: MV presente, com roncos de transmissão difusos. Ausculta cardíaca sem alterações. Abdome doloroso à palpação difusa, sem massas ou visceromegalias palpáveis.

Em relação à alteração comportamental, qual é o tratamento medicamentoso mais adequado?

- A Diazepam.
- B Clorpromazina.
- C Clonazepam.
- D Haloperidol

Questão 37 Rastreio da retinopatia diabética

Mulher, 52 anos, com hipertensão e diabetes tipo 2 há 4 anos, relata que ultimamente vem urinando mais, com surgimento de nictúria no último mês. Refere dificuldade para aderir a dieta e exercício físico regularmente. Está em uso de losartana, metformina e gliclazida. Exame físico sem alterações. Glicemia de jejum: 246 mg/dL, hemoglobina glicada: 8,9% (VR: 4,3-6,1); funções hepática e renal normais.

Qual exame mais adequado para rastreio de complicação crônica do diabetes neste momento?

- A Ultrassonografia de rins.
- B Fundo de olho.
- C Gasometria venosa.
- D Lipidograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164286](#)

Questão 38 Crise adrenal

Mulher, 32 anos, relata fraqueza, indisposição, emagrecimento, náuseas e vômitos há 6 meses. Refere também ciclos menstruais irregulares, sendo a data da última menstruação há 3 meses. Ao exame físico: PA = 100 x 60 mmHg em decúbito e 80 x 50 mmHg em ortostase escurecimento de pele e rarefação de pelos pubianos.

Considerando a hipótese clínica mais provável, qual é o tratamento?

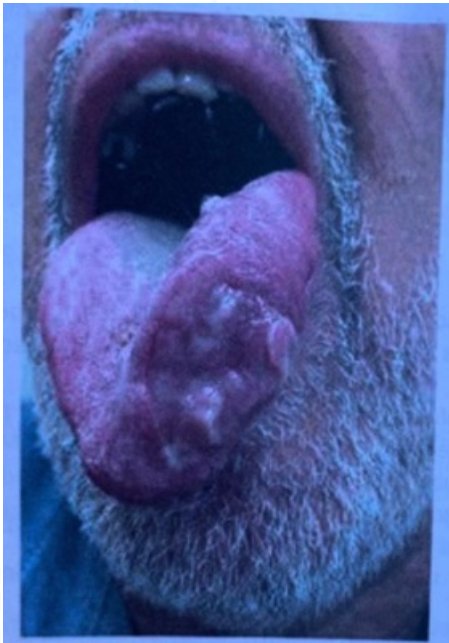
- A Estrógeno e progestágeno.
- B Levotiroxina.
- C Cabergolina.
- D Prednisona e fludrocortisona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164285](#)

Questão 39 Dermatologia Manifestações clínicas

Homem, 61 anos, relata lesão na língua há 3 anos (figura), com dificuldade de alimentação e perda de peso. Etilista de 6 garrafas de cerveja por semana e nega tabagismo. Ao exame: BEG, corado. Linfonodo submandibular à esquerda de 0,5 cm, móvel e indolor. Cicatriz de aspecto apergaminhado no dorso do pé direito.

Anatomopatológico da lesão da língua: epitélio com hiperplasia pseudoepiteliomatosa; infiltrado na submucosa denso e misto, rico em plasmócitos, com esboço de formação de granulomas. Não foram visualizados parasitas nas colorações especiais (GMS, Giemsa e Ziehl-Neelsen) e as culturas da lesão foram negativas.



Qual é o diagnóstico mais provável?

- ☐ A Carcinoma espinocelular.
- ☐ B Paracoccidiodomicose.
- ☐ C Doença de Behçet.
- ☐ D Leishmaniose mucosa.

Medicina Livre
Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164284](https://www.4000164284.com)

Questão 40 Estenose aórtica

Homem, 80 anos, tabagista e hipertenso, é internado por dor precordial aos pequenos esforços e um episódio de síncope enquanto caminhava dentro de casa. Exame físico: FC = 85 bpm, PA = 115 x 80 mmHg, pulso carotídeo com ascenso lento e baixa amplitude, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, ictus cordis com 2 polpas digitais, sopro sistólico rude com pico tardio em foco aórtico, sopro mitral piante e desdobramento paradoxal da segunda bulha, sem outras alterações.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- ☐ A Insuficiência mitral.
- ☐ B Estenose aórtica.
- ☐ C Estenose mitral.
- ☐ D Estenose pulmonar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164283](https://www.4000164283.com)

Questão 41 Tratamento Ginecologia

Mulher, 84 anos, G4P4A0 (4PN), DUM: há 37 anos. Paciente refere que há 12 anos iniciou com frouxidão vaginal e que há 6 meses tem notado abaulamento em região perineal que tem incomodado e atrapalha sua vida cotidiana e sexual. Tem HAS, diabetes e dislipidemia sem controle adequado com medicação. Antecedente pessoal de infarto agudo do miocárdio há 7 anos. Exame físico: regular estado geral, IMC: 32,2 Kg/m², exame ginecológico abaixo.



Qual a melhor conduta neste momento?

- A Colporrafia anterior e posterior.
- B Uso de pessário vaginal.
- C Histerectomia total vaginal.
- D Colpocleise a LeFort.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164282](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 42 Descarga papilar

Mulher, 54 anos, menopausada, tem observado saída de secreção escura (marrom-esverdeada) por vários ductos das papilas mamárias bilateralmente, há cerca de seis meses. Nega qualquer antecedente pessoal ou familiar de doença mamária. Não é tabagista e o exame clínico das mamas é normal, exceto por descarga papilar bilateral, com secreção fluida, escura, por vários ductos. A mamografia recente mostra BIRADS 2.

Qual o diagnóstico mais provável?

- A Abscesso subareolar.
- B Ectasia ductal.
- C Papiloma intra-ductal.
- D Carcinoma "in situ".

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164281](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 43 OginoKnaus

Mulher, 23 anos, saudável, G1P1, com ciclo menstrual variando de 24-33 dias nos últimos 6 meses. O volume menstrual é normal e a duração do sangramento é de 4 a 5 dias. Após as orientações, ela optou pelo uso da tabelinha.

Considerando que você usou o método do calendário (ou ritmo) para seus cálculos (Organização Mundial da Saúde, 2018), qual a alternativa contém o período do ciclo menstrual que essa mulher deverá fazer abstinência ou usar preservativo para evitar uma gravidez?

- A 7° ao 23° dia do ciclo.
- B 5° ao 24° dia do ciclo.
- C 8° ao 19° dia do ciclo.
- D 6° ao 22° dia do ciclo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164280](#)

Questão 44 Quadro clínico Tratamento das mulheres que desejam engravidar Diagnóstico

Nuligesta, 28 anos, deseja engravidar. Refere relações sexuais 3 vezes por semana, sem uso de métodos contraceptivos, há 2 anos. Ciclos menstruais com intervalos variados, geralmente superiores a 45 dias, 6 a 10 dias de duração e fluxo normal. Refere acne e aumento de pilificação após suspender o uso de anticoncepcional combinado oral. Esposo de 30 anos, saudável.

Ao exame físico: acne em face, abdome e região dorsal.

Peso = 68 Kg; altura = 1,66 m; IMC = 24,7 Kg/m²; cintura = 83 cm; Ferriman = 6.

Exame ginecológico sem alterações. Exames laboratoriais do casal: normais

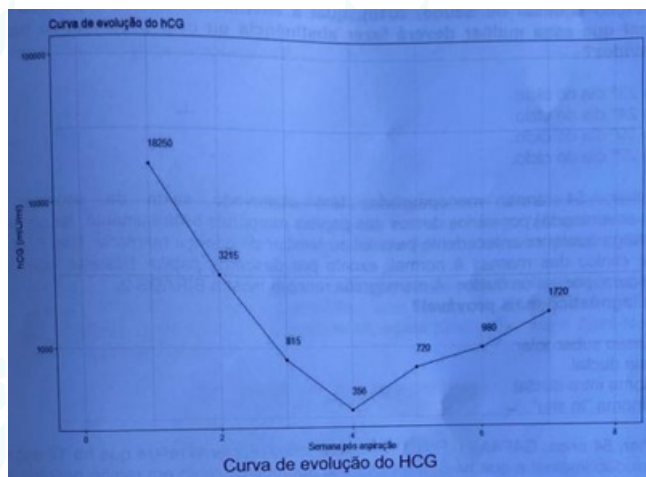
Qual a melhor conduta?

- A Indução da ovulação com clomifeno para inseminação intrauterina.
- B Estimulação ovariana com gonadotrofinas para fertilização in vitro.
- C Cirurgia laparoscópica ovariana para coito natural.
- D Indução da ovulação com letrozol para coito programado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164279](#)

Questão 45 Sangramento primeira metade

Mulher, 21 anos, G1P0A1, submetida a vácuo-aspiração com diagnóstico histopatológico de mola hidatiforme completa. Recebeu implante de etonogestrel logo após a aspiração. O exame ginecológico não evidencia alterações. A curva de evolução do hCG está apresentada na imagem abaixo.



Qual a melhor conduta?

- A Iniciar metotrexato.
- B Refazer a vácuo aspiração.
- C Indicar histerectomia.
- D Manter a observação clínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164278](#)

Questão 46 Interpretação e conduta frente as atipias citológicas

Mulher, 32 anos, G1P1, usuária de implante de etonogestrel, vivendo com HIV há 5 anos em uso de terapia antirretroviral com carga viral abaixo do limite de detecção e contagem de linfócitos TCD4 de 350 células/mm³. Resultado da colpocitologia coletada há 1 mês: amostra satisfatória, epitélio escamoso glandular e células compatíveis com lesão intraepitelial de baixo grau.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras do Instituto Nacional do Câncer (2016), qual melhor conduta?

- A Realizar colposcopia imediatamente.
- B Coletar biologia molecular.
- C Repetir a citologia em seis meses.
- D Realizar tratamento excisional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164277](#)

Questão 47 Diagnóstico Ginecologia Etiologia

Menina, 14 anos, menarca há 2 anos, apresentando ciclos menstruais normais, queixa-se de aumento do volume abdominal há 2 meses. Ao exame clínico abdominal identifica-se uma massa estendendo-se da pelve à cicatriz umbilical. A ultrassonografia confirma a presença de uma massa predominantemente sólida ocupando a pelve, não há ascite ou alterações em abdome superior. As dosagens de marcadores tumorais mostram CA 125 com valor normal e alfafetoproteína com valor elevado.

Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Endometrioma ovariano.
- B Leiomioma uterino.
- C Tumor de células germinativas do ovário.
- D Tumor epitelial maligno do ovário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164276](#)

Questão 48 Dor pélvica crônica Síndrome Miofascial

Mulher, 38 anos, G4P3A1 (3PC), DUM: há 10 dias. Encaminhada ao ambulatório de ginecologia por dor em fossa ilíaca esquerda tipo pontada e em queimação há 5 meses. Durante exame físico identificado ponto doloroso nesta região de moderada intensidade com irradiação para face medial da coxa, sem outras alterações, IMC = 20,1 Kg/m².

Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A Granuloma por corpo estranho.
- B Neuroma de parede abdominal.
- C Endometrioma de parede.
- D Síndrome miofascial abdominal

4000164275

Questão 49 Ginecologia Tratamento

Nuligesta, 26 anos, vem ao pronto atendimento queixando de corrimento fétido há 10 dias e dor no baixo ventre há sete dias. Nega febre, vômitos ou diarreia. Usa dispositivo intrauterino (DIU) de cobre há um ano. Ao exame, observa-se conteúdo vaginal de coloração esverdeada e odor fétido, dor a palpação profunda de hipogástrio e ao toque vaginal apresenta dor à mobilização do colo e palpação de anexos.

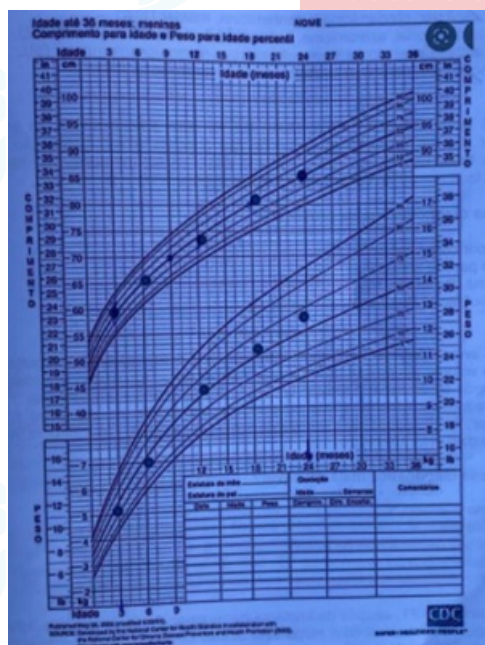
Qual o manejo mais adequado para essa paciente?

- A Interação helipítitar, clindamicina e gentamicina, manter DIU.
- B Tratamento ambulatorial, azitromicina, ceftriaxona e metronidazol, retirar DIU.
- C Tratamento ambulatorial, doxiciclina, ceftriaxona e metronidazol, manter DIU.
- D Internação hospitalar, penicilina cristalina e ceftriaxona, retirar DIU.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164274

Questão 50 Variantes Benignas da precocidade Sexual Pediatria

Mãe traz filha de 2 anos à consulta referindo ter observado crescimento de ambas as mamas há 3 meses. Nega desenvolvimento de pelos ou odor axilar. Antecedentes pessoais: nasceu de parto normal a termo e peso adequado. Nega antecedentes de doenças. Antecedentes familiares: irmãs de 4 e 7 anos com ausência de desenvolvimento puberal. Exame físico: Tanner M2 P1, genitália externa feminina e pré-púbere. Desenvolvimento pondero estatural no gráfico abaixo.



curva de estatura e peso do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC)

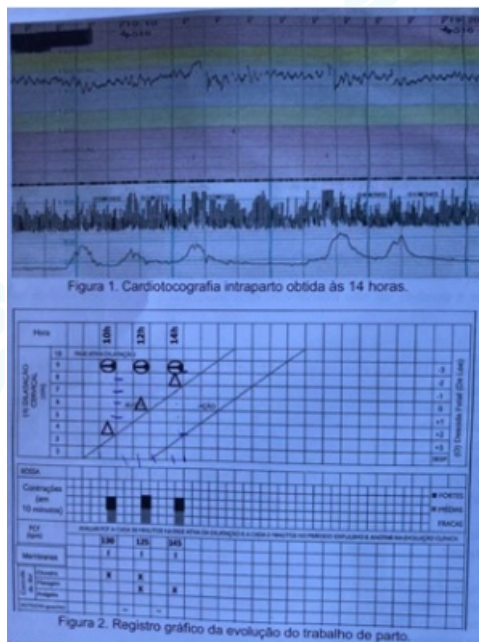
Qual a melhor conduta para esta paciente?

- A Solicitar ultrassonografia das mamas.
- B Bloquear o eixo hipotálamo-hipofisário com agonista do GnRH.
- C Reavaliar estatura e desenvolvimento puberal em 3 meses.
- D Bloquear a produção de estradiol com inibidor da aromatase.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164273](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 51 Assistência ao parto pélvico Obstetrícia

Secundigesta (G2P1C1A0), 32 anos, com 39 semanas de gestação, interna na fase ativa do trabalho de parto espontâneo. Relata cesárea prévia, há 3 anos, por "parada de dilatação cujo recém-nascido pesou 3750 gramas. Exame físico geral normal, altura uterina 34 cm. A monitorização intraparto está demonstrada abaixo (Figura 1), assim como a evolução do trabalho de parto, até às 14h (Figura 2)



Contra preços abusivos na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

De acordo com o Programa de Humanização do Parto do Ministério da Saúde do Brasil, qual seria a conduta para essa parturiente?

- A Evitar uso de analgesia farmacológica de parto.
- B Indicar resolução da gestação por parto cesárea.
- C Prescrever infusão endovenosa de ocitocina.
- D Manter assistência obstétrica habitual.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164272](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 52 Hipotireoidismo na gestação

Primigesta, 21 anos, com idade gestacional de 12 semanas, retorna trazendo os exames complementares solicitados em consulta pré-natal anterior. Nega outras queixas clínicas e obstétricas. Antecedentes pessoais: história pregressa de quadro clínico de tireotoxicose há aproximadamente oito meses, evoluindo com adequado controle após prescrição de metimazol.

Ao engravidar, a paciente suspendeu o uso de metimazol por conta própria.

Exame físico: dentro dos padrões de normalidade para o período gestacional.

Exames complementares atuais: hormônio estimulador da tireoide (TSH): 6,33 UI/ml, tiroxina livre: 0,96 ng/dL e anticorpo antitireoperoxidase (anti-TPO) positivo.

Além da monitorização periódica da função tireoidiana, qual a conduta mais adequada nesse caso?

- ☐ A Prescrever propiltiouracil.
- ☐ B Reiniciar metimazol.
- ☐ C Manter sem medicação.
- ☐ D Iniciar levotiroxina.

4000164271

Questão 53 **Assistenciao parto pélvico** **Obstetrícia**

Primigesta, 21 anos, durante o acompanhamento pré-natal de risco habitual, elabora e registra institucionalmente o seu plano de parto, pelo qual manifesta expressa vontade de um parto sem intervenções, incluindo a recusa de: uterotônicos para indução ou estimulação de trabalho de parto, manipulação vaginal desnecessária, amniotomia, analgesia farmacológica, episiotomia. A equipe assistencial acolhe o plano de parto e promove esclarecimentos e orientações sobre viabilidade de cada tópico abordado. Durante a evolução do trabalho de parto espontâneo a termo, paciente manteve sinais vitais normais, atividade uterina efetiva e vitalidade fetal preservada. Após 6 horas de evolução, com 4 cm de dilatação cervical, ocorre corioamniorrexe espontânea com saída de líquido amniótico claro e com grumos, intensificando a sintomatologia dolorosa às contrações uterinas. Conforme previsto no plano de parto, foram disponibilizados e aplicados métodos não farmacológicos de alívio de dor, porém a parturiente passa a demandar verbalmente por analgesia farmacológica devido à não melhora da sintomatologia dolorosa.

Qual a melhor conduta para esse caso?

- ☐ A Explicar que a analgesia farmacológica será ofertada após maior progressão da dilatação cervical.
- ☐ B Condicionar a oferta da analgesia farmacológica à reformulação do plano de parto.
- ☐ C Atender à solicitação da parturiente e realizar analgesia farmacológica.
- ☐ D Manter a conduta de não intervenção com analgesia farmacológica prevista no plano de parto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164270](https://www.4000164270.com.br)

Questão 54 **Condiloma** **Papilomavírus humano HPV**

Primigesta, 16 anos, 21 semanas, refere lesões na vulva há 30 dias. Na consulta Unidade Básica de Saúde, a avaliação da genitália evidencia as lesões mostradas na figura 1.



Qual a melhor conduta para esse caso?

- A Ácido tricloacético 80%.
- B Podofilotoxina.
- C Expectante.
- D Imiquimode.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164269](https://www.4000164269.com)

Questão 55 Toxoplasmose na gestação

Primigesta, 23 anos, branca, amasiada, do lar, idade gestacional: 11 semanas. Vem à consulta de retorno pré-natal, na Unidade Básica de Saúde, para checar resultados de exames descritos a seguir:

Hemoglobina: 12,6 g/dl; hematócrito: 40%.

Sorologia para toxoplasmose (quimioluminescência): IgG reagente e IgM reagente.

Qual o melhor manejo para essa gestante no pré-natal de origem?

- A Repetir sorologia para toxoplasmose.
- B Encaminhar para realização de amniocentese.
- C Realizar orientações profiláticas e repetir sorologia.
- D Iniciar espiramicina e solicitar teste avidéz.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164269](https://www.4000164269.com)

Questão 56 Trabalho de parto prematuro TPP Obstetria

Multigesta (G4PN3), 32 anos, com 35 semanas de gestação, procurou atendimento com contrações uterinas há 6 horas. Sem outras queixas. Refere que na última gestação, seu recém-nascido teve "quadro grave, foi transferido para UTI logo no primeiro dia de vida, precisou de antibiótico por 10 dias e quase morreu". Pré-natal sem intercorrências até o momento, com exames de sangue, culturas e ultrassonografias normais. Exame físico geral normal, altura uterina 33 cm, 4 contrações moderadas de 40 segundos/10 minutos, boa vitalidade fetal e colo curto, dilatado 4 cm, feto cefálico, com bolsa íntegra.

Qual é a alternativa adequada na assistência dessa paciente?

- A Condução do parto com sulfato de magnésio endovenoso.
- B Assistência ao parto com penicilina cristalina endovenosa.
- C Inibição do trabalho de parto com administração de nifedipina oral.
- D Duas doses de betametasona intramuscular intercaladas por 24 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164267](https://www.4000164267.com)

Questão 57 Obstetria Hepatites na gestação

Primigesta, 16 anos, 16 semanas gestacionais, hígida. Encaminhada da rede básica por ser portadora do vírus da hepatite do tipo B decorrente de transmissão vertical. No serviço terciário confirmou-se carga viral = 912 cópias/mL e exames de função hepática normais.

Considerando via de parto e amamentação natural, quais são as condutas mais adequadas para esta paciente?

- A Parto cesárea e inibir lactação.
- B Parto vaginal e inibir lactação.
- C Parto cesárea e amamentação natural.
- D Parto vaginal e amamentação natural.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164266](https://www.4000164266.com)

Questão 58 Predição e prevenção

Mulher; 22 anos, G2P1 (1 PN) em seguimento no pré-natal com 33 semanas de gestação pelo ultrassom. Comparece no centro obstétrico com queixa de contrações uterinas há 2 horas, nega perdas vaginais e refere boa movimentação fetal. Ao exame: bom estado geral, pressão arterial: 160 x 110 mmHg. Abdome: gravídico, AU: 32cm, dinâmica: ausente e BCF: 150 bpm. Cardiotocografia: feto ativo.

Exames laboratoriais: urina tipo 1: proteinúria ausente, creatinina: 0,7 mg/dL. Hemoglobina: 13,2 g/dL. Plaquetas: 233.000 mm³. Bilirrubina total: 0,6 mg/dL. Transaminase oxalacética (TGO): 26 U/L.

Qual o diagnóstico mais adequado neste momento?

- A Hipertensão transitória.
- B Pré-eclâmpsia.
- C Hipertensão arterial crônica.
- D Hipertensão gestacional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164265](https://www.4000164265.com)

Questão 59 Obstetria Doença hemolítica perinatal DHPN

Primigesta, 28 anos, O Rh negativo, triagem de anticorpos: negativo, recebeu imunoglobulina anti-D 300 mcg com 28 semanas. Evoluiu para parto vaginal sem intercorrências com 37 semanas.

Exames no puerpério:

Tipagem sanguínea da mãe: O Rh negativo.

Triagem de anticorpo: positivo.

Tipagem sanguínea do recém-nascido: O Rh positivo.

Qual a melhor conduta?

- ☐ A Prescrever imunoglobulina anti-D.
- ☐ B Considerar diagnóstico de isoimunização Rh.
- ☐ C Solicitar a titulação de anticorpos.
- ☐ D Encaminhar ao hematologista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164264](#)

Questão 60 Trabalho de parto prematuro TPP Obstetrícia

Mulher, 28 anos, G2P1A0, 1 parto pré-termo anterior espontâneo com 32 semanas sem intercorrências, está em seguimento pré-natal em uso de progesterona via vaginal. Comparece no ambulatório para realizar ultrassom morfológico e medida colo uterino. Ultrassom morfológico sem alterações e avaliação do colo uterino com 2,6 cm de comprimento.

Qual a conduta clínica?

- ☐ A Indicar cerclagem.
- ☐ B Suspender a progesterona.
- ☐ C Manter a progesterona.
- ☐ D Colocar pessário cervical.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164263](#)

Questão 61 Doença de LeggCalvéPerthes

Menino de 5 anos apresenta dor moderada no quadril direito há 2 meses. A família notou diminuição progressiva da atividade da criança e piora dos sintomas neste período. Relata piora da dor aos movimentos e alívio ao repouso. Ao exame físico apresenta claudicação antálgica e limitação moderada dos movimentos do quadril direito pela dor. Não foram identificadas outras regiões dolorosas ou deformidades. Radiografias em anexo.



Qual o diagnóstico mais provável?

- A Artrite séptica do quadril com osteomielite associada.
- B Artrite reumatoide juvenil.
- C Necrose idiopática da cabeça do fêmur (doença de Legg-Calvé-Perthes).
- D Displasia epifisária múltipla.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164262](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000164262)

Questão 62 Oclusão Arterial Crônica OAC Cirurgia

Homem, 65 anos, apresentava-se com dor em artelhos do pé esquerdo há dois meses com piora progressiva sem fator de melhora com a postura ou posição. Há um mês notou aparecimento de lesão necrótica no hálux esquerdo. Fumante há 40 anos e hipertenso com controle irregular fazendo uso de losartana 50 mg dia. Ao exame clínico apresentava-se com pulso femoral amplo e palpável e ausência de pulsos em região de poplitea, tibial posterior e de artéria pediosa. Lesão gangrenada e seca envolvendo 2/3 do hálux esquerdo com discreta hiperemia de bordos e sem edema.

Qual melhor conduta imediata para o caso?

- A Antibioticoterapia de amplo espectro e terapia por oxigenioterapia hiperbárica.
- B Arteriografia do membro inferior esquerdo para planejamento de revascularização.
- C Amputação primária do hálux seguido de anticoagulação plena.
- D Dupla antiagregação plaquetária seguido de exame de ultrassonografia vascular arterial e venosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164261](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000164261)

Questão 63 Isquemia Colônica Cirurgia

Homem de 65 anos dá entrada com quadro de ruptura de aneurisma de aorta abdominal e é operado na emergência por correção aberta. Durante o período intra operatório apresentou sangramento de grande volume, necessitando de transfusão de hemoderivados e permanecendo hipotenso a maior parte do tempo. A correção cirúrgica foi realizada com clampagem infra-renal utilizando-se prótese de poliéster do tipo bifurcada com anastomose proximal em aorta abdominal infra-renal e anastomoses distais nas artérias femorais. Paciente saiu estável do procedimento com aminas vasoativas em dose baixa. Foi extubado no segundo pós-operatório na unidade de terapia intensiva e apresentava boa evolução clínica pelo porte da cirurgia. No quarto pós-operatório iniciou queixa de dor abdominal, principalmente no andar inferior, com piora dos parâmetros hemodinâmicos. Ao exame físico, o abdome encontrava-se distendido, com dor difusa à palpação e descompressão brusca positiva inespecífica e ainda sem ruídos hidro aéreos. Os exames laboratoriais seguem em anexo (figura):

	1º PO	2º PO	3º PO	4º PO
Creatinina (mg/dl)	1,6	1,5	1,5	2,5
Hemograma	Hb: 11,5g/dl; GB: 11000 (Bast); neut: 89,5%	Hb: 11,2 g/dl GB: 11500 (Bast); neut: 88%		Hb: 11,1 g/dl GB: 12000 (Bast); neut: 87%
Lactato (mmol/l)	3,5	3,5	4,5	6,5
Gasometria arterial (pO2mmHg; pCO2 mmHg; HCO3 mmol/L; BE mmol/L)	pH: 7,36; pO2: 100; pCO2: 32; HCO3: 22; BE: -4 sat O2: 98,4%			pH: 7,22; pO2: 150; pCO2: 9,6; HCO3: 3,9 BE: -23,7 sat O2: 99,9%

Exames laboratoriais pós-operatórios

Qual o provável diagnóstico?

- A Colecistite alitiásica.
- B Sepses de origem abdominal.
- C Hemorragia.
- D Colite isquêmica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164260](https://www.4000164260.com)

Questão 64 **Aneurisma de Aorta Abdominal** **Cirurgia**

Homem, 68 anos, com dor abdominal tipo cólica em flanco direito há um dia, sem melhora com analgésicos. Foi encaminhado, em caráter de emergência, ao hospital terciário (pronto socorro) com laudo de ultrassom mostrando aneurisma de aorta abdominal fusiforme de cerca de 3,8 cm no maior diâmetro. No momento sua pressão arterial estava em 160 x 90 mmHg e FC de 92 bpm. Tomografia mostrou mesmos achados do ultrassom e aneurisma de 2,0 cm de colo proximal infra-renal e com a informação adicional de não haver extravasamento de contraste da aorta com presença de duas imagens cálcicas de cerca de 4 mm cada uma em pelve renal à direita.

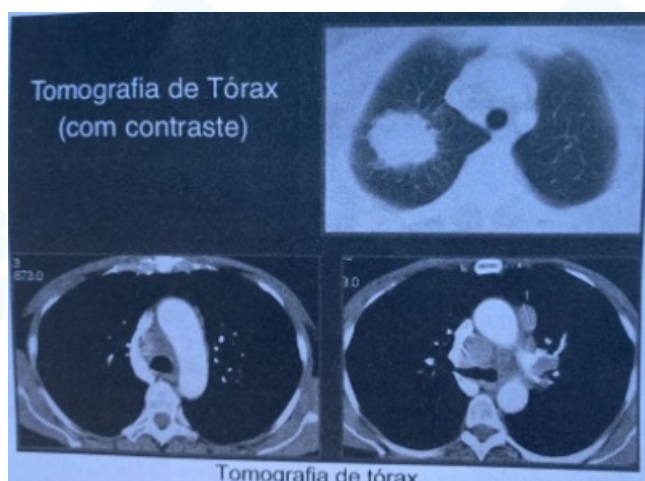
Qual a melhor conduta para este caso em referência ao aneurisma de aorta?

- A Controle clínico da pressão arterial e posterior cirurgia convencional do aneurisma.
- B Acompanhamento clínico ambulatorial com ultrassom periódico do aneurisma.
- C Tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal.
- D Angiorressonância para melhor avaliação da espessura da aorta e possível indicação terapêutica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164259](https://www.4000164259.com)

Questão 65 **Diagnóstico** **Estadiamento**

Mulher, 73 anos, tabagista 55 anos/maço, procura pneumologista com queixa de tosse e hemoptoicos há 4 semanas. Tomografia de tórax mostra lesão espiculada periférica de 4,0 cm no lobo superior direito. PET-TC (tomografia por emissão de pósitrons) apresenta lesão pulmonar com captação aumentada (SUV = 7) e em linfonodos mediastinais (SUV = 6) e hilares à direita (SUV = 4). A avaliação funcional pulmonar mostrou espirometria com VEF1 = 2,3L compatível com ressecção até bilobectomia.



Qual o próximo passo mais adequado no manejo deste paciente?

- A Pneumonectomia direita e broncoplastia (margem de segurança).
- B Preparo para cirurgia com intenção curativa com programação de segmentectomia apical direita e esvaziamento mediastinal.
- C Realizar amostragem dos linfonodos mediastinais e hilares por EBUS (*endobronchial ultrasound*- Ultrassonografia endobrônquica).
- D Encaminhar para avaliação oncológica clínica para protocolo de neoadjuvância.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164258](https://www.4000164258.com)

Questão 66 Estenose Carotídea Cirurgia

Homem de 71 anos com história de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e tabagismo sem antecedentes de acidente vascular encefálico, acidente isquêmico transitório ou outras queixas cerebrovasculares ou cardíacas. Está em seguimento ambulatorial com médico generalista que descobriu sopro cervical esquerdo, investigado com ultrassonografia com Doppler e angiotomografia, sendo diagnosticada estenose de carótida interna esquerda de 75%. Ainda, de antecedentes mórbidos, recentemente foi diagnosticado com adenocarcinoma esofágico estágio IV B.

Qual a conduta em relação à estenose carotídea?

- A Endarterectomia de carótida.
- B Angioplastia com stent em carótida.
- C Ressonância magnética encefálica para investigar infartos lacunares.
- D Tratamento clínico otimizado.

4000164257

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 67 Neurologia PréRequisitos Exame Clínico

Criança de 2 meses, admitida após traumatismo crânio-encefálico por acidente automobilístico (capotamento), com duas mortes na cena. Foi submetido a drenagem de hematoma subdural e craniectomia descompressiva. No segundo dia pós-operatório, encontra-se intubada, com escala de coma de Glasgow de 3, midríase fixa bilateral e ausência bilateralmente dos reflexos córneo-palpebrais, óculo-cefálicos, e vestibulo-calóricos, além de ausência do reflexo de tosse. Sua pressão arterial é de 70 x 52 mmHg, sua temperatura é de 37°C e seus exames de sangue mostram eletrólitos, função renal e hepática dentro dos valores normais. Retirados os sedativos (midazolam e fentanil) há 20 horas.

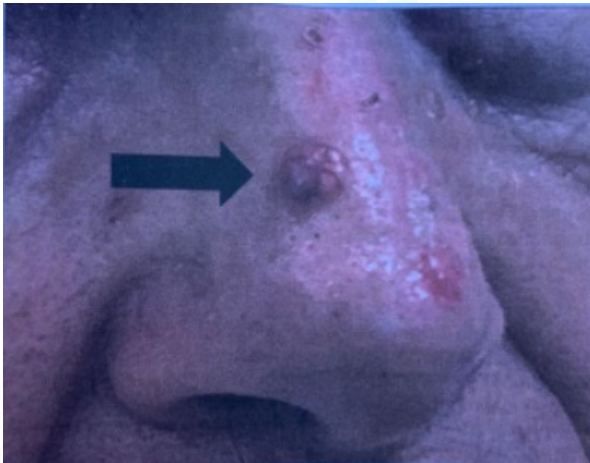
Com relação ao diagnóstico de morte encefálica (ME), qual das condutas abaixo é a mais adequada neste momento?

- A Comunicar a família que será aberto protocolo de ME.
- B Realizar angiografia cerebral.
- C Iniciar a primeira prova de ME após 4 horas.
- D Realizar teste de apneia.

4000164253

Questão 68 Tratamento Apresentação clínica

Mulher de 62 anos, trabalhadora rural, procurou unidade básica de saúde queixando-se de lesão cutânea em nariz (figura), com crescimento progressivo nos últimos 6 meses.



Baseado na principal hipótese diagnóstica, qual o tratamento mais indicado?

- A Terapia fotodinâmica.
- B Curetagem e eletrocoagulação.
- C Radioterapia superficial.
- D Exérese com margens de segurança.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164252](https://www.4000164252.com.br)

Questão 69 Ortopedia Síndrome de BrownSequard Síndromes Medulares

Homem de 21 anos, admitido após ferimento por arma de fogo em região cervical direita. Ao exame físico, apresentava via aérea pérvia, estando hemodinamicamente estável com pulso periférico presente e boa perfusão. Ao exame neurológico, apresentava escala de coma de Glasgow de 15, pupilas isocóricas, hemiparesia à direita grau 2, sinal de Babinski à direita. perda da sensibilidade proprioceptiva à direita e perda da sensibilidade termoalgésica à esquerda.

Qual é o diagnóstico síndrome?

- A Lesão da medula anterior.
- B Hemissecção medular.
- C Lesão central da medula.
- D Lesão da medula posterior.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164249](https://www.4000164249.com.br)

Questão 70 Tratamento e conduta

Mulher de 56 anos notou surgimento de lesão escurecida e irregular em antebraço direito. A biópsia da lesão identificou melanoma nodular, com Breslow de 0,5 milímetro, sem regressão, sem invasão angiolinfática, sem mitoses e com ulceração. Ao exame físico: cicatriz da biópsia em antebraço direito em bom aspecto e sem sinais de recidiva local, cadeia linfática axilar direita sem massas ou adenomegalias. Os exames radiológicos não mostraram sinais de metástase em outros

órgãos.

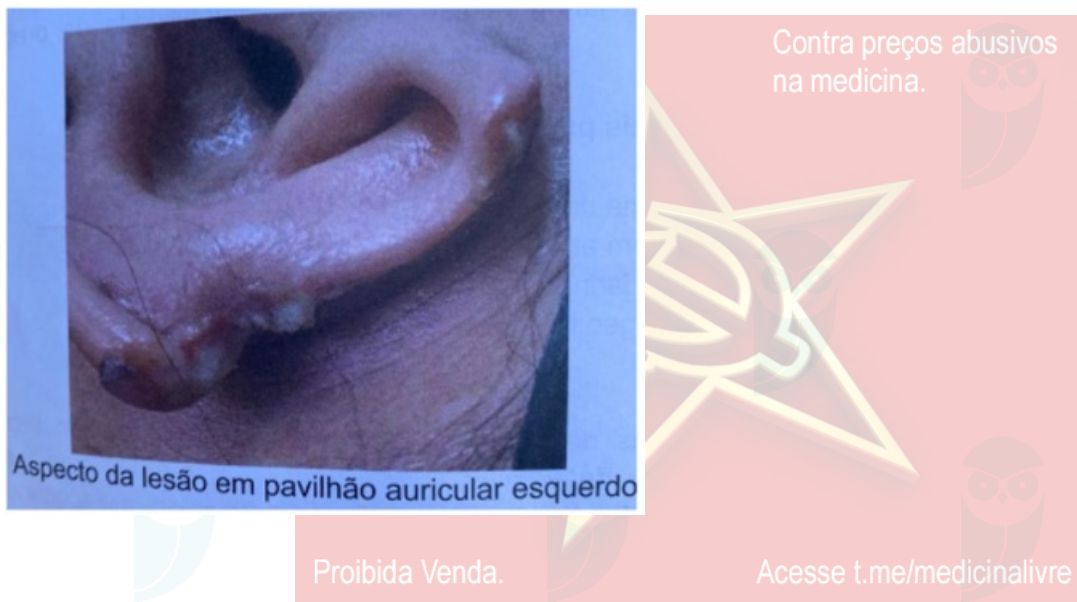
Que condutas devem ser implementadas?

- A Ampliação de margens de 2 cm e linfadenectomia axilar ipsilateral.
- B Ampliação de margens de 2 cm e biópsia de linfonodo sentinela.
- C Ampliação de margens de 1 cm e biópsia de linfonodo sentinela.
- D Ampliação de margens de 1cm e linfadenectomia axilar ipsilateral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164248](#)

Questão 71 **Cirurgia**

Mulher 45 anos, do lar, vem para atendimento em uma unidade de pronto atendimento, com ferimento em orelha esquerda causada por mordedura de cão há cerca de 48 horas. Relata que não compareceu antes por estar sem acessibilidade a um serviço de saúde. Na figura em anexo nota-se secreção e exposição de cartilagem no leito da lesão.



Qual a melhor conduta?

- A Curativos diários, antibioticoterapia e fechamento primário retardado.
- B Curativo diários, antibioticoterapia e cicatrização por segunda intenção.
- C Debridamento, sutura das bordas e antibioticoterapia.
- D Referenciar o paciente para atendimento especializado hospitalar.

4000164247

Questão 72 **Fratura do rádio distal** **Conceitos Básicos do Trauma Ortopédico** **Diagnóstico**

Homem de 52 anos sofreu fratura da região distal do rádio que foi tratada com imobilização gessada há 12 horas. Retornou ao pronto socorro com forte dor no punho que não melhorava com analgesia. Ao exame físico apresentava edema dos dedos e dor forte ao movimentá-los. Perfusão dos dedos presente com enchimento capilar lentificado.

Qual a melhor conduta?

- A Encaminhar para cirurgia para realização de osteossíntese da fratura e liberação dos compartimentos.
- B Retirada imediata da imobilização, confecção de imobilização provisória, observação da evolução.
- C Encaminhar para cirurgia para realização de osteossíntese da fratura sem necessidade de fasciotomia.
- D Iniciar uso imediato de opioides e elevar o membro sem interferir no tratamento da fratura.

4000164246

Questão 73 Estenose Hipertrófica do Píloro Cirurgia

Menina de 45 dias de vida, previamente saudável, amamentação com leite materno exclusivo, com história de vômitos logo após as mamadas, com início há 1 semana, de conteúdo de leite talhado. A mãe relata que tem percebido que a criança vomita praticamente todo leite ingerido nos últimos 2 dias e que não está ganhando peso. A criança evacua diariamente, mas em pequena quantidade. O pediatra orientou medidas posturais e dietéticas e prescreveu domperidona, sem resposta.

Qual o diagnóstico mais provável?

- A Estenose hipertrófica do píloro.
- B Alergia a proteína do leite de vaca.
- C Má rotação intestinal.
- D Refluxo gastroesofágico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164245](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 74 Nervosas

Homem de 55 anos, pedreiro, compareceu a consulta com queixa de rouquidão há 6 meses. Refere tabagismo de 60 anos-maço, e ingere 50 ml de bebida alcoólica destilada, diariamente, há 20 anos. Informa que a disfonia se iniciou após ser submetido a cirurgia para remoção de carcinoma de tireoide há 8 meses. Ao exame do pescoço, não apresenta massas cervicais palpáveis e a laringoscopia apresenta imobilidade da prega vocal esquerda em posição paramediana.

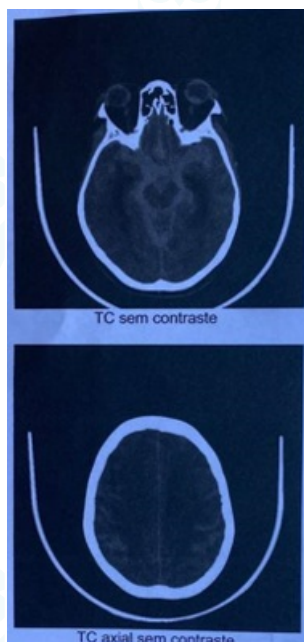
Qual o diagnóstico mais provável?

- A Recidiva do carcinoma de tireoide.
- B Luxação de cartilagem aritenoide.
- C Carcinoma inicial de laringe.
- D Lesão do nervo laríngeo inferior.

4000164244

Questão 75 Investigação Hemorragia Subaracnoidea HSA Neurologia

Homem de 50 anos, previamente hígido, com quadro de cefaleia súbita associada a vômitos e perda da consciência transitória durante realização de atividade física. Acompanhante relata não ter havido traumatismo craniano. Deu entrada no Pronto Atendimento consciente e lúcido, sem déficits sensitivo-motores, com rigidez de nuca e presença do sinal de Brudzinski. Seu exame de tomografia computadorizada inicial sem contraste encontra-se em anexo.



Qual a etiologia mais provável?

- A Ruptura de malformação artério-venosa intracraniana.
- B Hipertensão arterial (pico hipertensivo).
- C Ruptura de aneurisma intracraniano.
- D Vasculite do sistema nervoso central.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164238

Questão 76

Complicações

Cirurgia

Homem de 64 anos foi submetido a revascularização do miocárdio, cujo acesso cirúrgico foi por meio de esternotomia mediana. Após 25 dias de cirurgia, iniciou drenagem purulenta e deiscência da ferida operatória. O tratamento inicial foi feito com desbridamento dos tecidos desvitalizados e terapia por pressão negativa. Após três ciclos de terapia, a ferida cirúrgica encontra-se como mostrado na figura.



Qual o melhor tratamento subsequente?

- A Cicatrização por segunda intenção.
- B Enxerto de pele total.
- C Rotação de retalho miocutâneo.
- D Fechamento primário da pele.

4000164237

Questão 77 Atendimento Inicial às Vítimas de Queimadura Cirurgia

Homem de 42 anos sofreu queimaduras por combustão de álcool em tronco e membros inferiores. Foi trazido ao pronto-socorro de hospital secundário, onde recebeu o atendimento inicial. Ao exame: consciente e orientado, Glasgow 15, ventilação com murmúrio vesicular presente a simétrico, saturação de oxigênio em ar ambiente de 97%, frequência respiratória de 20 ipm, frequência cardíaca de 98 bpm, pressão arterial de 100 x 60 mmHg, queimaduras de segundo e terceiro grau em abdome, coxa direita e coxa esquerda. A equipe médica iniciou a reposição volêmica com cristaloides e realizou analgesia endovenosa.

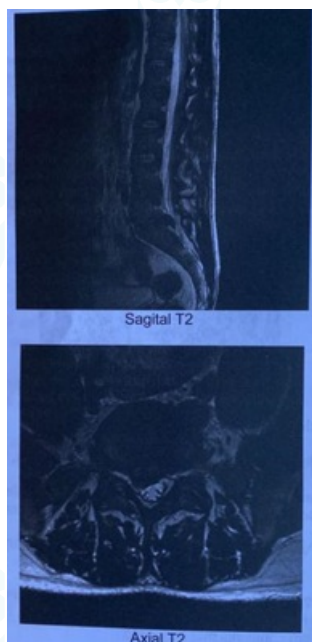
Qual das condutas abaixo também deve ser implementada no atendimento inicial desse paciente?

- A Checagem da vacinação antitetânica.
- B Cateter nasal com oxigênio a 100%.
- C Desbridamento das queimaduras de terceiro grau.
- D Monitorização cardíaca em terapia intensiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164234](https://www.4000164234.com)

Questão 78 Doença degenerativa discal e hérnia discal

Homem de 45 anos, sem comorbidades prévias, queixa-se de lombalgia de início súbito com irradiação para membro inferior direito há 2 dias, iniciado após levantar armário em casa para limpeza. Utilizou paracetamol por conta própria, com melhora parcial. Ao exame físico não apresenta alterações a não ser por dor no membro citado, principalmente quando elevado em posição reta acima de 40 graus. Realizou o exame de ressonância magnética em anexo.



Qual o tratamento mais indicado para este paciente?

- A Cirurgia-microdissectomia.
- B Conservador (analgésia).
- C Uso de colete lombar (de Putti).
- D Infiltração radicular com glicocorticoide.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164230](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 79 Persistência do Conduto Peritônio vaginal Patente Cirurgia

Menino de 1 ano e 2 meses de idade, com história de abaulamento inguinal esquerdo, indolor, notado pela mãe há 20 dias, durante o banho. Na palpação, nota-se tumoração tensa, não dolorosa, irreductível, em canal inguinal esquerdo.

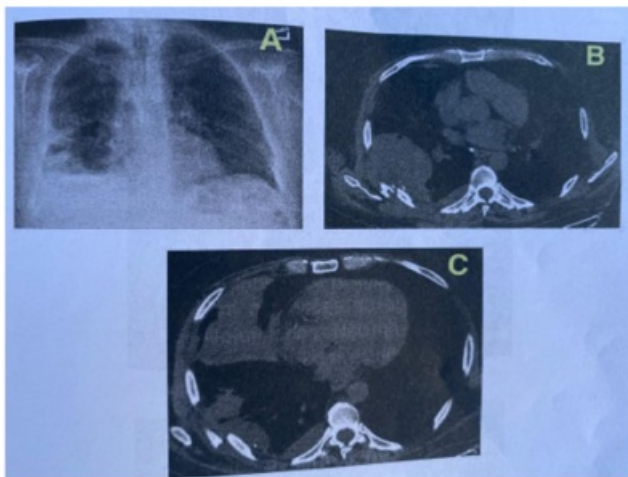
Qual o provável diagnóstico?

- A Hidrocele comunicante.
- B Adenomegalia reacional.
- C Cisto de cordão espermático.
- D Hérnia inguinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164229](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 80 Hemotórax Cirurgia

Homem, 18 anos, vítima de trauma torácico fechado (colisão carro com ônibus). Atendido em Centro de Trauma, apresentava fratura costal à direita. Realizado drenagem pleural fechada por hemo-pneumotórax (figura A). Boa evolução com resolução e expansão pulmonar, dreno pleural retirado após 48 horas e seguida de alta hospitalar. Retorna ao serviço de emergência após 14 dias da alta com queixa de dor pleurítica à direita e picos febris há 2 dias. Encontra-se hemodinamicamente estável e eupnéico. Submetido a tomografia de tórax (figuras B e C).



Qual a conduta terapêutica mais adequada?

- A Passagem de dreno pleural tipo "pigtail" para uso de trombolíticos, irrigação contínua por 48 horas.
- B Toracotomia póstero-lateral com pleurectomia parietal para controle de sangramento.
- C Dreno pleural calibroso (36F), uso de irrigação contínua e sistema de aspiração pleural reduzida
- D Videotoracoscopia ou VATS (*Video-Assisted Thoracoscopic Surgery*).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164228](https://www.4000164228.com.br)

Questão 81 Imunidade de rebanho Vacina contra hepatite B Vacina contra febre amarela

Você trabalha como médico em uma Unidade de Saúde da Família e atende um paciente de 45 anos, lavrador, hígido, que foi orientado a atualizar sua carteira vacinal pelo agente comunitário de saúde, mas se recusou a fazê-lo. O paciente recusou a aplicação das vacinas contra hepatite B e febre amarela, alegando que sua esposa e filhos são vacinados contra essas doenças e que por isso ele se sente protegido contra as mesmas.

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que indica a melhor orientação a ser oferecida a esse paciente.

- A Explicar que a vacinação de sua família não lhe confere proteção alguma contra hepatite B, e nem contra febre amarela silvestre. Recomendar a aplicação de ambas as vacinas.
- B Explicar que a vacinação de sua família não lhe confere proteção alguma contra hepatite B, mas sim contra a febre amarela silvestre. Recomendar a aplicação da vacina contra hepatite B.
- C Explicar que a vacinação de sua família lhe confere parcialmente alguma proteção contra hepatite B e nenhuma contra febre amarela silvestre. Recomendar a aplicação de ambas as vacinas.
- D Explicar que a vacinação de sua família lhe confere parcialmente alguma proteção contra hepatite B e parcialmente contra febre amarela silvestre. Recomendar a aplicação de ambas as vacinas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164227](https://www.4000164227.com.br)

Questão 82 Dermatite de fraldas

A enfermeira da saúde da família do bairro avaliou um bebê de 2 meses e meio de idade que foi levado à unidade para consulta de puericultura. Durante conversa, a mãe relatou que a criança, nos últimos dias, estava chorando muito, mais irritada em algumas horas do dia. Negava febre, perda de peso ou alteração do apetite. Ao retirar a fralda para examinar a criança, a enfermeira percebeu área de pele com eritema importante e áreas de abrasão, acometendo o períneo, raiz das coxas, parte das nádegas, se estendendo até a região perianal. O médico foi chamado, avaliou a criança e orientou o

tratamento, medidas de cuidado e prevenção.

Qual o melhor tratamento medicamentoso para o quadro desta criança?

- A Antibiótico tópico.
- B Corticosteroide tópico.
- C Antifúngico tópico.
- D Dexpantenol tópico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164226](https://www.4000164226.com.br)

Questão 83 Classificação Tratamento

Paciente de 35 anos, procura a Unidade de Saúde da Família com queixa de uma mancha esbranquiçada na perna direita. O paciente nega dores, prurido ou outras queixas em relação à mancha, que percebeu há cerca de 2 anos e vem aumentando de tamanho, lentamente. Nega perda de força ou parestesias no membro afetado. Paciente nega tabagismo, uso de bebida alcoólica, de medicamentos ou de qualquer problema de saúde. Ao exame, o médico de família e comunidade (MFC) percebe a mancha hipocrômica, de cerca de 6 cm de diâmetro, com perda de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Também percebeu o nervo fibular à direita mais espessado. Não encontrou outras alterações de pele ou outros nervos espessados.

Com esses achados, a melhor conduta do MFC é:

- A Iniciar tratamento com rifampicina, clofazimina e dapsona, com duração de 6 meses.
- B Iniciar tratamento com rifampicina e clofazimina, com duração de 12 meses.
- C Encaminhar o paciente para confirmação diagnóstica em ambulatório especializado.
- D Iniciar tratamento com rifampicina e dapsona, com duração de 6 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164226](https://www.4000164226.com.br)

Questão 84 Apresentação Clínica

Você trabalha como médico em uma Unidade de Saúde da Família e atende um jovem de 16 anos, previamente hígido, que procura atendimento queixando-se de odinofagia e febre há 5 dias. Há 3 dias, procurou o serviço de pronto-atendimento, onde foi atendido por um médico que lhe prescreveu amoxicilina + clavulanato (500/125 mg) 1 cp 8/8h por 1 semana e dipirona, se necessário. Desde então, o rapaz notou piora dos sintomas e o aparecimento de lesões avermelhadas no tronco. Fotos de sua orofaringe e tronco no dia da consulta estão ilustradas abaixo.



Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa que contém o diagnóstico mais provável e a conduta mais apropriada para o caso.

- A Abscesso periamigdaliano. Manter amoxicilina + clavulanato e encaminhar o paciente para drenagem cirúrgica imediata.
- B Herpangina, farmacodermia à amoxicilina + clavulanato. Trocar amoxicilina + clavulanato por clindamicina 600 mg (vo) 8/8h.
- C Amigdalite bacteriana, falha no tratamento antimicrobiano. Trocar amoxicilina + clavulanato por ceftriaxona 2g (EV) ou (IM) 1 vez ao dia.
- D Mononucleose infecciosa. Suspender amoxicilina + clavulanato e intensificar analgesia com nimesulide 100 mg (vo) 12/12h.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164224](#)

Questão 85 **Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS** **Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

Na discussão semanal da equipe de saúde da família, a preocupação em relação ao dimensionamento inadequado de agentes comunitários de saúde (ACS) para a cobertura de toda a população cadastrada na Unidade de Saúde da Família (USF) foi externada pelos membros da equipe de saúde. O número ideal de ACS previsto para a USF, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) era de seis (6), e naquele momento, a equipe contava com apenas três (3).

Essa situação vivenciada pela equipe da USF prejudica, principalmente, que atributo da atenção primária à saúde?

- A Participação comunitária.
- B Coordenação do cuidado.
- C Longitudinalidade do cuidado.
- D Atenção ao primeiro contato.

4000164223

Questão 86 **Abordagem Familiar**

Durante a reunião de discussão de família, a agente comunitária de saúde (ACS) informou que uma nova família havia se mudado para o território da Unidade de Saúde da Família (USF). Por meio da visita domiciliar para o cadastramento, a ACS identificou que no domicílio residia um casal jovem (homem 35 anos e mulher 33 anos), com duas crianças (um menino de 7 anos e uma menina de 4 anos). A mulher estava desempregada, o marido trabalhava em uma indústria de bebidas durante o dia, o menino estava frequentando a escola e a menina ficava em casa com a mãe, pois não havia vaga na creche do bairro. A mulher informou também que ela e o marido não eram os pais biológicos das crianças.

Considerando as estruturas familiares, a equipe pode classificar esta família como:

- A Extensa.
- B Composta.
- C Nuclear.
- D Funcional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164222](#)

Questão 87 **Tratamento da Hipertensão arterial** **Tratamento medicamentoso**

Paciente com 49 anos do sexo masculino em consulta para avaliação de exames e acompanhamento de pressão arterial

alterada, tem antecedente de gota. Na consulta, verificou-se pressão arterial de 152 x 90 mmHg, além de IMC de 38. Resultados de exames: glicemia de jejum: 88 mg/dl, colesterol total: 270 mg/dl, HDL colesterol: 94 mg/dl, triglicérides: 197 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl, sódio: 142 mEq/L potássio: 4,7 mEq/L. ácido úrico: 9.2 mg/dl, urina tipo 1: sem alterações significativas.

Valores de referência:

Glicemia: 70-99 mg/dl

Colesterol total: < 200 mg/dl

HDL Colesterol: 40-60 mg/d

Triglicérides: <150 mg/dl

Creatinina: < 1,3 mg/dl

Sódio: 135-145 mEq/L

Potássio: 3,5-5,5 mEq/L

Ácido úrico: 4,0-7,0 mg/dl

Confirmado o diagnóstico de hipertensão arterial e com base nas características clínicas e resultados dos exames, qual a classe de anti-hipertensivo você indicaria preferencialmente?

- ☐ A Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA).
- ☐ B Bloqueador de canal de cálcio diidropiridínico.
- ☐ C Beta-bloqueador não-seletivo.
- ☐ D Diurético tiazídico.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164221](#)

Questão 88 Avaliação funcional e ultrassonográfica da glândula tireoide Diagnóstico etiológico da tireotoxicose

Paciente do sexo feminino, 20 anos, comparece à Unidade de Saúde da Família (USF) para consulta, com história de há 2 meses ter iniciado quadro de palpitações, irritabilidade e fraqueza. Em registro anterior de prontuário, observou-se ainda, perda ponderal de 4 Kg, no período. Nega uso de medicações. Ao exame: peso 52 Kg, FC: 114 bpm. PA: 110 x 70 mmHg. FR 14 ipm. Pele: quente e úmida. ACV: Ritmo Regular, com 2 Bulhas normofonéticas, sem sopros. AR: MV Simétrico, sem RA. Tireoide: palpável, sem aumento de tamanho e sem nódulos palpáveis.

Qual a melhor conduta inicial a ser realizada no contexto da atenção primária à saúde?

- ☐ A Solicitar anticorpos anti-receptores de TSH (TRAb).
- ☐ B Solicitar ultrassom de tireoide, TSH e T4 livre.
- ☐ C Solicitar TSH, T4 livre e T3.
- ☐ D Solicitar TSH, cintilografia de tireoide com captação.

4000164220

Questão 89 Medicina Preventiva

Gestante, 30 anos, G2P1A0C1, IG 1º USC 26 semanas. Vinha realizando o pré-natal em Unidade de Saúde da Família (USF) quando foi condenada a cumprimento definitivo de pena, com reclusão em regime fechado.

Além do parto hospitalar, a gestante terá direito:

- A Terminar pré-natal em estabelecimento prisional. Período de amamentação de 6 meses em prisão domiciliar.
- B Terminar pré-natal em USF. Retorno para estabelecimento prisional após o parto.
- C Terminar pré-natal em unidade prisional. Período de amamentação em berçário de unidade prisional.
- D Terminar pré-natal em USF. Período de amamentação de 6 meses em prisão domiciliar.

4 000164219

Questão 90 Dependência de Tabaco

Paciente de 46 anos procura seu médico de família e comunidade (MFC). O paciente tem antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica (controlada com medicamentos) e de gota. Apresentou quadro de epilepsia dos 2 aos 15 anos de idade, com a última crise convulsiva aos 12 anos. Está em tratamento de úlcera gástrica, diagnosticada há 1 semana. Faz uso crônico de losartana (100 mg ao dia), alopurinol (300 mg ao dia) e em uso recente de claritromicina, amoxicilina e omeprazol. É tabagista desde os 18 anos de idade. Fuma cerca de 20 cigarros ao dia. Fuma o primeiro cigarro 20 minutos após acordar, pela manhã. Tem sintomas de fissura quando fica mais de 2 horas sem fumar. Não tem queixas respiratórias. Nega uso de bebidas alcoólicas. O paciente informa que, devido à crise gerada pela pandemia de Covid-19, foi demitido há 6 meses e não conseguiu outro emprego, até o momento. Também está passando por dificuldades no relacionamento com a esposa. Há cerca de 2 meses vem apresentando sintomas de tristeza, anedonia, dificuldades de sono e ganho de peso. Durante a entrevista o MFC diagnosticou um episódio depressivo maior e a pontuação de Fagerstrom foi 8. Também relata que deseja cessar o tabagismo. O exame físico do paciente não mostrou qualquer alteração importante. Diante do quadro, o MFC decide iniciar intervenção psicoterapêutica e tratamento farmacológico com mais de uma droga.

A prescrição mais indicada para este quadro seria:

- A Adesivo de nicotina e nortriptilina.
- B Adesivo de nicotina e goma de nicotina.
- C Goma de nicotina e bupropiona.
- D Adesivo de nicotina e bupropiona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164218](https://www.4000164218.com.br)

Questão 91 Medicina Preventiva

A figura abaixo foi extraída de um artigo científico que aborda a efetividade da aplicação em massa da vacina CoronaVac para a prevenção de Covid-19, no Chile.

Table 2. Effectiveness of CoronaVac Vaccine in Preventing Covid-19 Outcomes in Overall Study Cohort, According to Immunization Status.^a

Outcome and Immunization Status	Study Cohort No. of Person-Days	Persons with Covid-19		Vaccine Effectiveness (95% CI)		
		No. of Persons	Incidence Rate no. of events/ 1000 person-days	Analysis Adjusted for Sex and Age	Analysis Adjusted for All Covariates	Stratified Analysis
Covid-19						
Unvaccinated	614,868,240	185,633	0.3019	—	—	—
Partially immunized	68,788,352	20,865	0.2990	8.0 (6.5–9.4)	15.5 (14.2–16.8)	17.2 (15.4–18.6)
Fully immunized	91,671,797	12,386	0.1340	61.2 (60.3–62.0)	65.9 (65.2–66.6)	63.7 (62.8–64.6)

Tabela: Efetividade da vacina Coronavac.

Considerando a efetividade da aplicação de duas doses da vacina estimada pela análise estratificada em 63,7%, isso

significa que:

- A 63,7% das pessoas vacinadas foram efetivamente protegidas e não desenvolveram Covid-19.
- B 63,7% das pessoas vacinadas produziram anticorpos (soro converteram) contra Covid-19.
- C A prevalência de Covid-19 foi 63,7% menor nas pessoas vacinadas que nas não vacinadas.
- D A incidência de Covid-19 foi 63,7% menor nas pessoas vacinadas que nas não vacinadas.

4 000164217

Questão 92 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Durante uma visita de estudantes do primeiro ano de medicina à uma Unidade de Saúde da Família (USF), o professor apresentou a estrutura da unidade (ambiência, equipamentos, recursos humanos) e explicou que os serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), estão organizados em uma rede de atenção à saúde (RAS), composta por pontos assistenciais de densidades tecnológicas distintas que atendem condições de saúde de diferentes complexidades. Também comentou que a atenção primária à saúde (APS) se constitui a porta preferencial de acesso dos usuários à RAS e que a USF, apesar de não dispor de muitos equipamentos, apresentava um bom vínculo com a comunidade, uma equipe multiprofissional bem integrada e uma taxa de resolutividade próxima à 90%.

Após a visita à USF e baseados na explicação do professor sobre a organização da RAS os estudantes concluíram que:

- A A atenção secundária apresenta baixa densidade tecnológica e elevado grau de tecnologia leve-dura.
- B A atenção terciária apresenta alta densidade tecnológica e elevado grau de tecnologia leve.
- C A atenção primária apresenta baixa densidade tecnológica e elevado grau de tecnologia dura.
- D A atenção primária apresenta baixa densidade tecnológica e elevado grau de tecnologia leve.

4 000164216

Questão 93 Prevenção

Uma criança de oito anos de idade é trazida à Unidade de Saúde da Família (USF) com história de ter sido atacada por um porco doméstico, ao adentrar o interior de um chiqueiro, na propriedade rural onde vive com seus pais. O exame físico revela lesão única e superficial na panturrilha direita. A família informa que a criança nunca havia recebido vacinas antirrábicas anteriormente.

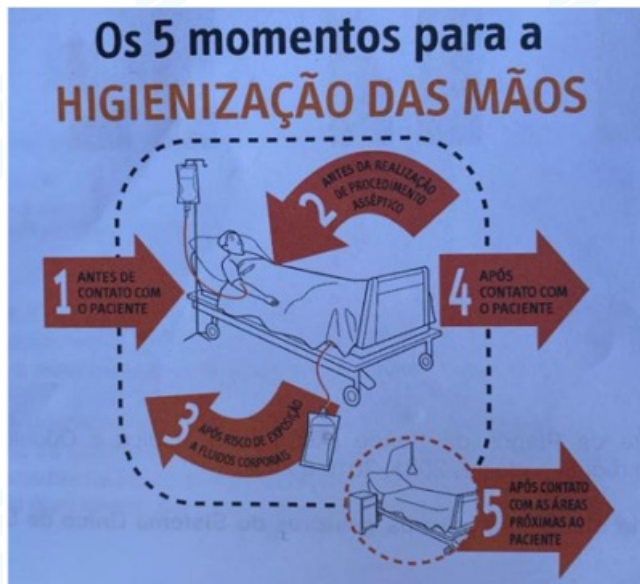
Com vistas à profilaxia antirrábica, a conduta a ser adotada neste caso envolve limpeza criteriosa e desinfecção do local atingido, acompanhada de:

- A Quatro doses de vacina, sem uso de soro.
- B Três doses de vacina e observação do animal.
- C Quatro doses de vacina e uma dose de soro.
- D Apenas acompanhamento do animal.

4 000164215

Questão 94 Prevenção

A figura abaixo ilustra as indicações principais para higienização das mãos pelos profissionais da saúde segundo a



Com base na figura e nas recomendações da OMS sobre higienização de mãos, assinale a alternativa correta.

- A A indicação 5 pode ser dispensada no caso de o paciente estar em isolamento de contato e o profissional tiver usado luvas de procedimento.
- B Na indicação 4, o profissional deve preferencialmente lavar as mãos com água e sabonete líquido, ao invés de aplicar formulação alcóolica.
- C A indicação 1 pode ser dispensada no caso de o paciente estar em isolamento de contato e o profissional for calçar luvas de procedimento.
- D Na indicação 2, o profissional deve realizar a higienização das mãos, mesmo que já a tenha feito antes do primeiro contato com o paciente.

4 000164 214

Questão 95 Imunodeficiências primárias

O médico de família e comunidade está preocupado com uma criança de 2 anos que se mudou para sua área recentemente. Na consulta passada a mãe contou que, nos últimos 12 meses, a criança apresentou vários episódios de sinusite, otite e pneumonia, todos necessitando de antibióticos por tempo longo e que, no momento, vem apresentando diarreia difícil de controlar. Informou que a criança chia o peito às vezes e tem uma alergia na pele (eczema), desde os primeiros meses de vida. Relatou também que a criança precisou tomar, por vários meses, um medicamento porque aos 7 meses de idade apareceu um caroço na axila direita que supurou. A mãe disse ainda que, quando era pequena (a mãe), perdeu um irmão alguns dias após nascer e que há alguns anos perdeu uma sobrinha, mas não sabe dizer a causa.

Qual a principal suspeita diagnóstica para o quadro desta criança?

- A Alergia à proteína do leite de vaca.
- B Erro inato da imunidade.
- C Intolerância à lactose.
- D Parasitose intestinal.

4 000164 213

Questão 96 Saúde Suplementar

Na reunião do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASEMS), uma das pautas foi a importância de se analisar a tendência de cobertura da população por planos de saúde (beneficiários dos planos de saúde). O gestor estadual, que representou a região sudeste do Brasil, apresentou alguns dados sobre a cobertura de assistência médica e odontológica para os quatro estados da região, em três períodos distintos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Cobertura de Planos de Saúde (assistência médica e odontológica exclusiva) segundo estados da região sudeste, 2021,

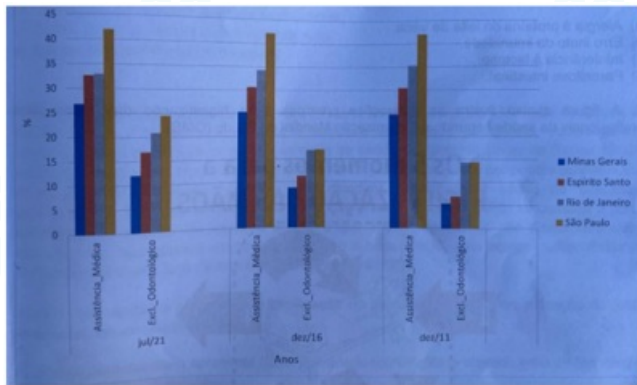


Gráfico 1. Cobertura de Planos de Saúde (Assistência Médica e Odontológica Exclusiva) segundo estados da região sudeste, 2021, 2016 e 2011

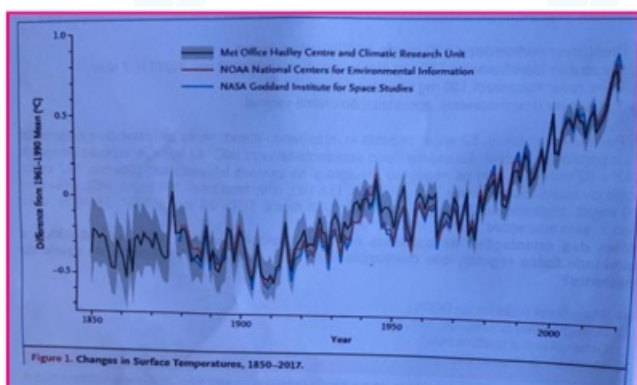
A importância desta discussão para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) está relacionada:

- A A análise da abrangência e do impacto do SUS no atendimento das necessidades de saúde da população.
- B Ao aumento da oferta de serviços médicos e odontológicos para atender às necessidades de saúde da população.
- C A desobrigação de atendimento das necessidades de saúde da população coberta pelos planos de saúde (beneficiários).
- D A diminuição do ressarcimento ao SUS dos serviços prestados aos beneficiários dos planos de saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164212

Questão 97 Medicina Preventiva Cardiologia

O gráfico abaixo, extraído de um artigo científico (N Engl J Med 2019; 380:263-73), ilustra a elevação da temperatura média da superfície terrestre nos últimos 170 anos, segundo diferentes medições. Para a Organização Mundial da Saúde, esse fenômeno é a maior ameaça atual à saúde pública global.



Considerando que o Brasil é atualmente o 6º maior emissor de gases de efeito estufa, qual seria a medida mais efetiva a ser tomada pelo país visando minimizar sua contribuição para o aquecimento global?

- A Reduzir o uso de gasolina, aumentando a produção de etanol a partir da cana de açúcar.
- B Reduzir a queima de carvão mineral, investindo na produção de energia eólica.
- C Reduzir as queimadas na Floresta Amazônica, que constitui grande reserva de carbono.
- D Reduzir o uso de óleo diesel, aumentando a eficiência do transporte de cargas.

4000164211

Questão 98 **Pediatria** **Asma**

A paciente comparece à unidade de saúde da família com seu filho de 7 anos. Informa que a criança foi diagnosticada com asma há 4 meses, quando iniciou o tratamento com budesonida spray oral, em uso até o momento. Relata que a criança estava bem até há 2 dias quando começou a apresentar sibilos e tosse seca principalmente à noite e pela manhã, ao acordar. Nega dispneia e não sabe informar sobre a ocorrência de febre. Durante a consulta, a médica colheu a história clínica da criança, realizou o exame físico completo e mediu o pico de fluxo expiratório (PFE), constatando que a asma não estava controlada.

Com base nas informações descritas acima, qual a conduta inicial mais adequada para o caso desta criança?

- A Prescrever corticosteroide por via oral por 5 dias e, se não houver melhora, encaminhar a criança ao especialista para avaliação do caso.
- B Iniciar broncodilatador de ação-rápida inalatório por 5 dias e, se não houver melhora, encaminhar a criança ao especialista para avaliação e conduta.
- C Verificar presença de infecção respiratória atual, a adesão aos medicamentos, a técnica de uso do dispositivo inalatório e o cuidado ambiental.
- D Encaminhar a criança ao especialista para avaliação do caso, realização de exames específicos e ajuste do esquema terapêutico para asma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000164210](#)

Questão 99 **Prevenção**

Paciente masculino, 52 anos, sedentário, recebendo atendimento de rotina com diagnóstico de hipertensão arterial. Ao exame físico apresenta-se com IMC: 42 kg/m² e pressão arterial de 132 x 82 mmHg e com os seguintes resultados de exames laboratoriais: glicemia: 112 mg/dl, teste de tolerância à glicose 75g (GTT 75): 112/190, colesterol total: 198 mg/dl, HDL colesterol: 49mg/dl, triglicérides 270 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl, TGO: 28 mg/dl, TGP: 37 mg/dl, urina tipo 1: sem alterações.

Além das orientações de cuidados não farmacológicos como orientação dietética e atividade física regular, que medicação seria mais adequada à condição de saúde do paciente?

- Essa questão possui comentário do professor no site [4000164209](#)

Essa questão possui comentário do professor no site 4000164208

[illegible]

Questão 1 Isquemia Mesentérica Crônica Cirurgia

Homem de 64 anos com quadro de perda acentuada de peso (20 kg em 6 meses), astenia e dor abdominal pós prandial. Possui hipertensão arterial sistêmica descontrolada e tabagismo ativo. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, hipocorado e hidratado. Peso atual 47 kg, Abdome escavado sem dor à palpação no momento. Aorta abdominal palpável e pulsátil, porém endurecida. Sopro sistólico audível em mesogástrio sem alteração com a respiração. Pulsos em membros inferiores presentes e simétricos. Realizou tomografia de abdome abaixo: Qual o diagnóstico mais provável?



- A Síndrome do ligamento arqueado mediano.
- B Neoplasia de cabeça de pâncreas.
- C Compressão duodenal por aneurisma de aorta abdominal.
- D Isquemia mesentérica crônica.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182192

Questão 2 Cirurgia Síndrome Compartimental

Mulher de 54 anos com queixa de frialdade, cianose não fixa, parestesia e dor súbita em pé e perna direita há 8 horas. Possui de antecedentes uma prótese valvular aórtica mecânica com controle irregular da anticoagulação com Varfarina. Foi submetida a embolectomia de emergência para revascularização de membro inferior direito, bem-sucedida. Uma hora após do procedimento, já na recuperação, apresentou recrudescimento da dor no membro, edema de panturrilha e perda de pulsos que haviam sido restabelecidos com a cirurgia. Qual o provável diagnóstico?

- A Síndrome compartimental.
- B Flegmasia cerúlea dolens.
- C Novo episódio embólico.
- D Trombose arterial devido a lesão iatrogênica pelo cateter de Fogarty.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182191

Questão 3 Pseudoobstrução Colônica Síndrome de Ogilvie Cirurgia

Homem de 90 anos, com internação prolongada e imobilização por tratamento cirúrgico de fratura do colo do fêmur. Estava em antibioticoterapia para tratamento de pneumonia nosocomial e passou a apresentar parada de eliminação de flatos e fezes associada à distensão abdominal dolorosa. Ao exame, o estado geral era bom, entretanto o abdome era distendido, doloroso à palpação superficial, hipertimpânico e sem sinais de irritação peritoneal. A radiografia simples de abdome mostrou importante distensão gasosa de todo o cólon. Qual o provável diagnóstico e a melhor conduta indicada neste caso?

- A Íleo metabólico; compensação dos distúrbios hidroeletrolíticos e dieta laxativa.
- B Megacólon funcional; colectomia total com ileostomia temporária e sepultamento do reto.
- C Pseudo obstrução colônica aguda; descompressão endoscópica do cólon.
- D Volvo colônico; colonoscopia descompressiva e compensação dos distúrbios e hidroeletrolíticos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182190](#)

Questão 4 Escroto Agudo Cirurgia

Homem, 21 anos, vem a um serviço de pronto atendimento com queixa de dor no testículo direito, de início insidioso, com progressão há um dia, associada à disúria. Exame físico: hiperemia da bolsa escrotal, dor á palpação do testículo e endurecimento do epidídimo. Sinal de Prehn positivo. Qual a melhor conduta no pronto atendimento?

- A Analgesia, colher urina I, urocultura e encaminhar paciente para serviço especializado de urologia.
- B Encaminhar paciente para realizar ultrassonografia com Doppler e avaliar do fluxo sanguíneo testicular
- C Analgesia e encaminhar paciente para exploração cirúrgica de emergência
- D Tratamento clínico com anti-inflamatório, antibioticoterapia empírica e reavaliação entre 7 e 10 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182189](#)

Questão 5 Intussuscepção Intestinal Cirurgia

Menino, 6 meses de idade. Há 6 horas iniciou quadro de dor abdominal em cólica, intensa, com período de acalmia. Evoluiu com piora da dor apresentando episódios mais frequentes com as mesmas características e vômitos. Na ocasião da troca das fraldas, informante refere sangue e muco. Exame físico: estado geral preservado, sem dor na ocasião do exame. Hidratado, corado, eupneico, afebril. Abdome globoso, flácido, sem distensão. Sinal de Dance positivo. Imediatamente encaminhado para exame contrastado, enema opaco. Considerando o provável diagnóstico e a conduta (enema opaco) proposta, qual o resultado esperado?

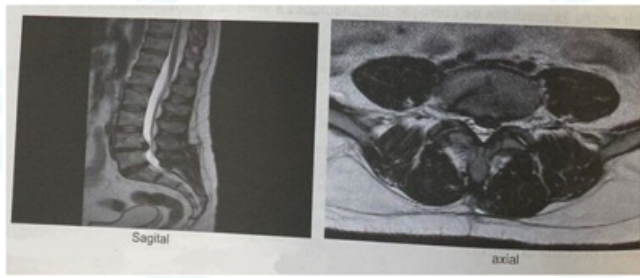
- A Identificação da zona de transição confirmando Hirschsprung.
- B Melhora clínica da enterocolite pela descompressão.
- C Confirmação diagnóstica de volvo intestinal.
- D Redução hidrostática do intussuscepto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182188](#)

Questão 6 Doença degenerativa discal e hérnia discal

Homem de 32 anos, sem comorbidades prévias, queixa se de lombalgia de início súbito com irradiação para membro inferior esquerdo há 7 dias, contínua, melhora parcial com analgésicos. Ao exame físico, além de dor no membro citado (principalmente quando elevado em posição reta acima de 40 graus), apresenta outra nítida alteração semiológica ipsilateral.

Realizou o exame de ressonância magnética em anexo. Qual a alteração vista no exame neurológico?



- A Hipostesia na face posterior da coxa.
- B Paresia da extensão do hálux.
- C Pé caído.
- D Hiporreflexia do aquileu.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182187](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 7 **Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação**

Homem de 36 anos, 100 kg, foi vítima de queimaduras por combustão de álcool ao acender churrasqueira. Após 2 horas, foi admitido no pronto-socorro de hospital terciário, trazido pelo SAMU, tendo recebido no transporte 1.000 ml de solução de ringer lactato. Ao exame: consciente e orientado, Glasgow 15, saturação de oxigênio em ar ambiente de 95%, ventilação com murmúrio vesicular presente e simétrico, frequência respiratória de 18 ipm, frequência cardíaca de 86 bpm, pressão arterial de 110 x 70 mmHg, queimaduras de segundo e terceiro grau em metade do tronco posterior e todo membro inferior direito. De acordo com a 10ª edição do ATLS, como deve ser realizada a reposição volêmica deste paciente nas próximas horas?

- A 2.700 ml de solução cristaloide nas próximas 6 horas.
- B 2.700 ml de solução cristaloide nas próximas 8 horas.
- C 1.700 ml de solução cristaloide nas próximas 6 horas.
- D 1.700 ml de solução cristaloide nas próximas 8 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182186](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 8 **Clínica e tipos histológicos** **Dermatologia** **Tratamento e conduta**

Mulher de 50 anos procura cirurgião plástico preocupada com lesão papular hiperocrômica na face, com cerca de 2 mm de espessura, simétrica, bordos regulares, coloração homogênea, diâmetro de 5 mm e crescimento lento. Qual a melhor conduta?

- A Exérese com margem de 5 mm e pesquisa do linfonodo sentinela cervical.
- B Eletrocauterização.
- C Crioterapia.
- D Exérese com margem de 2 mm e exame anatomopatológico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182185](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 9 Lesão da Árvore Traqueobrônquica Cirurgia

Mulher, 20 anos, vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo, na altura do 3º EIC junto à linha axilar anterior; chega dispneica à sala de trauma com saturação de O₂ = 88%. O tórax foi drenado com dreno tubular e sistema coletor selo d'água. A saturação após a drenagem pleural = 90%. Realizado RX de tórax ainda na sala de trauma que mostra dreno bem posicionado com pneumotórax persistente, apesar do coletor borbulhar bastante. Qual a próxima conduta?

- A Colocar um segundo dreno de tórax.
- B Tomografia computadorizada de tórax.
- C Broncoscopia de urgência.
- D Trocar o dreno de tórax.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182184](https://www.4000182184.com)

Questão 10 Apendicite Aguda Complicada Apendicite Aguda Cirurgia

Mulher de 70 anos, com dor abdominal inicialmente no andar inferior do abdome que migrou para hemi abdome direito e, principalmente, na fossa ilíaca direita associada a cerca de 5 evacuações diárias sem sangue ou muco há 15 dias. Há 12 dias, em serviço externo, iniciou tratamento para infecção do trato urinário com antibiótico. Houve discreta melhora e foi submetida a exame de imagem que motivou o encaminhamento para hospital terciário. Na admissão estava consciente e orientada, desidratada +/-, frequências cardíaca de 78 batimentos por minuto e respiratória de 18 incursões por minuto e saturação de oxigênio de 95%. O abdome era globoso, distendido, com ruídos hidroaéreos hipoativos, massa palpável e dolorosa no hemi abdome direito e com reação de defesa à palpação de fossa ilíaca direita. A tomografia revelou volumosa coleção parcialmente delimitada com focos gasosos com extensão para o músculo iliopsoas, a cavidade e a parede abdominal, com provável fecalito no interior. Em adição às medidas de correção das alterações sistêmicas e antibioticoterapia, qual a abordagem a ser adotada?



- A Drenagem percutânea.
- B Laparotomia exploradora.
- C Drenagem ecoendoscópica
- D Laparoscopia exploradora.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182183](https://www.4000182183.com)

Questão 11 Tratamento Cirurgia

Homem, 25 anos, vítima de queda de moto, trazido pelo SAMU, é admitido na sala de trauma de um hospital referência, confuso e com dor abdominal. Exame físico: saturação de O₂ = 94%. FC = 130 bpm, PA = 90 x 60 mmHg, Escala de Coma de Glasgow = 14. Após reanimação volêmica com 1L de solução cristaloide e infusão de dois concentrados de hemácias e um PFC, passou a apresentar FC = 105 bpm e PA = 100 x 70 mmHg. Realizou tomografia computadorizada de corpo inteiro, que evidenciou lesão hepática grau

V. com blush e volumoso hemoperitôneo. Qual a conduta mais adequada?

- A Manter paciente em observação na sala de trauma nas primeiras 24 horas.
- B Encaminhar paciente para tratamento não cirúrgico em leito intensivo.
- C Encaminhar paciente para tratamento cirúrgico.
- D Encaminhar paciente para a embolização.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182182](#)

Questão 12 Tratamento Cirurgia

Em uma avaliação médica de rotina de puericultura, notou-se em menino 2 anos de idade ausência do testículo esquerdo na bolsa. Já ao nascer o pediatra orientou os pais que até os dois anos o testículo poderia descer espontaneamente. O paciente encontra-se saudável e o exame físico geral não apresenta alterações. O testículo direito é tópico e normotrófico. Qual a próxima medida diagnóstica a ser tomada?

- A Descartar testículo retrátil.
- B Solicitar ressonância magnética de abdome e pelve.
- C Solicitar US abdominal.
- D Prescrever gonadotrofina coriônica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182181](#)

Questão 13 Hemorragia Subaracnoidea HSA Neurologia Cefaleia Induzida por Hemorragia Subaracnoidea

Paciente de 23 anos, previamente hígida, é trazida ao pronto-socorro devido queixa de cefaleia súbita e de forte intensidade. Familiares negam perda de consciência, assim como negam episódios prévios semelhantes. Ao exame: sonolenta e confusa (Glasgow 13), pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficits neurológicos focais, apresentando rigidez de nuca (+2/+4), afebril e estável hemodinamicamente. Qual a medida inicial indicada?

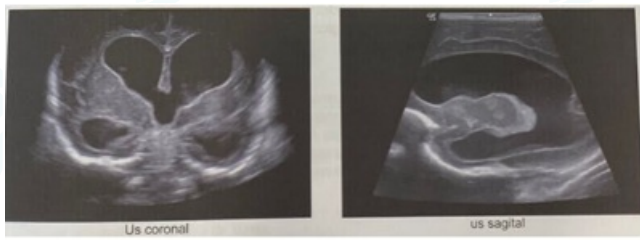
- A Tomografia computadorizada de crânio.
- B Punção lombar diagnóstica.
- C Administração de solução salina hipertônica 3%.
- D Intubação orotraqueal seguida por hiperventilação controlada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182180](#)

Questão 14 Neurologia Sinais e sintomas

Criança de 1 mês de idade, nascida de parto cesárea sem intercorrências, com quadro de irritabilidade e baixo ganho de peso. A mãe teve diagnóstico de toxoplasmose confirmado durante a gestação. Ao exame físico, encontra-se desperto e reativo, com peso de 2400 g e perímetro craniano de 42 cm; fontanelas abauladas, com mobilidade ocular normal. Seu

exame de ultrassonografia de crânio transfontanelar encontra-se abaixo.



Qual é a melhor conduta terapêutica?

- A Terceiroventriculocisternostomia endoscópica
- B Acetazolamida oral
- C Punção lombar de alívio
- D Derivação ventriculoperitoneal

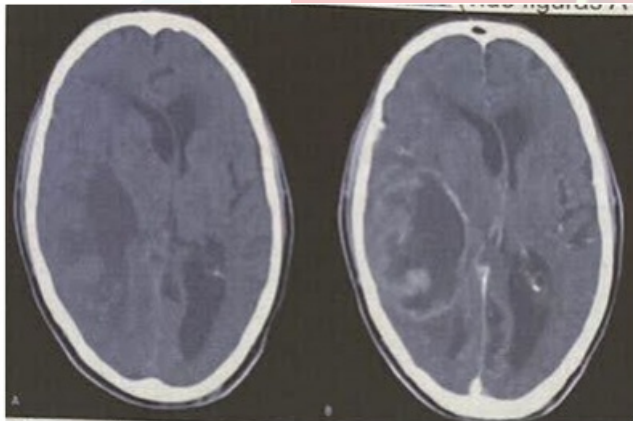
Medicina Livre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182179

na medicina.

Questão 15 Neuroimagem em Epilepsia Crise Única e Crise Sintomática Aguda Provocada Neurologia

Paciente de 76 anos, previamente hipertensa, é admitida no pronto atendimento com história de crise convulsiva inédita há 2 horas. Familiares negam episódios prévios, assim como referem que a crise convulsiva foi autolimitada, com ocorrência de liberação esfinteriana e abalos musculares tônico clônicos. Ao exame: confusa e sonolenta (Glasgow 13), pupilas isocóricas e bradirreagentes e hemiparesia diminuída à esquerda. Solicitada tomografia computadorizada de crânio sem e com administração de contraste endovenoso (vide figuras A e B, respectivamente). Tomografia computadorizada de crânio sem e com contraste Qual o diagnóstico mais provável?



Acesse t.me/medicinalivre

- A Acidente vascular cerebral isquêmico.
- B Glioblastoma.
- C Hemorragia intraparenquimatosa.
- D Meningioma.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182178

Questão 16 Protocolo de transfusão maciça Cirurgia

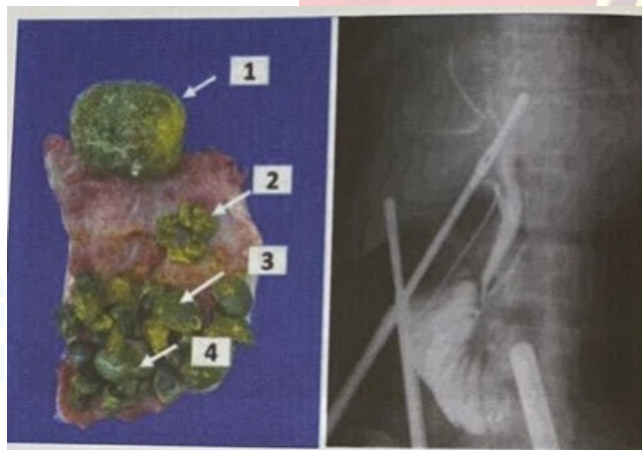
Homem, 20 anos, vítima de acidente automobilístico em rodovia há 40 minutos, com trauma de crânio evidente, trazido pelo SAMU; chega à sala de trauma de um hospital terciário com intubação traqueal em razão do rebaixamento do nível de consciência. A equipe de atendimento pré-hospitalar informou que o paciente apresentava sinais de choque hipovolêmico e infundiu até a chegada ao hospital 1 litro de solução cristaloide. Exame físico: saturação de O_2 = 95%, FC = 140 bpm, PA = 80 x 60 mmHg, ECG = 3. Qual a melhor forma de tratar o choque hemorrágico deste paciente?

- A Infundir hemácias e plasma fresco em proporções altas, sem necessidade de aguardar exames laboratoriais e buscar foco de sangramento.
- B Infundir 1 litro de cristaloide, aguardar exames laboratoriais para iniciar transfusão hemácias e buscar foco de sangramento.
- C Infundir 1 litro de cristaloide, realizar hipotensão permissiva, iniciar transfusão de hemácias e buscar foco de sangramento.
- D Infundir hemácias, realizar hipotensão permissiva, aguardar exames laboratoriais para infundir plasma fresco e buscar foco de sangramento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182177](https://www.4000182177.com)

Questão 17 Etiologia Cirurgia Coledocolitíase

Mulher de 32 anos, admitida com dor no andar superior do abdome há 12 horas. Achados físicos: icterícia +/4+, temperatura de 37 °C, frequências respiratória e cardíaca de 20 incursões e 100 batimentos por minuto, respectivamente, distensão e dor abdominal no andar superior à palpação superficial e profunda. Achados laboratoriais: Glóbulos brancos: 16.000/ml (valor de referência de 4.000 a 10.000/ml), amilase de 1.200 U/dl (valor de referência até 125 U/L), bilirrubinas totais e direta de 4,6 e 3,2 mg/dl (valor de referência de até 1,10 e 0,30 mg/dL, respectivamente). As imagens foram obtidas durante o tratamento cirúrgico realizado após uma semana da admissão. Dentre os cálculos observados, as manifestações clínicas e laboratoriais e os achados radiológicos estão associadas, provavelmente, ao:



- A 3
- B 4
- C 1
- D 2

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182176](https://www.4000182176.com)

Questão 18 Cardiologia Indicações de revascularização

Homem de 66 anos, diabético, portador de coronariopatia obstrutiva e doença arterial obstrutiva periférica, ambas

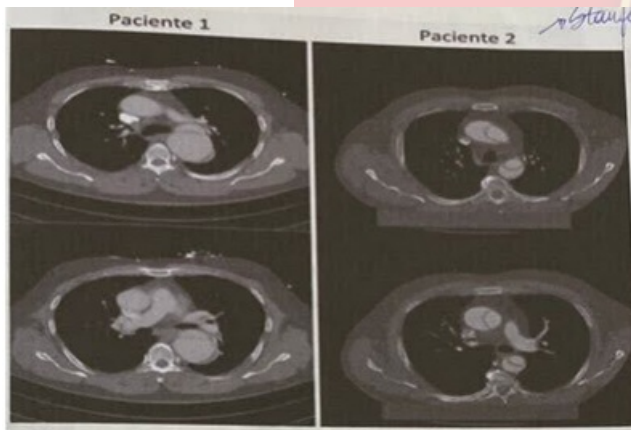
ateroscleróticas, creatinina de 1,4 mg/dl, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 30%, com 22% de miocárdio isquêmico pela cintilografia, com lesão de 55% de tronco de artéria coronária esquerda e obstruções maiores que 70% em ramo marginal da circunflexa, descendente anterior proximal, segundo ramo diagonal e porção distal da coronária direita que é dominante. O Syntax Score I é de 38. Apresenta angina classe III segundo a Sociedade Canadense de Cardiologia. Qual alternativa aponta para a conduta que tem maior probabilidade de oferecer maior sobrevida em 4 anos?

- A Cirurgia de revascularização do miocárdio.
- B Tratamento paliativo.
- C Tratamento medicamentoso otimizado apenas.
- D Intervenção Coronária Percutânea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182175](https://www.4000182175.com)

Questão 19 Tratamento da dissecação aórtica tipo A Tratamento da dissecação aórtica tipo B Cardiologia

As figuras abaixo mostram os achados radiológicos de dois pacientes masculinos, Paciente 1 e Paciente 2, atendidos no serviço médico de urgência com história de dor súbita de forte intensidade em região anterior do tórax. Ambos têm 65 anos de idade e são hipertensos de longa data. Ambos receberam beta bloqueador e analgésico opioide na admissão e estão hemodinamicamente estáveis. Após medicados, a pressão arterial de ambos é de 130/80 mmHg, a frequência cardíaca de 56 bpm, ambos apresentaram redução significativa da dor e não apresentaram intercorrências. Das alternativas abaixo, qual mostra a conduta mais adequada para cada paciente?



- A O Paciente 2 deve ser submetido a tratamento medicamentoso
- B O Paciente 1 deve ser submetido a tratamento endovascular imediato.
- C Paciente 1 deve ser submetido a tratamento medicamentoso.
- D O Paciente 2 deve ser submetido a tratamento endovascular imediato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182174](https://www.4000182174.com)

Questão 20 Tratamento Cirurgia

Homem de 65 anos de idade, diabético, apresenta-se no pronto-socorro com uma úlcera na região plantar do pé esquerdo há 6 semanas. Sem febre, com sinais vitais estáveis e com contagem de leucócitos de 9000 cells/mm³. A radiografia simples do pé demonstra destruição óssea significativa do primeiro e do segundo metatarsos distais. Ao exame, há uma ferida aberta de 3 x 4 cm sobre o antepé, com eritema circundante moderado menor que 0,5 cm. Pulsos distais ausentes, a pele do pé é brilhante e há perda dos fâneros até a metade da perna. O ultrassom mostra uma coleção discreta de fluido

plantar sobre a primeira e a segunda cabeça do metatarso. O índice tornozelo braço (ITB) do lado esquerdo é 0,5. Foi internado e prescrito antibiótico endovenoso. Qual das alternativas a seguir descreve a melhor sequência de manejo cirúrgico para este paciente?

- A Revascularização e posterior desbridamento.
- B Desbridamento e curativo com pressão negativa.
- C Desbridamento e oxigenioterapia hiperbárica.
- D Amputação do primeiro e segundo raio e posterior revascularização.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182173](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 21 **Esclerose sistêmica** **Reumatologia** **Fenômeno de Raynaud**

Mulher, 52 anos, há três anos apresenta arroxamento, formigamento e queimação em dedos das mãos ao contato com superfícies ou ambientes frios. Refere disfagia para alimentos sólido, com frequente queimação retroesternal pós alimentar. Exame físico: bom estado geral; redução da elasticidade da pele em dorso das mãos; murmúrio vesicular bem distribuído, com estertores em velcro nas bases pulmonares. Teste de contato com gelo resultou na imagem abaixo: Qual medicação está indicada para a alteração mostrada na imagem?



Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Metotrexato.
- B Nifedipino.
- C Varfarina.
- D Prednisona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182172](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 22 **Reumatologia** **Artrite psoriásica**

Mulher, 52 anos, refere dor e rigidez em região lombar pela manhã há 1 ano. Ambos os sintomas são aliviados, parcialmente após horas e atividade ou uso de AINEs. Refere dor em calcanhares há 3 meses. Nega doenças e tratamentos. Exame físico: bom estado geral, corada; sem lesões cutâneas; unhas: onicólise e mancha de óleo nos pés; teste de Patrick positivo à esquerda. Os pés são mostrados na foto abaixo: Qual diagnóstico é mais provável?



- A Gota tofácea crônica.
- B Artrite psoriásica.
- C Artrite reumatoide.
- D Espondilite anquilosante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182170](https://www.4000182170.com.br)

Questão 23

Esclerose sistêmica

Reumatologia

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Mulher, 41 anos, refere dispneia progressiva há 1 ano, atualmente ao andar 50 metros. Há 8 meses notou edema de membros inferiores. Refere que as mãos ficam arroxeadas e em seguida esbranquiçadas, quando em contato com água gelada, e diz ter disfagia com engasgos há 3 anos. Exame físico: BEG, corada, hidratada, elasticidade da pele reduzida em membros e face. com diminuição da abertura oral. Murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios FR: 26 ipm. Sat O2: 87% em ar ambiente. Ritmo cardíaco regular com hiperfonese de B2. FC: 98 bpm. PA: 110 x 60 mmHg. Estase jugular a 45 graus. Qual sintoma adicional seria mais compatível?

- A Síncope.
- B Ortopneia.
- C Hemoptise.
- D Chiado.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

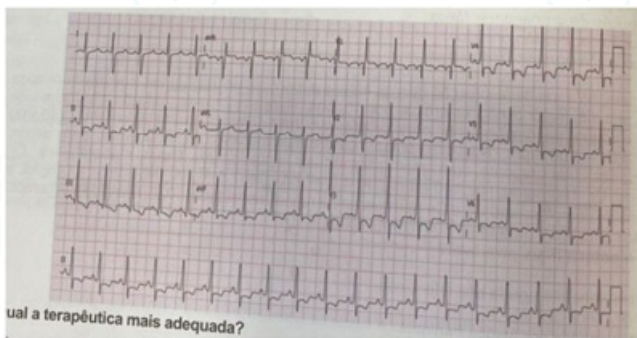
Essa questão possui comentário do professor no site [4000182170](https://www.4000182170.com.br)

Questão 24

Trombolítico

Pneumologia

Mulher, 67 anos, previamente hígida, internada por dispneia súbita, hemoptise e dor torácica há 1 hora. Tromboembolismo pulmonar foi confirmado por angiotomografia de tórax, sendo iniciada anticoagulação plena com enoxaparina. A dispneia passou a ser discreta, aos esforços. No terceiro dia de internação apresentou se em REG, descorada (+/4+), consciente. Murmúrio vesicular simétrico, sem ruídos adventícios FR: 30 ipm. Ritmo cardíaco regular, FC: 128 bpm. PA: 60 x 30 mmHg, má perfusão distal. Sem sinais neurológicos focais. Eletrocardiograma abaixo:



- A Realizar cinecoronariografia
- B Controle de frequência cardíaca.
- C Trombólise com alteplase.
- D Repetir angiotomografia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182169](https://www.4000182169.com)

Questão 25 **Etiologia** **Insuficiência Cardíaca**

Homem, 41 anos, trabalhador rural, hipertenso em uso irregular de anti-hipertensivos. Foi admitido em hospital com queixa de dispneia, ortopneia, edema de membros inferiores e palpitações há 1 mês além de oligúria há 2 dias. Feito o diagnóstico inicial de insuficiência cardíaca e tratado com furosemida e vasodilatadores, sem melhora do quadro. História de consumo prévio de 95 g de etanol/dia por 15 anos; parou há 4 meses, no decorrer dos quais perdeu 10 Kg. Exame físico: consciente, afebril, PA 130/75 mmHg, FC: 121 bpm, estase jugular, edema depressível generalizado, pulsos amplos extremidades quentes, sem nistagmo ou ataxia. Exames complementares revelam: derrame pleural bilateral, acidose láctica, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 77% (aferida por ecocardiograma). Qual a etiologia mais provável da insuficiência cardíaca?

- A Deficiência de tiamina.
- B Miocardite viral.
- C Miocardiopatia alcoólica.
- D Cardiopatia hipertensiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182168](https://www.4000182168.com)

Questão 26 **Nefrologia**

Homem, 55 anos, hipertenso em uso de hidroclorotiazida 25 mg/dja e atenolol 50 mg 2x ao dia, refere edema de membros inferiores e redução do volume de diurese há 30 dias. Submetido a biopsia renal, cujos achados foram compatíveis com nefropatia por IgA. Exame físico: PA: 110 x 70 mmHg. FC: 65 bpm. Ausculta respiratória com crepitações em terço inferior bilateral. Edema de membros inferiores 3+/4+. Exames laboratoriais: Cr: 1,5 mg/d (taxa de filtração glomerular estimada: 45 mL/min/1,73 m²); Ur: 85 mg/dL, K: 5.0 mg/dL; urina rotina densidade: 1018, proteínas: 300 mg/dL, hemácias: 10/campo. Proteinúria de 24 h: 900 mg (volume urinário de 1000 mL). Qual medicação deve ser associada ao tratamento?

- A Micofenolato mofetil.
- B Ciclosporina.
- C Prednisona.
- D Losartana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182167](https://www.4000182167.com)

Questão 27 Doença por lesões mínimas Nefrologia

Homem, 55 anos, teve infecção de vias aéreas superiores há 3 semanas, com melhora após uso de anti-inflamatório não esteroidal por 10 dias. Refere adinamia, redução do volume de diurese e edema de membros inferiores, progressivo, há 1 semana. Exame físico: PA= 140 x 90 mmHg, FC = 100 bpm. Ausculta: bulhas cardíacas rítmicas e hiperfonéticas, sem sopro: murmúrio vesicular presente, com crepitações em bases pulmonares. Exames laboratoriais Cr 3,0 mg/dL, Ur: 100mg/dL, Na: 140 mEq/L, K: 4,0 mEq/L, Ca: 7,5 mg/dL, albumina: 1,8 mg/ dL e dosagens de complemento C3 e C4 normais; urina rotina densidade: 1020, hemácias: 2/campo, leucócitos: 2/campo, proteínas: 500 mg/dL, lipídeos: 3+. Qual a hipótese mais provável?

- A Glomerulonefrite aguda pós infecciosa.
- B Nefrite intersticial aguda.
- C Glomerulopatia por lesões mínimas.
- D Nefropatia por IgA.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182166](https://www.4000182166.com)

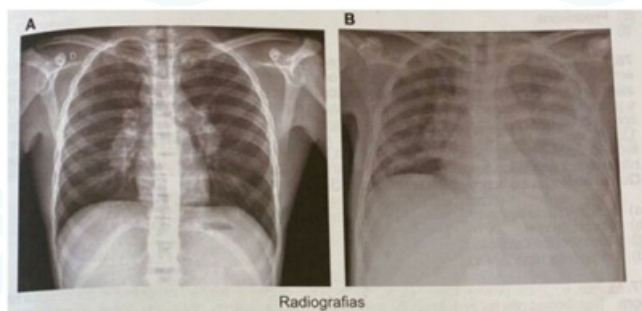
Questão 28 Derrame Pleural Pneumologia

Homem, 17 anos, com adenomegalia, perda de peso e febre há 1 mês. Exame físico: linfonodos palpáveis em cadeias cervicais, axilares e inguinais, com 2 a 3 cm de diâmetro. Abdome: indolor, fígado e baço palpáveis. Ap. respiratório e cardiovascular sem alterações.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Radiografia da admissão hospitalar é mostrada na figura A. Nova radiografia, após 20 dias de internação, é mostrada na figura B. Foram realizadas biópsia de linfonodo cervical e toracocentese diagnóstica. Líquido pleural: aspecto turvo e esbranquiçado; leucócitos: 4363 células/mm³ (VR < 200) (35% de 63% linfócitos); pH: 7.44; LDH: 138 L: proteínas totais: 4,29 g/dL; colesterol total: 54,1 mg/dL; triglicérides: 143 mg/dL. Relação proteína líquido pleural/sangue = 0,58; relação LDH líquido pleural/sangue = 0.53. Qual é o mecanismo fisiopatológico mais provável para a ocorrência de derrame pleural?



- A Inflamação da pleura.
- B Obstrução de drenagem linfática.
- C Redução da pressão oncótica.
- D Aumento na pressão hidrostática.

4000182165

Questão 29 Faringite por *Streptococcus pyogenes* Infectologia Faringites Bacterianas

Mulher, 18 anos, procura atendimento médico devido a febre e dor de garganta há 2 dias. Teve reação anafilática aos 10 anos após uso de penicilina benzatina. Exame físico: edema e exsudato puntiforme nas tonsilas palatinas, associados a petéquias no palato. Dois linfonodos palpáveis e dolorosos em cadeia submandibular à direita com cerca de 2 cm de diâmetro. Qual é o tratamento mais adequado?

- A Cefuroxima.
- B Ampicilina.
- C Azitromicina.
- D Amoxicilina.

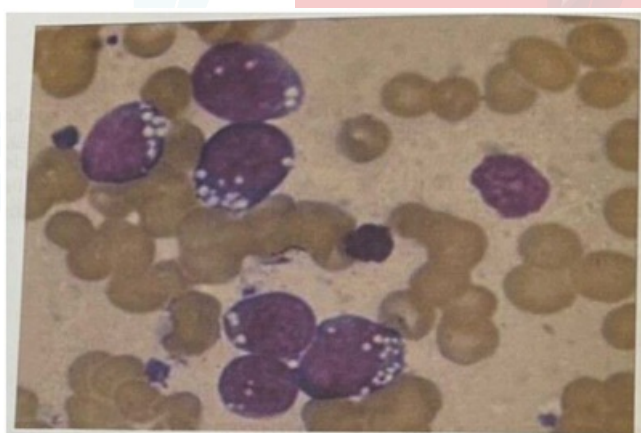
Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182164

Questão 30 Síndrome de Lise Tumoral SLT Síndrome de Lise Tumoral Síndrome de lise tumoral SLT

Homem, 39 anos, apresenta distensão abdominal e não evacua há 48 horas. Realizada tomografia computadorizada de abdome com achado de massa de 11 x 8 cm nos maiores diâmetros e sinais de compressão intestinal. Exames laboratoriais: Hemograma: Hb: 8,4 g/ dL, HE 25%, VCM: 98 L, leucócitos: 14.000/mm³, plaquetas: 56.000/mm³ (esfregaço do sangue periférico mostrado na Figura): LDH: 3.236 U/L (VR < 230). ácido úrico: 13 mg/dL (VR < 6.0). Qual alteração eletrolítica é mais provável?

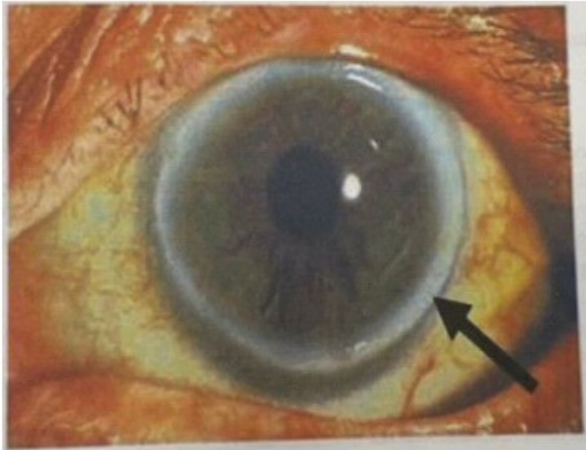


Acesse t.me/medicinalivre

- A Hiponatremia.
- B Hiperfosfatemia.
- C Hipercalcemia.
- D Hipocalemia.

Questão 31 Oftalmologia

Homem, 74 anos, relata que há dois anos vem notando faixa esbranquiçada no olho. Ao exame: presença de arco opaco esbranquiçado na junção esclerocorneal, na periferia da íris bilateral (Figura). Qual a conduta mais adequada em relação à alteração ocular mostrada?



- A Não prosseguir com investigação.
- B Avaliação com lâmpada de fenda.
- C Realização de topografia corneana.
- D Prescrição de lágrima artificial.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.Essa questão possui comentário do professor no site [4000182162](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000182162)**Questão 32** Mecanismo Fisiopatológico

Homem, 66 anos, com diarreia há 5 dias. Relata 10 a 12 evacuações ao dia, com fezes líquidas, em pequeno volume, que após dois dias passaram a ser mucossanguinolentas, e acompanhadas de tenesmo. Ademais, refere dor abdominal difusa, em cólica, de intensidade moderada e sem alívio com a evacuação, febre não aferida e náuseas. Exame : abdome com ruídos hidroaéreos hiperativos, doloroso à palpação difusamente, sem descompressão brusca. Qual mecanismo mais provável associado à diarreia?

- A Inflamatório
- B Cismótico.
- C Motor.
- D Secretor

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182161](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000182161)**Questão 33** Marcadores sorológicos Hepatologia

Mulher, 28 anos, procura atendimento médico após seu irmão receber o diagnóstico de hepatite B. Assintomática. Exames laboratoriais: HBsAg negativo; anti HBc IgG positivo HBeAg negativo; anti-HBs positivo; anti HBe positivo. Como devemos interpretar estes resultados?

- A Cura funcional da hepatite B.
- B Infecção crônica pelo vírus B.
- C Vacinação prévia para hepatite B.
- D Imunotolerância ao vírus B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182160](#)

Questão 34 Endocrinologia

Mulher, 56 anos, diabética há 8 anos e em tratamento com insulina, está internada para realização de colecistectomia. Você é chamado para avaliar a paciente por ela apresentar sudorese e tremores em mãos e estar agitada. Exame físico: bom estado geral, consciente, orientada, com palidez cutâneo mucosa. FC: 112 bpm. PA: 140 x 80 mmHg. Glicosimetria capilar: 46mg/dL. Qual é a conduta preconizada?

- A Oferecer sanduíche.
- B Glicose 5% endovenosa.
- C Glicose 50% endovenosa.
- D 300 mL de suco de laranja.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182159](#)

Questão 35 Diagnóstico etiológico da hipernatremia Manifestações clínicas Nefrologia

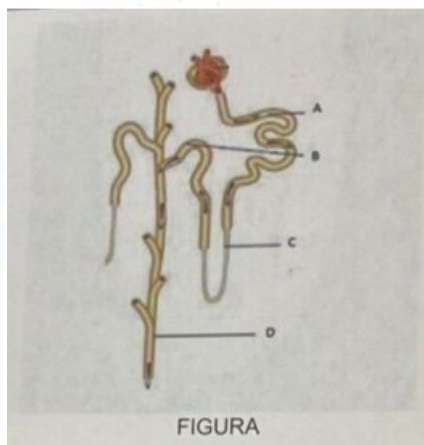
Homem, 19 anos, iniciou quadro de poliúria e polidipsia após bater a cabeça durante uma partida de futebol. Exame físico: bom estado geral, mucosas hidratadas, eupneico, estável hemodinamicamente. Diurese das 8h às 20h: 3000 mL; das 20h às 8h: 2600 mL. Exames laboratoriais: glicemia: 80 mg/dL (VR: 70 a); Na: 146 mEq/L (VR: 136 a 145); osmolalidade urinária: 75 mOsm/kg (VR: 300 a 900); osmolalidade plasmática: 304 mOsm/kg (VR: 280 a 295); TSH: 5,6 mUI/L (VR: 0,5 a 5), T4 livre: 1,1 ng/dL (VR: 0,8 a 1,8); creatinina e cortisol normais. Considerando a doença mais provável, qual tratamento é indicado?

- A Desmopressina.
- B Restrição hídrica.
- C Diurético.
- D Levotiroxina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182158](#)

Questão 36 Tratamento da cirrose Nefrologia Diuréticos poupadores de potássio

Homem, 60 anos, portador do hepatite C diagnosticada há 20 anos, sem tratamento. Refere aumento progressivo do volume abdominal, edema nos membros inferiores e alteração do ciclo sono vigília. Exame físico: REG, descorado +/4+, hidratado. Abdome globoso, presença de macicez móvel e do sinal do piparote. Exames laboratoriais: Cr: 1,0 mg/dL. Na: 121 mEq/L, K: 3,8 mEq/L. Qual é o local de ação do diurético mais indicado?



FIGURA

- A D
- B C
- C A
- D B

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182157](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 37 **Alcalose respiratória** **Nefrologia**

Mulher, 60 anos, tabagista (40 anos-maço), queixa-se de dispneia aos mínimos esforços. Nega tosse, febre ou outros sintomas gripais. Exame físico: REG, corada, hidratada, sonolenta; Peso = 150 kg e altura = 1,60 m; Ap. resp.: murmúrio vesicular presente, diminuído globalmente, sem RA, SatO₂: 97% com cateter de O₂ a 4L/min. Foi coletada uma gasometria arterial para avaliação. Qual é o resultado de gasometria arterial esperado?

- A pCO₂ = 20 mmHg
- B HCO₃ = 42 mEq/L
- C pO₂ = 50 mmHg
- D pH = 7,5

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182156](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 38 **Reação do tipo 1** **Dermatologia**

Homem, 40 anos, em tratamento de hanseníase dimorfa com poliquimioterapia multibacilar (PQT MB) há 2 meses, apresenta edema e aumento das lesões de pele, além de aparecimento de lesões ao redor das lesões prévias há 15 dias. Em associação, relata dor intensa na região de fossa cubital direita e piora do formigamento na mão ipsilateral. Não apresenta outras patologias ou alterações ao exame físico. Qual a conduta mais adequada?

- A Ultrassonografia de nervos e substituição para PQT alternativa.
- B Eletroneuromiografia e suspensão da PQT MB.
- C Talidomida e substituição para PQT alternativa.
- D Corticoterapia e manutenção da PQT MB.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182155](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 39 Clínica e tipos histológicos Dermatologia

Mulher, 62 anos, parda, diabética e hipertensa controlada, portadora de lúpus sistêmico em uso de cloroquina e azatioprina há 8 anos. Refere trauma na unha do 1º quirodáctilo da mão esquerda há 1 ano. Desde então notou escurecimento da unha (Figura). Qual diagnóstico mais provável?



- A Melanoníquia traumática.
- B Melanoma ungueal.
- C Nevo melanocítico.
- D Melanoníquia medicamentosa.

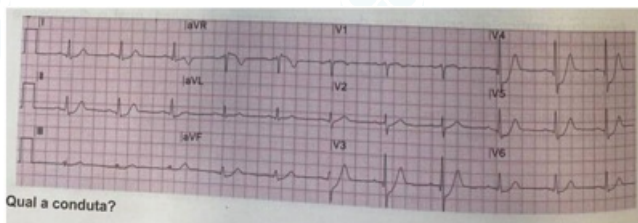
medicina livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182154](#)

Questão 40 Estratificação de risco Eletrocardiograma Cardiologia

Homem, 45 anos, dislipidêmico, refere dor precordial há 2 horas com irradiação para ombro direito, associada a diaforese e náuseas. Exame físico: estertores pulmonares basais, sem outras alterações; FC = 70 bpm, PA = 100 x 60 mmHg. Eletrocardiograma (ECG) abaixo. Qual a conduta?



- A Seriar ECG e observação clínica.
- B Seriar troponina e eletrocardiograma.
- C Intervenção coronariana percutânea.
- D Tomografia computadorizada de tórax.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182153](#)

Questão 41 Infectologia Larva migrans

Paciente chega à Unidade de Saúde da Família queixando-se de lesão no braço há 5 dias. Passou pelo acolhimento e como havia vaga para consulta eventual, o paciente foi orientado a aguardar. Na consulta, o paciente referiu ao médico de família aparecimento de lesão em região posterior do braço D que vem aumentando progressivamente e o prurido se intensificando, atrapalhando o sono e suas atividades no trabalho. Diante do apresentado, qual a melhor conduta para o quadro do paciente?



Contra preços abusivos
na medicina.

- A Prescrever albendazol oral.
- B Prescrever corticosteroide tópico.
- C Solicitar exame parasitológico de fezes.
- D Solicitar raios x de tórax PA e perfil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182152](https://www.4000182152.com)

Questão 42 Avaliação do Crescimento. Pediatria

Acesse t.me/medicinalivre

Os pais de um garoto de 13 anos e 7 meses trazem-no em uma consulta de rotina em uma unidade de saúde da família. Os pais demonstraram grande preocupação com a altura do filho, já que ele sempre foi o mais baixo da sala de aula da escola. A mãe conta que a gestação do menino ocorreu muito bem, sem intercorrências. O parto foi normal, a termo, sem intercorrências, peso ao nascimento 3180 gramas, comprimento 49 cm, PC 33 cm, Apgar 9/10. A criança apresentou o desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Fica resfriado com uma frequência alta segundo a opinião dos pais. Sem outras doenças prévias, uso de medicamentos ou cirurgias. História familiar sem informações relevantes. EF: sem alterações dignas de nota, genitália masculina típica, estadiamento de Tanner G2P2, exame de idade óssea 11 anos, Calculada a altura alvo do garoto através das alturas dos pais. Avaliado o gráfico de crescimento do paciente desenhado acima, qual o diagnóstico provável do paciente?



- A Deficiência do hormônio do crescimento.
- B Estatura normal.
- C Baixa estatura constitucional.
- D Baixa estatura familiar.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182151

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Questão 43 Dermatologia Dermatite de contato alérgica

Uma paciente, do sexo feminino, chega à USF solicitando consulta porque há vários dias vem apresentando lesões eritematosas, descamativas e muito pruriginosas localizadas em regiões laterais De E do tórax, dirigindo se para região posterior, contornando o tronco de forma simétrica. Refere também lesões semelhantes em antebraço esquerdo, próximo ao punho que surgiram da mesma forma que as lesões em tronco inicialmente formavam pápulas eritematosas, evoluindo para vesículas de conteúdo seroso e depois descamação, sempre acompanhadas de muito prurido. Informa praticar atividade física regularmente e nos últimos tempos tem se dedicado à natação e corrida, mas no momento não está conseguindo porque sente piora após a realização dos exercícios. Fotos abaixo. Diante da história clínica e imagens das lesões, qual, na sua opinião, o diagnóstico mais provável desta paciente?



- A Dermatite herpetiforme.
- B Dermatite de contato.
- C Dermatite psoriasiforme.
- D Dermatite atópica.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182150

Questão 44 Medicina Preventiva

Os gestores da Região de Saúde (RS) X se reuniram para discutir a operacionalização da rede de atenção à saúde (RAS) regional, considerando as orientações de Ministério da Saúde sobre este assunto. Durante a discussão houve um impasse, pois alguns gestores defendiam a construção de mais dois hospitais na RS, enquanto outros argumentavam que era preciso construir mais unidades de atenção primária à saúde (APS). Os gestores que defendiam o maior investimento na APS, se apoiavam no conceito de que uma RAS os serviços de saúde devem ser organizados de forma que o que é frequentemente necessário esteja disseminado e o que é raramente necessário esteja concentrado. Esse conceito empregado pelos gestores se refere a que princípio do Sistema Único de Saúde?

- A Universalização
- B Hierarquização.
- C Descentralização.
- D Integralidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182149](#)

Questão 45 Medicina Preventiva

Os cinco gestores da Região de Saúde (RS) X solicitaram uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR) da Região de Saúde Y para discutir especificamente duas questões: a falta de agentes comunitários que estava prejudicando o cadastramento da população nas unidades de atenção primária e a fila de espera de 8 meses para a realização de colonoscopia, disponibilizada apenas no município sede da RS. Para enfrentar estes problemas os gestores fizeram a pactuação de tentar organizar colaborativamente o sistema de saúde regional no formato de rede de atenção à saúde (RAS), pois eles acreditavam ser esse o caminho mais acertado para se melhorar o atendimento de saúde à população. Quais elementos constitutivos da RAS estavam prejudicados na RS do caso descrito?

- A Estrutura operacional e modelo de atenção.
- B Modelo de atenção e sistemas logísticos.
- C Sistemas logísticos e governança.
- D Gestão de base populacional e sistemas de apoio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182148](#)

Questão 46 Infectologia Vacinas Infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* ILTB

Você atua como Médico de Família e Comunidade em uma Unidade Básica de Saúde e faz seguimento de uma paciente do sexo feminino de 75 anos, que trata hipertensão arterial com enalapril há aproximadamente 10 anos e está com a carteira de vacinação em dia. Ela comparece para consulta de rotina, assintomática, quando você detecta a presença de esplenomegalia no exame abdominal e a encaminha a um hematologista para investigação diagnóstica. Um mês depois, a hematologista lhe devolve a paciente com o diagnóstico de linfoma de células B (zona marginal) esplênico. Ela propõe como tratamento esplenectomia + 4 sessões de rituximabe, um anticorpo monoclonal anti células B, e lhe pergunta quais os cuidados necessários para a prevenção de complicações infecciosas potencialmente associadas ao mesmo. Diante dessa situação, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que contém a conduta apropriada para essa paciente.

- A Realização de teste tuberculínico e indicação de rifapentina + Isoniazida se resultado do teste maior ou igual a 5mm.
- B Vacinação contra pneumococo e meningococo e Haemophilus influenzae tipo B, no mínimo 4 semanas após a cirurgia.
- C Realização de teste tuberculínico e indicação de rifapentina + Isoniazida se resultado do teste maior ou igual a 10mm.
- D Vacinação contra pneumococo, meningococo e Haemophilus influenzae tipo B, no mínimo 2 semanas antes da cirurgia.

4000182147

Questão 47 Sarampo

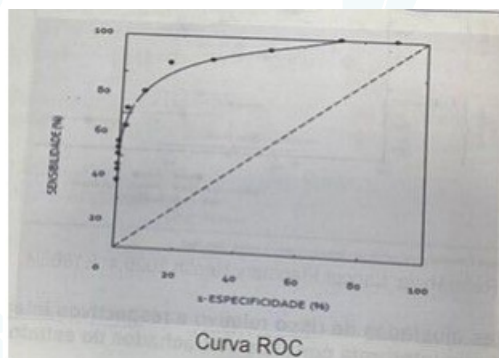
O conhecimento dos períodos de incubação e de transmissibilidade de uma doença infecciosa é essencial para o médico orientar adequadamente a conduta frente às situações em que ocorre contato entre um indivíduo infectado e outras pessoas da população. Para o sarampo, os períodos de incubação e de transmissibilidade são, respectivamente, de 7 a 18 dias até o aparecimento da febre, e de quatro dias antes a quatro dias após o surgimento do exantema. Suponha que a criança A tenha regressado recentemente de um país europeu e que no dia 1º/10/2022 apresentou sinais e sintomas de sarampo com surgimento de exantema. No dia 30/9/2022, havia tido contato com a criança B, nunca vacinada contra sarampo. Frente a essa situação, você indicaria:

- A Quarentena até 7/10 para A e isolamento até 6/10 para B.
- B Quarentena até 6/10 para A e isolamento até 15/10 para B.
- C Isolamento até 5/10 para A e quarentena até 18/10 para B.
- D Isolamento até 9/10 para A e quarentena até 14/10 para B.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182146

Questão 48 Medicina Preventiva

Com base nos valores de sensibilidade e especificidade de um teste diagnóstico, a chamada Curva ROC (Receiver Operation Characteristic) é uma representação gráfica que busca facilitar a identificação do melhor ponto de corte desse teste quando aplicado a uma doença. Na Curva ROC aqui representada, o ponto de corte mais adequado para o diagnóstico da doença seria:



- A O que mais se aproxima do quadrante superior direito.
- B O que se situa no ponto médio da linha diagonal tracejada.
- C O que mais se aproxima do quadrante inferior direito.
- D O que mais se aproxima do quadrante superior esquerdo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182145](#)

Questão 49 Medicina Preventiva

Um recurso utilizado para estimar o potencial epidêmico de uma doença transmissível é o chamado número básico de reprodução (RO), que representa o número médio de indivíduos que poderão ser infectados a partir de um caso, desde que nenhuma medida preventiva seja estabelecida e que haja 100% de susceptibilidade populacional. A partir de uma pessoa infectante e após cinco gerações de transmissão, uma doença com $RO = 2$ atingirá um número médio de casos equivalente a:

- A 48
- B 18
- C 32
- D 12

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182144](#)

Questão 50 Medicina Preventiva

Na reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) durante a discussão sobre o Programa Previne Brasil, os Secretários de Saúde foram estimulados a implantar em seus municípios Programas de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Saúde, na Atenção Primária à Saúde (APS) confirmando o compromisso da gestão pública com a formação de profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Os gestores foram informados que aqueles que implantassem os programas de residência receberiam financiamento federal para o custeio desta atividade. A implantação de Programas de Residência, de acordo com o Programa Previne Brasil, refere-se a que componente do financiamento da APS?

- A Capitação ponderada.
- B Incentivo para ação estratégica.
- C Pagamento por desempenho.
- D Pagamento por produtividade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182143](#)

Questão 51 Medicina Preventiva

O gráfico abaixo foi extraído de um estudo de coorte em que os autores avaliaram o meio principal de transporte utilizado por quase 400.0000 pessoas no Reino Unido e sua associação com a incidência de algumas doenças e também sobre a mortalidade ao longo de 25 anos de seguimento. Considerando as taxas ajustadas de risco relativo e respectivos intervalos de confiança, assinale a alternativa que interpreta corretamente achados do estudo.

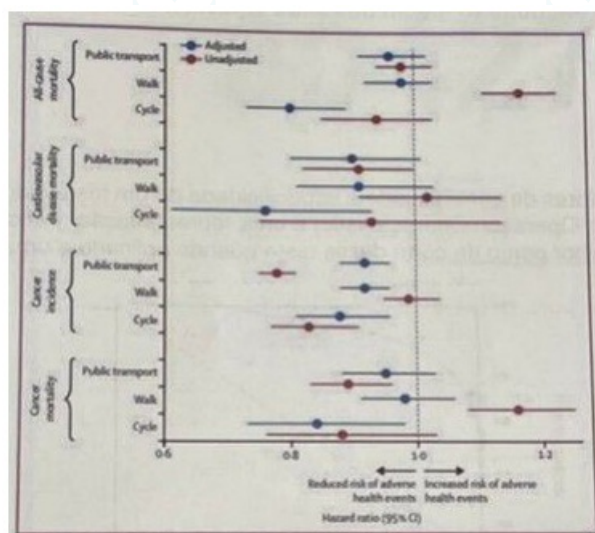


Figure 1: Mortality and cancer outcomes by commute mode, 1991-2016

Referência: Lancet Planetary Health 2020;4: E186/94.

- A Comparativamente àqueles que dirigiam carro, os que usavam a bicicleta tiveram menor mortalidade por câncer e doenças cardiovasculares.
- B Comparativamente àqueles que dirigiam carro, os que usavam transporte público tiveram menor mortalidade por doenças cardiovasculares.
- C Comparativamente àqueles que dirigiam carro, os que usavam caminhavam tiveram menor mortalidade por doenças cardiovasculares.
- D Comparativamente àqueles que dirigiam carro, os que caminhavam tiveram menor incidência de câncer e mortalidade por câncer.

4000182142

Questão 52 Lombalgia

Paciente de 34 anos de idade, sexo masculino, trabalha como pedreiro, sem doenças prévias, não faz uso de medicamentos de rotina. Chega à unidade de saúde da família com queixa de dor lombar de forte intensidade há 21 dias. A dor surgiu após esforço físico intenso em seu serviço. A dor está incomodando-o muito, impedindo de trabalhar normalmente nos últimos dias. Está fazendo uso de analgésicos comuns e anti-inflamatórios orais diariamente desde o início do quadro, com pouca melhora. A dor piora aos esforços e melhora com o repouso. A dor não irradia para os membros inferiores, nega perda de força ou formigamentos nos MMII, nega febre, dores noturnas. Sem queixas urinárias, gastrointestinais. EF: realizado exame físico completo, tendo como alteração apenas a dor lombar à mobilidade da coluna, dores à palpação da musculatura paravertebral lombar, sem déficit neurológico nos membros, sem outras alterações dignas de nota. Qual a abordagem mais adequada para diagnóstico do paciente neste momento?

- A Não há indicação de exames de imagem neste momento.
- B Solicitar radiografia simples da coluna lombar.
- C Solicitar tomografia computadorizada coluna lombar.
- D Solicitar ressonância nuclear magnética da coluna lombar.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182141

Questão 53 Infectologia Infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis ILTB

Você é o médico de uma unidade de saúde da família em uma cidade de pequeno porte que faz seguimento dos pacientes

portadores do HIV. Você atende um paciente recém diagnosticado com HIV, totalmente assintomático, sem comorbidades. Faz os exames iniciais para investigação e início do tratamento para HIV. Nos exames tem resultado do teste tuberculínico de 15 mm. Sem história de tuberculose no passado. Exames bioquímicos e hemograma normais. Contagem de CD4 370 cel/mm³, carga viral 10000 cópias/ml. Paciente não apresenta queixas respiratórias, exame físico do aparelho respiratório normal e radiografia do tórax normal. Além de iniciar tratamento para HIV, qual a conduta mais adequada?

- A Iniciar isoniazida, pirazinamida, rifampicina e etambutol.
- B Iniciar tratamento com isoniazida.
- C Manter observação clínica.
- D Repetir o teste tuberculínico após 30 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182140](#)

Questão 54 **Disfunção sexual masculina** **Urologia** **Cirurgia**

Numa consulta de paciente na unidade de atenção primária do sexo masculino, 47 anos, casado, heteroafetivo, parceira única. O paciente questiona sobre o seu desempenho nas relações sexuais. O mesmo refere que sua ereção não é a mesma de antes e que isso tem ocorrido com mais frequência nesse ano. Paciente nega queixas urinárias como dor, incontinência, jato fraco, hesitação ou sensação de esvaziamento incompleto. Nega alterações ejaculatórias como ejaculação precoce ou diminuição do volume ejaculado.

Refere que mantém desejo sexual e que relacionamento está bom, mas parceira tem notado a diferença na ereção. Refere que continua mantendo episódios de ereção reflexa. Nega sintomas de ansiedade ou de depressão, mas que está preocupado em relação a seu desempenho. Não faz uso de nenhuma medicação, não tem hábitos de tabagismo, etilismo ou de substâncias psicoativas. Refere sedentarismo. Ao Exame físico: IMC de 42 Kg/m². Ausculta cardíaca sem alterações. Pressão Arterial: 128 x 74 mmHg. Sem sinais clínicos de obstrução arterial periférica. Genitais sem lesões, deformidades, testículos normotróficos. Exames: Glicemia: 95 mg/dl Valor de referência 70-100 mg/dl Colesterol total: 270 mg/dl Valor de referência 140-200 mg/dl HDL Colesterol: 58 mg/dl Valor de referência > 45 mg/dl Triglicérides: 290 mg/dl Valor de referência < 150 mg/dl Testosterona total: 429 ng/dl Valor de referência 250-900 ng/dl Além de recomendar atividade física de maneira regular, orientação sobre resposta sexual e controle do peso, qual seria a melhor terapêutica medicamentosa para o paciente?

- A Clomipramina.
- B Finasterida.
- C Alprostadil.
- D Sildenafil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182139](#)

Questão 55 **Tratamento da Hipertensão arterial**

Paciente com 44 anos do sexo feminino de raça negra vem em retorno para avaliação de exames e acompanhamento de pressão arterial alterada, não fuma, faz uso de álcool aos finais de semana. Na consulta verificado pressão arterial de 142 x 92 mmHg, além de IMC de 38, Resultados de exames: Glicemia de jejum: 109 mg/dl, colesterol total: 207 mg/dl, HDL colesterol: 58 mg/dl, triglicérides: 190 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sódio: 142 mEq/l, potássio: 4,9 mEq/l, ácido úrico: 5,1 mg/dl, urina tipo 1: sem alterações. Valores de referência: Glicemia 70 - 100 mg/dl Colesterol total: < 200 mg/dl HDL Colesterol: 40-60 mg/dl Triglicérides: < 150 mg/dl Creatinina: 1,3 mg/dl Sódio: 135 - 145 mEq/l Potássio: 3,5 - 5,5 mEq/l

Ácido Úrico: 4,0 - 7,0 mg/dl Qual tratamento é o mais indicado?

- A Beta bloqueador.
- B Vasodilatador direto.
- C Bloqueador de canal de cálcio.
- D Antagonista alfa 1 adrenérgico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182138](#)

Questão 56 Infectologia Diagnóstico Quadro clínico

Homem, 35 anos, trabalha como pedreiro e comparece à unidade de saúde para uma consulta, acompanhado de sua esposa, pois acha estranho o marido estar com tosse há 1 mês. Paciente relata que no início a tosse era seca e que atualmente está com catarro. Acha que perdeu peso porque suas roupas estão mais largas e que, frequentemente, tem tido febre quando chega do trabalho à tarde. A esposa declara que o marido geralmente apresenta febre de 38.5°C e que durante à noite transpira bastante. Não é hipertenso e nem diabético. Nega problemas pulmonares na infância. É tabagista de paieiro há 15 anos. À ausculta pulmonar observa-se murmúrio vesicular reduzido. Qual seria o melhor exame para confirmar o diagnóstico?

- A Hemograma completo.
- B Hemocultura.
- C Baciloscopia de escarro.
- D Espirometria.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182137](#)

Questão 57 Diagnóstico da Depressão Depressão

Mulher de 75 anos vem à consulta de saúde acompanhada da filha que refere que sua mãe está apresentando muitos esquecimentos, há aproximadamente 6 meses. Paciente é hipertensa, diabética e faz uso de losartana 50 mg 1 comprimido ao dia e glifage XR 500 mg 2 comprimidos ao dia. Paciente estudou até a 8ª série do ensino médio. Ao exame clínico: PA: 120 x 80 mmHg, FC: 71 bpm, FR: 16 ipm Peso: 60 Kg, Alt: 1.65 m, IMC: 22, saturação de O₂: 98% dextro: 110 mg/dl. Exames laboratoriais: vitamina B12: 400 (VR: 210-980 pg/ml), TSH: 2.80 (VR: 0.3-4.8), MEEM: 28 pontos. GDS (Escala de Depressão Geriátrica) 8. De acordo com o quadro descrito acima, qual o diagnóstico mais provável?

- A Hipotireoidismo.
- B Síndrome demencial.
- C Transtorno depressivo.
- D Hipovitaminose de B12.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182136](#)

Questão 58 Calendário infantil

Criança de 5 meses e 17 dias vem para consulta de puericultura com seu médico de família e mãe apresenta o cartão vacinal abaixo. Segundo o Calendário Nacional de vacinação apresentado, qual vacina está em atraso?

Plano Vacinal									
Vacinas		Vacinas		Vacinas		Vacinas		Vacinas	
Nome	Indicação	Nome	Indicação	Nome	Indicação	Nome	Indicação	Nome	Indicação
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose
BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose	BCG	Proteção à tuberculose

- A Febre Amarela.
- B Pentavalente.
- C VIP.
- D Meningocócica C.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182135](https://www.4000182135.com.br)

Medicina Livre

na medicina.

Questão 59 Exame dermatoneurológico Diagnóstico Dermatologia

J.E.C. 50 anos, sexo masculino, refere que há 2 anos apresenta câimbras e dormência em perna esquerda. Nega história de traumatismo, cirurgias ou lesões na pele. Nega lombalgia. Nega doenças crônicas e uso de medicamentos. Ao exame: IMC 28 Kg/m², PA 134 x 78 mmHg. FC 68 bpm. Pele sem lesões visíveis. AR: MV + sem RA. ACV: RCR 2BNF, sem sopros. Abdome indolor, sem massas ou VMG. MMII: sem edema, com nervo fibular comum à esquerda palpável e o seguinte exame de sensibilidade com estesiômetro. Qual a suspeita diagnóstica mais provável?



- A Hanseníase com comprometimento neural.
- B Diabetes com neuropatia diabética.
- C Hérnia de disco com compressão de raiz nervosa.
- D Distúrbio hidroeletrólítico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182134](https://www.4000182134.com.br)

Questão 60 Clínica Médica

L.C.P. 39 anos, vendedora, sexualmente ativa, procura seu Médico de Família e Comunidade sem queixas, desejando realizar exames, pois "faz tempo que não realiza". Como antecedente pessoal, informa ser G1P1A0C0 com parto há 5 anos. Refere cirurgia para implante de prótese mamária por motivo estético há 15 anos. Nega doenças. Refere uso de DIU de

cobre há 5 anos. Nega história familiar de doenças. Ao exame físico apresenta IMC 24 kg/m², pele sem lesões, mucosas normocoradas. Além da realização de exame citopatológico do colo do útero e aferição de pressão arterial, qual a ação também está indicada para rastreamento assintomático com evidência científica grau de recomendação A?

- A Lipidograma
- B Glicemia de jejum
- C Mamografia
- D Rastreamento de tabagismo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182133](#)

Questão 61 Anticoncepção em condições especiais

Homem trans, 32 anos, hipertenso, comparece para consulta de rotina em UBS. Refere-se relacionar sexualmente com homem cisgênero, e atualmente está em uso regular de contraceptivo oral combinado (COC) contendo levonorgestrel (0,15 mg) + etinilestradiol (0,03 mg) para controle de sangramento vaginal volumoso. Refere ter iniciado o uso de testosterona em outro serviço há 2 meses. Exame físico: sem lesões ou achados anormais ao exame da genitália. Qual a melhor conduta clínica neste momento?

- A Trocar para anel ou adesivo contraceptivo e suspender a testosterona.
- B Prescrever análogo de GnRH e suspender temporariamente a testosterona.
- C Substituir o COC por progestágeno isolado e manter a testosterona.
- D Suspender o COC e manter apenas a testosterona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182132](#)

Questão 62 Interpretação e conduta frente as atipias citológicas

Mulher, 33 anos, G2PC2, último parto há 3 anos, realizou última coleta de colpocitologia durante o último pré-natal, sem anormalidades citológicas de acordo com a informação da paciente. Refere ciclos menstruais regulares em uso de contraceptivo hormonal injetável mensal. Comparece para checar o resultado da colócitologia que evidencia amostra satisfatória com epitélio metaplásico e cilíndrico e anormalidades em células glandulares sem outras especificações. Qual a conduta mais adequada para esta paciente?

- A Realizar coscopia.
- B Realizar ultrassom transvaginal.
- C Solicitar biologia molecular.
- D Repetir colpocitologia

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182131](#)

Questão 63 Tratamento Ginecologia

Nuligesta, 24 anos, há um ano tenta engravidar sem sucesso. Apresenta ciclos menstruais de 27 a 29 dias, com fluxo normal. Tem atividade sexual regular, com relação pênisvagina quatro vezes na semana. Marido, 28 anos, tem três filhos de outro relacionamento e nega comorbidades. Exames complementares: FSH 5,4 mUI/mL (2,8 a 14,4 mUI/mL), TSH μ UI/mL (0,3 a 4,0 μ UI/mL). Ultrassonografia transvaginal com útero e ovários normais e contagem de folículos antrais de 9 em cada ovário, imagem hipocogênica alongada em topografia de anexo esquerdo. Histerossalpingografia com cavidade uterina normal,

trompa direita filiforme e trompa esquerda dilatada, sem passagem de contraste bilateralmente. Espermograma com volume de 2mL, 16 milhões de espermatozoides/mL, 50% vivos, 30% de motilidade progressiva e 5% normais (critério de Kruger).

Qual é o melhor tratamento para esse casal?

- A Ciclo de fertilização *in vitro*.
- B Coito programado após indução da ovulação.
- C Ciclo de fertilização *in vitro* após salpingectomia.
- D Inseminação intrauterina após indução da ovulação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182130](https://www.4000182130.com)

Questão 64 **Ginecologia** **Diagnóstico** **Classificação**

Mulher, 53 anos, com antecedente de 5 partos vaginais prévios e menopausa há 2 anos. Procura o serviço médico com sensação de peso no períneo e de uma bola que sai pela vagina. O exame ginecológico identificou um prolapso descrito segundo o instrumento POPQ (Pelvic Organ Prolapse Quantification) conforme mostrado na figura a seguir. Quais os diagnósticos podem ser feitos de acordo com as anotações presentes no POP-Q?

-3 Aa	-3 Ba	-6 C
4.5 gh	1 pb	8 tvI
+2 Ap	+5 Bp	— D

- A Prolapso de parede posterior, rotura perineal, histerectomia prévia.
- B Prolapso de parede anterior, prolapso de cúpula vaginal, histerectomia prévia.
- C Prolapso de parede posterior, prolapso uterino grau III, rotura perineal.
- D Prolapso de parede anterior, prolapso uterino grau II, prolapso de parede posterior.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182129](https://www.4000182129.com)

Questão 65 **Obstetrícia** **Gestação ectópica**

Mulher, 28 anos, procura atendimento ginecológico com queixa de dor pélvica à direita há 2 dias de fraca intensidade, mas que impede de desenvolver suas atividades laborais. Ao exame físico: PA: 120 x 70 mmHg, FC:84 bpm, abdome plano, normotenso com discreta dor em fossa ilíaca direita à palpação profunda, descompressão brusca negativa. Exames complementares solicitados: Hb: 12,3 g/dl; Ht:33%, B HCG: 1720,0 mUI/ml, progesterona: 5,2 ng/ml (VR: 11 a 90 ng/ml). Ultrassonografia pélvica: útero AVF, centrado, vol: 110 cm³, ovário esquerdo: 5 cm³, ovário direito: 6,5 cm³, em região anexial direita presença de lesão ovalada, amorga com 2,2 x 1,9 x 1,7 cm com vascularização aumentada ao redor da lesão, sem líquido livre na cavidade abdominal. Considerando se a possibilidade diagnóstica mais provável, qual a conduta mais apropriada neste momento após internação da paciente?

- A Laparotomia exploradora.
- B Cetoprofeno 100 mg EV.
- C Observação clínica.
- D Metotrexate IM 50 mg/m²

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182128](#)

Questão 66 Endocrinologia

Nuligesta, 21 anos, procura atendimento ginecológico referindo que não menstrua há seis meses. Histórico de ciclos menstruais regulares com intervalos de 28 a 30 dias. Refere cefaleia frequente, que melhora com analgésicos. Em uso de amitriptilina há um ano para tratamento de depressão. Nega alterações ponderais. Faz atividade física regularmente. Sem atividade sexual há dois anos. Exame físico: PA = 90X60 mmHg; IMC = 17 Kg/m². Mamas M5, sem nódulos e expressão negativa. Exame ginecológico: sem alterações. Exames complementares: prolactina = 112 ng/ml (VN < 25 ng/ml); FSH = 4,0 mIU/ml (VN - 2,5 a 10,2 mIU/ml); TSH = 2,1 mIU/ml (VN = 0,4 a 4,0 mIU/ml). Qual a conduta mais adequada para o caso neste momento

- A Solicitar ressonância magnética de crânio e sela túrcica.
- B Dosagem de prolactina 1 semana após troca do antidepressivo.
- C Iniciar cabergolina 0,5 mg 2 vezes por semana.
- D Iniciar terapia hormonal com estrogênio e progesterona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182127](#)

Questão 67 Tratamento

Mulher, 62 anos tratada de câncer de mama há 4 anos, em uso de tamoxifeno 20 mg via oral ao dia. Apresenta sangramento vaginal de pequeno volume há 2 meses. A ultrassonografia transvaginal identificou eco endometrial irregular com 9 mm de espessura, sem outras alterações. A histeroscopia diagnóstica e a biópsia dirigida foram compatíveis com hiperplasia endometrial atípica. Qual a melhor conduta?

- A Repetir a ultrassonografia em 3 meses.
- B Suspender o tamoxifeno e introduzir inibidor da aromatas
- C Histerectomia e salpingooforectomia bilateral.
- D Progesterona via oral por 6 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182126](#)

Questão 68 Dor mamária mastalgia

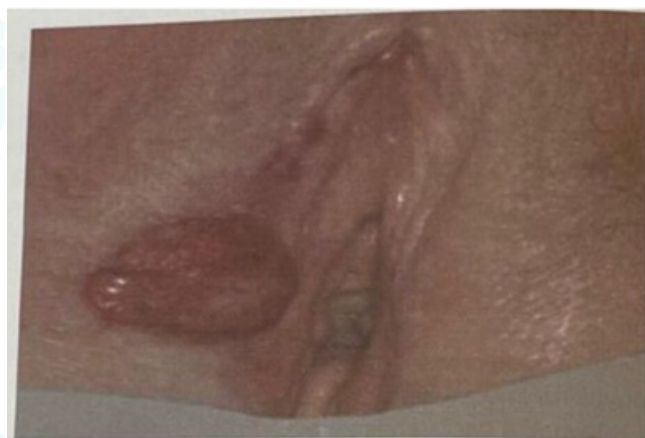
Mulher, 27 anos, G1P1, usuária de DIU de cobre, menstruando regularmente. Queixa-se de dor intensa em quadrante supero lateral da mama direita, há 3 meses, com piora importante pré-menstrual e melhora parcial após. Está preocupada com histórico de câncer na família, pois tia avó materna teve câncer de mama aos 68 anos. Exame físico: mamas sem nódulos ou lesões. Cadeias linfonodais sem alterações. Dor à Ultrassonografia de mamas realizadas há 10 dias: cistos mamários bilaterais, maior diâmetro 0,5 cm, BI RADS:2. Qual a melhor conduta?

- A Retorno com ultrassonografia de mamas em 6 meses.
- B Solicitar ressonância magnética das mamas.
- C Tranquilizar e prescrever anti-inflamatório tópico.
- D Teste terapêutico com tamoxifeno 20 mg/dia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182125](https://www.4000182125.com)

Questão 69 Câncer de vulva

Mulher de 68 anos, queixa-se de prurido vulvar há cerca de 8 meses. A inspeção genital está representada na imagem. Diante do quadro clínico e do exame físico, qual a melhor conduta?



- A Exérese completa com margem de 3 mm.
- B Biópsia incisional da borda da lesão.
- C Corticosteroide de alta potência.
- D Antibioticoterapia com penicilina benzatina.

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182124](https://www.4000182124.com)

Questão 70 Sangramento uterino anormal

Mulher, 30 anos, G2P2, com queixa de sangramento uterino anormal há 5 anos. Não apresenta comorbidades e nem faz uso de medicações. Marido fez vasectomia. No prontuário está descrito como sangramento de causa endometrial. Qual alternativa contém a descrição do ciclo e do achado da ultrassonografia transvaginal (USTV) mais prováveis para este caso?

- A Ciclo irregular com aumento de volume e USTV com espessamento endometrial difuso.
- B Ciclo regular com sangramento prolongado e USTV com perda junção miométrio endométrio.
- C Ciclo regular com aumento de volume e USTV sem alterações.
- D Ciclo irregular com sangramento prolongado e USTV sem alterações.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182123](https://www.4000182123.com)

Questão 71 Diabetes na gestação DMG Obstetrícia

Primigesta, 24 anos, com 29 semanas de idade gestacional, sem comorbidades prévias à gestação. Retorna à consulta de

pré-natal sem queixas. Recebeu diagnóstico de Diabetes Mellitus gestacional há 10 dias, com adequada adesão ao plano nutricional, programa de atividade física e automonitorização glicêmica, porém mantendo-se acima das metas glicêmicas em aproximadamente 50% dos valores aferidos. Exame físico geral e obstétrico dentro dos padrões de normalidade. Ganho de peso de 300 gramas em uma semana. Foi indicada insulinoterapia, porém paciente é moradora de área rural com dificuldade de acesso, transporte e armazenamento adequados da insulina. Considerando as recomendações brasileiras de 2019 (Organização Pan Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes), qual a alternativa terapêutica farmacológica mais adequada para essa paciente?

- A Gillbenclamida.
- B Acarbose.
- C Liraglutida.
- D Metformina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182122](https://www.4000182122.com.br)

Questão 72 **HIV na gestação** **Infectologia**

Gestação, 25 anos, G2P1, idade gestacional de 39 semanas + dias, portadora do vírus da imunodeficiência humana e uso regular de tenofovir+lamivudina+dolutegravir. A carga viral com 35 semanas e 3 dias era: 165 cópias/mL e T CD4: 648 células/mL. Demais exames sem alterações. Feto cefálico com vitalidade preservada. Qual alternativa contempla a condução mais adequada neste caso, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil?

- A Cesárea sem zidovudina endovenosa.
- B Parto vaginal e zidovudina endovenosa.
- C Parto vaginal sem zidovudina endovenosa.
- D Cesárea e zidovudina endovenosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182122](https://www.4000182122.com.br)

Questão 73 **Corioamnionite** **Rotura prematura de membranas ovulares RPM** **Obstetrícia**

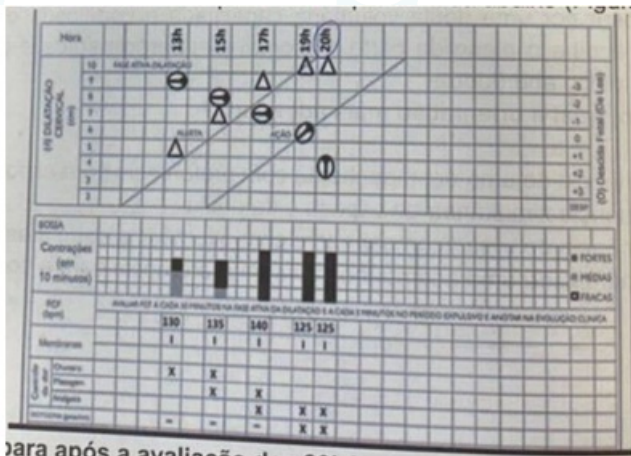
Secundigesta (G2P1N), 33 semanas de gestação, está internada com diagnóstico de corioamniorrexe prematura em conduta expectante há uma semana. Na ocasião do diagnóstico recebeu betametasona e 48 horas de penicilina cristalina. Na avaliação realizada hoje, se queixou de dor abdominal. Exame físico: BEG, temperatura de 38,0°C, demais sinais vitais e exame físico geral normais. Atividade uterina ausente, feto apresentação cefálica. Vitalidade geral preservada. Toque: colo posterior, médio, 1 polpa, feto cefálico. Exames laboratoriais: Hemograma: glóbulos brancos = 13.500/mm³, 17% de bastões, plaquetas 180.000/mm³. Swab vaginal/endoanal para *Streptococcus* do grupo B positivo. Quais as melhores condutas nesse momento?

- A Clindamicina, betametasona por 24 horas e resolução da gestação por cesárea
- B Clindamicina, penicilina cristalina e indução do trabalho de parto.
- C Amoxicilina, azitromicina, penicilina cristalina e indução do trabalho de parto na 34ª semana.
- D Clindamicina, gentamicina e resolução da gestação por cesárea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182122](https://www.4000182122.com.br)

Questão 74 **Obstetria** **Partograma**

Primigesta, 32 anos, 41 semanas de gestação de risco habitual. Interna na fase ativa da dilatação para assistência ao parto. Na admissão apresentava sinais vitais e exame físico geral normal, altura uterina=38 cm, vitalidade fetal normal. A evolução gráfica de seu trabalho de parto está representada abaixo (Figura). Qual é a conduta para após a avaliação das 20h?



para após a avaliação das 20h:

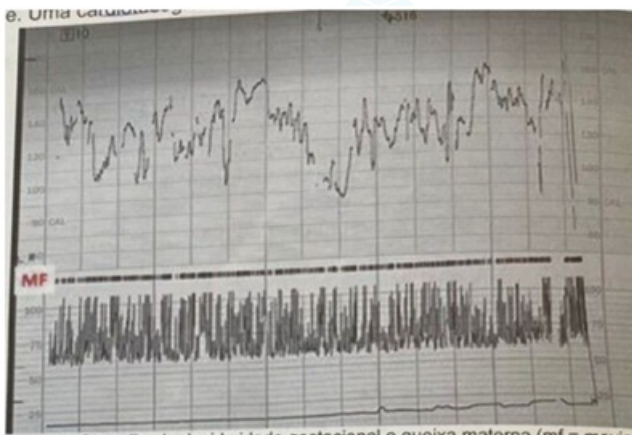
- A Aguardar mais uma hora de período expulsivo.
- B Realizar parto instrumentalizado.
- C Realizar amniotomia artificial.
- D Estimular a paciente a realizar puxos dirigidos.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4 000182119](https://www.4000182119.com)

Questão 75 **Avaliação da vitalidade fetal** **Obstetria**

Secundígesta, 29 anos, com 40 semanas de gestão, comparece a maternidade devido a redução da movimentação fetal nas últimas horas. Sem outras queixas. Nega doenças e não houve intercorrências em seu pré-natal. Exame físico geral normal. Ausência de atividade uterina, altura uterina=35 cm e frequência cardíaca feral normal, com percepção de movimento fetal ao exame. Uma cardiografia foi realizada (figura). Qual alternativa apresenta a melhor conduta? Figura: Cardiotocografia realizada devido idade gestacional e queixa materna (mf=movimentos fetais)



- A Realizar parto cesárea imediatamente.
- B Conduta expectante com alta hospitalar.
- C Internar para indução do trabalho de parto.
- D Realizar perfil biofísico fetal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182118](#)

Questão 76 Obstetrícia Assistência ao parto normal

Primigesta, 20 anos, durante o acompanhamento de pré-natal de risco habitual, elabora e registra institucionalmente o seu plano de parto, pelo qual manigesta expressa vontade, dentre outros aspectos, de ser acompanhada durante seu trabalho de parto e parto tanto por sua esposa, como também por uma doula voluntária capacitada e certificada de sua escolha. A equipe assistencial acolhe o plano de parto e promove esclarecimentos e orientações sobre viabilidade de cada tópico abordado. Em relação ao caso, qual a orientação mais adequada?

- A Permitir a permanência de uma acompanhante com preferência para esposa.
- B Permitir a permanência simultânea da esposa e da doula.
- C Permitir a permanência de uma acompanhante com alternância entre a esposa e a doula.
- D Permitir a permanência de uma acompanhante com preferência para a doula.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182117](#)

Questão 77 Obstetrícia

Secundisgesta com 1 parto normal anterior a termo, 26 anos, 15 semanas de gestação, com comorbidades prévias. Comparece à consulta para iniciar pré-natal, sem queixas clínicas ou obstétricas. Exame física: bom estado geral, PA: 105 x 72 mmHg Peso: 92 kg estatura: 160 cm. Altura uterina: 18 cm ausculta de batimentos cardíacos fetais 142 bpm. Além da suplementação de ferro, qual a conduta mais adequado para essa paciente?

- A iniciar ácido acetilsalicílico e enoxaparina.
- B Iniciar ácido acetilsalicílico e cálcio.
- C Iniciar ácido acetilsalicílico.
- D Não indicar profilaxia medicamentosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182116](#)

Questão 78 Anticoagulantes antagonistas da vitamina K Trombose na gestação Heparinas

Primigesta, 34 anos, com 16 semanas de gestação, comparece ao ambulatório de gestação de alto risco para iniciar seguimento de pré-natal. Sem queixas clínicas e obstétricas. Antecedentes pessoais: cardiopatia reumática com válvula metálica, classe funcional I, em uso de warfarin 5 mg uma vez ao dia. O resultado do RNI (Razão Normalizada Internacional) colhido há 1 semana apresenta valor de 1,8 vezes o controle. Qual é a melhor conduta com relação à anticoagulação dessa paciente?

- A Aumentar a dose de warfarin para 7,5 mg uma vez ao dia.
- B Suspender warfarin e iniciar dose terapêutica de enoxaparina.
- C Manter a dose de warfarin 5 mg uma vez ao dia.
- D Suspender warfarin e iniciar AAS 100 mg uma vez ao dia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182115](#)

Questão 79 **Técnicas de Anestesia do Neuroeixo** **Distúrbios hipertensivos na gestação DHEG** **Cirurgia**

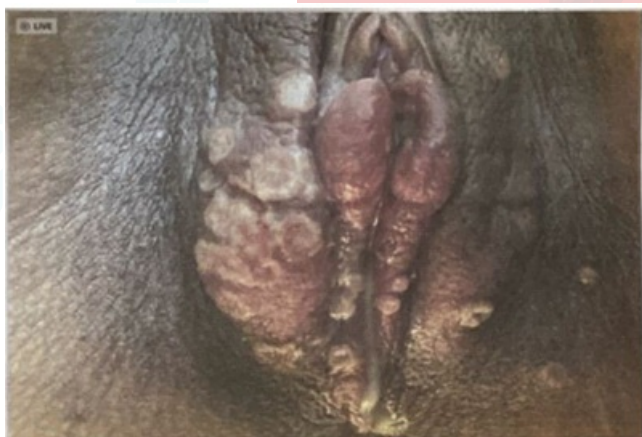
Secundisgesta com 1 parto cesárea anterior, 24 anos, 31 semanas de gestação, é trazida ao centro obstétrico pela família devido quadro de crise convulsiva há 30 minutos. Ao exame: regular estado geral, pressão arterial: 160 x 120 mmHg, frequência respiratória: 24 irpm. Abdome: altura uterina: 32 cm, atividade uterina ausente, ausculta fetal de 150 bpm, sem desacelerações. Toque vaginal: colo posterior, longo, amolecido, impérvio. Equipe inicia administração de sulfato de magnésio e decide pela interrupção da gestação por cesárea. Considerando a maior segurança materna, qual(is) exame(s) é(são) mandatário(s) para orientar o procedimento anestésico cirúrgico?

- A Ureia e creatina.
- B Fibrinogênio.
- C Hemograma.
- D TP e TTPA

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182114](#)

Questão 80 **Ginecologia** **Úlceras infecciosas de causa sexualmente transmissível**

Primigesta, 21 anos, 26 semanas de gestação, procura o pronto atendimento referindo lesões genitais muito dolorosas. Informa que as lesões apareceram há três dias, mas não observou vesículas previamente ao aparecimento de lesões. Nega episódios semelhantes no passado. Nega queixas em relação à gravidez. Ao exame, observa-se a imagem a seguir:



Inspeção vulvar: lesões genitais

Além do alívio da dor e orientações de higiene, que tratamento deve ser prescrito para essa gestante?

- A Aciclovir 400 mg 8/8 horas via oral.
- B Ceftriaxone 500 mg IM dose única.
- C Azitromicina 1 grama via oral dose única.
- D Penicilina benzatina 2400.000 UI por duas semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182113](#)

Questão 81 **Síndrome Narcótica** **Intoxicações Exógenas**

Um pré-escolar de 4 anos e 12 kg foi submetido a cirurgia abdominal de baixa complexidade com anestesia geral, sem intercorrências. Ao final do procedimento, recebeu uma dose adicional endovenosa de fentanil e cetoprofeno para analgesia. Veio direto para enfermaria pediátrica, 1 hora após o final da cirurgia. Após 30 minutos, você é chamado para avaliar a criança, pois a mãe diz que ela não acorda. Ao exame físico: corada, hidratada, acianótica, anictérica e afebril. Frequência cardíaca 110 bpm, frequência respiratória 10 irpm, pressão arterial 95 x 55 mmHg, saturação periférica de oxigênio 90% em ar ambiente. Ausculta respiratória mostra murmúrio vesicular simétrico, sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaca revela ritmo regular, duas bulhas normofonéticas, sem sopros, pulsos centrais e periféricos fortes, tempo de enchimento capilar 2 segundos. Abdome sem anormalidades. Pupilas mióticas e isocóricas. Com base no quadro clínico acima, qual o tratamento farmacológico imediato mais adequado para esta situação clínica?

- A Haloperidol.
- B Flumazenil.
- C Glicose.
- D Naloxona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182112](#)

Questão 82 **Tratamento**

Recém-nascido de parto normal, a termo, após uma gestação sem intercorrências. Mãe de 25 anos, G2, saudável, com acompanhamento pré-natal adequado. As sorologias maternas foram negativas com 10 semanas de gestação e no momento do parto (HIV, VDRL, toxoplasmose IgG/IgM, hepatites B e C). Ao nascimento, foi observado que o recém-nascido apresentava peso no percentil 4 para a idade gestacional, petéquias em face e tronco, hepatoesplenomegalia e microcefalia. Exames realizados: Hemograma com Hb/Ht normais, série branca normal, plaquetas 87.000/ μ L; TGO 92 U/L (VR até 32 U/L); TGP normal; fundoscopia ocular: sem alterações; ultrassom transfontanelar: presença de calcificações periventriculares; triagem auditiva: ausência de respostas bilateralmente; análise de líquido cefalorraquidiano normal Qual é o tratamento indicado para a causa mais provável deste quadro?

- A Aciclovir.
- B Penicilina cristalina.
- C Ganciclovir.
- D Sulfadiazina e pirimetamina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182111](#)

Questão 83 **Amamentação na primeira hora de vida** **Contato pele a pele** **RNs maiores de 34 semanas**

Recém-nascido atendido em sala de parto de uma maternidade. Nasceu de parto normal com 40 semanas de idade

gestacional, após uma gestação sem intercorrências; bolsa rota há 2 horas, com líquido amniótico meconiado. Imediatamente após o nascimento, o recém-nascido apresentava choro forte, tônus muscular em flexão e cianose generalizada. Foi secado rapidamente, colocado em contato pele a pele com a mãe e o coberto com tecido seco e aquecido. Qual é a conduta imediata mais adequada na assistência a este recém-nascido?

- A Oferecer oxigênio inalatório suplementar.
- B Avaliar a frequência cardíaca, o tônus e a respiração.
- C Levar ao berço de reanimação, sob fonte de calor radiante.
- D Posicionar o pescoço em hiperextensão

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182110](#)

Questão 84 Diagnóstico do Autismo Transtorno do Espectro Autista TEA

Uma criança de quatro anos com deficiência intelectual e diagnóstico de síndrome de Down é avaliada por atraso de falo. Apresenta déficit de comunicação, socialização, estereotípias motoras e hipersensibilidade aos estímulos auditivos e táteis. Qual a provável comorbidade dessa criança?

- A Transtorno do movimento estereotipado.
- B Apraxia de fala na infância.
- C Transtorno do espectro autista.
- D Déficit de atenção e hiperatividade

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182109](#)

Questão 85 Atresia de vias biliares Tratamento Atresia da Via Biliar

Paciente com 6 meses, apresenta história de icterícia, colúria e acolia desde um mês de idade. Apresenta bom desenvolvimento pondero estatural, sendo alimentada por aleijamento materno e papas. Exame físico: icterico ++/4, fígado a 3 cm do rebordo costal direito, firme; baço a 2 cm do rebordo costal esquerdo. Exames laboratoriais: bilirrubinas totais = 7,3 mg/dL; bilirrubina direta = 5,1 mg/dl; TGO = 245 U/L (Valor de referência [VR] <31); TGP = 295 U/L (VR < 31); GamaGT = 400 U/L (VR < 50); INR = 1,5 (VR < 1,3); albumina = 3,0 g/dl (VR: 3,5-5). Ultrassom abdominal: fígado com bordas rombas, contornos lobulados, aumento difuso da ecogenicidade; presença de massa fibrosa de forma triangular situada na porção cranial da bifurcação da meia porta; esplenomegalia. Biópsia hepática percutânea: fibrose moderada, com septos e nódulos; proliferação de ductos biliares e frequentes lagos biliares. Com base no seu principal diagnóstico etiológico, qual a melhor opção para esta criança?

- A Colangiografia intraoperatória.
- B Colangiografia endoscópica retrógrada.
- C Transplante hepático.
- D Cirurgia de Kasai.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182108](#)

Questão 86 Glomerulonefrite pósestreptocócica Nefrologia

Menino com 8 anos e história de feridas na perna há 15 dias. Há 5 dias evoluiu com edema palpebral e urina escurecida. Exame físico: edema palpebral e de membros inferiores, frequência respiratória 20 ipm, murmúrio vesicular presente,

simétrico, com alguns estertores nas bases, estase jugular discreta; frequência cardíaca 80 bpm, PA 120 x 80 mmHg, fígado palpável a 2,5 cm do rebordo costal direito. Exames laboratoriais: urina tipo 1: proteína ++/4+, leucócitos 60 a 80 por campo; hemácias incontáveis; ureia 71 mg/dL; creatinina 0,7 mg/dL. Qual o tratamento medicamentoso inicial mais indicado para o caso?

- A Prednisona.
- B Enalapril.
- C Amoxicilina + clavulanato.
- D Furosemida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182107](#)

Questão 87 **Calendário infantil**

Criança de 15 meses é filha de mãe com infecção pelo HIV que realizou tratamento prénatal irregular. A criança apresentou exames de carga viral do HIV indetectáveis ao nascimento, com 15 dias, com 6 semanas e com 12 semanas de vida. Comparece com a mãe na sala de vacina regularmente e hoje se apresenta para receber a imunização de rotina de 15 meses. Legenda: SCR: sarampo, caxumba e rubéola. VOP: vacina oral contra poliomielite. DPT: difteria, tétano e coqueluche. VIP: vacina inativada contra poliomielite. Entre as vacinas que poderão ser administradas estão:

- A DPT, VIP, febre amarela, SCR.
- B DPT, VOP, varicela, hepatite A.
- C SCR, DPT, VOP, hepatite A.
- D SCR, varicela, DPT, VIP.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182106](#)

Questão 88 **Tratamento Geral** **Pediatria**

Paciente de 4 anos, levado ao pronto atendimento com história de coriza há 5 dias, evoluiu com tosse produtiva e febre há 2 dias, hiporexia leve. Mãe nega doentes em casa, criança frequenta escolinha, apresente vacinação em dia. Peso 16,8 kg, previamente hígido. Ao exame: estado geral bom, corado, hidratado, acianótico, anictérico; frequência respiratória 36 ipm, sem retrações. com boa expansibilidade torácica. Ausculta pulmonar: murmúrios presentes bilateralmente, presença de estertores crepitantes localizados em terço médio à direita. Qual a conduta mais adequada para o caso?

- A Iniciar amoxicilina oral e retorno em 48 horas.
- B Iniciar ceftriaxone endovenoso e internar.
- C Prescrever penicilina benzatina e retorno em 48 horas.
- D Prescrever azitromicina e liberar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182105](#)

Questão 89 **Objetos não Traumáticos no Esôfago** **Ingestão de Corpo Estranho**

Pré escolar com 4 anos é trazido ao pronto socorro com relato de ter ingerido objeto enquanto brincava no quintal de sua casa. Mãe refere que no momento da ingestão criança relatou dor na boca, chorou muito e apresentou cianose em lábios que se resolveu espontaneamente. No momento apresenta sialorreia discreta, sem qualquer outra manifestação. Você indica realização de radiografia a seguir.



- A Observação clínica e radiografia controle em 24 horas.
- B Remoção endoscópica de urgência.
- C Induzir vômito para eliminação do corpo estranho
- D Remoção de urgência por broncoscopia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182104](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 90 Crise de sequestro esplênico

Criança de 2 anos, com anemia falciforme, é levada pelos pais ao pronto socorro com queixa de dor abdominal importante e em membros. Mãe refere que criança iniciou com tosse, coriza e febre há 2 dias e refere que hemoglobina basal da criança geralmente fica em torno de 8 g/dL. Ao exame: prostrada, palidez importante, febril, icterica. Frequência cardíaca 180 bpm, frequência respiratória 30 ipm, saturação de oxigênio 96%, PA 80 x 50 mmHg. Fígado a 2 cm do rebordo costal direito a baço a 8 cm do rebordo costal esquerdo. Exames laboratoriais: Hb 2,9 g/dL; Ht 11% VCM 78; HCM 21,8; plaquetas 68 mil/ul; GB 14 mil/ul (3% bastonetes); contagem de reticulócitos: 17,43% (VR: 0,5 - 2,1%); bilirrubinas: total 2 mg/dL; direta 0,4 mg/dL; LDH: 1827 U/L (VR: 85 - 227 U/L). Diante deste cenário, qual é a hipótese diagnóstica?

- A Anemia aplástica.
- B Crise vaso oclusiva.
- C Sequestro esplênico.
- D Síndrome torácica aguda.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182103](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 91 Pediatria Avaliando o desenvolvimento

Durante uma consulta de rotina de puericultura, a mãe de uma criança de 8 meses relata que está preocupada porque o seu filho ainda não consegue sentar sem apoio. A criança nasceu a termo e não há outras queixas; teste do pezinho: sem alterações. Você observa, durante a consulta, que a criança necessita de auxílio para passar da posição supina para a sentada, mas uma vez nessa posição permanece estável, sem cair. Restante do exame físico sem alterações. Qual a melhor conduta?

- A Manter retorno regular de puericultura.
- B Solicitar dosagem sérica de TSH e T4 livre.
- C Solicitar eletroneuromiografia e dosagem sérica de CPK.
- D Solicitar tomografia computadorizada de crânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182102](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 92 **Ânion Gap** **Acidose metabólica com ânion gap aumentado****Manifestações clínicas da acidose metabólica**

Pré-escolar de 4 anos com história de trauma contuso em membro inferior esquerdo há 5 dias, evoluiu com febre, associada a edema, hiperemia, dor e calor no membro há 2 dias. Há 12 horas, encontra-se apático e alternando irritabilidade com sonolência. Chega à sala de emergência com frequência cardíaca 160 bpm, frequência respiratória 30 ipm, pressão arterial 70//20 mmHg, saturação de oxigênio 95%, tempo de enchimento capilar menor que 1 segundo, com extremidades quentes e avermelhadas e pulsos bem amplos. Os exames laboratoriais mostram: pH 7,30, PO_2 100mmHg, PCO_2 30 mmHg, bicarbonato 15 mEq/L, base excess 10, sódio 140 mEq/L, potássio 4,0 mEq/L, cloro 103 mEq/L. Qual é o diagnóstico do distúrbio acidobásico?

- ☐ A Acidose metabólica de ânion gap aumentado e alcalose respiratória.
- ☐ B Acidose metabólica de ânion gap normal.
- ☐ C Acidose metabólica de ânion gap normal e alcalose respiratória.
- ☐ D Acidose metabólica de ânion gap aumentado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182101](#)

Questão 93 **Conceito** **Laboratório da hemostasia**

Menino de 3 anos é trazido à consulta pediátrica com história de hematoma em perna direita desproporcional após trauma na região. Mãe refere equimoses e epistaxes ocasionais. Nega outras queixas e história familiar de sangramento. Ao exame: Hematoma de 6 x 6 cm em região de panturrilha direita. Equimose em axila esquerda de 2 x 3 cm e em região dorsal de 3 x 4 cm. Ausência de petéquias. Restante do exame físico sem alterações. Exames complementares: Hb: 12,5 g/dL, GB: 7.600/ul (48% neutrófilos, 52% linfócitos), plaquetas: 245.000/uL. TTPA ratio: 1,1 (VR < 1,3); TP INR: 2,4 (VR < 1,2); TT ratio: 1,1 (VR < 1,2). Com base na história e exames acima, qual é o diagnóstico mais provável?

- ☐ A Deficiência do fator V ou X.
- ☐ B Deficiência do fator VIII, IX ou XI.
- ☐ C Doença de von Willebrand
- ☐ D Deficiência do fator VII.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182100](#)

Questão 94 **DDS46XY** **insensibilidade androgênica ou defeito no receptor androgênico** **Pediatria**

Você examina um recém-nascido, primeiro filho de um casal jovem, saudável e sem consanguinidade. Foi uma gestação muito aguardada e todo o acompanhamento pré-natal foi completo e sem intercorrências. Entretanto, aos 6 meses de gestação realizaram também um exame de sexagem fetal, cujo o resultado (46,XY) foi discrepante dos achados da ultrassonografia fetal. Durante o exame físico, você não encontra nenhuma outra anormalidade aparente e o exame da região genital é mostrado na figura abaixo. O exame ultrassonográfico não encontrou útero e demais derivados Mullerianos. Considerando que o resultado do exame citogenético seja de fato confirmado, qual é o provável diagnóstico desta criança?

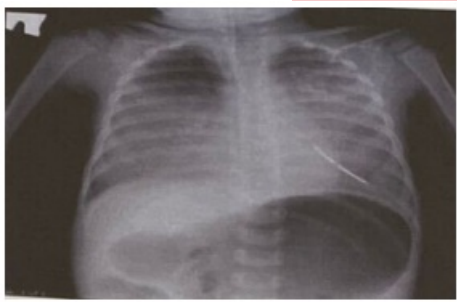


- A Síndrome de resistência androgênica.
- B Hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21 hidroxilase.
- C Síndrome de Rokitansky (Mayer Rokitansky Kuster Hauser).
- D Disgenesia gonadal mista.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182099](https://www.4000182099.com.br)

Questão 95 Temas Gerais em Cirurgia Cirurgia

Um pré-escolar de 5 anos e 20 kg, foi internado para o tratamento de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Devido à inapetência e para prevenção de broncoaspiração, foi indicada alimentação por sonda nasogástrica. Após a passagem da sonda pela enfermagem, foi realizada a seguinte radiografia Qual a conduta imediata mais apropriada?



- A Introduzir mais a sonda.
- B Injetar ar sob ausculta.
- C Liberar a sonda para uso.
- D Retirar a sonda

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182099](https://www.4000182099.com.br)

Questão 96 Diagnóstico Pediatria

Menina de 10 anos apresenta dor e edema em tornozelos e lesões cutâneas, principalmente em membros inferiores e nádegas, há 5 dias (foto), sem nenhuma outra queixa. O restante do exame físico está sem alteração. Há 20 dias, apresentou quadro de infecção respiratória. Exames complementares: Hb: 14 g/dL, GB: 7.200/mm³ (40% neutrófilos, 60% linfócitos), plaquetas: 480.000/mm³, VHS 40 mm/1 hora, proteína C reativa 3 mg/dl (VR: abaixo de 0,5 mg/dl), urina rotina sem alterações. Ultrassonografia de abdome normal. Além de observar a evolução do quadro, qual a conduta terapêutica nesse momento?



- A Analgésico.
- B Corticoide.
- C Dapsona.
- D Tacrolimus.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182097](https://www.4000182097.com)

Questão 97 Tratamento de Manutenção Tratamento de manutenção da asma Pneumologia

Criança de 7 anos de idade, diagnosticada com asma aos 6 anos, com base na história clínica e espirometria. Nega uso de medicações de uso contínuo. Nos últimos 6 meses, vem apresentando tosse e dispnéia diariamente e despertar noturno, devido à tosse, 3 vezes por semana. Como deve ser o tratamento inicial?

- A Corticoide inalado associado a teofilina.
- B Corticoide inalado associado a montelucaste
- C Corticoide inalado associado a beta 2 de ação prolongada.
- D Corticoide inalado associado a imunobiológico.

Proibida venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182096](https://www.4000182096.com)

Questão 98 Comunicação interventricular

Criança de 8 anos, sexo feminino, vem a consulta devido a arroxamento dos lábios e unhas, além de cansaço durante esforços físicos. Esses episódios começaram há cerca de 1 anos e estão se tornando mais frequentes. Nega internações prévias e quadros de chiados no peito. Familiar refere que no primeiro ano de vida, época em que fez puericultura, foi observado sopro sistólico e desconforto respiratório, porém médico disse que paciente devia ter "algum burquinho no coração que fecharia sozinho". Refere também que sentia uma vibração torácica em região de rebordo esternal esquerdo baixo, mas que desapareceu ao longo dos anos. Qual hipótese diagnóstico deve ser investigada?

- A Transposição de grandes artérias.
- B Comunicação interatrial.
- C Tetralogia de Fallot.
- D Síndrome de Eisenmenger

Questão 99 **Cirurgia Infantil** **Cirurgia** **Íleo Paralítico**

Criança de 5 anos, queixa-se de vômitos 3 vezes ao dia há 3 dias, acompanhados de diarreia aquosa de médio volume, 5 vezes ao dia. Hoje a mãe notou que a criança está apática, com dor abdominal e diminuição das evacuações. Não está se alimentando adequadamente. Exame físico: regular estado geral, descorado +/4+, febril, hidratado. Aparelho respiratório: sem alterações. Aparelho cardiovascular: 2 bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros, FC: 130 bpm, PA: 90 x 50 mmHg, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar > 2 segundos. Abdome: distensão abdominal, com dor à palpação difusa e ruídos hidroaéreos diminuídos. Exames laboratoriais: Na: 135 mEq/L, K: 2,9 mEq/L, Ca iônico: 1/2 mg/dl. Escala de alvarado modificada: 3. Qual a hipótese diagnóstica?

- A Constipação intestinal.
- B Íleo paralítico
- C Apendicite aguda.
- D Adenite mesentérica.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182094

Questão 100 **Medicina Livre** **Quadro clínico da leucemia linfóide aguda LLA** **Diagnóstico da leucemia linfóide aguda LLA**

Menino de 8 anos, previamente hígido, apresenta quadro de dor intensa nos joelhos e tornozelos, que o impede de caminhar. Refere que o quadro iniciou há 30 dias, com piora progressiva. A dor é pior no período noturno e o acorda algumas vezes durante a noite. Nega traumas ou infecções recentes, Perdeu 2 quilos no período. Ao exame físico: regular estado geral, fâcies de dor, adenomegalia cervical e inguinal com gânglios de até 2 cm, bilaterais, não coalescentes, de consistência fibroelástica. Dor intensa e limitação à movimentação de joelhos e tornozelos, sem edema ou outras alterações. Exames complementares iniciais: Hb; 10 g/dL, GB: 3.200/mm³ (20% neutrófilos, 80% linfócitos), plaquetas: 240.000/mm³, VHS 50 mm/1 hora, proteína C reativa 7 mg/dl (VR: abaixo de 0,5 mg/dl). Com relação à principal hipótese diagnóstica, qual o exame a ser solicitado nesse momento?

- A Ecocardiograma.
- B Anticorpo antinuclear.
- C Análise de líquido sinovial.
- D Mielograma.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182093

Respostas:

1	D	2	A	3	C	4	D	5	D	6	C	7	C	8	D	9	A	10	A	11	D
12	A	13	A	14	D	15	B	16	A	17	D	18	A	19	C	20	A	21	B	22	B
23	A	24	C	25	A	26	D	27	C	28	B	29	C	30	B	31	A	32	A	33	A
34	D	35	A	36	A	37	B	38	D	39	B	40	C	41	A	42	C	43	B	44	B
45	D	46	D	47	C	48	D	49	C	50	B	51	A	52	A	53	B	54	D	55	C
56	C	57	C	58	D	59	A	60	D	61	C	62	A	63	C	64	A	65	C	66	B
67	C	68	C	69	B	70	C	71	D	72	B	73	B	74	A	75	D	76	B	77	B
78	B	79	C	80	A	81	D	82	C	83	B	84	C	85	C	86	D	87	D	88	A
89	B	90	C	91	A	92	D	93	D	94	A	95	D	96	A	97	C	98	D	99	B
100	D																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.



Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 Tratamento nas crianças e adolescentes

Menina, 6 anos de idade, com antecedente de Diabetes Mellitus tipo 1, em uso regular de insulina NPH, foi admitida no serviço de emergência há 2 horas, devido a quadro de vômitos e dor abdominal há 3 dias. Os exames coletados e as medidas realizadas na sala de emergência estão descritos na tabela abaixo.

Exames Séricos	Entrada 08:00	09:00	10:00
Glicemia capilar (mg/dL)	340	260	180
Glicemia sérica (mg/dL)	346		170
Sódio / Potássio (mEq/L)	132/5,7		135/5,3
Calcio iônico/ Fósforo (mmol/L; mg/dL)	1,2/2,6		1,3/2,6
Uréia/ Creatinina (mg/dL)	50/0,8		45/0,7
pH / Bicarbonato (- / mEq/L)	7,05/6,0		7,10/8,0
pCO ₂ / pO ₂ (mmHg)	18/60		21/64
Tratamento			
Fluidoterapia	Soro Fisiológico 20 ml/kg/hora	Soro Fisiológico 20 ml/kg/hora	
Insulina Regular EV contínua		0,1 UI/Kg/hora	

Ao exame, paciente encontra-se em regular estado geral, mucosas secas, FC: 115bpm, frequência respiratória de 35 ipm, PA 90/50 mmHg, tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Queixa-se apenas de fraqueza.

Dentre as medidas a serem realizadas na terceira hora, inclui-se:

- A Suspender insulino terapia.
- B Introduzir dieta pobre em potássio.
- C Adicionar glicose à fluidoterapia.
- D Adicionar bicarbonato à fluidoterapia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4 00011993

Questão 2 Diagnóstico e exames complementares Tratamento e condutas

Recém-nascido de termo, masculino, adequado para a idade gestacional, de 39 1/7 semanas, com peso de 4100g e estatura de 52 cm, nascido de parto vaginal, e mãe primigesta de 22 anos. Ao primeiro exame físico, sem anormalidades significativas, exceto por reflexo de moro assimétrico à direita, com membro superior direito com menos força, voltado medialmente, estendido e pronado.

Baseado no diagnóstico principal, a conduta é:

- A Ultrassonografia transfontanela.
- B Observação clínica.
- C Imobilização de membro.
- D Fisioterapia motora.

Questão 3 Distúrbios metabólicos do período neonatal

Recém-nascido masculino, 2º dia de vida, apresenta quadro de tremores de membros superiores, sem outros sintomas associados. Trata-se de recém-nascido de termo, adequado para idade gestacional, filho de mãe tercigesta, realizou pré-natal com 12 consultas, com diagnóstico de diabetes gestacional. Nasceu de parto vaginal, sem intercorrências, pesando 3.120 gramas, boletim de Apgar: 09/10/10. Glicemia capilar neste momento: 52 mg/dL.

Está indicado:

- A Ampliar a investigação, com a dosagem de eletrólitos séricos, incluindo cálcio e magnésio.
- B Obter glicemia plasmática, pois o valor da glicemia capilar não é confiável nesta idade.
- C Iniciar complementação via oral, oferecendo fórmula láctea adequada para a idade.
- D Obter acesso venoso, para administrar soro glicosado 10% em bolus na dose de 2 a 4 ml/kg.

4 00011943

Questão 4 Diagnóstico Sinais e sintomas

No exame físico inicial de um recém-nascido de termo, masculino, pequeno para idade gestacional, foi notado microcefalia (PC: 31 cm) e presença de petéquias em face. Frente aos achados, foi realizada uma ultrassonografia transfontanela, com achado de calcificações peri-ventriculares, sem outras alterações. Também colhido hemograma, com Hb 16,2, Ht 41%, leucócitos: 11.300, plaquetas: 75.000. Triagem auditiva neonatal: falhou bilateralmente. Nasceu de parto cesárea por iteratividade, filho de mãe de 32 anos, tercigesta, sem comorbidades e com pré-natal inadequado, sem coleta de exames.

Os seguintes exames maternos foram colhidos nesta internação:

HIV: negativo;

VDRL: negativo;

Hepatite C: negativo;

Hepatite B: Anti-HBs positivo, anti-HBc negativo, Hbs Ag negativo;

Toxoplasmose: IgM negativo / IgG negativo;

Rubéola: IgM negativo / IgG positivo;

Citomegalovírus: IgM negativo / IgG positivo.

Frente a principal hipótese diagnóstica, a conduta indicada é:

- A Coleta de teste do pezinho ampliado e cariótipo.
- B Pesquisa de citomegalovírus por PCR na urina.
- C Aplicar vacina e imunoglobulina para hepatite B.
- D Pesquisar consumo excessivo de álcool na gestação.

Questão 5 Icterícia neonatal

Recém-nascido masculino, 34 horas de vida, está em alojamento conjunto com boa aceitação do seio materno. Ao exame clínico, apresenta icterícia leve (zona I-II pela classificação de Kramer), sendo optado pela coleta de bilirrubinas, com bilirrubina total de 6,5 mg/dL, bilirrubina indireta de 6,2 mg/dL. Trata-se de criança nascida de termo, adequado para a idade gestacional de 40 semanas, com peso ao nascer de 3650g, sem intercorrências. A tipagem sanguínea materna é O negativo, Coombs indireto negativo e a do recém-nascido A positivo, Coombs direto: negativo e Eluato positivo. A mãe recebeu imunoglobulina profilática na 28ª semana de gestação.

A conduta neste momento é:

- ☐ A Fototerapia.
- ☐ B Exsanguineotransfusão.
- ☐ C Observação clínica.
- ☐ D Imunoglobulina.

4 00011842

Questão 6 Técnicas de amamentação

Recém-nascido feminino, 10 dias de vida, é trazido para a primeira consulta de puericultura. Trata-se de criança nascida de termo, parto vaginal, sem intercorrências, com peso de nascimento de 3.350g, adequado para a idade gestacional, boletim de Apgar 9/10/10. Filho de mãe primigesta, de 22 anos, sem comorbidades e sem intercorrências durante o pré-natal. Tipagem sanguínea materna e do RN: A+. A criança recebeu alta no 3º dia de vida, com peso de 3.100g. Na consulta de hoje, a mãe refere que produz bastante leite e que a criança suga bem, mas está cansada porque a criança quer mamar de hora em hora, eventualmente com intervalos de 30 minutos entre as mamadas. Criança evacua três vezes ao dia, com fezes amareladas. Diurese clara, com 4 trocas de fraldas ao dia. Ao exame clínico, apresenta icterícia zona III, sem outras alterações significativas. Peso atual de 3.205g.

A conduta indicada é:

- ☐ A Orientar mamadas mais longas e efetivas, e marcar retorno precoce para reavaliação do peso.
- ☐ B Reforçar a manutenção do regime de livre demanda e realizar seguimento habitual de puericultura.
- ☐ C Iniciar fototerapia, com investigação de infecções, doenças metabólicas e erros inatos do metabolismo.
- ☐ D Encaminhar a mãe para avaliação psicológica e convocar familiares para auxiliarem o cuidado.

Essa questão possui comentário do professor no site 400011821

Questão 7 Síndrome torácica aguda

Adolescente masculino, 13 anos de idade, portador de anemia falciforme em seguimento regular com hematologista, apresenta queixa de febre e tosse há dois dias e dor em face anterior do tórax a direita. Ao exame clínico encontra-se em regular estado geral, levemente descorado, FC: 84 bpm, FR: 34 ipm, Saturação de Oxigênio: 95% em ar ambiente, Temp: 38°C, PA: 100/60 mmHg. Realizou radiografia de tórax, que mostrou a imagem abaixo:



A conduta inicial mais adequada é:

- A Prescrição de amoxicilina, alta hospitalar com reavaliação.
- B Internação com ceftriaxone e claritromicina.
- C Fibrinolítico endovenoso e enoxaparina dose terapêutica.
- D Hiper-hidratação endovenosa e oxigenioterapia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000111806

Questão 8 Síndromes clínicas da cardiopediatria

Menino, 8 anos de idade, portador de síndrome nefrótica corticodependente, encontra-se internado há dois dias por quadro atual de descompensação da síndrome, desencadeada por infecção de vias aéreas superiores. Está recebendo albumina humana 20% intravenosa. Após a infusão de cerca de metade da dose, apresenta queixa de desconforto respiratório. Em sua avaliação clínica, nota-se FR: 32 ipm, FC: 138 bpm, PA: 140/88 mmHg, Saturação de Oxigênio de 89% em ar ambiente, ausculta de estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares e fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito.

Qual é o medicamento indicado neste momento?

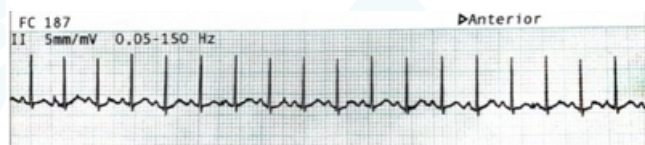
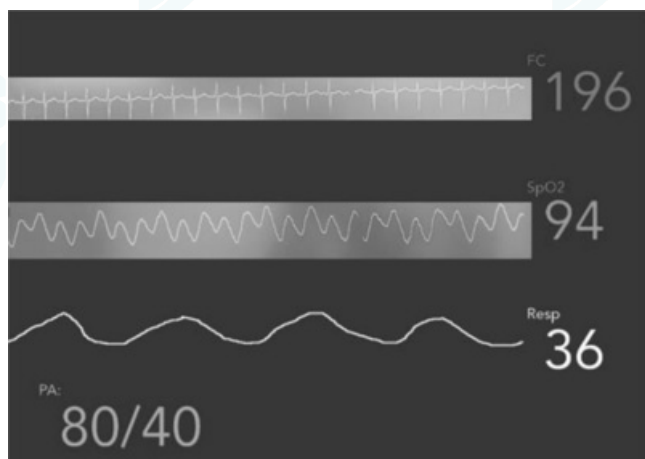
- A Alteplase.
- B Dobutamina.
- C Furosemida.
- D Epinefrina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000111783

Questão 9 Tratamento do Choque Séptico

Menina, 7 anos de idade, previamente hígida, apresenta quadro de febre há 1 dia de até 39,5°C, mal-estar e hipoatividade. Foi admitida no Pronto-Socorro letárgica, sendo levada à sala de emergência. Na avaliação primária, estava febril, sonolenta, porém responsiva ao chamado, hidratada. Apresentava extremidades frias, pulsos finos e tempo de enchimento capilar de 6 segundos. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, abdome indolor, sem visceromegalias. Abaixo os

dados de monitorização do paciente.



Qual é a conduta imediata?

- A Sedação seguida de cardioversão elétrica.
- B Ceftriaxone e expansão volêmica.
- C Manobra vagal seguida de adenosina.
- D Antitérmico e reavaliação após 1 hora.

Medicina Livre
Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111760](https://www.4000111760.com)

Questão 10 Tratamento

Lactente masculino, 2 meses de idade, nascido de termo, parto vaginal, sem intercorrências até o momento, está sendo reavaliado na retaguarda de um Pronto-Socorro. Há 4 dias iniciou quadro de coriza hialina e tosse, e há um dia evoluiu com desconforto respiratório. Apresentou febre de até 38,6°C apenas no primeiro dia de história do quadro atual. O paciente deu entrada há cerca de 10 horas e está com a seguinte prescrição:

Peso 4,8 kg;

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1. Jejum | | |
| 2. Soro Glicosado 5%..... | 1000 ml | } EV, infundir a 20 ml/hora |
| NaCl 20%..... | 40 ml | |
| KCl 19,1%..... | 10 ml | |
| 3. Inalação com soro fisiológico 5 ml se necessário | | |
| 4. Máscara de oxigênio não reinalante com reservatório 15L/min oxigênio | | |

No momento da sua reavaliação, o paciente está em regular estado geral, hidratado, pálido, com ausculta pulmonar com sibilos e crepitações difusas, tiragens subdiafragmática, intercostal e de fúrcula, batimento de asas nasais. FR: 88 ipm, saturação de oxigênio 90% com oferta de O₂, FC: 180bpm, PA: 78/40mmHg. Sem alterações das propedêuticas cardíaca e abdominal. Tempo de enchimento capilar de 2 segundos, pulsos normais, sem edema. Radiografia de tórax realizada há 15 minutos:



<https://radiopaedia.org/>

Com relação ao suporte hídrico prescrito, está correto afirmar que:

- A Deve-se aumentar a velocidade de infusão para 30 mL/hora.
- B O soro de manutenção está hipertônico e deve ser corrigido.
- C O soro de manutenção deve ser suspenso e iniciar fórmula láctea 10 mL de 3/3 horas.
- D O soro de manutenção está adequado nesse momento.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 400011714

Questão 11 Tratamento

Lactente masculino, 2 meses de idade, nascido de termo, parto vaginal, sem intercorrências até o momento, está sendo reavaliado na retaguarda de um Pronto-Socorro. Há 4 dias iniciou quadro de coriza hialina e tosse, e há um dia evoluiu com desconforto respiratório. Apresentou febre de até 38,6°C apenas no primeiro dia de história do quadro atual. O paciente deu entrada há cerca de 10 horas e está com a seguinte prescrição: [Acesse t.me/medicinalivre](https://t.me/medicinalivre)

Peso 4,8 kg;

- | | |
|---|---------|
| 1. Jejum | |
| 2. Soro Glicosado 5%..... | 1000 ml |
| NaCl 20%..... | 40 ml |
| KCl 19,1%..... | 10 ml |
| } EV, infundir a 20 ml/hora | |
| 3. Inalação com soro fisiológico 5 ml se necessário | |
| 4. Máscara de oxigênio não reinalante com reservatório 15L/min oxigênio | |

No momento da sua reavaliação, o paciente está em regular estado geral, hidratado, pálido, com ausculta pulmonar com sibilos e crepitações difusas, tiragens subdiafragmática, intercostal e de fúrcula, batimento de asas nasais. FR: 88 ipm, saturação de oxigênio 90% com oferta de O₂, FC: 180bpm, PA: 78/40mmHg. Sem alterações das propedêuticas cardíaca e abdominal. Tempo de enchimento capilar de 2 segundos, pulsos normais, sem edema. Radiografia de tórax realizada há 15 minutos:



<https://radiopaedia.org/>

Qual é a conduta imediata para estabilizar o paciente?

- A Indicar drenagem torácica à direita.
- B Iniciar antibiótico de amplo espectro e expansão volêmica.
- C Escalonar suporte ventilatório invasivo ou não invasivo.
- D Prescrever droga vasoativa com efeito inotrópico.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000111676

Questão 12 Tratamento Pediatria

Menino, 2 anos de idade, há 6 dias apresenta quadro de febre alta e irritabilidade com piora nos últimos dias, acompanhada das seguintes alterações:



<http://www.pods.org.uk>

Acesse t.me/medicinalivre

Não há queixas respiratórias ou gastrointestinais.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o tratamento?

- A Vitamina A.
- B Paracetamol.
- C Penicilina benzatina.
- D Gamaglobulina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111633](#)

Questão 13 Reanimação neonatal

Na sala de parto um recém-nascido de termo é seco e estimulado ao nascer, está em apneia, hipotônico e cianótico com frequência cardíaca de 70 bpm. Com um minuto de vida, continua cianótico, hipotônico e tem uma frequência cardíaca de 70 bpm, respirando irregularmente a uma taxa de 15 respirações por minuto e faz algumas caretas durante a estimulação, mas não chora. A equipe segue as diretrizes apropriadamente, faz ventilação com pressão positiva com máscara. Aos 5 minutos, a frequência cardíaca subiu para 90 bpm, o tronco ficou corado (mas as mãos e os pés permanecem cianóticos), está respirando espontaneamente e tem melhora do tônus flexor, mas não se movimenta ativamente. Aos 10 minutos, o lactente está chorando, respirando, se movimentando ativamente, completamente corado e com frequência cardíaca de 120 bpm.

Quais notas foram as pontuações do Boletim de Apgar dessa criança?

- A 3, 6 e 10.
- B 3, 7 e 9.
- C 4, 6 e 9.
- D 4, 7 e 10.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111585](#)

Questão 14 Diagnóstico Diferencial Fibrose Cística Trato Gastrointestinal

Menina, 9 anos de idade, vem para sua primeira consulta de acompanhamento. A mãe afirma que sempre apresentou infecções respiratórias frequentes, com uso de antibióticos em múltiplos tratamentos desde 1 ano de idade. Refere ter tosse com produção de secreção, diariamente, e falta de ar na atividade física da escola. A mãe também está preocupada com o seu baixo crescimento e baixo ganho de peso. Ao exame clínico está abaixo do percentil 5 na altura e também no peso para sua idade. À ausculta apresenta estertores grossos difusos e baqueteamento de dedos.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o quadro?

- A Asma não controlada.
- B Fístula traqueoesofágica.
- C Fibrose cística.
- D Tuberculose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111562](#)

Questão 15 Desenvolvimento psicossocial do adolescente

Adolescente, sexo feminino, 14 anos de idade, veio para consulta ambulatorial acompanhada de sua mãe, que está muito

preocupada com o seu desempenho escolar. A adolescente está no 9º ano, nunca reprovou, mas este semestre está de recuperação em matemática, física e química, cujas provas serão realizadas amanhã. Ao ser questionada se já começou a estudar para as provas de amanhã, diz que pretende fazer isso hoje após a consulta, pois acha que a matéria não é muito extensa. Na consulta de hoje, a adolescente está nitidamente sonolenta. Quando confrontada sobre a sonolência, refere que passou a madrugada na fila para comprar ingressos de um show musical que ocorrerá em junho do próximo ano. A previsão de abertura da bilheteria era hoje pela manhã, mas ela chegou com 24 horas de antecedência, por medo de perder o ingresso, sendo a primeira da fila.

Levando em consideração as características do desenvolvimento psicológico-emocional presentes na adolescência, podemos enquadrar a descrição acima como uma manifestação de:

- A Vivência temporal singular.
- B Atitude social reivindicatória.
- C Desenvolvimento do pensamento abstrato.
- D Flutuação constante de humor.

4000111550

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Questão 16

Síndrome do Lactente Sibilante Bebê chiador

Diagnóstico

Epidemiologia

Menino, 1 ano e 6 meses de vida, está em acompanhamento ambulatorial devido a sibilância recorrente. O primeiro episódio foi com 7 meses de vida, iniciado por tosse, coriza e febre baixa, evoluindo com desconforto respiratório. Foi internado devido hipoxemia, recebeu alta hospitalar após dois dias com receitas de inalação com soro fisiológico e lavagem nasal. Ocorreram mais 5 episódios, nos quais ele recebeu prednisolona e inalações com salbutamol, sempre com boa resposta, e sem novas internações. O último episódio foi há 1 mês. A mãe notou que não é sempre que a sibilância é precedida por sintomas respiratórios virais. Refere que fica assintomático entre os episódios, sem limitações nas atividades do dia-a-dia. Sono tranquilo. João nasceu de termo, sem intercorrências, começou a frequentar a creche com 6 meses de vida. Mora com mãe, pai e irmão de 7 anos, todos sem comorbidades conhecidas. Apresenta ausculta pulmonar normal, a única alteração ao exame clínico é a presença de um eczema em face, acometendo maxilares e mento, poupando o maciço central da face, com xerodermia difusa.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Baseado nos critérios de Castro-Rodriguez (Índice Preditivo de Asma) para diagnóstico de asma em lactentes, podemos afirmar que a probabilidade desta criança ter asma é:

- A Alta, devido à ocorrência de mais de 3 episódios em um ano e à boa resposta ao corticoide e ao broncodilatador.
- B Alta, devido ao diagnóstico pessoal de dermatite atópica e à presença de sibilância sem desencadeante viral.
- C Baixa, devido à ausência de história familiar de doenças atópicas, sendo o quadro atribuível à entrada precoce na creche.
- D Baixa, devido à ausência de sintomas no período intercrítico e à ausência de interferência no sono e nas atividades do dia-a-dia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111494](https://t.me/medicinalivre)

Questão 17

Vigilância Epidemiológica

Pediatria

Lactente masculino, 2 meses de idade, é levado ao Pronto-Socorro por tosse produtiva há 10 dias. Teve febre de 37,8°C no início do quadro. Há 2 dias com piora da tosse, apresentando episódios de cianose após tosse e pausa respiratória. Na casa moram 4 pessoas, a mãe, o pai e um irmão de 2 anos de idade, este sem comorbidades e sem nenhuma vacinação prévia.

Considerando a principal hipótese diagnóstica para este paciente, qual é a conduta imediata para seu irmão?

- A Indicar bloqueio vacinal.
- B Coletar secreção respiratória e medicar se resultado positivo.
- C Manter observação clínica e só medicar se apresentar sintomas.
- D Iniciar azitromicina em dose terapêutica.

4000111464

Questão 18 **Profilaxia Ferro** **Anemia Fisiológica**

Lactente masculino, 3 meses de vida, está em consulta ambulatorial de rotina. Tem antecedente de prematuridade de 34 semanas de gestação, devido a pré-eclâmpsia e trabalho de parto prematuro, tendo nascido com peso de 1.820 g, adequado para a idade gestacional. Nasceu bem, sem necessidade de manobras de reanimação, permaneceu internado por 15 dias para tratamento de icterícia por incompatibilidade ABO e para ganho de peso. Atualmente a criança tem estatura de 59 cm e peso de 4.700 g (ambos no percentil 50 pela idade gestacional corrigida), tendo ganhado 32 g por dia desde a última consulta. Alimenta-se de seio materno complementando com fórmula infantil adequada para idade (30 mL, 7 vezes ao dia). Nega intercorrências desde o nascimento. Na semana passada, colheu hemograma que veio com Hb 10,0 g/dL, Ht 30,0%, VCM 82 fl, RDW 14,1%, com leucócitos e plaquetas sem alterações. Tendo em vista os dados apresentados, qual a recomendação da diretriz mais recente de Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP – 2018) sobre o uso de sulfato ferroso para este paciente?

- A Oferecer na dose de 4 mg/kg/dia com hemograma de controle em 4 semanas.
- B Iniciar apenas após completar 6 meses de idade corrigida.
- C Oferecer na dose de 2 mg/kg/dia até completar 1 ano de idade.
- D Iniciar apenas se deixar de receber fórmula infantil adequada para idade.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000111445

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 19 **Episódio hipotônico-hiporresponsivo**

Lactente feminino, 4 meses de idade, é levada a UBS pela mãe, que deseja orientações sobre vacinação. A mãe refere que a criança apresentou com um quadro de palidez intensa, associado a hipotonia generalizada, iniciado 6 horas após a aplicação da vacina dos 2 meses de vida. Refere que a criança não reagia quando estimulada. À época, a mãe levou a criança ao serviço de saúde, mas o episódio se resolveu antes da chegada ao hospital. A criança foi avaliada, permaneceu em observação por algumas horas e depois foi liberada. Evoluiu bem, sem novos episódios. Atualmente com desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade.

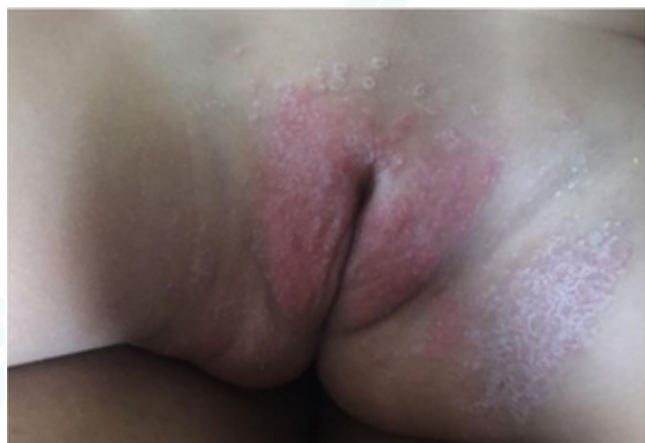
Levando em consideração os dados informados pela mãe, a conduta é:

- A Contraindicar as vacinas de vírus vivos atenuados (rotavírus e poliomielite) e encaminhar para imunologia pediátrica para avaliação.
- B Administrar todas as vacinas previstas para a idade e manter observação médica por 6 horas após aplicação.
- C Administrar cada uma das vacinas previstas para a idade em dias diferentes e observar possíveis reações de cada uma.
- D Trocar a vacina tríplice bacteriana de células inteiras (DPT) por DPT acelular e aplicar as demais vacinas previstas para a idade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111422](https://www.4000111422.com)

Questão 20 Intertrigo por cândida Dermatite de fraldas

Menina, 1 ano e 11 meses de idade, sem comorbidades, levada a UBS hoje devido a lesões em períneo surgidas há 1 semana, conforme figura abaixo. Sem outras queixas e sem outras alterações ao exame clínico. Para o tratamento da lesão atual está indicado o uso tópico de:

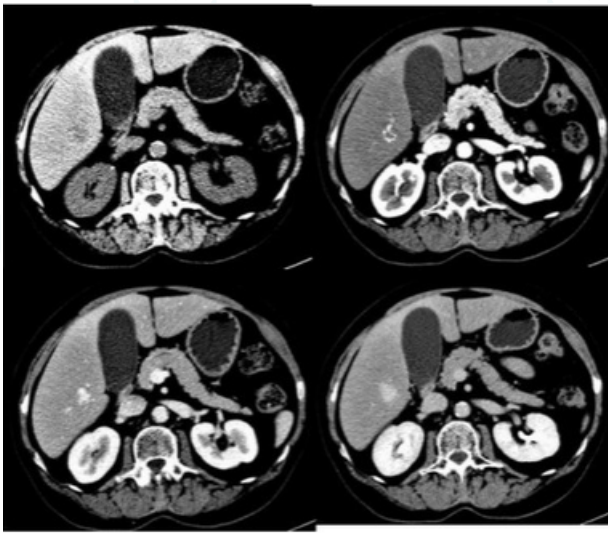


- A Hidrocortisona pomada.
- B Cetoconazol creme.
- C Neomicina + bacitracina pomada.
- D Pimecrolimo creme.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111401](https://www.4000111401.com)

Questão 21 Tumores Hepáticos Benignos

Mulher de 33 anos, em uso de anticoncepcional oral há 18 anos, realiza tomografia em investigação de dor abdominal, que evidenciou o nódulo hepático mostrado na imagem a seguir.



Qual é a melhor conduta?

- A Observação clínica.
- B Nodulectomia.
- C Embolização por arteriografia seletiva.
- D Suspensão do anticoncepcional.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111364](https://www.4000111364.com)

Questão 22 Tratamento cirúrgico da obesidade Complicações Cirurgia

Mulher de 44 anos, no 3º dia de pós-operatório de gastroplastia em Y de Roux por videolaparoscopia para tratamento de obesidade mórbida (IMC 44 Kg/m²). Ao exame físico apresenta-se taquicárdica (frequência cardíaca: 140bpm), PA 140 x 85 mmHg, eupneica, murmúrios vesiculares diminuídos nas bases, abdome flácido sem sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais: Hb: 13g/dL; Ht: 42%; Leucograma: 17,33mil/mm³; Creatinina: 1,5g/dL; Ureia: 78g/dL; PCR: 140g/dL.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Qual é a principal hipótese diagnóstica e conduta?

- A Hérnia interna (Petersen), laparoscopia.
- B Atelectasia pulmonar, fisioterapia respiratória.
- C Tromboembolismo pulmonar, anticoagulação terapêutica.
- D Deiscência de anastomose, tomografia de abdome.

4000111340

Questão 23 Terapia por Pressão Negativa Processo de Integração do Enxerto de Pele Debridamento

Homem, 23 anos de idade, motociclista, foi vítima de colisão com automóvel. No Serviço de Emergência foi avaliado e liberado pela Cirurgia Geral e pela Ortopedia, sendo posteriormente encaminhado à cirurgia plástica que identificou ferimento descolante de terço médio da perna direita, após descartada fratura. Qual é a melhor conduta, além da limpeza com soro fisiológico e degermação?

- A Ressecção e desprezo dos tecidos descolados, curativo oclusivo simples ou de pressão negativa sobre o leito cruento.
- B Ressecção e emagrecimento da pele descolada, enxertia da pele emagrecida sobre o leito cruento, curativo de pressão negativa sobre enxerto.
- C Ressecção de toda pele descolada e rotação de retalho local da coxa.
- D Ressecção de toda pele descolada, enxerto parcial de pele de coxa contralateral e curativo de pressão negativa sobre enxerto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111326](https://www.4000111326.com)

Questão 24 Fraturas da diáfise do fêmur

Homem, 23 anos de idade, vítima de queda de motocicleta há 2 horas. Sem outras alterações ao exame físico, exceto a fratura isolada de fêmur direito. Sem lesões vasculonervosas ou de partes moles (figura a seguir).



Qual é o melhor tratamento?

- A Fixador externo linear simples transarticular de joelho.
- B Endoprótese de fêmur.
- C Haste intramedular anterógrada de fêmur.
- D Fixação com placas de titânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111304](https://www.4000111304.com)

Questão 25 Estadiamento Adenocarcinoma de Esôfago Métodos Complementares

Homem, 63 anos, em acompanhamento em Unidade Básica de Saúde por conta de queixa de azia há mais de 10 anos, vem apresentando disfagia para alimentos sólidos. Realizou exame de endoscopia digestiva alta que revelou lesão ulcerada, subestenotante na região do esôfago distal até a transição esôfago-gástrica. A biópsia está em análise.

Qual é a principal suspeita anátomo-patológica e a próxima etapa para estadiamento do caso, de acordo com esta

hipótese?

- A Adenocarcinoma; tomografia de pescoço, tórax, abdome e pelve.
- B Adenocarcinoma; tomografia de tórax e laparoscopia.
- C Carcinoma espino-celular; tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT).
- D Carcinoma espino-celular; tomografia de pescoço, tórax, abdome e pelve.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111268](#)

Questão 26 Estenoses Traqueais Cirurgia

Homem, 19 anos de idade, com antecedente de queda da motocicleta há 70 dias com múltiplas fraturas de costelas à direita, contusão pulmonar, hemopneumotórax e trauma craniano grave. Tratado, na ocasião, com drenagem torácica à direita e ventilação mecânica por 17 dias. Recebeu alta hospitalar após 28 dias de internação em bom estado geral. Retorna ao serviço de emergência com queixa de dispneia de instalação progressiva associada a cornagem. Ao exame clínico, saturação de 94% frequência respiratória de 24 ipm, tiragem de fúrcula.

Qual é a hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento imediato?

- A Estenose de traqueia; intubação orotraqueal e ventilação invasiva.
- B Estenose de traqueia; corticoesteroide endovenoso, inalação com adrenalina e ventilação não-invasiva.
- C Estenose de laringe; cricotireoidostomia e ventilação invasiva.
- D Estenose de laringe; corticoesteroide e broncodilatadores inalatórios e ventilação não- invasiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111242](#)

Questão 27 Neoplasias Renais Malignas Cirurgia

Mulher, 45 anos de idade, com sangramento menstrual irregular, realizou ultrassom abdominal que evidenciou uma lesão exofítica hiperecogênica no rim direito medindo 3,3 cm de diâmetro. Realizada tomografia computadorizada de abdome que demonstrou lesão no terço inferior do rim direito, medindo 3,5 cm, com realce da lesão após a injeção do contraste endovenoso; rim esquerdo sem alterações.

Qual é a melhor conduta?

- A Nefroureterectomia radical e seguimento.
- B Nefrectomia radical com radioterapia.
- C Nefrectomia parcial e seguimento.
- D Nefrectomia parcial com quimioterapia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111211](#)

Questão 28 Características Gerais

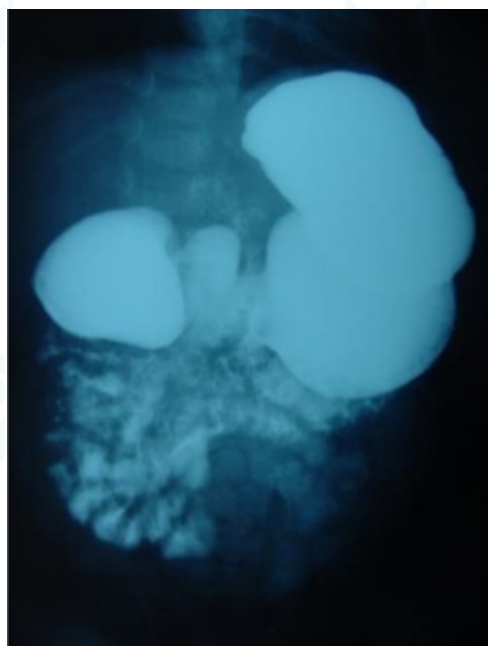
Homem, 50 anos de idade, fumante e estilista, apresenta nódulo de 3 cm cervical baixo à esquerda (Nível IV) que percebeu há 1 mês. Sem outras queixas. O nódulo é móvel e único. Cavidade oral e orofaringe normais. Qual é a melhor conduta?

- A Biópsia incisional do nódulo com exame de congelação.
- B Biópsia por agulha grossa do nódulo guiado por ultrassom e exame de congelação.
- C Biópsia excisional do nódulo com exame anatomopatológico em parafina.
- D Punção aspirativa do nódulo com agulha fina e análise de citologia oncológica.

400011191

Questão 29 Atresias e Estenoses Duodenais

Lactante de 10 meses portador de Síndrome de Down é encaminhado ao cirurgião pediátrico para realização de funduplicatura por refluxo grave com dificuldade de ganho ponderal. A mãe relata que o filho apresenta vômitos alimentares 2 a 3 vezes ao dia e o quadro se intensificou aos 6 meses, quando foram introduzidos alimentos pastosos. Traz um exame contrastado que revela a imagem a seguir.



Qual é a melhor conduta?

- A Píloroplastia.
- B Duodeno-duodeno anastomose.
- C Hiato plastia e funduplicatura.
- D Ranitidina e domperidona.

Essa questão possui comentário do professor no site 400011170

Questão 30 Tumor Estromal Gastrointestinal GIST

Homem, 54 anos de idade, apresentou hematêmese. Realizada endoscopia digestiva alta que evidenciou abaulamento no corpo gástrico (grande curvatura), com pequena úlcera e sinais de sangramento recente. Biópsia revelou tratar-se de tumor estromal do trato gastrointestinal (GIST). Tomografia de tórax e abdome: lesão de 10cm na grande curvatura/corpo gástrico, sem invasões de estruturas adjacentes. Sem sinais de lesões hepáticas ou pulmonares, ascite ou implantes peritoneais.

Qual é a melhor conduta?

- A Gastrectomia sem linfadenectomia.
- B Gastrectomia com linfadenectomia.
- C Químio-radioterapia neoadjuvante.
- D Quimioterapia neoadjuvante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000111145](https://www.4000111145.com)

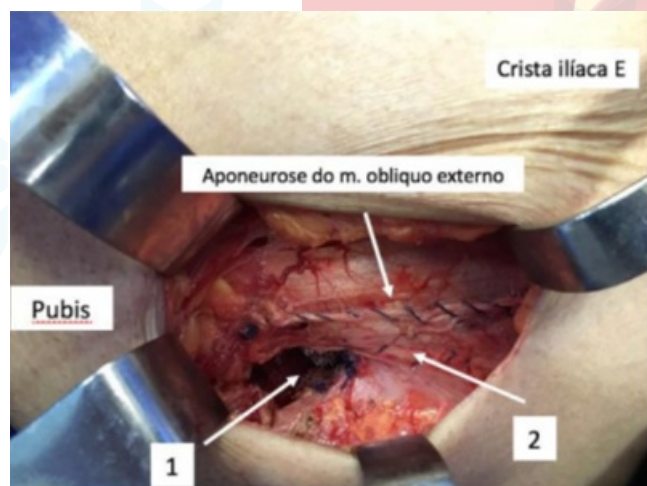
Questão 31 **Anatomia da Região Inguinal** **Cirurgia**

Mulher, 80 anos de idade, com história de dor e abaulamento na região inguino-crural esquerda conforme ilustra a figura a seguir.



Contra preços abusivos
na medicina.

Foi submetida a tratamento operatório conforme demonstrado na figura a seguir. Cite as estruturas anatômicas assinaladas:



Acesse t.me/medicinalivre

- A 1. Anel inguinal externo; 2. Ligamento pectíneo.
- B 1. Anel femoral; 2. Ligamento pectíneo.
- C 1. Anel inguinal externo; 2. Ligamento inguinal.
- D 1. Anel femoral; 2. Ligamento inguinal.

Questão 32 Trauma Abdominal Penetrante Cirurgia

Homem, 37 anos de idade, foi vítima de ferimento por arma branca (faca de cozinha) na região periumbilical há 1 hora. Admitido no serviço: A: Falando (hálito etílico), saturação de 96% em ar ambiente; B: Sem alterações; C: FC: 76bpm, PA: 140x70 mmHg. Realizado FAST: negativo; D: Glasgow 15; E: Obeso (IMC 41kg/m²), com ferimento na parede anterior do abdome, de 2cm, próximo à cicatriz umbilical, sem sangramento ativo, com dor apenas no local. Dorso sem alterações.

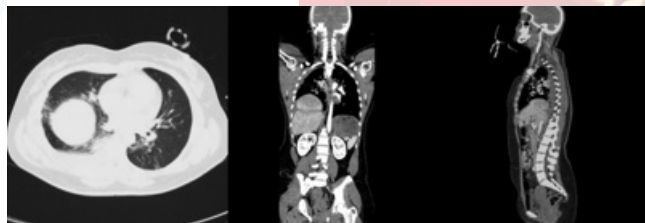
Qual é a melhor conduta?

- ☐ A Tomografia de abdome.
- ☐ B Laparoscopia diagnóstica.
- ☐ C Repetir FAST em 6 horas.
- ☐ D Radiografia de abdome em 3 posições.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000111075

Questão 33 Avaliação Inicial Vias aéreas Ventilação e Choque Cirurgia Trauma Abdominal e Pélvico

Homem, 27 anos de idade, foi admitido no Serviço de Emergência após colisão de automóvel contra anteparo fixo. A: via aérea pérvia. Saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente; B: dor à palpação do tórax à direita na região inferior e linha axilar média. Hematoma e crepitação no local da dor; C: FC:90bpm e PA: 130x70mmHg. D: Glasgow de 15. Pupilas sem alterações; E: Diurese clara. Dorso sem alterações. Abdome indolor a palpação. Realizada tomografia de abdome demonstrada a seguir:



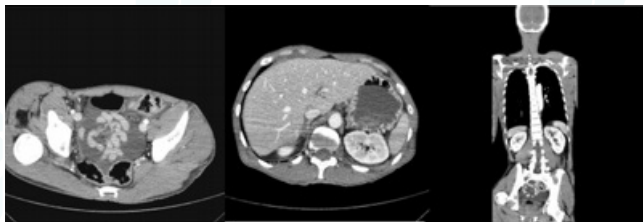
Qual é a melhor conduta?

- ☐ A Laparotomia.
- ☐ B Arteriografia.
- ☐ C Drenagem torácica.
- ☐ D Toracotomia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000111061

Questão 34 Traumatismo Urológico Cirurgia

Homem, 59 anos de idade, foi vítima de atropelamento por automóvel com velocidade estimada em 40km/h. Admitido no serviço com: A: via aérea pérvia, saturação de 97% ar ambiente; B: ausculta e expansibilidade pulmonar simétricas; C: FC: 80bpm; PA: 110 x 70mmHg; D: Glasgow de 15. Sem alterações de pupilas; E: Dor abdominal na fossa ilíaca direita e supra-púbica. Presença de hematuria. Dor na região coxo-femoral direita com deformidade do membro inferior direito. Realizada tomografia do abdome com os seguintes achados:



Qual é a melhor conduta no trauma abdominal?

- A Cistoscopia.
- B Laparoscopia.
- C Embolização.
- D Sondagem vesical.

Essa questão possui comentário do professor no site [400011029](#)

Questão 35 Técnicas de Hemostasia Endoscópica Classificação de Forrest
Hemorragia por Úlcera Péptica HDA por DUP

Homem, de 64 anos, portador de cirrose alcoólica, vem ao Pronto-Socorro referindo vômitos com sangue em grande quantidade. Nega antecedente de hemorragia digestiva. Realizada endoscopia digestiva alta com achado de varizes em esôfago e fundo gástrico, de médio calibre e úlcera gástrica pré-pilórica Forrest 2A.

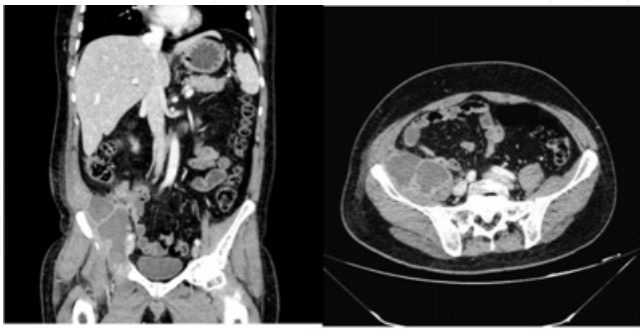
Qual é a taxa aproximada de ressangramento e a conduta indicada?

- A 10%, tratamento da úlcera com esclerose com argônio.
- B 30%, tratamento das varizes com terlipressina.
- C 45%, tratamento da úlcera com clip e esclerose.
- D 50%, tratamento das varizes com esclerose.

Essa questão possui comentário do professor no site [400011005](#)

Questão 36 Apendicite Aguda Cirurgia

Homem, 37 anos de idade, refere dor abdominal na fossa ilíaca direita há 12 dias, acompanhada de febre de até 38°C, perda de apetite e queda do estado geral. Procurou o serviço de urgência por duas vezes e há 6 dias foi iniciado ciprofloxacino devido à hipótese de infecção urinária. Retorna hoje ao Pronto-Socorro devido a persistência do quadro. Ao exame clínico: Regular estado geral, febril, FC:90 bpm, PA: 130x80 mmHg; Tórax sem alterações. Abdome flácido, massa palpável de cerca de 10cm na fossa ilíaca e flanco direito, dor localizada na região da massa. Sem sinais de irritação peritoneal. Toque retal sem alterações. Exames laboratoriais: Hb: 14,6 g/dL; Leuco: 26,57 mil/mm³; PCR: 324mg/dL; Creat: 1,37 mg/dL; Ureia: 51 mg/dL; demais exames normais. Realizada tomografia de abdome (imagens a seguir):



Qual é o melhor tratamento?

- A Laparotomia exploradora e apendicectomia.
- B Apendicectomia por incisão de McBurney.
- C Drenagem da coleção por laparotomia mediana.
- D Drenagem percutânea da coleção.

Medicina Livre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110988](https://www.4000110988.com)
Contra preços abusivos na medicina.

Questão 37 Litíase biliar Tratamento Cirúrgico

Primigesta, 28 anos de idade, com 14 semanas de gestação, apresentou quadro de dor abdominal de forte intensidade na região do epigastro com irradiação para dorso, acompanhada de vômitos. Exames laboratoriais confirmaram pancreatite aguda. Apresentou boa aceitação da dieta no 3º dia após os sintomas, além de normalização de todos os exames laboratoriais. Realizado ultrassom de abdome superior que evidenciou múltiplos cálculos na vesícula biliar de 0,2 a 0,5cm, sem dilatação da via biliar.

Qual é a conduta neste momento?

- A Ultrassom endoscópico.
- B Colangiografia endoscópica com avental de chumbo.
- C Acompanhamento clínico pré-natal.
- D Colecistectomia.

Deside Vende

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110971](https://www.4000110971.com)

Questão 38 Cirurgia Exames Diagnósticos e Tratamento

Homem, 54 anos de idade, apresenta icterícia, colúria e acolia fecal há 10 dias. Sem febre ou perda de peso. Nega alteração de hábito intestinal. Nega comorbidades. Exame físico sem alterações, exceto icterícia;

Exames laboratoriais: Hb: 14,6 g/dL, Leuco: 9,32 mil/mm³; TGO: 168 U/L ; FA: 469 U/L ; GGT: 678 U/L ; BT: 9,64 mg/dL; BD: 8,5 mg/dL;

Ultrassom de abdome: Vesícula biliar repleta de cálculos. Dilatação das vias biliares intra e extra-hepática, porém difícil caracterização do colédoco distal devido a interposição gasosa. Corpo do pâncreas sem alterações e difícil caracterização da cabeça. Fígado sem alterações.

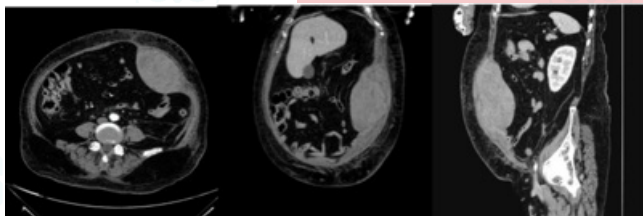
Qual deve ser o próximo passo?

- A Colecistectomia com colangiografia.
- B Colangioressonância.
- C Colangiografia endoscópica.
- D Papilotomia endoscópica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110943](https://www.4000110943.com)

Questão 39 **Fáscias e Músculos** **Cirurgia**

Mulher, 73 anos de idade, refere dor abdominal de início súbito e abaulamento progressivo no flanco esquerdo há 1 dia. Nega alterações do hábito intestinal e urinárias. Está em tratamento para exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica há 5 dias, porém com persistência da tosse. Tem hipertensão arterial controlada com medicamentos e fibrilação atrial em uso de anticoagulante. Ao exame físico: Bom estado geral, temperatura de 37,7°C; Tórax com raros roncospilobios; Abdome flácido e sem sinais de irritação peritoneal. Massa endurecida e dolorosa na região do flanco esquerdo de aproximadamente 15cm. Exames laboratoriais: Hb: 10,5 g/dL, Ht: 30%; Leucócitos: 13,54 mil/mm³; PCR: 34 mg/dL; Realizada tomografia de abdome (imagem a seguir):



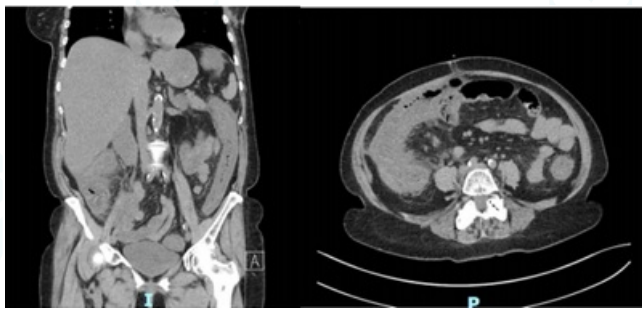
Qual é a melhor conduta?

- A Drenagem operatória.
- B Drenagem percutânea.
- C Observação clínica.
- D Biópsia incisional.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110943](https://www.4000110943.com)

Questão 40 **Diarreia** **Cirurgia**

Mulher, 64 anos de idade, se queixa de dor abdominal difusa de forte intensidade há 24 horas, acompanhada de febre e diarreia sem sangue. Nega sintomas urinários. Antecedente de internação prévia há 1 mês devido a pneumonia. Refere tabagismo. Tem hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito, controlados com medicamentos. Ao exame físico: Regular estado geral, FC:110 bcp, FR: 16, PA: 100x70 mmHg; Ausculta torácica sem alterações. Abdome distendido, doloroso com sinais de irritação peritoneal difusamente. Exames bioquímicos: Hb: 11,3 g/dL; Leuco: 19,57 mil/mm³; PCR: 60mg/dL; Creat: 2,19 mg/dL; Ureia: 141 mg/dl; Lactato: 28 mg/dL; Gasometria sem outras alterações; Tomografia de abdome:



Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Colite pseudomembranosa.
- B Trombose venosa mesentérica.
- C Úlcera péptica perforada.
- D Diverticulite complicada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110890](https://www.4000110890.com.br)

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Questão 41 Medidas de Associação e Medidas de Impacto

No sentido de quantificar a associação entre consumo de laticínios, doença cardiovascular e óbito foi realizado um estudo multicêntrico, que acompanhou por 15 anos grupo de 136.000 indivíduos entre 35 e 70 anos de idade, em 21 países. Os participantes foram divididos entre os que não consumiram laticínios e aqueles que os consumiram. Os dados que seguem resumem os principais resultados do estudo.

Tabela X. Associação entre consumo diário de laticínios (CDL) e eventos clínicos.

Evento	CDL Não ^A	HR ^B Sim	IC _{95%} ^C
Mortalidade total	1	0,83	0,72 – 0,96
mortalidade não cardiovascular	1	0,86	0,72 – 1,02
mortalidade cardiovascular	1	0,77	0,58 – 1,01
Doença cardiovascular grave	1	0,78	0,67 – 0,90
infarto do miocárdio	1	0,89	0,71 – 1,11
acidente vascular cerebral	1	0,66	0,53 – 0,82
insuficiência cardíaca	1	1,06	0,71 – 1,57

Acesse t.me/medicinalivre

Obs: ^A= intervalo de 95% de confiança; ^B = Hazard ratio; ^C= grupo de referência para HR;

Fonte: Lancet 2018; 392: 2288-97.

Qual é a alternativa correta quanto ao consumo de laticínios?

- A Aumentou o risco de óbito.
- B Aumentou o risco de insuficiência cardíaca.
- C Reduziu o risco de doença cardiovascular grave.
- D Diminuiu o risco de infarto do miocárdio.

Questão 42 Sensibilidade

Aplicou-se questionário para identificar indivíduos com apneia do sono em 1.800 indivíduos do sexo masculino, com idade média de 52 anos ($dp=\pm 9$ anos) e IMC de 33,8 ($dp=\pm 4\text{kg/m}^2$); obtidos em clínicas especializadas em distúrbios do sono. Neste grupo apresentou o seguinte desempenho sensibilidade (S) de 97% e especificidade (E) de 13%. Este mesmo questionário foi aplicado em população jovem onde esta doença atinge cerca de 1% do grupo. Qual alternativa reflete corretamente comportamento esperado deste questionário?

- A Aumentará apenas a especificidade.
- B Diminuirá apenas a sensibilidade.
- C Diminuirá sensibilidade e aumentará especificidade.
- D Manterá mesma sensibilidade.

4000110767

Questão 43 Prevenção

Maria, 56 anos, foi mordida na perna pelo cachorro da vizinha. No momento do acidente, a paciente realizou limpeza com água e sabão e manteve suas atividades domésticas. Cerca de 9 horas após o acidente, foi à Unidade Básica de Saúde (UBS) onde foi atendida pela enfermeira. A enfermeira coletou a informação de que o cachorro era conhecido e habitava a casa da vizinha, avaliou tratar-se de ferimento superficial, sem sangramento, constituído por pontos perfurantes correspondentes a mordedura.

Qual é a conduta?

- A Encaminhar para realizar vacinação antirrábica em Maria.
- B Manter observação do cão por 10 dias.
- C Encaminhar para realizar vacinação e soro antirrábico em Maria.
- D Encaminhar para realizar vacinação antirrábica em Maria se o cão não foi vacinado.

Proibida Venda

Essa questão possui comentário do professor no site 4000110750

Questão 44 Medidas de Associação e Medidas de Impacto

A força isocinética foi medida em 200 homens e mulheres saudáveis de 45 a 78 anos de idade para examinar a relação entre força muscular, idade e composição corporal. O pico de torque foi medido a 60 e 240 graus/s no joelho e a 60 e 180 graus/s no cotovelo usando o dinamômetro Cybex II®. A massa isenta de gordura (MIG) foi estimada por pesagem hidrostática em todos os sujeitos, e a mesma massa muscular (MM) foi determinada em 141 indivíduos a partir da excreção de creatinina urinária. Observou-se que a MIG e MM foram menores no grupo dos mais velhos ($p<0,001$). A força de todos os grupos musculares foi menor em mulheres e nos mais velhos ($p<0,006$), mas quando ajustada para MIG ou MM, estas diferenças não se mostraram significantes. Estes dados sugerem que o MM é um principal determinante das diferenças relacionadas à idade e sexo na força muscular esquelética.

(Journal of Applied Physiology 7 (2), 644-50)

Qual das medidas de associação a seguir pode ser utilizada neste tipo de estudo?

- A Risco atribuível.
- B Hazard ratio.
- C Risco relativo.
- D Razão de prevalência.

4000110734

Questão 45 Filtro especial identificando o tipo de estudo epidemiológico pela descrição da metodologia

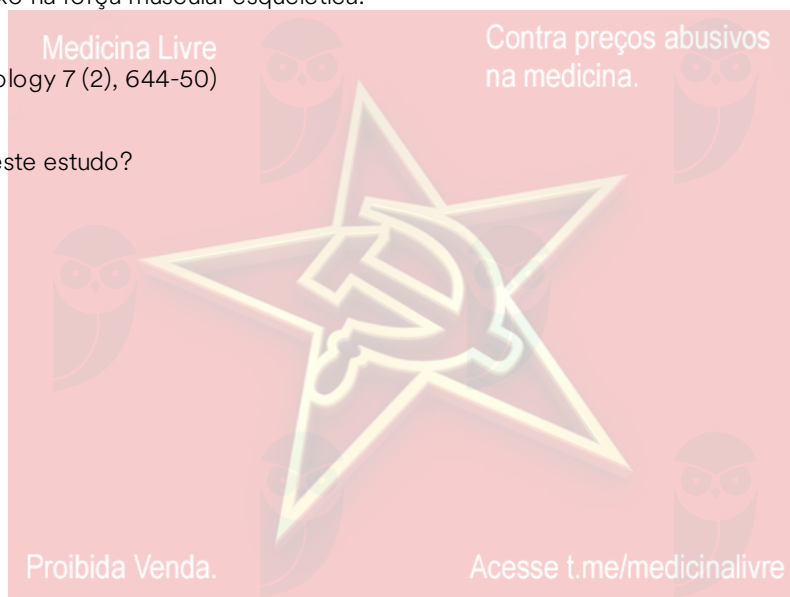
A força isocinética foi medida em 200 homens e mulheres saudáveis de 45 a 78 anos de idade para examinar a relação entre força muscular, idade e composição corporal. O pico de torque foi medido a 60 e 240 graus/s no joelho e a 60 e 180 graus/s no cotovelo usando o dinamômetro Cybex II®. A massa isenta de gordura (MIG) foi estimada por pesagem hidrostática em todos os sujeitos, e a mesma massa muscular (MM) foi determinada em 141 indivíduos a partir da excreção de creatinina urinária. Observou-se que a MIG e MM foram menores no grupo dos mais velhos ($p < 0,001$). A força de todos os grupos musculares foi menor em mulheres e nos mais velhos ($p < 0,006$), mas quando ajustada para MIG ou MM, estas diferenças não se mostraram significantes. Estes dados sugerem que o MM é um principal determinante das diferenças relacionadas à idade e sexo na força muscular esquelética.

(Journal of Applied Physiology 7 (2), 644-50)

Qual é o delineamento deste estudo?

- A) Transversal.
- B) Coorte.
- C) Caso-controle.
- D) Experimental.

- A Transversal.
- B Coorte.
- C Caso-controle.
- D Experimental.



Essa questão possui comentário do professor no site 4000110720

Questão 46 Letalidade Incidência Mortalidade

Qual a alternativa que corresponde, respectivamente, aos indicadores de saúde estimados a partir das informações a seguir, visto que foram obtidos os seguintes valores: 5/100.000; 1/100.000 e 20%?

Quadro. Casos notificados e óbitos por meningite bacteriana no Estado de São Paulo, no ano de 2013.

Número de casos notificados	2.000
Número de óbitos	400
População residente*	40.000.000

Dados modificados para facilitar cálculos:

*População residente em 2012, estimativa pelo IBGE.

Fonte: SINAN/DDTR/CVE/CCD/SES-S

- A Taxa de Letalidade, Coeficientes de Mortalidade e de Incidência.
- B Coeficientes de Prevalência, de Mortalidade e Taxa de Letalidade.
- C Coeficientes de Incidência, de Mortalidade e Taxa de Letalidade.
- D Coeficientes de Incidência, de Mortalidade e de Prevalência.

4000110701

Questão 47 Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

É reconhecido que a saúde de indivíduos é determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais.

Por que a religiosidade e espiritualidade são aspectos importantes a considerar no enfrentamento da doença?

- A É necessário tornar o ambiente clínico imune a influências de aspectos religiosos ou espiritualistas, os quais prejudicam a eficácia terapêutica.
- B O uso da religiosidade para lidar com a doença pode mobilizar atitudes e iniciativas positivas e também negativas, com potencial de impacto para a melhoria ou piora da qualidade de vida das pessoas em tratamento.
- C É necessário evitar que a religiosidade interfira na terapêutica, protegendo o paciente de eventuais efeitos depreciativos sobre suas convicções religiosas.
- D A religiosidade pode mobilizar atitudes positivas e também negativas, mas seu potencial de impacto é indiferente para a melhoria ou piora da qualidade de vida das pessoas em tratamento.

4000110647

Questão 48 Avaliação em Saúde

Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), qual é um dos objetivos das agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde?

- A Reduzir os custos decorrentes dos processos de decisão sobre incorporação de novas tecnologias no Sistema de Saúde.
- B Fornecer aos fabricantes de medicamentos informações que auxiliem nos processos de decisão sobre incorporação de tecnologias no Sistema de Saúde.
- C Impedir a incorporação de novas tecnologias que não apresentem uma relação de custo-efetividade aceitável.
- D Assegurar que as novas tecnologias incorporadas no Sistema de Saúde sejam seguras, efetivas e eficientes.

4000110560

Questão 49 Relação Médico-Paciente

Qual a afirmação correta relacionada aos aspectos comunicacionais da relação médico-paciente?

- A As habilidades comunicacionais do profissional resultam em: formação de vínculo entre o médico e o paciente; aumento da precisão diagnóstica; determinação da autonomia do médico nas tomadas de decisão e maior adesão ao tratamento.
- B Empatia diz respeito à disponibilidade interna para o contato emocional, capacidade de compreensão das vivências do outro e possibilidade de comunicação desse entendimento.
- C A transferência é um fenômeno inconsciente, em que há projeção de traços de memória de personagens do passado e repetição de padrões de comportamento sobre pessoas com as quais se estabelece relações no presente, portanto não diz respeito a processos comunicacionais.
- D A dimensão subjetiva do adoecimento interfere no reto raciocínio diagnóstico do médico e, por isso, o profissional deve evitar essa "contaminação" no processo de comunicação com o paciente.

4 000110531

Questão 50 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Considere os princípios e diretrizes do SUS e a situação atual do expressivo número de refugiados que estão atravessando a fronteira brasileira na região norte do país.

Qual é a afirmação correta?

- A Os refugiados, não sendo cidadãos brasileiros, não representam demanda potencial por atenção nos serviços de saúde, apesar de criarem novo cenário epidemiológico que demanda ações de vigilância e articulação com setores envolvidos em políticas sociais.
- B Os refugiados, não sendo cidadãos brasileiros, não representam demanda potencial por atenção nos serviços de saúde; mas demandam ações de vigilância epidemiológica a cargo de organismos internacionais (OPAS, OMS) que serão integradas a outros setores envolvidos em políticas sociais.
- C Ações de vigilância epidemiológica e articulação com outros setores envolvidos em políticas sociais devem ser desenvolvidas para o potencial aumento de demanda por atenção nos serviços de saúde.
- D Embora não tragam impactos diretos ao setor saúde, os refugiados representarão impacto indireto, pois as mudanças sócio sanitárias certamente impactarão nas demandas por atenção à saúde, ações de vigilância epidemiológica e políticas inter- setoriais de impacto na saúde.

4 000110511

Questão 51 Valor Preditivo Positivo

Qual a afirmativa correta com relação às propriedades de um teste diagnóstico?

- A Quanto mais sensível maior é a redução de falsos positivos.
- B Quanto menor a prevalência menor o valor preditivo positivo.
- C Quanto mais específico maior é a redução de falsos negativos.
- D Quanto maior a prevalência maior o valor preditivo negativo.

4 000110489

Questão 52 Mortalidade

Qual é a definição correta para indicador de mortalidade?

- A** Mortalidade proporcional é a razão entre os óbitos por dada doença e o total de óbitos ocorridos em dado período.
- B** Mortalidade proporcional é a razão entre os óbitos em dada faixa etária e o total de óbitos ocorridos em dado período.
- C** Mortalidade infantil é a razão entre os óbitos de menores de um ano, e o total de óbitos ocorridos em dado período.
- D** Letalidade é o número de óbitos decorrentes de uma doença considerando o total de óbitos ocorridos em dado período.

4000110471

Questão 53 Seguimento do tratamento Vacinação Prevenção

Considerando os objetivos do desenvolvimento sustentável da OMS, além da vacinação com BCG, quais das seguintes ações programáticas são propostas como estratégias para melhoria dos indicadores de saúde para a tuberculose?

- A** Tratar sintomáticos respiratórios.
- B** Tratar a infecção latente para todos os contatos.
- C** Confirmar cura dos casos.
- D** Tratar reatores ao teste tuberculínico.

4000110447

Questão 54 Epidemiologia

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) constituem grupo heterogêneo de enfermidades, com características comuns listadas em publicação de 2018 da Organização Mundial da Saúde. Em relação à ocorrência das DTN's no Brasil, qual é a afirmativa correta?

- A** Aumento da incidência de oncocercose na região nordeste.
- B** Incidência de leishmaniose visceral estável.
- C** Eliminação da raiva humana transmitida por cães.
- D** Maior prevalência de tracoma nas periferias das grandes cidades.

4000110428

Questão 55 Prevenção Primária

Durante atendimento de pré-natal de baixo risco, primigesta recebe orientação alimentar, indicação para cessar tabagismo e solicitação para realizar sorologia de sífilis e HIV. Realiza vacina para tétano. Segundo o modelo clássico de Leavell & Clark, qual das alternativas abaixo traz a correspondência correta entre a medida adotada e seu nível de prevenção?

- A** Medida adotada: Orientação alimentar/Nível de prevenção: Secundário
- B** Medida adotada: Cessação do tabagismo/Nível de prevenção: Secundário
- C** Medida adotada: Sorologia para sífilis/Nível de prevenção: Terciário
- D** Medida adotada: Vacinação/Nível de prevenção: Primário

Questão 56 Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

O estudo histórico dos processos de adoecimento e das demandas de saúde da população brasileira traz em seus objetivos a possibilidade de reflexão frente aos contextos em que tais processos e demandas são produzidos, em meio a rupturas e permanências históricas. Neste contexto, qual a afirmação correta?

- A As chamadas ""artes de curar"" se apresentam ainda hoje como relevantes na formação geral da população brasileira, ainda que em contextos conflitantes, contribuindo ativamente para a conformação de práticas de cuidado, com suas atitudes de acolhimento, concepções de adoecimento e estratégias de cura.
- B A história de formação sociocultural brasileira produziu uma série de concepções populares em torno dos adoecimentos e suas causas, produzindo aquilo que entendemos por ""artes de curar"", mas essas foram completamente suplantadas e desconsideradas pela chamada medicina tradicional, não existindo mais suas práticas e representações.
- C A Saúde Pública no Brasil teve como eixo formador a identificação das representações populares como nucleares em sua produção tecnológica, o que teria redundado numa perspectiva de cunho sempre popular, pouco afeita às influências advindas do campo médico e de instituições internacionais.
- D A Medicina no Brasil foi criada, a partir do século XIX, num contexto circular, sempre tendo em conta e sem conflitos, as dimensões do mundo popular, das cidades e das áreas rurais, criando tecnologias apropriadas no sentido de dar conta de todas as demandas nacionais, incluindo seus profissionais no mundo político e social do país.

4000110379

Questão 57 Política Nacional de Atenção Básica PNAB

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é importante dispositivo à organização do sistema de atenção à saúde no Brasil. Quais são seus objetivos?

- A Suprir a atenção básica com especialistas para ampliar a cobertura de casos complexos.
- B Incrementar e ampliar a referência e contra referência de casos.
- C Ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
- D Encaminhar os casos que necessitam atendimento especializado.

4000110343

Questão 58 Método SOAP

Josefa é uma mulher negra de 62 anos de idade que frequenta a unidade básica de saúde há muitos anos. Ela era acompanhada por diabetes e hipertensão arterial, ambas as condições com bom controle clínico. Há cerca de 10 dias, Josefa foi ao Pronto-Socorro devido um desmaio seguido de perda de força em braço e perna esquerdos. Foi encaminhada a hospital terciário, com hipótese de acidente vascular, encefálico (AVE). Esta hipótese diagnóstica foi confirmada com tomografia. Ela recebeu cuidados adequados e teve alta hospitalar, ainda com alguma perda de força em perna esquerda.

Hoje ela vem em consulta e traz os documentos que recebeu na alta hospitalar, além da prescrição medicamentosa:

Encaminhamento ao endocrinologista, por diabetes mellitus; Encaminhamento ao cardiologista, por hipertensão arterial sistêmica;

Encaminhamento ao fisioterapeuta, para reabilitação pós-AVE;

Retorno no neurologista do hospital em um mês;

Durante a consulta, Josefa mostra-se preocupada com o custo dos remédios prescritos no hospital e dificuldade de ir às consultas. Chora ao falar das suas dificuldades. Ela mora com uma filha e três netos. No momento, sua filha está desempregada e era Josefa quem trabalhava como diarista para pagar as contas. Um de seus netos está envolvido com drogas e álcool e isso preocupa muito Josefa. Tem irmãos que moram em cidades vizinhas, porém sem tanta proximidade, Josefa mora em uma viela no morro, e para chegar na sua casa é preciso subir uma escada estreita e íngreme. Hoje ela teve muita dificuldade de descer os degraus para ir a UBS.

O médico escuta Josefa, realiza exame clínico que constata hemiparesia desproporcionada à esquerda, com força muscular grau V em membro superior e grau III em membro inferior. O restante do exame clínico é normal. Conversa com Josefa e propõe seguir o tratamento da diabetes e hipertensão na própria UBS. Troca alguns medicamentos de sua prescrição por outros de mesmas classes disponíveis na UBS. escreve contra-referência para o hospital informando a troca de medicação e seguimento da hipertensão e diabetes na UBS, cancelando estes encaminhamentos. Planeja discutir o caso com equipe multidisciplinar para acionar o fisioterapeuta pensando na reabilitação de Josefa e assistente social para discutir indicação de benefícios aplicáveis. Por fim, combina retorno precoce com Josefa na UBS para conversar sobre a adaptação dela e da sua família a este novo ciclo de vida.

De acordo com a sistematização do registro clínico orientado a problemas (modelo SOAP), qual das opções abaixo apresenta em todos os campos itens corretamente registrados para esta consulta?

- A S: Preocupada com custo dos medicamentos / O: Hemiparesia / A: Acidente vascular encefálico / P: Discussão com equipe multidisciplinar.
- B S: Medo de doença / O: Diabetes e hipertensão / A: Acidente vascular encefálico / P: Retorno precoce para reavaliação.
- C S: Medo de doença / O: Hemiparesia / A: Divergência com especialista / P: Discussão com equipe multidisciplinar.
- D S: Preocupada com custo dos medicamentos / O: Diabetes e hipertensão / A: Divergência com especialista / P: Retorno precoce para reavaliação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110324](https://www.4000110324.com.br)

Questão 59 Princípios e Diretrizes do SUS a serem operacionalizados pela Atenção Básica Prevenção Quaternária

Josefa é uma mulher negra de 62 anos de idade que frequenta a unidade básica de saúde há muitos anos. Ela era acompanhada por diabetes e hipertensão arterial, ambas as condições com bom controle clínico. Há cerca de 10 dias, Josefa foi ao Pronto-Socorro devido um desmaio seguido de perda de força em braço e perna esquerdos. Foi encaminhada a hospital terciário, com hipótese de acidente vascular, encefálico (AVE). Esta hipótese diagnóstica foi confirmada com tomografia. Ela recebeu cuidados adequados e teve alta hospitalar, ainda com alguma perda de força em perna esquerda.

Hoje ela vêm em consulta e traz os documentos que recebeu na alta hospitalar, além da prescrição medicamentosa:

Encaminhamento ao endocrinologista, por diabetes mellitus; Encaminhamento ao cardiologista, por hipertensão arterial sistêmica;

Encaminhamento ao fisioterapeuta, para reabilitação pós-AVE;

Retorno no neurologista do hospital em um mês;

Durante a consulta, Josefa mostra-se preocupada com o custo dos remédios prescritos no hospital e dificuldade de ir às consultas. Chora ao falar das suas dificuldades. Ela mora com uma filha e três netos. No momento, sua filha está desempregada e era Josefa quem trabalhava como diarista para pagar as contas. Um de seus netos está envolvido com drogas e álcool e isso preocupa muito Josefa. Tem irmãos que moram em cidades vizinhas, porém sem tanta proximidade, Josefa mora em uma viela no morro, e para chegar na sua casa é preciso subir uma escada estreita e íngreme. Hoje ela teve muita dificuldade de descer os degraus para ir a UBS.

O médico escuta Josefa, realiza exame clínico que constata hemiparesia desproporcionada à esquerda, com força muscular grau V em membro superior e grau III em membro inferior. O restante do exame clínico é normal. Conversa com Josefa e propõe seguir o tratamento da diabetes e hipertensão na própria UBS. Troca alguns medicamentos de sua prescrição por outros de mesmas classes disponíveis na UBS. escreve contra-referência para o hospital informando a troca de medicação e seguimento da hipertensão e diabetes na UBS, cancelando estes encaminhamentos. Planeja discutir o caso com equipe multidisciplinar para acionar o fisioterapeuta pensando na reabilitação de Josefa e assistente social para discutir indicação de benefícios aplicáveis. Por fim, combina retorno precoce com Josefa na UBS para conversar sobre a adaptação dela e da sua família a este novo ciclo de vida.

Com relação ao cancelamento dos encaminhamentos para o endocrinologista e o cardiologista, realizados pelo médico da UBS, é correto afirmar:

- A Foi uma conduta correta, pois apesar de Josefa se beneficiar deste seguimento especializado, poderia reduzir o acesso de outros pacientes.
- B Foi uma conduta correta, pois se a paciente tinha bom controle clínico, não há necessidade atual para este seguimento especializado.
- C Foi uma conduta incorreta, pois a interferência na autonomia de prescrição de outro colega é infração prevista no Código de Ética Médica.
- D Foi uma conduta incorreta, pois não ir a essas consultas pode prejudicar o acompanhamento de Josefa com a equipe da neurologia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000110274

Questão 60 Método Clínico Centrado na Pessoa

Josefa é uma mulher negra de 62 anos de idade que frequenta a unidade básica de saúde há muitos anos. Ela era acompanhada por diabetes e hipertensão arterial, ambas as condições com bom controle clínico. Há cerca de 10 dias, Josefa foi ao Pronto-Socorro devido um desmaio seguido de perda de força em braço e perna esquerdos. Foi encaminhada a hospital terciário, com hipótese de acidente vascular, encefálico (AVE). Esta hipótese diagnóstica foi confirmada com tomografia. Ela recebeu cuidados adequados e teve alta hospitalar, ainda com alguma perda de força em perna esquerda.

Hoje ela vêm em consulta e traz os documentos que recebeu na alta hospitalar, além da prescrição medicamentosa:

Encaminhamento ao endocrinologista, por diabetes mellitus; Encaminhamento ao cardiologista, por hipertensão arterial sistêmica;

Encaminhamento ao fisioterapeuta, para reabilitação pós-AVE;

Retorno no neurologista do hospital em um mês;

Durante a consulta, Josefa mostra-se preocupada com o custo dos remédios prescritos no hospital e dificuldade de ir às consultas. Chora ao falar das suas dificuldades. Ela mora com uma filha e três netos. No momento, sua filha está desempregada e era Josefa quem trabalhava como diarista para pagar as contas. Um de seus netos está envolvido com drogas e álcool e isso preocupa muito Josefa. Tem irmãos que moram em cidades vizinhas, porém sem tanta proximidade, Josefa mora em uma viela no morro, e para chegar na sua casa é preciso subir uma escada estreita e íngreme. Hoje ela teve muita dificuldade de descer os degraus para ir a UBS.

O médico escuta Josefa, realiza exame clínico que constata hemiparesia desproporcionada à esquerda, com força muscular grau V em membro superior e grau III em membro inferior. O restante do exame clínico é normal. Conversa com Josefa e propõe seguir o tratamento da diabetes e hipertensão na própria UBS. Troca alguns medicamentos de sua prescrição por outros de mesmas classes disponíveis na UBS. escreve contra-referência para o hospital informando a troca de medicação e seguimento da hipertensão e diabetes na UBS, cancelando estes encaminhamentos. Planeja discutir o caso com equipe multidisciplinar para acionar o fisioterapeuta pensando na reabilitação de Josefa e assistente social para discutir indicação de benefícios aplicáveis. Por fim, combina retorno precoce com Josefa na UBS para conversar sobre a adaptação dela e da sua família a este novo ciclo de vida.

Qual dos componentes do método clínico centrado na pessoa foi mais acionado para abordar as dificuldades da Josefa com o uso da medicação?

- A Acolhimento e escuta qualificada.
- B Fortalecendo a relação entre a pessoa e o médico.
- C Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.
- D Entendendo a pessoa como um todo.

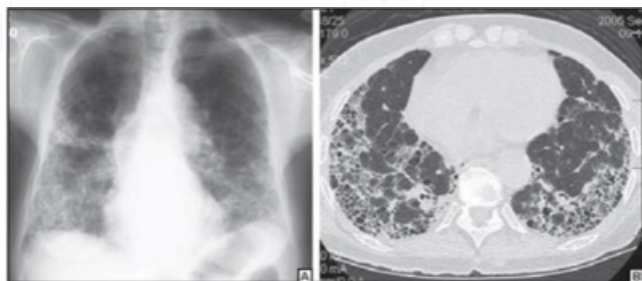
Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

4 000110213

Questão 61 Pneumopatia Intersticial Usual PIU Fibrose Pulmonar Idiopática FPI

Mulher de 69 anos de idade, natural e procedente de São Paulo é dentista. Tabagista de 20 maços-ano, apresenta dispneia e tosse seca há 2 anos, sem outras queixas. No exame clínico apresenta saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente e estertores em velcro bilaterais, sendo o restante do exame clínico normal. A radiografia e tomografia de tórax estão a seguir. A espirometria mostra VEF1 e CVF diminuídos com relação VEF1/CVF preservada.



Pulmão RJ 2006;15(4):212-218

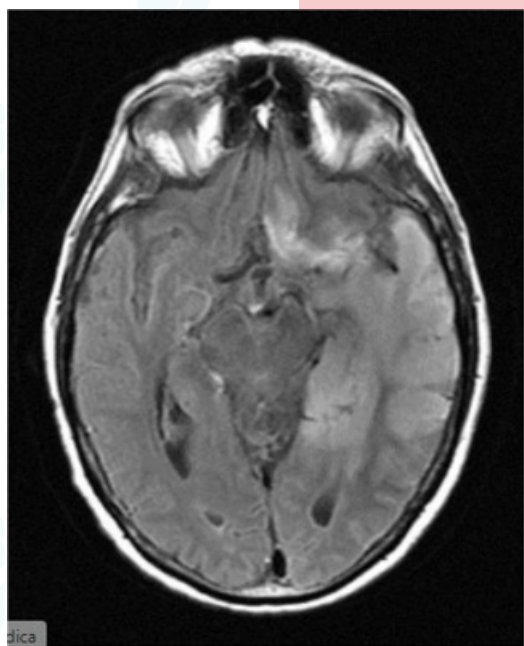
Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Fibrose intersticial pulmonar idiopática.
- B Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- C Pneumoconiose.
- D Tuberculose pulmonar.

4000110054

Questão 62 Diagnóstico

Mulher, 52 anos de idade, veio trazida ao Pronto-Socorro por queixa de cefaleia e uma crise tônico-clônica generalizada que ocorreu dois dias antes da admissão. Em seguida evoluiu com sonolência. Ao exame de admissão tem temperatura de 38°C, PA 100x60 mmHg, FC: 112bpm e restante do exame clínico geral sem alterações. No exame neurológico, encontrava-se sonolenta, com abertura ocular aos estímulos verbais vigorosos, retirada inespecífica dos membros à dor, falando palavras desconexas, reflexos profundos globalmente vivos e reflexo cutâneo plantar em flexão bilateral. Também foram observadas algumas clonias em hemiface direita. Tomografia computadorizada de crânio mostrou uma hipotenuação em lobo temporal esquerdo. Exames laboratoriais revelaram uma leucocitose de 13500 sem desvios à esquerda e um aumento da proteína C reativa. Foi então submetida a uma punção lombar para coleta de líquido cefalorraquidiano cujo resultado foi de 41 células (66% de linfócitos, 32% de monócitos e 2% de neutrófilos), 48 hemácias, proteína de 59 mg/dL, glicose de 64 mg/dL e lactato de 25 mg/dL.



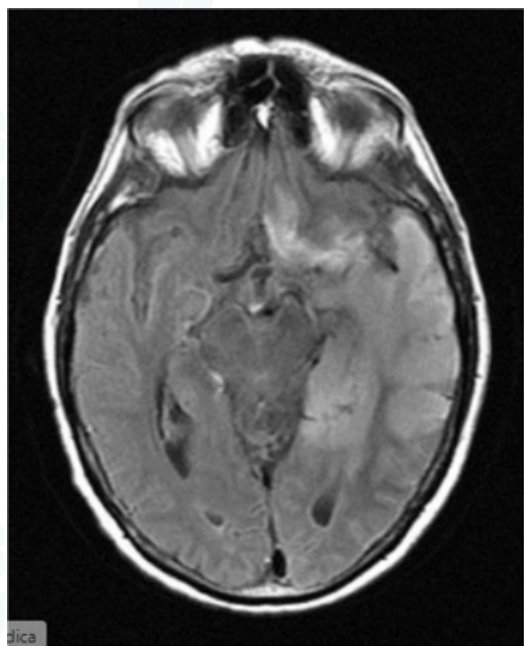
Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Meningoencefalite por tuberculose.
- B Meningoencefalite por HIV.
- C Meningoencefalite por herpes.
- D Meningoencefalite por linfoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000110019](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 63 Escala de Coma de Glasgow Neurologia

Mulher, 52 anos de idade, veio trazida ao Pronto-Socorro por queixa de cefaleia e uma crise tônico-clônica generalizada que ocorreu dois dias antes da admissão. Em seguida evoluiu com sonolência. Ao exame de admissão tem temperatura de 38°C, PA 100x60 mmHg, FC: 112bpm e restante do exame clínico geral sem alterações. No exame neurológico, encontrava-se sonolenta, com abertura ocular aos estímulos verbais vigorosos, retirada inespecífica dos membros à dor, falando palavras desconexas, reflexos profundos globalmente vivos e reflexo cutâneo plantar em flexão bilateral. Também foram observadas algumas clonias em hemiface direita. Tomografia computadorizada de crânio mostrou uma hipoatenuação em lobo temporal esquerdo. Exames laboratoriais revelaram uma leucocitose de 13500 sem desvios à esquerda e um aumento da proteína C reativa. Foi então submetida a uma punção lombar para coleta de líquido cujo resultado foi de 41 células (66% de linfócitos, 32% de monócitos e 2% de neutrófilos), 48 hemácias, proteína de 59 mg/dL, glicose de 64 mg/dL e lactato de 25 mg/dL.



Qual é a pontuação dessa paciente pela escala de coma de Glasgow?

- A 8.
- B 10.
- C 12.
- D 14.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109971](https://www.4000109971.com)

Questão 64 Síndromes Sensitivas

Mulher, de 23 anos de idade, procurou o Pronto-Socorro com a queixa de "sensação estranha de fraqueza nas pernas", também relata "uma sensação de aperto, como uma faixa apertada na altura do meu umbigo". Diz que percebeu os sintomas há três dias, que inicialmente eram muito leves mas que pioraram progressivamente. Quando indagada, acha que também notou algum tipo de dificuldade para controlar a micção. O exame clínico geral está normal. O exame neurológico mostra paresia crural direita (força muscular grau 4), perda da sensibilidade vibratória e anestésica no membro inferior direito, diminuição da percepção dolorosa e térmica em membro inferior esquerdo, sinal de Babinski à direita, os reflexos patelar e aquileu à direita estão exaltados.

Qual a topografia responsável pelos achados do exame neurológico?

- A Decussação das pirâmides.
- B Cauda equina.
- C Medula espinhal cervical à direita.
- D Medula torácica baixa à direita.

4000109866

Questão 65 Tratamento Sintomático Tratamento Profilático

Homem de 52 anos de idade, tabagista, apresenta há alguns anos crises de forte dor de cabeça que se concentram principalmente no olho esquerdo. A cefaleia aparece de 2 em 2 anos quase sempre nesta época do ano e permanece por cerca de 45 a 60 dias, a dor dura geralmente 1 hora e na maioria das vezes aparece durante a madrugada despertando-o: fica absolutamente "desesperado" quando sente a dor e tem vontade de "bater a cabeça na parede". Durante a dor apresenta vermelhidão no olho esquerdo e lacrimejamento intenso desse lado. As crises atuais começaram há 15 dias realizou uma tomografia durante um período de crises, que era normal.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, o que é correto afirmar?

- A Devemos prescrever Prednisona via oral durante 2 a 3 semanas.
- B Trata-se de uma cefaleia primária responsiva à Indometacina.
- C As crises intensas devem ser tratadas com Morfina endovenosa.
- D Anti depressivo tricíclico deve melhorar esse tipo de dor de cabeça.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000109842

Questão 66 Gastroenterologia Hérnias Hiatais

Mulher de 60 anos de idade refere dor epigástrica, tosse e náuseas após as refeições há cerca de 1 ano. Realizou uma radiografia de tórax com a imagem abaixo:



Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Neoplasia esofágica.
- B Abscesso pulmonar.
- C Hérnia gástrica hiatal.
- D Tuberculose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109810](#)

Questão 67 Antipsicóticos

Paciente jovem apresentando quadro psicótico de início agudo, há dois dias foi levado ao Pronto-Socorro em estado de agitação psicomotora. Recebeu uma dose de haloperidol IM e saiu com prescrição de haloperidol 10 mg/dia por via oral. Atualmente está com piora da agitação. Não consegue se manter sentado durante a entrevista, fica em pé balançando o corpo de um lado para o outro e esfrega as mãos com uma fisionomia angustiada. Qual é a conduta?

- A Aumentar a dose do antipsicótico.
- B Administrar benzodiazepínico e substituir antipsicótico.
- C Associar medicação anticolinérgica.
- D Suspender antipsicótico e fazer eletroconvulsoterapia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109783](#)

Questão 68 Retinopatia Diabética

Dentre as alternativas abaixo, quais são as alterações mais precoces encontrados na retinopatia diabética?

- A Ingurgitamento venoso.
- B Exsudatos duros.
- C Micro-hemorragias.
- D Microaneurismas.

4000109744

Questão 69 Manifestações clínicas Diagnóstico Artrite reativa

Homem de 27 anos de idade apresenta quadro de artropatia inflamatória de membros inferiores, associada às alterações de exame clínico mostradas a seguir.



Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é a manifestação ocular mais comum?

- A Conjuntivite.
- B Irite.
- C Ceratite.
- D Neurite.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109723](https://www.studocu.com/pt-br/document/universidade-federal-de-pernambuco/medicina/4000109723)

Questão 70 Tratamento Artrite gonocócica

Homem de 35 anos de idade procurou serviço de emergência por dor em joelho esquerdo há 1 dia. Refere febre e dificuldade à deambulação pela dor. Refere episódios esporádicos de dor lombar, principalmente no fim da tarde. Nega tabagismo, etilismo, uso de drogas e tem vida sexual ativa. Sem outras queixas anteriores. Ao exame: bom estado geral, corado, hidratado, temperatura 38°C, PA 120x80mmHg, FC 100bpm, FR 24ipm, pulsos radiais palpáveis e simétricos. Joelho esquerdo com calor, edema e limitação da amplitude de movimento, sem hiperemia. Sem outras alterações do restante do exame clínico. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual deve ser o tratamento inicial?

- A Alopurinol.
- B Colchicina.
- C Prednisona.
- D Ceftriaxone.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109664](https://www.studocu.com/pt-br/document/universidade-federal-de-pernambuco/medicina/4000109664)

Questão 71 Diagnósticos diferenciais

Homem de 42 anos de idade com antecedente de hipertensão arterial, apresenta dor lombar crônica há cinco anos, após levantar peso no ambiente de trabalho. No episódio inicial apresentou dor intensa e súbita associada à limitação de movimentos que levou a afastamento do trabalho por um período de 10 dias. Voltou a trabalhar, porém, manteve dor lombar contínua, de intensidade leve a moderada com irradiação para ambas as coxas de forma difusa e piora com esforços. Vários períodos de afastamento laboral desde então, sempre com manutenção das queixas. Há 6 meses refere dor moderada a intensa com irradiação para ambos os membros inferiores e grande limitação para atividades diárias sem qualquer melhora

com uso de anti-inflamatórios ou analgésicos. Faz uso eventual de tramadol, porém nega melhora significativa. Nega febre ou perda de peso. O exame clínico é normal exceto por dor à flexão e extensão lombar. O exame neurológico é normal. Paciente traz exame de ressonância magnética realizado há 2 meses com desidratação discal L4-L5 e L5-S1. Discretas protrusões discais nestes níveis sem conflito radicular.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Lombalgia mecânica comum.
- B Estenose do canal lombar.
- C Espondilite anquilosante.
- D Hérnia discal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109646](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 72 Introdução Diagnóstico

Mulher de 21 anos de idade procura o ambulatório por queixa de astenia e sonolência. Refere que suas menstruações ocorrem em ciclos regulares a cada 30 dias, com duração média de 10 dias e fluxo abundante. Refere que este padrão se mantém desde a menarca, que ocorreu aos 13 anos de idade. Exame clínico normal, exceto por palidez 2+/4+. Exames laboratoriais:

	Resultado
Hemoglobina	7,9 g/dl
Hematócrito	25,3%
VCM	70,1 fl
HCM	22,7 pg
CHCM	25,3 g/dl
RDW	17,6
Leucócitos Totais	4790/mm ³
Neutrófilos	2760/mm ³
Linfócitos	1340/mm ³
Eosinófilos	200/mm ³
Basófilos	100/mm ³
Monócitos	390/mm ³
Plaquetas	590000/mm ³
Reticulócitos	0,5%
Tempo de Protrombina (TP)	92%
Tempo de Trombina (TT)	16 segundos
TTPa (relação)	1,42

Quanto à alteração no coagulograma, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Deficiência do fator VIII.
- B Doença de Von Willebrand.
- C Deficiência do fator XI.
- D Trombastenia de Glanzmann.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109627](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 73 **Transtornos de Personalidade** **Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva Anancástica**

Um estudante de direito de 28 anos é admitido no hospital por acidente automobilístico sem traumatismo craniano. Ele se mostra obstinado e rígido, exigindo que a equipe faça as coisas à sua maneira, mantendo suas tarefas acadêmicas no computador. Fala que sua namorada ameaçou deixá-lo caso ele continue com sua forma inflexível de ser e não jogue fora coisas inúteis que costuma armazenar. Qual a principal hipótese diagnóstica quanto ao tipo de transtorno de personalidade?

- ☐ A Antissocial.
- ☐ B Evitador.
- ☐ C Histriônico.
- ☐ D Obsessivo-compulsivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109588](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 74 **Imunodeficiências primárias** **Imunodeficiências celulares ou de células T**
Imunodeficiências combinadas

Mulher de 38 anos de idade refere quadros de infecções de vias aéreas superiores recorrentes há cinco anos. Está sempre com secreção nasal espessa amarelada e utiliza antibióticos frequentemente. Nos últimos dois anos também apresentou duas pneumonias documentadas e tratadas com antibióticos. Há seis meses com diarreia crônica, tendo perdido sete quilos. Ao exame clínico apresenta-se emagrecida e com linfadenopatia cervical indolor. Traz consigo sorologia para o vírus HIV que é negativa.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- ☐ A Doença Granulomatosa Crônica.
- ☐ B Neutropenia cíclica de início tardio.
- ☐ C Imunodeficiência Comum Variável.
- ☐ D Deficiência do fator C4.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000109570

Questão 75 **Hanseníase tuberculoide**

Homem de 36 anos de idade apresenta há 9 meses placa eritemato-infiltrada, com borda elevada, ovalada, de 6 cm, anestésica, no braço esquerdo. O exame histopatológico da lesão mostrou dermatite granulomatosa não-caseosa, com células gigantes tipo Langhans e infiltrado linfo-plasmocitário perivascular, perianexial e ao redor de filetes nervosos, pesquisa de BAAR negativa. O teste de Mitsuda foi positivo. Qual o diagnóstico?

- ☐ A Hanseníase indeterminada.
- ☐ B Hanseníase wirchowiana.
- ☐ C Micobacteriose atípica.
- ☐ D Hanseníase tuberculoide.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109548](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 76 **Psoríase** **Diagnóstico e avaliação de gravidade** **Artrite psoriásica**

Mulher, 45 anos de idade, apresenta há 8 anos lesões eritematosas e descamativas, bem delimitadas, com eritema vermelho vivo e escamas branco prateadas aderentes e esparsas no couro cabeludo, região sacral, cotovelos e joelhos. Sinal da vela e do orvalho sangrento estão presentes. Apresenta história de monoartrite de articulação interfalangeana proximal no 3º quirodáctilo direito.

Qual é o diagnóstico?

- A Lúpus eritematoso cutâneo crônico.
- B Psoríase.
- C Artrite reumatoide.
- D Dermatite seborreica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109527](https://www.4000109527.com)

Questão 77 Diagnóstico eletrocardiografico do IAMCSST

Homem de 68 anos de idade, fumante 30 maços-ano, tem doença renal crônica em programação de diálise. Chega em Pronto-Socorro com história de mal-estar e náuseas há 40 minutos. Apresenta PA 150x100 mmHg, sem outras alterações do exame clínico. Feito o eletrocardiograma a seguir.



Qual é o diagnóstico?

- A Infarto agudo do miocárdio.
- B Hipercalcemia.
- C Hipercalcemia.
- D Bloqueio de ramo esquerdo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109503](https://www.4000109503.com)

Questão 78 Distúrbios da condução atrioventricular Cardiologia

Homem de 55 anos de idade, hipertenso e com antecedente de angina estável, em uso de anlodipina, AAS, carvedilol e enalapril. Hoje queixa-se de fraqueza e tontura. Exame clínico bradicárdico sem outras alterações. Feito o eletrocardiograma a seguir.



Qual é o diagnóstico?

- A BAV total.
- B Bradicardia sinusal.
- C BAV de segundo grau.
- D BAV de primeiro grau.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109480](https://www.4000109480.com.br)

Questão 79 Peritonite bacteriana espontânea PBE Tratamento

Homem, 46 anos de idade, etilista há mais de 20 anos, em tratamento irregular para hipertensão arterial e cirrose hepática de etiologia alcoólica, procura o Pronto-Socorro queixando-se de desconforto, aumento do volume abdominal e inapetência há cerca de 1 semana. Nega febre, nega trauma ou sangramentos. Está evacuando 2x ao dia, com uso regular de laxativos. Ao exame clínico: Regular estado geral, desidratado +2/+4, vigil, calmo e colaborativo. PA=100x60mmHg; FC=108 bpm; FR=20rpm; abdome distendido, com maciez móvel presente, indolor à palpação profunda ou à descompressão brusca. Semiologias pulmonar e cardíaca sem alterações. Membros inferiores com edema +2/+4. Optou-se pela realização de uma paracentese diagnóstica, que encontrou a albumina de 0,5g/dL e 460 células/mm³ (80% de polimorfonucleares e 20% de mononucleares). O resultado da bacterioscopia com coloração de Gram foi ausente e a cultura do líquido ascítico está em análise. Exames laboratoriais séricos demonstram: Albumina = 2,5 g/dL; U=120 mg/dl; Cr=1,8 mg/dl; Na⁺ 128 mEq/l; K⁺ 3,2 mEq/L; Cálcio iônico= 1,20 mmol/l; Fósforo = 2,9mg/dL; urina tipo 1 normal; Hemograma com Hb=11,1 g/dl com VCM= 105 fl, Leucócitos=10.850/mm³ (diferencial normal); plaquetas=98.000/mm³.

Qual das alternativas a seguir traz elementos que devem ser incluídos na prescrição deste paciente?

- A Furosemida e suplementação de potássio.
- B Furosemida e lactulose.
- C Expansão volêmica e vancomicina.
- D Expansão volêmica e ceftriaxone.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109453](https://www.4000109453.com.br)

Questão 80 Rastreamento Indicações de rastreio da osteoporose Confirmação Diagnóstica

Mulher de 67 anos de idade, cozinheira, vem para consulta, com demanda de prevenção de doenças e promoção da saúde. Nega doenças prévias. É tabagista 30 maços-ano e tem hábitos sedentários. Nega etilismo ou uso de drogas ilícitas.

Ao exame clínico: dentes em mal estado de conservação, IMC= 32kg/m², circunferência abdominal 108 cm, PA= 136x70 mmHg, frequência cardíaca= 76bpm, sem outras alterações.

Dentre as alternativas abaixo, qual delas apresenta dois exames que devem ser solicitados para esta paciente?

- A Densitometria óssea e colesterol total e frações.
- B Mamografia e angiotomografia de coronárias.
- C Ultrassonografia de abdome e glicemia de jejum.
- D Pesquisa de sangue oculto nas fezes e teste ergométrico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109433](https://www.4000109433.com.br)

Questão 81 Corioamnionite

Sr.^a AS, secundigesta com 32 semanas de gravidez, com 1 parto vaginal há 3 anos, vem ao pronto atendimento com queixa de corrimento de odor fétido há 6 dias, inicialmente em pequena quantidade, hoje chegou a molhar a roupa. Ao exame clínico, bom estado geral afebril, FC114, PA 10x7, altura uterina 27 cm, BCF 162, dinâmica uterina 3 contrações fracas em 10 minutos. Forro vaginal úmido. Aspecto de forro vaginal e de exame especular abaixo. Colo médio, 2cm de dilatação.



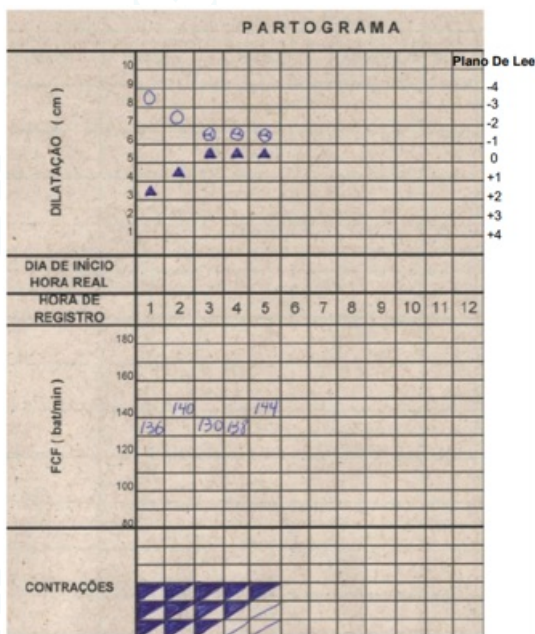
Qual deve ser a conduta obstétrica?

- A Inibição do trabalho de parto.
- B Indução de parto.
- C Realização de cerclagem do colo.
- D Tratamento antimicrobiano vaginal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109416](https://www.4000109416.com.br)

Questão 82 Parada secundária da dilatação

O partograma abaixo caracteriza:



- A Fase de latência.
- B Vício pélvico.
- C Distocia funcional.
- D Expulsivo prolongado.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109344](https://www.4000109344.com)

Questão 83 Cálculo da idade gestacional pela ultrassonografia IG USG

Paciente de 16 anos de idade procura o serviço de saúde preocupada porque acha que a barriga está pequena e não sente o bebê mexer ainda. Não iniciou pré-natal por medo de contar para os pais da gravidez, não se lembra da data da última menstruação, mas acha que está com 7 meses (lembra de ter sangrado em maio). Nega doenças, refere uso eventual de maconha e cigarro. Ao exame obstétrico, altura uterina 22cm, BCF presente e rítmico ao sonar, especular sem alterações, toque vaginal com colo amolecido, grosso e impérvio. Realizada ultrassonografia obstétrica, com peso fetal estimado de 650g e índice de líquido amniótico de 10cm, biometria compatível com 24 semanas.

A orientação para a paciente é de que:

- A A datação da gravidez é de 24 semanas, seguir pré-natal normal.
- B Realizar dopplervelocimetria de artérias uterinas.
- C É necessário repetir a ultrassonografia em 14 a 21 dias para confirmar a datação.
- D Realizar amniocentese e cariótipo fetal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109329](https://www.4000109329.com)

Questão 84 Particularidades no puerpério

Paciente com diagnóstico pré-natal de diabetes gestacional realizado no teste de tolerância á glicose com 26 semanas, controlada com insulina NPH e regular.

No pós-parto imediato a prescrição deve contemplar:

- A Dieta geral e suspensão da terapêutica hipoglicemiante, sem controle de glicemia.
- B Dieta para diabetes, manter insulina, controle de glicemia capilar às refeições.
- C Dieta para diabetes, suspensão da terapêutica hipoglicemiante, glicemia às refeições.
- D Dieta geral, iniciar hipoglicemiante oral, controle de glicemia capilar às refeições.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109307](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 85 Trabalho de parto prematuro TPP

Quartigesta com 3 partos vaginais anteriores, 28 semanas de gravidez, vem ao pronto atendimento com queixa de dor em hipogástrio há 3 horas. Nega sangramento e refere secreção vaginal aumentada. Ao exame, bom estado geral, normotensa, afebril. Abdômen gravídico, normotônico, 2 contrações fracas em 10 minutos, BCF presente rítmico 140bpm. Especular com secreção bolhosa amarela fluida abundante, toque vaginal com colo amolecido, grosso, entreaberto.

Qual é a conduta recomendada neste momento?

- A Nifedipina.
- B Metronidazol.
- C Betametasona.
- D Progesterona.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109288](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 86 Conduta Interpretação

Gestante, 32 anos de idade, secundigesta com uma cesárea anterior, 40 semanas e 2 dias de gravidez. Refere contrações irregulares e redução de movimentação fetal há 1 dia. Ao exame clínico, bom estado geral, corada, PA 120x70mmHg, altura uterina 30 cm, BCF presente rítmico. Toque vaginal com colo grosso, posterior, impérvio. Vitalidade fetal: tônus adequado, movimentação corpórea e respiratória presentes, índice de líquido amniótico de 4,2 cm. Cardiotocografia apresentada.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre



Qual é a conduta adequada neste momento?

- A Controlar a vitalidade fetal em 2 dias.
- B Preparar o colo com prostaglandina.
- C Indicar parto de imediato por via alta.
- D Realizar hidratação materna e reavaliação.

Questão 87 Conduta

Primigesta, 27 anos de idade, vem para iniciar pré-natal. É hipertensa crônica diagnosticada aos 22 anos de idade, fez uso de enalapril por 3 anos e, após mudança de hábitos de vida, suspendeu o tratamento medicamentoso. Tem diabetes tipo 2, usava metformina antes de engravidar que também suspendeu. Idade gestacional de 9 semanas, assintomática. Ao exame clínico inicial, apresenta pressão arterial de 166x102mmHg, confirmada em segunda ocasião.

Nesse momento, qual é a conduta com relação à pressão arterial?

- A Tratamento medicamentoso ambulatorial.
- B Tratamento endovenoso em regime de internação.
- C Sulfato de magnésio em regime de urgência.
- D Não há necessidade de tratamento pressórico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000109191

Questão 88 Antecedentes obstétricos Etiologia e Prevenção

Paciente com 1 filho vivo, deseja engravidar novamente e vem para aconselhamento pré-concepcional. Traz a foto do primeiro filho, quando recém-nascido:



Qual é a orientação específica relacionada a esse quadro?

- A Aconselhamento genético com cariótipo do casal.
- B Sorologias para citomegalovírus, toxoplasmose, herpes.
- C Pesquisa da mutação da metilenotetraidrofolato redutase.
- D Suplementação pré-concepcional de ácido fólico.

4000109178

Questão 89 Prevenção e manejo dos principais problemas relacionados à amamentação Pediatria

Paciente de 34 anos de idade, no segundo dia pós-parto normal, recém-nascido de termo e adequado para a idade gestacional. Refere muita dor mamilar à sucção da criança e pede orientação para a amamentação.

Entre as figuras abaixo, qual das situações está relacionada com a queixa da paciente?

A)



B)



C)



D)



A A

B B

C C

D D



4000109125

Paciente secundigesta com 9 semanas de gravidez pela data da última menstruação, refere cólica abdominal de forte intensidade e sangramento vaginal volumoso e espontâneo. Ao exame especular, moderada quantidade de sangue em fundo de saco posterior, com sangramento ativo. Toque vaginal com colo pérvio para 2 cm.

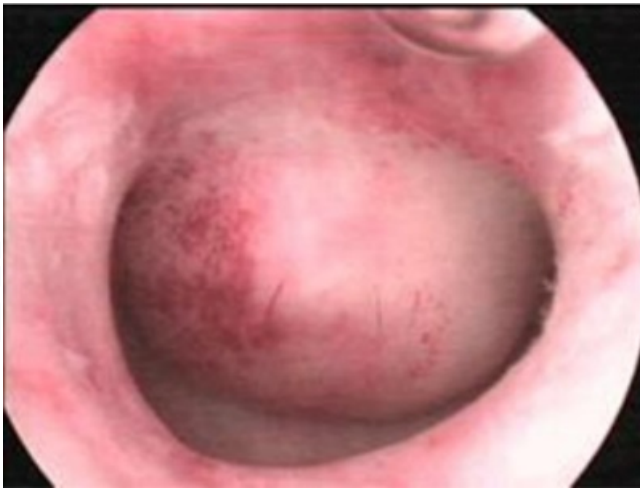
Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Abortamento retido.
- B Gestação incipiente.
- C Abortamento inevitável.
- D Incompetência cervical.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109059](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000109059)

Questão 91 Etiologia Exames complementares Quadro clínico

Paciente de 40 anos apresenta sangramento menstrual excessivo com o seguinte achado histeroscópico:



Qual é o tratamento mais adequado?

- A Dispositivo intrauterino com progesterona.
- B Ácido tranexâmico.
- C Embolização.
- D Ablação histeroscópica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109045](https://www.studocu.com/pt-br/doc/4000109045)

Questão 92 Tratamento adjuvante

Paciente de 45 anos e diagnóstico de câncer de mama esquerda, foi submetida a quadrantectomia e pesquisa de linfonodo sentinela. O estadiamento pós-cirúrgico foi T1; N0; M0. O exame anatomopatológico revelou carcinoma ductal invasor sem expressão para receptor de estrogênio, progesterona e HER-2.

Qual é o tratamento adjuvante mais adequado?

- A Modulador seletivo de receptor estrogênio.
- B Quimioterapia com antraciclina.
- C Inibidor de aromatase.
- D Bloqueador de receptor c-erb-2.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109016](#)

Questão 93 Indução de ovulação

Paciente de 34 anos apresenta ciclos menstruais com intervalos longos, próximo a 40 dias, acne moderada e IMC de 28. Nuligesta, tenta engravidar há 1 ano, sem sucesso. Opta-se por induzir sua ovulação com inibidor de aromatase no início do ciclo menstrual.

Qual a ação deste medicamento associada à maior fertilização?

- A Liberar o folículo antral.
- B Diminuir a produção de prolactina da adeno-hipófise.
- C Reduzir a produção estrogênica ovariana e periférica.
- D Aumentar o feedback positivo estrogênico hipotalâmico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000109000](#)

Questão 94 Tumores ovarianos benignos

Paciente de 23 anos, vida sexual com uso de preservativo, ciclos menstruais regulares. Realiza exame ginecológico com achado de tumoração anexial direita, móvel e indolor. Exame ultrassonográfico complementar identifica tumoração ovariana de 6 cm compatível com diagnóstico de teratoma.

A ooforoplastia direita prevenirá qual das seguintes explicações?

- A Degeneração maligna.
- B Sangramento.
- C Infertilidade.
- D Torção.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108983](#)

Questão 95 Riscos Benefícios

Paciente de 42 anos apresenta falência ovariana prematura. Apresenta calores e sudorese noturnos, além de dispareunia. Qual das situações abaixo está associada com a terapia de reposição estrogênica?

- A Menor risco de doença cardíco-vascular.
- B Aumento de risco de câncer de cólon.
- C Redução de risco para câncer de ovário.
- D Maior risco para câncer de endométrio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108965](https://www.4000108965.com)

Questão 96 Herpes genital

Paciente de 40 anos refere dor vulvar intensa há 2 dias, com o seguinte achado clínico:



Qual é o tratamento adequado?

- A Ceftriaxone.
- B Valaciclovir.
- C Clotrimazol.
- D Penicilina.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108951](https://www.4000108951.com)

Questão 97 Indicações Benefícios

Paciente de 60 anos, menopausa há 7 anos, sem uso de terapia hormonal apresenta queixa de corrimento em pequena quantidade, acinzentado, com odor pronunciado e os seguintes achados: - pH vaginal 6.0; - teste de hidróxido de potássio positivo; - ausência de "clue cells" (esfregaço vaginal); - presença de células basais em grande quantidade (esfregaço vaginal). Qual é o tratamento tópico vaginal mais adequado?

- A Clotrimazol.
- B Metronidazol.
- C Gestrinona.
- D Estrogênio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108925](#)

Questão 98 Efeitos adversos

Paciente de 19 anos, sem antecedentes clínicos significativos, nuligesta, inicia contraceptivo hormonal oral combinado com cartela de 24 dias e pausa de 4 dias. Faz uso regular e perfeito do contraceptivo. Após 5 meses de uso, não apresenta sangramento de privação no intervalo de 4 dias após o término da cartela habitual.

Qual é a condição mais provavelmente associada a esta amenorreia?

- A Atrofia endometrial.
- B Gravidez.
- C Hiperprolactinemia.
- D Bloqueio eixo hipotálamo-hipófise.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108906](#)

Questão 99 Slings

Paciente de 45 anos refere perda de urina aos esforços. Apresenta ciclos menstruais regulares e antecedente de 2 partos vaginais assistidos e sem complicações, sendo o último há 9 anos. Ao exame ginecológico observa-se cistocele e retoccele moderadas e perda objetiva de urina em manobra de esforço. A cirurgia indicada é correção da incontinência urinária através de faixa/tela tipo "sling" transobturatório.

Qual é o princípio de correção da incontinência urinária do procedimento cirúrgico citado?

- A Correção da cistocele
- B Reforço do esfíncter uretral
- C Apoio suburetral
- D Reconstrução da fásia endopélvica

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108881](#)

Questão 100 Tratamento

Paciente de 21 anos com dor abdominal em hipogástrio e fossas ilíacas há 2 dias, com piora progressiva e febre medida de 38°C. Ao exame ginecológico apresenta conteúdo vaginal acinzentado e bolhoso; ao toque vaginal apresenta dor à mobilização do colo uterino e aumento anexial direito de difícil caracterização em decorrência da dor. Inicia tratamento com ceftriaxone intramuscular e doxiciclina oral.

Qual é o agente antimicrobiano que deve ser associado?

- A Metronidazol.
- B Amoxicilina.
- C Ciprofloxacino.
- D Eritromicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000108854](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 101 Câncer Colorretal

Homem, 64 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência devido a obstrução intestinal. Foi realizada radiografia digital que evidenciou ponto de obstrução na transição retossigmoideana. Trata-se de paciente obeso (IMC 31kg/m²) com diabetes melito, dislipidemia e hipertensão arterial controlada, sem disfunções orgânicas na admissão no serviço de emergência. Foram realizados os seguintes exames pré-operatórios, demonstrados na tabela a seguir. O achado intraoperatório foi de neoplasia de reto alto, sem outras lesões na cavidade abdominal. Foi realizada retossigmoidectomia à Hartmann (colostomia terminal e sepultamento do reto) com linfadenectomia e o ato operatório transcorreu sem intercorrências técnicas, porém durante a operação foi iniciado noradrenalina devido a hipotensão arterial. Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no oitavo dia de pós-operatório. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado com estadiamento TNM: pT3N1M0 (1 linfonodo comprometido de 21) O paciente está em programação de reconstrução de trânsito intestinal e passou em avaliação pré-operatória com o clínico que o liberou para o procedimento operatório.

Tabela: exames	
Hemoglobina	12,5g/dL
Leucograma	13,54 mil/mm ³
Albumina	3,8 g/dL
Creatinina	1,4 mg/dL
Ureia	61 mg/dL
Sódio	141 mEq/L
Potássio	3,9mEq/L



figura: imagem de radiografia

Acesse t.me/medicinalivre

Além da avaliação pré-operatória, cujos exames já foram realizados, cite quatro exames fundamentais a serem realizados para a reconstrução do trânsito intestinal.

4000100360

Questão 102 Tratamento Adjuvante

Homem, 64 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência devido a obstrução intestinal. Foi realizada radiografia digital que evidenciou ponto de obstrução na transição retossigmoideana. Trata-se de paciente obeso (IMC 31kg/m²) com diabetes melito, dislipidemia e hipertensão arterial controlada, sem disfunções orgânicas na admissão no serviço de emergência. Foram realizados os seguintes exames pré-operatórios, demonstrados na tabela a seguir. O achado intraoperatório foi de neoplasia de reto alto, sem outras lesões na cavidade abdominal. Foi realizada retossigmoidectomia à Hartmann (colostomia terminal e sepultamento do reto) com linfadenectomia e o ato operatório transcorreu sem intercorrências técnicas, porém durante a operação foi iniciado noradrenalina devido a hipotensão arterial. Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no oitavo dia de pós-operatório. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado com estadiamento TNM: pT3N1M0 (1 linfonodo comprometido de 21) A cirurgia foi oncológica adequada e o estadiamento anátomo patológico foi apresentado.

Tabela: exames	
Hemoglobina	12,5g/dL
Leucograma	13,54 mil/mm ³
Albumina	3,8 g/dL
Creatinina	1,4 mg/dL
Ureia	61 mg/dL
Sódio	141 mEq/L
Potássio	3,9mEq/L



figura: imagem de radiografia

Há necessidade de tratamento adjuvante? Caso afirmativo, qual? Caso negativo, justifique.

4000100346

Questão 103 Tratamento Cirúrgico

Homem, 64 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência devido a obstrução intestinal. Foi realizada radiografia digital que evidenciou ponto de obstrução na transição retossigmoideana. Trata-se de paciente obeso (IMC 31kg/m²) com diabetes melito, dislipidemia e hipertensão arterial controlada, sem disfunções orgânicas na admissão no serviço de emergência. Foram realizados os seguintes exames pré-operatórios, demonstrados na tabela a seguir. O achado intraoperatório foi de neoplasia de reto alto, sem outras lesões na cavidade abdominal. Foi realizada retossigmoidectomia à Hartmann (colostomia terminal e sepultamento do reto) com linfadenectomia e o ato operatório transcorreu sem intercorrências técnicas, porém durante a operação foi iniciado noradrenalina devido a hipotensão arterial. Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no oitavo dia de pós-operatório. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado com estadiamento TNM: pT3N1M0 (1 linfonodo comprometido de 21)

Tabela: exames	
Hemoglobina	12,5g/dL
Leucograma	13,54 mil/mm ³
Albumina	3,8 g/dL
Creatinina	1,4 mg/dL
Ureia	61 mg/dL
Sódio	141 mEq/L
Potássio	3,9mEq/L



figura: imagem de radiografia

Qual deve ser o tempo mínimo esperado para realizar a operação de reconstrução do trânsito intestinal?

4000100329

Questão 104 Tratamento do Câncer Retal

Homem, 64 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência devido a obstrução intestinal. Foi realizada radiografia digital que evidenciou ponto de obstrução na transição retossigmoideana. Trata-se de paciente obeso (IMC 31kg/m²) com diabetes melito, dislipidemia e hipertensão arterial controlada, sem disfunções orgânicas na admissão no serviço de emergência. Foram realizados os seguintes exames pré-operatórios, demonstrados na tabela a seguir. O achado intraoperatório foi de neoplasia de reto alto, sem outras lesões na cavidade abdominal. Foi realizada retossigmoidectomia à Hartmann (colostomia terminal e sepultamento do reto) com linfadenectomia e o ato operatório transcorreu sem intercorrências técnicas, porém durante a operação foi iniciado noradrenalina devido a hipotensão arterial. Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no oitavo dia de pós-operatório. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma

moderadamente diferenciado com estadiamento TNM: pT3N1M0 (1 linfonodo comprometido de 21)

Tabela: exames	
Hemoglobina	12,5g/dL
Leucograma	13.54 mil/mm ³
Albumina	3,8 g/dL
Creatinina	1,4 mg/dL
Ureia	61 mg/dL
Sódio	141 mEq/L
Potássio	3,9mEq/L



figura: imagem de radiografia

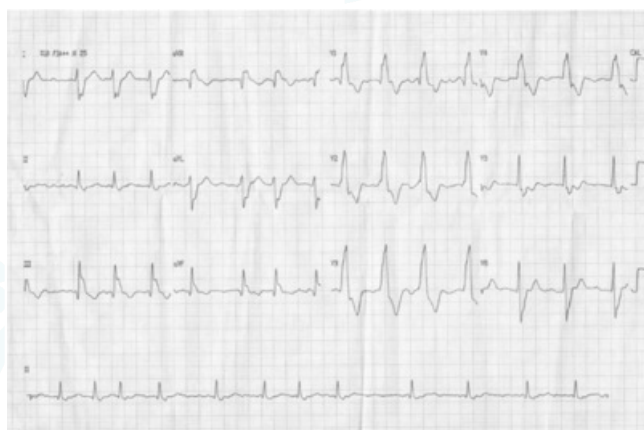
Cite duas justificativas para realização de colostomia na operação realizada neste paciente.

4000100315

Questão 105 **Medicações usadas para controle da frequência cardíaca** **Cardiologia** **Abordagem terapêutica**

Mulher de 67 anos de idade está em acompanhamento ambulatorial por hipertensão (diagnosticada há 20 anos) e insuficiência cardíaca (diagnosticada há 5 anos). Faz dieta hipossódica e está em uso regular de captopril 150 mg/dia e carvedilol 25 mg/dia (ou seja, ambos em dose máxima) há mais de dois anos. Na última consulta realizada há três meses, estava assintomática. O exame clínico era normal (com PA controlada), e havia trazido resultado de ecocardiograma no qual se evidenciavam: fração de ejeção de 37%; aumento moderado de ventrículo e átrio esquerdos; ausência de valvopatias; ausência de alterações segmentares da motricidade ventricular. Procura o Pronto-Socorro com queixa de piora da dispneia há 10 dias, atualmente ocorrendo aos médios esforços. Nega chiado, tosse ou dor torácica. Ao ser ativamente questionada, refere palpitação eventual nos últimos 15 dias, com último episódio há três dias. No exame clínico apresenta-se com P=118 bpm, arritmico, PA=126x72 mmHg, FR=18 ipm, T=36,5°C. Ausculta cardíaca com bulhas arritmicas em dois tempos sem sopros. Semiologia pulmonar com murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, com estertores finos na metade inferior de ambos os hemitóraxes. Membros inferiores com edema depressível 2+/4+ bilateralmente. O restante do exame clínico é normal. São realizados os exames complementares a seguir. Ecocardiograma transesofágico com presença de trombo em parede atrial esquerda.

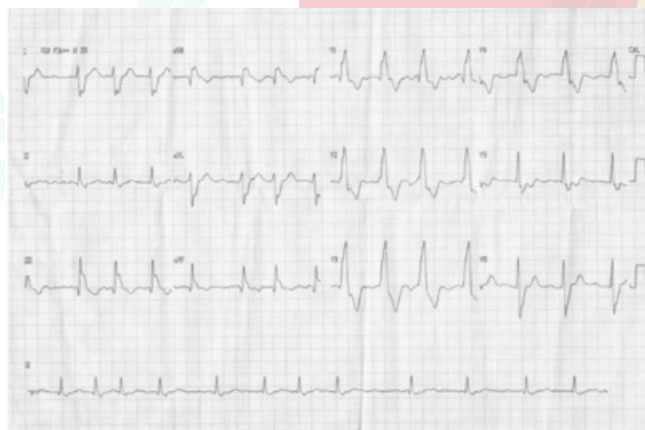
Sódio: 142 mEq/L	VCM: 90 fl
Potássio: 4,3 mEq/L	HCM: 30 pg
Ureia: 30 mg/dl	Leucócitos: 8.700/mm ³
Creatinina: 0,8 mg/dl	Plaquetas: 310.000/mm ³
Hb: 14,1 g/dl	TTPA (R): 1,05
Ht: 43%	TP (INR): 1,02



Questão 106 **Cardiologia** **Abordagem terapêutica**

Mulher de 67 anos de idade está em acompanhamento ambulatorial por hipertensão (diagnosticada há 20 anos) e insuficiência cardíaca (diagnosticada há 5 anos). Faz dieta hipossódica e está em uso regular de captopril 150 mg/dia e carvedilol 25 mg/dia (ou seja, ambos em dose máxima) há mais de dois anos. Na última consulta realizada há três meses, estava assintomática. O exame clínico era normal (com PA controlada), e havia trazido resultado de ecocardiograma no qual se evidenciavam: fração de ejeção de 37%; aumento moderado de ventrículo e átrio esquerdos; ausência de valvopatias; ausência de alterações segmentares da motricidade ventricular. Procura o Pronto-Socorro com queixa de piora da dispneia há 10 dias, atualmente ocorrendo aos médios esforços. Nega chiado, tosse ou dor torácica. Ao ser ativamente questionada, refere palpitação eventual nos últimos 15 dias, com último episódio há três dias. No exame clínico apresenta-se com P=118 bpm, arritmico, PA=126x72 mmHg, FR=18 ipm, T=36,5°C. Ausculta cardíaca com bulhas arritmicas em dois tempos sem sopros. Semiologia pulmonar com murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, com estertores finos na metade inferior de ambos os hemitóraxes. Membros inferiores com edema depressível 2+/4+ bilateralmente. O restante do exame clínico é normal. São realizados os exames complementares a seguir. Ecocardiograma transesofágico com presença de trombo em parede atrial esquerda.

Diante do quadro atual dessa paciente, indique com um X na tabela a conduta referente à prescrição de captopril e carvedilol



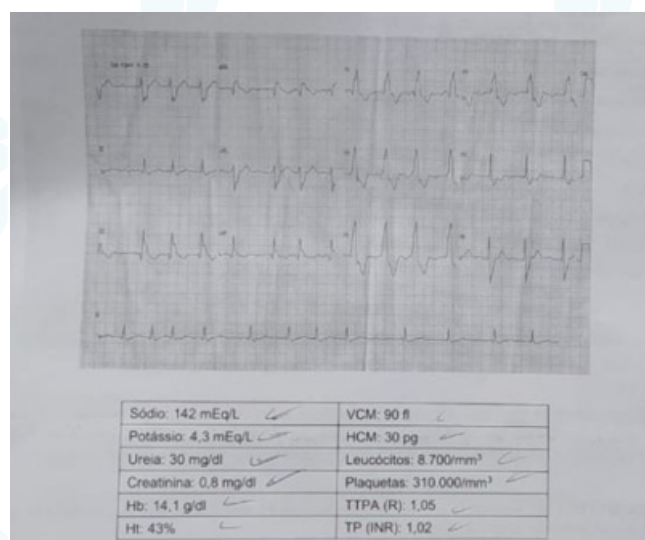
Sódio: 142 mEq/L	VCM: 90 fl
Potássio: 4,3 mEq/L	HCM: 30 pg
Ureia: 30 mg/dl	Leucócitos: 8.700/mm ³
Creatinina: 0,8 mg/dl	Plaquetas: 310.000/mm ³
Hb: 14,1 g/dl	TTPA (R): 1,05
Ht: 43%	TP (INR): 1,02

	Captopril	Carvedilol
Manter a dose		
Diminuir a dose		
Suspender o medicamento		

Questão 107 **Eletrocardiograma**

Mulher de 67 anos de idade está em acompanhamento ambulatorial por hipertensão (diagnosticada há 20 anos) e insuficiência cardíaca (diagnosticada há 5 anos). Faz dieta hipossódica e está em uso regular de captopril 150 mg/dia e carvedilol 25 mg/dia (ou seja, ambos em dose máxima) há mais de dois anos. Na última consulta realizada há três meses,

estava assintomática. O exame clínico era normal (com PA controlada), e havia trazido resultado de ecocardiograma no qual se evidenciavam: fração de ejeção de 37%; aumento moderado de ventrículo e átrio esquerdos; ausência de valvopatias; ausência de alterações segmentares da motricidade ventricular. Procura o Pronto-Socorro com queixa de piora da dispneia há 10 dias, atualmente ocorrendo aos médios esforços. Nega chiado, tosse ou dor torácica. Ao ser ativamente questionada, refere palpitação eventual nos últimos 15 dias, com último episódio há três dias. No exame clínico apresenta-se com P=118 bpm, arritmico, PA=126x72 mmHg, FR=18 ipm, T=36,5°C. Ausculta cardíaca com bulhas arritmicas em dois tempos sem sopros. Semiologia pulmonar com murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, com estertores finos na metade inferior de ambos os hemitóraxes. Membros inferiores com edema depressível 2+/4+ bilateralmente. O restante do exame clínico é normal. São realizados os exames complementares a seguir Ecocardiograma transesofágico com presença de trombo em parede atrial esquerda.



Qual é a conclusão do laudo do eletrocardiograma?

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000100191](https://www.4000100191.com.br)

Questão 108 Tipos de Estudos Epidemiológicos

Em 2015 foram detectados em RN, no Recife, aumento do número de casos de microcefalia com anomalias cerebrais. No mesmo período foi detectado também, o vírus da Zika observado em processos infecciosos, e que até então, não tinham sido descritos nas Américas. A infecção pelo vírus da Zika poderia explicar este aumento do número de casos de microcefalia? No sentido de buscar medidas pertinentes de controle, alguns estudos foram desenvolvidos para responder esta questão: Estudo 1: Dois casos de microcefalia congênita grave, não compatível com causas conhecidas, foram reportadas ao Estado da Paraíba. Ambas mulheres tiveram sintomas compatíveis com Zika naquelas gestações. Ambas apresentavam sorologia negativa para infecção por Zika nas amostras sanguíneas, mas positivas no líquido amniótico. Exames ultrassonográficos realizados nas duas pacientes, na 29ª e na 30ª semana gestacional, evidenciaram: além de outras alterações, diminuição na circunferência da cabeça, atrofia e assimetria cerebral, calcificações no parênquima cerebral - sugestivas de infecção intrauterina. A suspeita de um novo agente causador, no caso o vírus da Zika, passa a ser bastante provável, o que implicaria em consequências populacionais graves. Estudo 2: Foram investigados 60 casos suspeitos de microcefalia notificados à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, no período entre 1 de agosto de 31 de outubro de 2015. utilizou-se informações obtidas de registros de atendimento às gestantes e questionários aplicados às mães, 47 investigações foram concluídas. Nestas observou-se 40 casos de microcefalia confirmados, onde a maior parte dos casos apresentava sinais ultrassonográficos sugestivos de infecção congênita com calcificações cerebrais, ventriculomegalia e lisencefalia (ausência de desenvolvimento normal do cérebro) - lesões graves e incomuns nas de etiologias infecciosas mais conhecidas (TORCHS). Quando às mães, 27 referiam doença exantemática durante a gravidez, acompanhado de prurido, cefaleia e mialgia, sendo 20 no primeiro trimestre e sete no segundo. Concluiu-se que existe importante evidência sobre nova etiologia infecciosa nos casos estudados. Estudo 3: Outro estudo foi conduzido em oito maternidades públicas de Recife, PE, para identificar exposições da mãe, durante a gravidez, aos seguintes fatores de risco: infecção pelo vírus Zika,

exposição ao larvicida usado no controle da dengue, e a vacinação da mãe contra a coqueluche. foram reportadas 13.624 nascimentos entre 15 de janeiro a 30 de novembro de 2016, sendo 13.531 nascidos vivo. Foram selecionados recém-nascidos vivos com microcefalia (com perímetro cefálico menor que 2 desvios-padrão em relação à média) e recém-nascidos sem essa condição, nascidos nos mesmos hospitais e residentes nos mesmos bairros. Os principais resultados foram os seguintes: infecção pelo vírus Zika, OR = 87,0 (IC 95%: 15,6 - infinito); larvicida usado na caixa de água, OR = 1,0 (IC95%: ,6 - 1,8); Vacinação com tríplice bacteriana acelular (Tdap), OR = 0,6 (IC95%: 0,3 - 1,0). Os autores concluíram que a associação entre infecção pelo vírus Zika durante a gravidez e a microcefalia foi confirmada, e que as outras duas hipóteses foram rejeitadas. Estudo 4: Brasil e colaboradores no Rio de Janeiro, acompanharam um grupo de mulheres com e sem diagnóstico de infecção pelo vírus Zika (PCR em sangue e/ou urina) durante a gravidez. Dentre aquelas com diagnóstico de infecção pela Zika foram observadas anormalidade do feto à ultrassonografia em 29%, e em nenhum dos fetos daqueles sem infecção pelo Zika. Ocorreram dois óbitos fetais entre as grávidas infectadas e nenhum entre as não infectadas. Foram ainda observados nos fetos das grávidas infectadas, restrição do crescimento intrauterino, calcificações cerebrais e outras lesões do sistema nervoso central. Os autores concluíram que a infecção das grávidas pelo vírus Zika, apesar de ser clinicamente leve, pode levar a graves desfechos da gravidez, incluindo óbito fetal, restrição do crescimento fetal e anomalias do sistema nervoso central. Complete o quadro respondendo:

Qual o delineamento dos estudos descritos e cite duas justificativas para cada estudo, respectivamente, que orientaram sua resposta.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000100171

Questão 109

Neuropediatria

Tratamento

Definição e Etiologias

Menino, 3 anos de idade, com antecedente de prematuridade extrema, hemorragia periventricular grau III e hidrocefalia com derivação ventrículo peritoneal (DVP) colocada no primeiro mês de vida, trocada pela última vez há 3 meses. Tem epilepsia bem controlada e faz uso regular de ácido valpróico e lamotrigina. Ele foi trazido ao Pronto-Socorro devido a quadro de hipoatividade e sonolência há 4 dias, e vômitos hoje. No trajeto do hospital, iniciou crise epiléptica tônico-clônica generalizada, semelhante às anteriores, porém com duração mais prolongada. Na admissão, paciente ainda em crise epiléptica, apresentando os seguintes dados de avaliação inicial: FC 110 bpm, saturação de 94% em máscara não reinalante, afebril, PA: 136 x 80 mmHg, mucosas secas, preenchimento capilar periférico de 6 segundos, glicemia capilar de 55 mg/dL. Sem alterações na propedêutica cardíaca, pulmonar e abdominal. Sem outras alterações ao exame clínico. Peso: 12kg.

Após estabilização inicial e controle da crise epiléptica, foram vistos os resultados dos exames coletados na admissão ao Pronto Socorro:

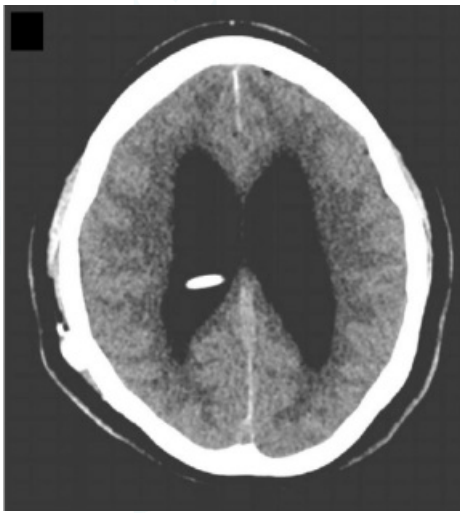
Sódio: 130 mEq/L, Potássio: 4,5 mEq/L; Ureia: 30 mg/dL; Creatinina 0,4 mg/dL

Gasometria venosa: pH 7,30; Bicarbonato 18 mEq/L

Glicemia 80 mg/dL

Urina tipo 1: pH 6,0, densidade: 1.030, leucócitos: 1.000/mL, hemácias: 1.000/mL, nitrito negativo.

Exame de imagem abaixo:



Referência: doi: 10.1542/pir.2015-0134

Ao exame clínico: Regular estado geral, sonolento e confuso, ao estímulo apresenta abertura ocular e localiza a fonte, PA: 130 x 70 mmHg, FC 70 bpm, FR 26 ipm, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Restante do exame clínico inalterado.

Frente aos dados apresentados, qual é o diagnóstico principal e a respectiva conduta?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000100156](https://www.4000100156.com)

Questão 110 Neuropediatria

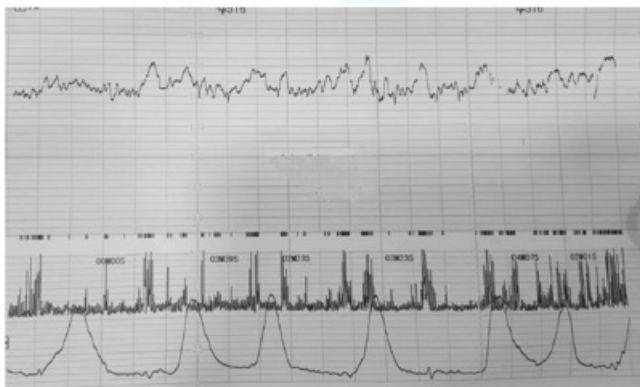
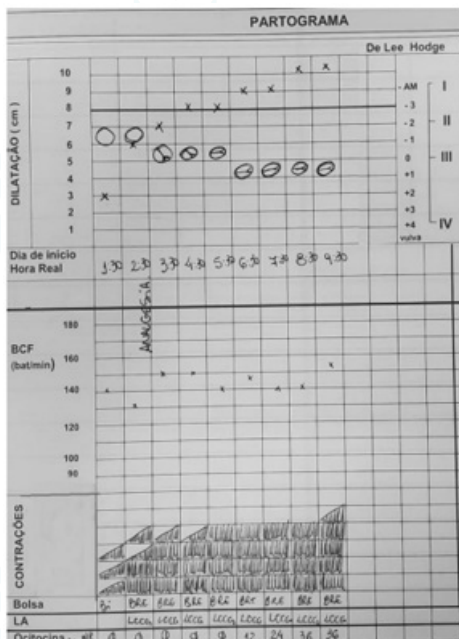
Menino, 3 anos de idade, com antecedente de prematuridade extrema, periventricular grau III e hidrocefalia com derivação ventrículo peritoneal (DVP) colocada no primeiro mês de vida, trocada pela última vez há 3 meses. Tem epilepsia bem controlada e faz uso regular de ácido valpróico e lamotrigina. Ele foi trazido ao Pronto-Socorro devido a quadro de hipoatividade e sonolência há 4 dias, e vômitos hoje. No trajeto do hospital, iniciou crise epiléptica tônico-clônica generalizada, semelhante às anteriores, porém com duração mais prolongada. Na admissão, paciente ainda em crise epiléptica, apresentando os seguintes dados de avaliação inicial: FC 110 bpm, saturação de 94% em máscara não reinalante, afebril, PA: 136 x 80 mmHg, mucosas secas, preenchimento capilar periférico de 6 segundos, glicemia capilar de 55 mg/dL. Sem alterações na propedêutica cardíaca, pulmonar e abdominal. Sem outras alterações ao exame clínico. Peso: 12kg.

Considerando que o paciente encontra-se em jejum, monitorizado e com acesso venoso, complete a prescrição apenas com os itens terapêuticos essenciais a serem administrados na sala de emergência e as respectivas doses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000100146](https://www.4000100146.com)

Questão 111 Tonus atonia uterina

Paciente, 36 anos, secundigesta com parto normal há 16 anos, idade gestacional 39 6/7 semanas. Pré-natal sem intercorrências. Encontra-se no centro obstétrico em trabalho de parto espontâneo. Exame clínico: bom estado geral, normotensa, normocárdica, afebril. Exame obstétrico: altura uterina 39 cm. Partograma e cardiotocografia abaixo: A conduta obstétrica adequada foi realizada e a paciente apresentou hemorragia e choque hemorrágico.



Contra preços abusivos
na medicina.

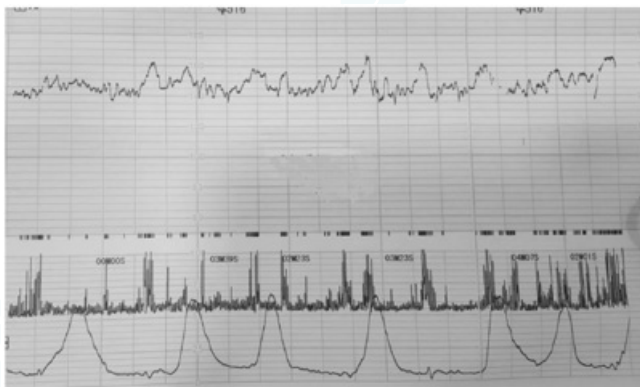
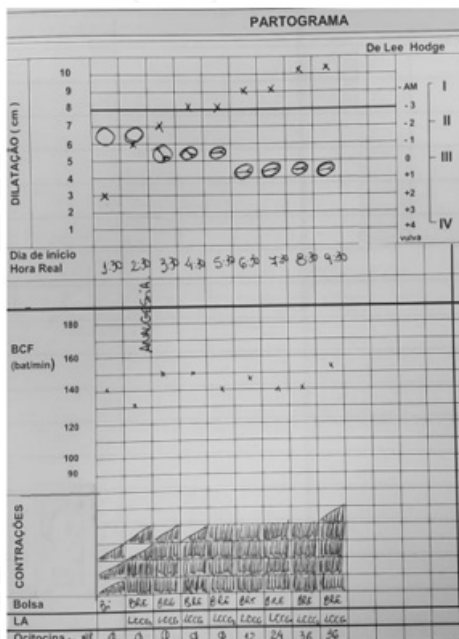
Cite as 4 causas de hemorragia obstétrica a serem pesquisadas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000100127](https://www.4000100127.com)

Questão 113 Diagnóstico de distocias no partograma

Acesse t.me/medicinalivre

Paciente, 36 anos, secundigesta com parto normal há 16 anos, idade gestacional 39 6/7 semanas. Pré-natal sem intercorrências. Encontra-se no centro obstétrico em trabalho de parto espontâneo. Exame clínico: bom estado geral, normotensa, normocárdica, afebril. Exame obstétrico: altura uterina 39 cm. Partograma e cardiotocografia abaixo:



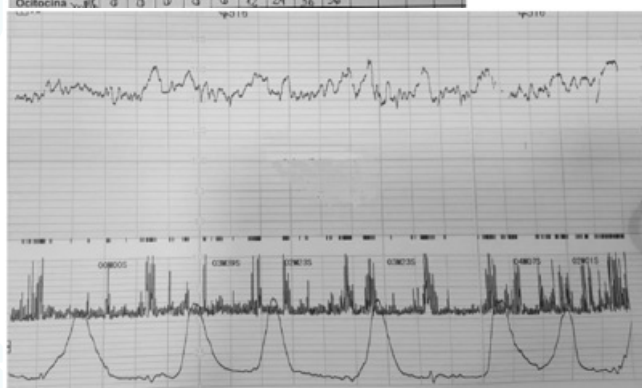
Neste momento, qual é a conduta obstétrica?

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000100120

Questão 114 Parada secundária da descida

Paciente, 36 anos, secundigesta com parto normal há 16 anos, idade gestacional 39 6/7 semanas. Pré-natal sem intercorrências. Encontra-se no centro obstétrico em trabalho de parto espontâneo. Exame clínico: bom estado geral, normotensa, normocárdica, afebril. Exame obstétrico: altura uterina 39 cm. Partograma e cardiotocografia abaixo:



Considerando o partograma, qual é o diagnóstico obstétrico?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000100103](#)

Respostas:

[illegible]

Questão 1 Avaliação da vitalidade fetal

Primigesta de 25 anos de idade, 39 semanas de gestação, está em trabalho de parto há 10 horas. A analgesia peridural foi instalada há 6 horas. No momento 8 cm de dilatação do colo uterino, inalterado há 2 horas. Dinâmica uterina com 5 contrações fortes em 10 minutos. Cardiotocografia com BCF de 140 bpm, variabilidade diminuída, sem acelerações transitórias, nem desacelerações. Na inspeção, observa-se a figura a seguir. Qual é a conduta obstétrica?



- A Sondagem vesical.
- B Ocitocina endovenosa.
- C Complementar analgesia.
- D Cesárea imediata.

Contra preços abusivos
na medicina.

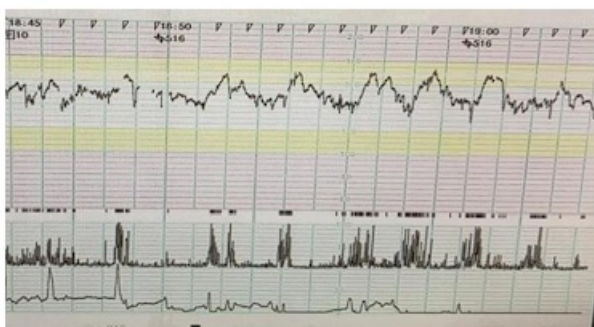
Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165648

Questão 2 Avaliação da vitalidade fetal

Gestante de 17 anos de idade, com 40 semanas e 3 dias de gestação comparece assintomática para controle de vitalidade. Ao exame clínico: PA 110x75 mmHg, FC 78 bpm, altura uterina 36 cm, toque com colo amolecido, grosso, posterior, pérvio para 2 cm, apresentação cefálica no plano -2 de DeLee. Na avaliação ultrassonográfica, feto com tônus preservado, índice de líquido amniótico de 4.6 cm, movimentos fetais e respiratórios presentes. Cardiotocografia apresentada.



Qual é a conduta obstétrica?

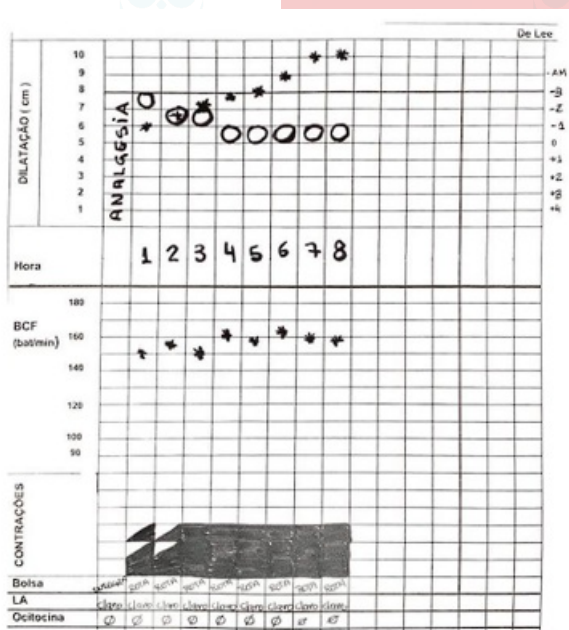
- A Indução do parto com ocitocina.
- B Reavaliação de vitalidade fetal em 48 horas.
- C Parto cesáreo segmentar transversa.
- D Maturação do colo uterino com prostaglandina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165647](https://www.4000165647.com)

Questão 3 Partograma

Mulher de 22 anos de idade, secundigesta com um parto cesáreo anterior com recém-nascido de 2632g há 4 anos. Chega ao pronto atendimento com dor em hipogástrio. Hoje está com 38 semanas e 2 dias de gestação e o pré-natal transcorreu sem intercorrências.

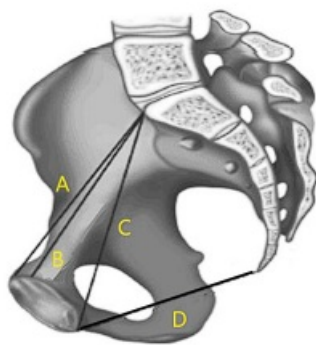
Ao exame: PA 110x72 mmHg, FC 88 bpm, dinâmica uterina presente de 3 contrações em 10 minutos, BCF 144 bpm, altura uterina de 35 cm, toque com colo fino pívrio para 6 cm, apresentação cefálica, alta e fixa, bolsa íntegra, amnioscopia líquido claro com grumos grossos.



Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre



Após análise do partograma, qual o diâmetro que estaria impedindo a descida da apresentação?

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165646](https://www.4000165646.com)

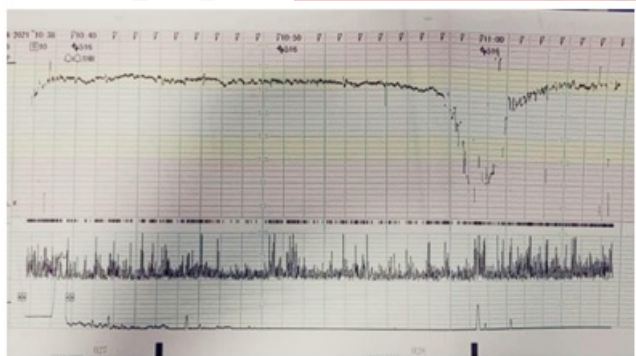
Questão 4 Covid na gestação

Gestante de 25 anos de idade, 31 semanas e 2 dias de gestação, chega ao pronto atendimento com queixa de coriza, tosse e febre

há 5 dias. Hoje amanheceu com falta de ar. Nega doenças prévias. Ao exame clínico, REG, descorada+/4, hidratada, FC= 122 bpm;

T= 37,9°C, Saturação 89%, bulhas rítmicas em dois tempos sem sopros, murmúrios vesiculares presentes e diminuídos em hemitórax direito roncos e sibilos bilaterais, altura uterina de 30cm, BCF presente e rítmico, dinâmica uterina ausente, tônus uterino normal.

Durante o atendimento inicial foi realizada a seguinte cardiotocografia:



Além de ofertar oxigênio, qual é a conduta obstétrica?

A Manter monitorização fetal.

B Indicar cesárea imediata

C Iniciar indução do parto.

D Inibir trabalho de parto prematuro.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165643](https://www.4000165643.com)

Questão 5 Segundo período período expulso Obstetria

Parturiente de 38 anos de idade, secundigesta com um parto normal há 10 anos, 39 semanas e 2 dias de gestação encontra-se em trabalho de parto há 5 horas, com analgesia de parto há uma hora. Refere pré-natal sem intercorrências, última ultrassonografia obstétrica foi com 35 semanas de gestação, com feto único em apresentação cefálica, dorso à esquerda, peso fetal estimado de 3180g (percentil 95 de Hadlock), placenta fúndica, e índice de líquido amniótico de 18. No momento do parto observa-se a seguinte situação:



Qual é a primeira manobra obstétrica que deve ser realizada nesse momento?

- A Anteriorizar o dorso fetal.
- B Fraturar a clavícula fetal.
- C Hiperfletir as coxas da parturiente.
- D Realizar manobra de Zavanelli.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165642](https://www.4000165642.com.br)

Questão 6 Sangramento primeira metade

Mulher de 28 anos de idade, chega ao Pronto-Socorro com queixa de dor de forte intensidade em hipogástrio acompanhada de sangramento vaginal de pequena quantidade. Na anamnese relata um abortamento espontâneo há 18 meses. Refere data da última menstruação em 08/10/2021. Refere ser diabética tipo I há 15 anos. Ao exame clínico: descorada ++/4, PA 90 x 51 mmHg, FC 110 bpm, FR 23 rpm. Dor à palpação profunda com sinal de descompressão brusca presente em fossa ilíaca direita. No toque vaginal o colo do útero é posterior, levemente amolecido, impérvio e com dor à mobilização. Foram recebidos os seguintes resultados de exames: Hb 9,1g/dl, Ht 28,2%, leucócitos 12.83mil/mm³, plaquetas 175 mil/mm³ e betaHCG 1820 mUI/ml. A imagem do ultrassom é apresentada.



Com base no quadro clínico e ultrassonográfico, qual é o diagnóstico?

- A Abortamento tubário.
- B Gravidez de sítio desconhecido.
- C Gravidez ectópica.
- D Gravidez incipiente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165641](https://www.4000165641.com.br)

Questão 7 Hemorragias pós parto HPP e rotura uterina

Gestante de 30 anos de idade, primigesta, 33 semanas de gestação e portadora de hipertensão arterial crônica. Está em uso de metildopa 1,0g por dia e chega ao Pronto-Socorro com queixa de sangramento vaginal e dor abdominal há 1 hora. Ao exame físico: descorada ++, PA 148 x 90 mmHg, FC 118 bpm, altura uterina 37 cm; BCF 102 bpm. Na palpação não há distinção das partes fetais, tônus uterino aumentado. Ao exame especular colo sem lesões, com presença de sangue escurecido em fundo de saco. Ao toque vaginal, colo médio, medianizado, pérvio para 3 cm, bolsa íntegra e tensa.

No puerpério imediato, paciente apresentou sangramento uterino importante havendo necessidade de hemotransfusão. Após administração de ácido tranexâmico e uterotônicos, sem resposta. Houve indicação de intervenção cirúrgica, com o seguinte achado operatório.



Qual é a próxima conduta na sequência de atendimento cirúrgico?

- A Histerectomia total.
- B Sutura compressiva.
- C Ligadura de artérias hipogástricas.
- D Observação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165639](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 8 Obstetrícia Eclâmpsia

Gestante de 30 anos de idade, primigesta, 33 semanas de gestação e portadora de hipertensão arterial crônica. Está em uso de metildopa 1,0g por dia e chega ao Pronto-Socorro com queixa de sangramento vaginal e dor abdominal há 1 hora. Ao exame físico: descorada ++, PA 148 x 90 mmHg, FC 118 bpm, altura uterina 37 cm; BCF 102 bpm. Na palpação não há distinção das partes fetais, tônus uterino aumentado. Ao exame especular colo sem lesões, com presença de sangue escurecido em fundo de saco. Ao toque vaginal, colo médio, medianizado, pérvio para 3 cm, bolsa íntegra e tensa.

Qual é a conduta obstétrica nesse momento?

- A Analgesia de parto.
- B Avaliação de vitalidade fetal.
- C Amniotomia imediata.
- D Inibição de trabalho de parto prematuro.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165637](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 9 Tireotoxicose gestacional transitória Avaliação funcional e ultrassonográfica da glândula tireoide

Mulher de 31 anos de idade, secundigesta, nulípara, chega ao pronto atendimento referindo náuseas e vômitos intensos (3 a 4 episódios por dia). Refere data da última menstruação em 23/09/2021. Portadora de distúrbio de ansiedade em uso de Sertralina 100 mg por dia, chegou bastante agitada. Ao exame clínico, paciente em regular estado geral, desidratada 2+/ 4+, PA 90x62 mmHg, FC 124 bpm, rítmico, Saturação 98%. Exame ginecológico mostrou conteúdo vaginal fisiológico, colo impérvio e útero compatível com a idade gestacional.

Foram colhidos os seguintes exames: Hb 11,4 g/dl; Ht 34,2%, Leucócitos 10,66mil/mm³; Plaquetas 268 mil/mm³; TSH 0,02 UI/ml, T4 total 8,2 mcg/dl; TGO 19U/L; TGP 28U/L; Cr 0,51 mg/dl; U 15 mg/dl; Na 136 mEq/L; K 3,0 mEq/L; PCR 0,06 mg/L; gasometria venosa (pH 7,47; pO₂ 80,1 mmHg; pCO₂ 29,2 mmHg; HCO₃ 29,1 mmol/L; BE +10). Eletrocardiograma:



Após estabilização do quadro agudo, qual é a conduta mais adequada?

- A Repetir TSH.
- B Introduzir Propiltiouracil.
- C Introduzir Propranolol.
- D Introduzir Levotiroxina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165635](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 10 Causas de alcalose respiratória Tireotoxicose gestacional transitória
Formas de reposição de potássio

Mulher de 31 anos de idade, secundigesta, nulípara, chega ao pronto atendimento referindo náuseas e vômitos intensos (3 a 4 episódios por dia). Refere data da última menstruação em 23/09/2021. Portadora de distúrbio de ansiedade em uso de Sertralina 100 mg por dia, chegou bastante agitada. Ao exame clínico, paciente em regular estado geral, desidratada 2+/ 4+, PA 90x62 mmHg, FC 124 bpm, rítmico, Saturação 98%. Exame ginecológico mostrou conteúdo vaginal fisiológico, colo impérvio e útero compatível com a idade gestacional.

Foram colhidos os seguintes exames: Hb 11,4 g/dl; Ht 34,2%, Leucócitos 10,66mil/mm³; Plaquetas 268 mil/mm³; TSH 0,02 UI/ml, T4 total 8,2 mcg/dl; TGO 19U/L; TGP 28U/L; Cr 0,51 mg/dl; U 15 mg/dl; Na 136 mEq/L; K 3,0 mEq/L; PCR 0,06 mg/L; gasometria venosa (pH 7,47; pO₂ 80,1 mmHg; pCO₂ 29,2 mmHg; HCO₃ 29,1 mmol/L; BE +10). Eletrocardiograma:



Além da prescrição de antiemético e hidratação, qual é a prescrição mais adequada no pronto atendimento?

- A Reposição de bicarbonato endovenosa.
- B Ofertar oxigênio em máscara aberta.
- C Reposição de potássio endovenosa.
- D Administrar diurético endovenoso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165634](#)

Questão 11 **Ginecologia** **Fertilização in vitro**

Mulher de 30 anos de idade está em processo de fertilização in vitro. Recebeu estimulação hormonal para estimulação ovariana, com boa resposta e o desenvolvimento de múltiplos folículos/oócitos e desenvolvimento acentuado de ambos os ovários. Qual a principal complicação associada a este procedimento?

- A Endometrite.
- B Ascite e derrame pleural.
- C Ooforite.
- D Gemelaridade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165633](#)

Questão 12 **Bisfosfonatos** **Terapia hormonal da menopausa** **Causas funcionais**

Mulher, 23 anos, atleta profissional de atletismo apresenta fratura de stress tibial. Refere que se encontra em amenorreia há 2 anos. Nuligesta, em uso de preservativo como contraceptivo. Teste de gravidez negativo. Na avaliação da fratura observou-se que apresenta baixa densidade mineral óssea. Além do tratamento específico da fratura, a paciente foi orientada para reprogramação de seus treinos e adaptação da dieta para maior ingesta energética. Qual a conduta mais adequada?

- A Contraceptivo hormonal combinado.
- B Bifosfonato.
- C Ingesta de doses elevadas de cálcio quelado.
- D Musculação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165632](#)

Questão 13 **Ginecologia** **Tratamento**

Mulher, 18 anos de idade, refere cólica menstrual importante, iniciando um dia antes do fluxo menstrual. Refere ciclos

menstruais regulares de 30 dias com duração de 4 dias. Menarca 12 anos e aparecimento das cólicas desde os 16 anos. Iniciou vida sexual aos 17 anos, faz uso de preservativo irregularmente. Nega dor à relação sexual, refere orgasmo. Exame clínico geral sem alterações. Exame ginecológico com genitais externos sem alteração, especular conteúdo vaginal habitual, colo epiteliado. Toque vaginal útero em anteversoflexão, volume habitual, móvel, não doloroso, regiões anexas livres e indolores. Qual é o tratamento inicial adequado?

- A Gestiona.
- B Azitromicina.
- C DIU progesterona.
- D Ácido mefenâmico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165631](https://www.4000165631.com.br)

Questão 14 Intoxicação

Mulher, 60 anos de idade, havia recebido o diagnóstico de osteopenia. Foi orientada a realizar exercícios físicos, consumir alimentos ricos em cálcio e suplemento de vitamina D. Por influência de redes sociais, iniciou por conta própria a ingestão de 40 mil unidades de vitamina D por dia. Qual alternativa reflete a consequência desta suplementação em longo prazo?

- A Aumento da massa óssea.
- B Hipotensão arterial.
- C Nefrocalcinose.
- D Hipocalcemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165630](https://www.4000165630.com.br)

Questão 15 Síndrome de Asherman Ginecologia

Mulher, 28 anos refere ter sido submetida a curetagem uterina por abortamento de 3 meses de gestação, há 6 meses. Desde o procedimento não apresentou menstruações. Nega gestações anteriores, nega uso de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. Qual é a imagem compatível com a principal hipótese diagnóstica?

A



B



C



D



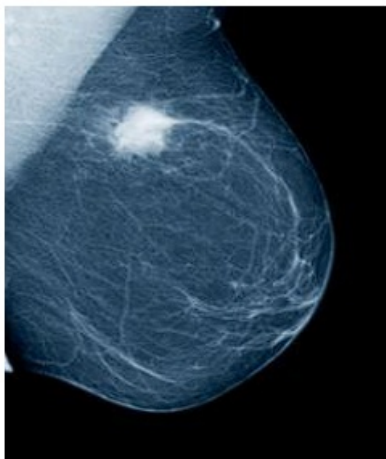
Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165629](https://www.4000165629.com)

Questão 16 Câncer de mama

Mulher, 60 anos, passa em consulta de rotina anual. Hipertensa em uso de anlodipino e diabetes controlado com metformina. Ao exame clínico das mamas observa-se linfonodos endurecidos, coalescidos, pouco móveis em palpação da axila direita e supraclavicular direita. A mamografia é apresentada. A principal hipótese diagnóstica é confirmada. Qual é a conduta adequada?



- A Mastectomia radical.
- B Quimioterapia primária.
- C Radioterapia primária.
- D Quadrantectomia com pesquisa de linfonodo sentinela.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165628](https://www.4000165628.com)

Questão 17 Anatomia da parede abdominal Ginecologia

Mulher, 45 anos de idade, é submetida a histerectomia total abdominal. Após a retirada do útero, o cirurgião sutura a cúpula vaginal através da aproximação da mucosa vaginal com pontos separados de poligalactina 00. Qual é o próximo tempo cirúrgico?

- A Sutura dos ligamentos útero-sacros à cúpula vaginal.
- B Fixação dos ligamentos pubo-vésico-cervicais à cúpula vaginal.
- C Fixação dos ligamentos redondos à cúpula vaginal.
- D Sutura do infundíbulo pélvico à cúpula vaginal.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165627](https://www.4000165627.com)

Questão 18 Ginecologia Fisioterapia

Mulher, 38 anos de idade, refere eventual perda urinária aos grandes esforços. Apresenta antecedente de 2 gestações e 2 partos normais, o último há 8 anos. Ciclos menstruais regulares e uso de preservativo. Nega cirurgias ou uso de medicamentos. Exame físico geral sem alterações. Exame ginecológico: discreta cistocele à Manobra de Valsalva, sem perda de urina observável. Especular com conteúdo vaginal habitual, colo do útero epitelizado.

A orientação para controle inicial da perda de urina é a realização de exercícios de Kegel. Nesta prática, qual é a musculatura que deve ser exercitada?

- A Esfíncter externo vesical.
- B Pubo-coccígea.
- C Obturador interno.
- D Detrusor.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165626](https://www.4000165626.com)

Questão 19 Dispositivos intrauterinos

Mulher de 30 anos com antecedente de 2 partos vaginais será submetida a inserção de dispositivo intra uterino. Qual dos seguintes instrumentos é necessário para este procedimento?

- A 
- B 
- C 
- D 



Essa questão possui comentário do professor no site [4000165626](https://www.4000165626.com)

Questão 20 Ginecologia Amenorreia secundária de causa hipotalâmica

Mulher, 43 anos de idade, queixa-se de ausência de menstruação há 60 dias. Realizou teste de gravidez com resultado negativo. Refere que apresentava ciclos menstruais regulares, com intervalos de 30 dias e duração de 4 dias. Utiliza preservativo masculino como contracepção. Apresenta 2 gestações com 2 partos normais, último há 6 anos. Apresenta antecedente de ooforectomia direita há 20 anos por torção anexial. Hipertensão arterial leve em uso de anlodipino 5mg há 4 anos. Há 4 meses em uso de sulpirida por quadro de depressão.

Exame físico geral: FC 82, PA 120 x 80 mmHg, FR 12 irpm; acne leve em face e discreto rash cutâneo em tórax.

Exame de mamas: palpação fibroglandular, discretamente dolorida, sem nódulos ou retrações, regiões axilares sem linfonodos

palpáveis, expressão areolo-papilar sem alterações.

Genitais externos tróficos; especular colo epitelizado, conteúdo vaginal habitual.

Toque vaginal útero AVF, móvel, indolor, regiões anexiais livres e sem massas identificáveis.

Considerando as informações clínicas, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Falência prematura ovariana.
- B Gravidez psicológica.
- C Síndrome ovários policísticos.
- D Bloqueio de gonadotrofinas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165624](https://www.4000165624.com)

Questão 21 Retalhos Cirurgia

Homem, 94 anos de idade, notou aparecimento de lesão crostosa e elevada na região parietal direita, de crescimento gradativo, há 6 meses. A biópsia prévia confirmou carcinoma espinocelular superficialmente invasivo, bem diferenciado. A imagem a seguir mostra a demarcação das margens oncológicas para carcinoma espinocelular, tendo como margem profunda a ressecção da gálea aponeurótica e o periósteo.



Neste caso, qual é a melhor técnica para reconstrução e cobertura do defeito?

- A Retalho cutâneo microcirúrgico.
- B Retalho cutâneo de transposição.
- C Enxertia de pele espessura parcial.
- D Enxertia de pele espessura total.

4000165623

Questão 22 Ortopedia Principais fraturas associadas

Menino, 5 anos de idade, caiu da bicicleta. Ao exame físico tem dor e deformidade do cotovelo. No serviço de urgência, foi realizada a radiografia apresentada.



Qual é o nervo mais acometido nesse tipo de fratura?

- A Nervo ulnar.
- B Nervo radial.
- C Nervo interósseo anterior.
- D Nervo interósseo posterior.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165622

Questão 23 Tratamento cirúrgico curativo

Homem, 65 anos de idade, com hepatite C e cirrose diagnosticados há 6 anos. Identificou nódulo hepático em ultrassom abdominal de seguimento. A hepatite C está com resposta virológica sustentada. Realizada endoscopia digestiva alta que não identificou varizes de esôfago. Tem função hepática preservada (Child-Pugh A).

Ao exame, está anictérico, sem encefalopatia e não apresenta estigmas de hepatopatia crônica. Palpação abdominal sem alterações.

Os exames laboratoriais não apresentam alterações e a alfafetoproteína é normal. Realizada tomografia computadorizada que evidenciou nódulo bem delimitado entre os segmentos 2 e 3 medindo 3,5 x 3,3 cm. As fases contrastadas evidenciaram lesão

hipervascular com fluxo rápido e homogêneo na fase arterial, seguido de lavagem ("washout") nas fases mais tardias. Qual a afirmativa correta?

- A Alfafetoproteína normal exclui o diagnóstico de carcinoma hepatocelular.
- B A função hepática preservada autoriza a hepatectomia parcial.
- C A biópsia da lesão é essencial para a confirmação diagnóstica e definição da conduta.
- D A inclusão em fila de transplante hepático está contraindicada.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165621

Questão 24 Aneurisma de Aorta Abdominal Cirurgia Ruptura de Aneurisma da Aorta Abdominal

Homem, 60 anos de idade, com antecedente de tabagismo e hipertensão, procura o hospital com queixa de dor abdominal súbita, de forte intensidade, irradiada para flanco e lombar à esquerda, há 4 horas. Relata que teve um quase desmaio, com

sudorese fria no momento do início da dor, e se recuperou após alguns minutos. Ao exame físico, apresenta-se normotenso, corado e bem perfundido, com pulsos palpáveis em todas as extremidades. O exame clínico do abdome revela massa pulsátil dolorosa. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Aneurisma de aorta roto, tamponado.
- B Dissecção aguda de aorta abdominal.
- C Trombose aguda da aorta abdominal.
- D Aneurisma de aorta de crescimento recente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165620](https://www.4000165620.com.br)

Questão 25 **Manifestações Clínicas** **Tratamento Cirúrgico do Megaesôfago NãoAvançado**

Mulher, 46 anos de idade, refere dor torácica e regurgitação após refeições há 2 anos, com piora progressiva. Quando tem dor, apresenta melhora após a ingestão de líquidos. A queixa é mais intensa após refeições sólidas, evitando alimentos com esta consistência. Associadamente tem regurgitação durante o sono. Perdeu 5 Kg (IMC atual: 20 kg/m²).

Realizou endoscopia digestiva alta, com achado de esofagite erosiva distal leve (grau A de Los Angeles) e gastrite erosiva leve de antro. Iniciou uso pantoprazol sem melhora dos sintomas.

Retornou à consulta, quando foi solicitada uma radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno.



Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o tratamento?

- A Esofagectomia subtotal.
- B Hiatoplastia e funduplicatura parcial.
- C Hiatoplastia e funduplicatura total.
- D Cardiomiectomia e funduplicatura parcial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165619](https://www.4000165619.com.br)

Questão 26 **Complicações Gastrointestinais** **Transtorno Alimentares** **Cirurgia**

Mulher, 33 anos de idade, foi submetida a gastroplastia em Y de Roux para tratamento de obesidade mórbida, há 2 meses. Procura o serviço de urgência com queixa de disfagia, regurgitação de alimentos sólidos, há 1 mês, com piora progressiva. Ao exame físico: bom estado geral, desidratada, corada, abdome flácido e indolor à palpação.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Transtorno alimentar (bulimia).
- B Hérnia interna.
- C Estenose da enteroentero anastomose.
- D Estenose da gastroenteroanastomose.

4000165618

Questão 27 **Pleurodese**

Homem, 67 anos de idade, está em tratamento paliativo para neoplasia de reto estadio IV. Tem diabetes melito e é ex-tabagista. Há 4 semanas, foi submetido a toracocentese de alívio, com retirada de 1100 mL. Houve melhora dos sintomas e expansão pulmonar completa em radiografia de controle. Retorna ao ambulatório com queixa de há 1 semana recidiva da dispneia e tosse seca. Nega dor torácica e febre. Apresenta KPS (performance status de Karnofsky) de 60. Abaixo a radiografia de tórax atual. Análise do líquido pleural confirmou etiologia neoplásica.



Qual é a conduta nesta situação?

- A Repetir a toracocentese esvaziadora.
- B Drenagem com cateter pleural e pleurodese.
- C Drenagem com cateter pleural e manter até diminuir o débito.
- D Toracotomia com pleurectomia parietal ampla.

4000165617

Questão 28 **Neoplasias Testiculares** **Cirurgia**

Homem, 28 anos de idade, procura atendimento médico com queixa de dor e aumento do volume do testículo direito, há dois meses. Nega trauma local. Ao exame físico apresenta testículo direito aumentado cerca de 5 vezes o normal, endurecido e doloroso. Não há hiperemia da pele escrotal e o epidídimo direito está normal. Realizou ultrassonografia que mostrou o testículo direito com 13 cm no maior diâmetro, com componente sólido e heterogêneo, e áreas de necrose e

hemorragia. O testículo esquerdo está normal. Indicada realização de tomografia de tórax e abdome. Qual é a conduta neste momento?

- A Coleta de alfa-feto proteína, DHL e betaHCG; orquiectomia por inguinotomia.
- B Coleta de CEA, CA72.4 e DHL; biópsia do testículo com agulha grossa.
- C Coleta de alfa feto proteína, DHL e betaHCG; biópsia do testículo com agulha grossa.
- D Coleta de CEA, CA72.4 e DHL; orquiectomia por inguinotomia.

4000165616

Questão 29 **Atresia do Esôfago e Fístula Traqueoesofágica** **Cirurgia**

Recém-nascido de termo apresenta salivação abundante e impossibilidade de passagem da sonda orogástrica na sala de parto. A ausculta cardiopulmonar é normal e não se notam outras alterações ao exame físico. Qual é o exame indicado neste momento?

- A Broncoscopia.
- B Tomografia de tórax e abdome com contraste oral.
- C Ultrassonografia de tórax e abdome.
- D Radiografia de abdome.

4000165615

Questão 30 **Complicações**

Homem, 44 anos de idade, foi submetido a tireoidectomia total há 6 horas. A enfermagem relata que o paciente está sentindo dificuldade para “puxar o ar”, usando musculatura acessória e se encontra cada vez mais agitado e sentado no leito. As imagens apresentadas ilustram a inspeção cervical ao você chegar (A) e nos minutos que se seguiram à sua avaliação (B).



Qual é a conduta neste momento?

- A Abertura imediata da sutura de pele e fásccio-muscular no leito.
- B Traqueostomia de emergência no centro cirúrgico.
- C Compressão do trígono carotídeo e estabilização.
- D Cricotireoidostomia por punção no leito.

4000165614

Questão 31 Sequência Rápida de Intubação SRI Préoxigenação

Homem, 71 anos de idade, foi admitido no serviço de emergência com quadro de dor e distensão abdominal e vômitos. Ao exame físico encontrava-se eupneico, com saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente e distensão abdominal. Realizada tomografia de abdome apresentada.



Indicada laparotomia exploradora. Exames laboratoriais séricos revelam Hb: 9,7 g/dL; potássio: 2,9 mEq/L e sódio: 140 mEq/L; Cr: 1,9 mg/dL e U: 90 mg/dL.

Qual é a melhor conduta no tratamento da via aérea para a anestesia geral?

- A Ventilar com máscara facial em pressão positiva e oxigênio 100%.
- B Respirar com oxigênio a 100% e usar técnica de sequência rápida.
- C Respirar com oxigênio a 100% e instalar a máscara laríngea.
- D Máscara facial em oxigênio 100% e instalar cânula de Guedel.

4000165613

Questão 32 Avaliação Inicial Vias aéreas Ventilação e Choque Trauma Abdominal Fechado Cirurgia

Homem, 41 anos de idade, foi vítima de atropelamento por trem. Na admissão no serviço de emergência, encontrava-se:

- A: Intubado; Saturação de O₂ 85%.
- B: Ausculta pulmonar abolida à esquerda, com hipertimpanismo à percussão.
- C: PA: 70x40 mmHg; FC: 140bpm; Tempo de enchimento capilar lentificado. FAST positivo em todos os quadrantes do abdome e negativo no pericárdio.
- D: Escala de Coma de Glasgow de 3 (sedado e intubado). Pupilas anisocóricas (midríase à direita).
- E: Amputação traumática de perna esquerda com curativo encharcado de sangue.

Com relação às lesões do doente, qual é a sequência correta do tratamento?

- A 1. Drenagem torácica; 2. Torniquete em membro inferior; 3. Tomografia de crânio; 4. Laparotomia exploradora.
- B 1. Tomografia de crânio; 2. Drenagem torácica; 3. Laparotomia exploradora; 4. Torniquete em membro inferior.
- C 1. Drenagem torácica; 2. Torniquete em membro inferior; 3. Laparotomia exploradora; 4. Tomografia de crânio.
- D 1. Torniquete em membro inferior; 2. Drenagem torácica; 3. Tomografia de crânio; 4. Laparotomia exploradora.

4000165612

Questão 33 Trauma Abdominal Penetrante Cirurgia

Homem, 19 anos de idade, foi vítima de ferimento por arma branca no dorso. Na sala emergência encontrava-se:

- A: Via aérea pérvia. Saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente.
- B: Ausculta pulmonar sem alteração.
- C: PA: 140 x 80 mmHg; FC: 90 bpm; Tempo de enchimento capilar normal. FAST abdominal negativo.
- D: Escala de Coma de Glasgow: 15.
- E: Ausência de dor abdominal; sondagem vesical com diurese clara. Toque retal sem alterações. Ferimento no dorso conforme imagem a seguir.



Realizada radiografia de tórax na sala de emergência, que não evidenciou alterações. Realizada hemostasia local. Qual é a melhor conduta neste momento?

- A Sutura do ferimento e profilaxia para tétano.
- B Laparoscopia exploradora.
- C Tomografia de abdome.
- D Toracoscopia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165611

Questão 34 Complicações Locais Tratamento

Mulher, 64 anos de idade, diabética, foi submetida a correção de hérnia incisional através de laparotomia mediana. A técnica operatória empregada foi a colocação de tela de polipropileno sobre a aponeurose (onlay). Na figura a seguir é possível observar o descolamento do tecido subcutâneo da aponeurose e a fixação da tela. Foram colocados 2 drenos fechados devido ao descolamento.



Além do seroma, qual é a complicação operatória mais frequente deste procedimento?

- A Necrose de pele e subcutâneo.
- B Infecção crônica da tela.
- C Rejeição da tela.
- D Deiscência da aponeurose.

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165610

Questão 35 **Complicações Locais** **Cirurgia**

Mulher, 47 anos de idade, foi submetida a laparotomia exploradora devido a obstrução intestinal por tumor no cólon direito. Foi realizada colectomia direita com ileostomia terminal. Tem diabetes melito, hipertensão arterial não controlada e é tabagista. No 4º pós-operatório apresentou saída de líquido serohemático pela ferida operatória. Hoje, encontra-se no 7º pós-operatório e a imagem da ferida está representada pela imagem a seguir. Nesta paciente, quais são os fatores de risco para esta complicação?



- A Cirurgia de urgência, ileostomia, hipertensão arterial.
- B Cirurgia de urgência, doença neoplásica, tabagismo.
- C Diabetes melito, hipertensão arterial, tabagismo.
- D Ileostomia, doença neoplásica, diabetes melito.

da Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000165609

Questão 36 **Antibioticoprofilaxia Cirúrgica** **Cirurgia**

Mulher, 43 anos de idade, foi admitida no serviço de emergência devido a dor no hipocôndrio direito. Ao exame físico

apresentava sinal de Murphy positivo. Tem hipertensão arterial e diabetes melito controlados com medicamentos. Realizados exames bioquímicos que evidenciaram leucograma de $14.373/\text{mm}^3$ e PCR de 45 mg/L . O ultrassom evidenciou espessamento e delaminação da parede da vesícula biliar, com cálculo impactado no infundíbulo. Foi submetida a colecistectomia laparoscópica que evidenciou intenso processo inflamatório perivesicular. Realizada punção da vesícula, com saída de bile escura. Neste cenário, qual é o tempo de antibiótico preconizado?

- A Até 24 horas.
- B 72 horas.
- C 5 dias.
- D 7 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165608](#)

Questão 37 Exames Complementares Cirurgia

Mulher, 31 anos de idade, com obesidade grau 1 está internada devido a pancreatite aguda leve. Evoluiu com melhora da dor, 2 dias após o início dos sintomas. Tem diabetes melito tipo 2 e hipotireoidismo. Foi submetida a ultrassonografia de abdome que evidenciou vesícula biliar de paredes finas, sem cálculos e com via biliar de $0,4 \text{ cm}$. Nega uso abusivo de álcool. Qual é o próximo passo?

- A Realizar ecoendoscopia.
- B Colecistectomia com colangiografia.
- C Tratamento com ácido ursodesoxicólico.
- D Realizar tomografia de abdome.

4000165607

Questão 38 Tratamento Cirurgia

Homem, 76 anos de idade, está internado em Unidade de Terapia Intensiva de Hospital Terciário devido a pneumonia bacteriana.

Evoluiu há 1 dia com dor abdominal inespecífica, mais acentuada no abdome superior. Ao exame físico:

Regular estado geral, confuso, FC: 90 bpm ; PA: $90 \times 60 \text{ mmHg}$ (uso de noradrenalina), Sat.O_2 : 92% (máscara de oxigênio), FR: 22 ipm .

Abdome: distensão abdominal difusa e dor mais intensa em hipocôndrio direito.

Exames laboratoriais: Hb $11,5 \text{ g/dL}$; Leucócitos 19.500 mm^3 ; Creatinina: $2,7 \text{ mg/dL}$; Ureia: 98 mg/dL ; PCR 170 mg/dL ; TGO 125 U/L ;

TGP 160 U/L ; FA: 230; GGT: 198; Bilirrubina total: 3,8.

Calculado o escore de APACHE2: 19.

Realizada tomografia de abdome que evidenciou distensão da vesícula biliar com borramento e densificação dos planos adjacentes,

bile espessa e cálculo de 1 cm no infundíbulo, sem dilatação da via biliar.

Qual é a conduta mais adequada neste momento?

- A Colangiografia endoscópica retrógrada com papilotomia.
- B Colectomia por laparotomia com colangiografia.
- C Colectomia laparoscópica com colangiografia.
- D Drenagem percutânea transhepática da vesícula biliar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165606](https://www.4000165606.com)

Questão 39 **Abdome Agudo Obstrutivo** **Cirurgia**

Homem, 62 anos de idade, é admitido no serviço de emergência devido a dor abdominal em cólica, vômitos e distensão abdominal há

4 dias. Última evacuação há 5 dias e, desde então, não elimina gases. Refere cólica abdominal há 3 meses, com vômitos esporádicos

que melhorava com jejum e medicamento antiespasmódico. Tem hipertensão arterial controlada e nega operações abdominais prévias.

Ao exame físico:

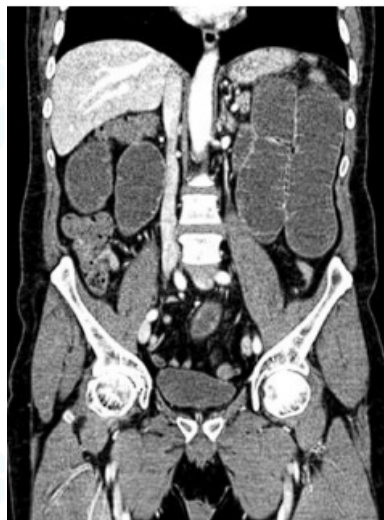
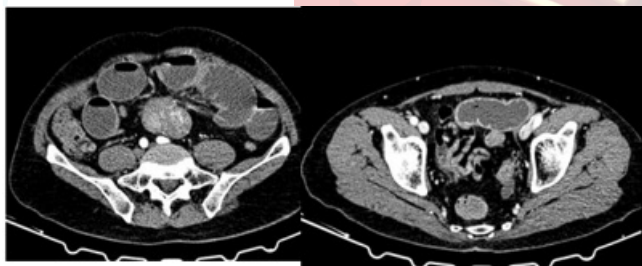
Bom estado, desidratado, eupneico.

Abdome: distendido, ruídos hidroaéreos aumentados, doloroso à palpação profunda sem irritação peritoneal.

Toque retal: sem fezes na ampola.

Exames laboratoriais: Hb: 10,9 g/dL; Ht: 38%; Creatinina: 2,9 mg/dL; Ureia: 110 mg/dL. Demais exames sem alterações.

Realizada a tomografia de abdome apresentada.



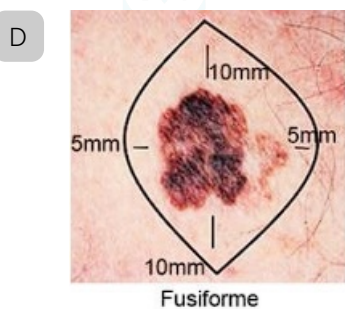
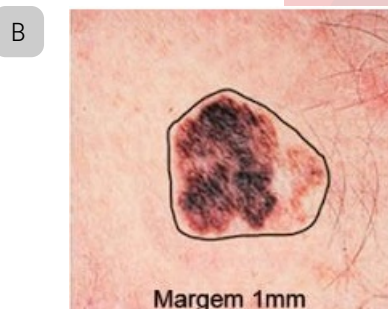
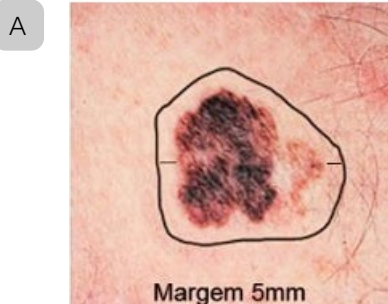
Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A Abdome agudo obstrutivo ao nível do sigmoide.
- B Síndrome de Ogilvie.
- C Abdome agudo obstrutivo ao nível de delgado.
- D Íleo paráltico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165605](#)

Questão 40 Dermatologia Tratamento e conduta

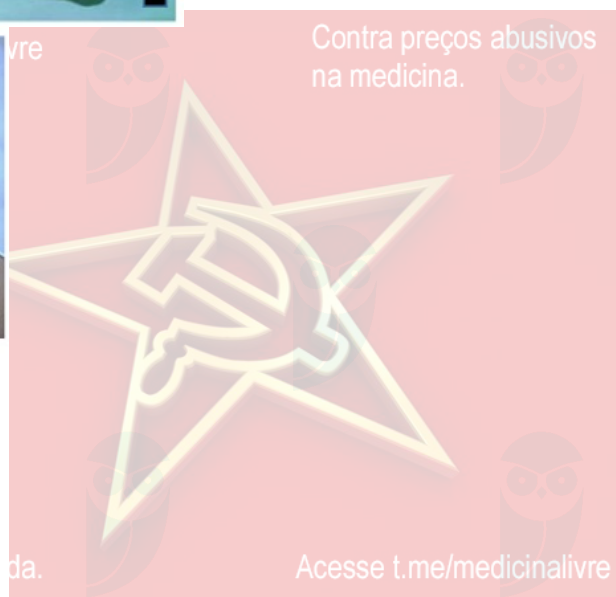
Mulher, 63 anos de idade, com antecedente de ressecção de melanoma no dorso, operado há 3 anos, com Breslow de 0,76mm. Em seguimento dermatológico de rotina, foi realizada dermatoscopia que evidenciou lesão no antebraço direito. Foi indicada a ressecção da lesão para diagnóstico. Qual é a alternativa que apresenta a linha de incisão na pele que deve ser realizada?



Essa questão possui comentário do professor no site [4000165604](#)

Questão 41 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria

Recém-nascido, 40 semanas de idade gestacional, sexo masculino, nasceu de parto cesárea por falha de indução, Apgar 9/10, peso de 2.950 g. Mãe primigesta, 20 anos, não fez pré-natal e relata ser usuária habitual de drogas ilícitas. O menor está sendo examinado no alojamento conjunto, com 72 horas de vida, e alguns dados do exame clínico estão apresentados nas imagens abaixo.



Qual é a conduta indicada face aos dados clínicos apresentados?

- A Apuração de maus-tratos no alojamento conjunto.
- B Solicitação de cariótipo.
- C Investigação neurológica complementar.
- D Alta hospitalar com seguimento de rotina em UBS.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165603](https://www.4000165603.com)

Questão 42 Exame físico do Recém-nascido **Pediatria**

Recém-nascido, sexo feminino, 24 horas de vida, está no alojamento conjunto. Nascida com idade gestacional de 40 semanas e 2 dias,

parto fórcepe, Apgar 8/9, peso de 3.950 g, com período expulsivo prolongado. Criança recebeu vacina de hepatite B, nitrato de prata ocular e vitamina K intramuscular. Pré-natal sem anormalidades. Ao exame clínico, criança em bom estado geral, e a inspeção da cabeça mostrou a presença de um abaulamento (Figura A), cujos limites anatômicos estão esquematicamente representados abaixo (figura B). Sem outras alterações significativas.



Figura A



Figura B

Qual é a conduta, considerando a principal hipótese diagnóstica?

- A Observação clínica e monitorização de icterícia.
- B Punção ou drenagem da coleção serossanguinolenta.
- C Realização de ressonância magnética de crânio.
- D Realização de segunda dose de vitamina K intramuscular.

Contra preços abusivos
na medicina.

4000165602

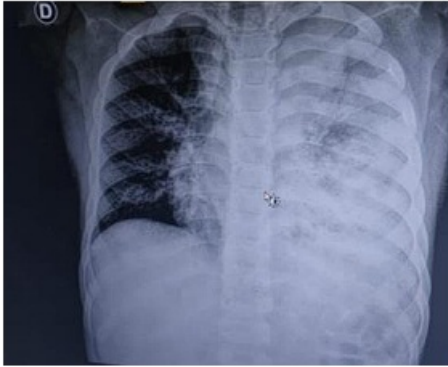
Questão 43 Síndrome de GuillainBarré Neurologia Exames Complementares

Pré-escolar, sexo feminino, 3 anos de idade, sem comorbidades prévias, é levada pela mãe ao Pronto-Socorro por queixa de recusa ao deambular, com choro intenso quando colocada em pé, referindo dor em membros inferiores bilateralmente. Nega febre, nega outras queixas, nega traumas. Refere que teve quadro diarreico há 15 dias, com duração de 3 dias, já resolvido. Ao exame clínico, demonstra dor à manipulação dos membros inferiores, com hipotonia muscular e força muscular grau III em porção distal e grau IV em porção proximal dos membros inferiores. Hiporreflexia patelar bilateral. Membros superiores com força, sensibilidade e reflexos preservados. Sem outros achados significativos. Qual das alternativas abaixo apresenta os resultados de exames complementares compatíveis com a hipótese diagnóstica mais provável para o caso?

- A Eletroencefalograma: traçado compatível com padrão de hipsarritmia.
- B Líquor: 3 células/mm³, 0 hemácias/mm³, glicose: 63 g/dL, proteína: 187 mg/dL, bacterioscopia negativa.
- C Tomografia de coluna lombossacra: invasão do canal vertebral e compressão medular.
- D VHS: 100 mm/h, proteína C reativa: 120 mg/L; creatinofosfoquinase (CPK): 2.000 U/L.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165601

Pré-escolar, sexo masculino, 2 anos e 6 meses de idade, está em consulta ambulatorial de rotina em UBS. Mãe conta que, neste último ano, desde que a criança entrou na creche, ficou gripada praticamente todo mês. Nos últimos 6 meses, a mãe refere que a criança precisou usar antibiótico cinco vezes (uma internação em UTI por pneumonia, três otites médias agudas e uma celulite em membro inferior direito). A mãe trouxe a radiografia de tórax realizada durante a internação em UTI:



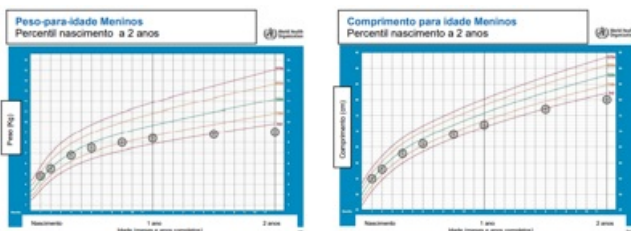
Além dessa internação, ocorreram outras duas, ambas em enfermaria: diarreia com desidratação grave aos 7 meses; celulite periorbitária secundária à sinusite bacteriana aos 2 anos de idade.

Apresenta vacinação em dia seguindo o programa nacional de imunizações. Aceita bem todos os tipos de alimento, exceto carne.

Recebeu vitamina A e D profiláticas até os 2 anos de idade, mas nunca recebeu sulfato ferroso profilático, porque não gostava do gosto e sempre cuspiu a medicação.

O peso e a estatura atuais são idênticos aos de seis meses atrás, quando realizou a última consulta de puericultura.

As curvas antropométricas estão representadas abaixo:



Qual é a conduta prioritária na consulta atual com base no diagnóstico mais provável?

- A** Reorientar alimentação, coletar hemograma e perfil de ferro e marcar retorno breve para decidir sobre necessidade de sulfato ferroso em dose terapêutica.
- B** Orientar que as infecções são frequentes nesta faixa etária devido aos baixos níveis de IgA esperados para a idade, e que as infecções se intensificam com a entrada na creche.
- C** Dosar hormônios tireoidianos (TSH e T4 livre) e de crescimento (GH, IGF1 e IGF BP3) e encaminhar para seguimento com endocrinologista.
- D** Iniciar investigação com coleta de hemograma completo, imunoglobulinas séricas, complemento, sorologia para sarampo e encaminhar para imunologista.

4000165600

Questão 45 Conjuntivite Neonatal Neonatologia

Recém-nascido, sexo masculino, 19 dias de vida, está em consulta ambulatorial. Trata-se de recém-nascido de termo, parto vaginal hospitalar, mãe com 28 anos de idade, sem seguimento adequado no pré-natal. Nota-se edema palpebral bilateral, conjuntivas hiperemiadas e secreção ocular purulenta há um dia. Sem outras alterações significativas ao exame clínico. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A** Conjuntivite por clamídia.
- B** Conjuntivite química por nitrato de prata.
- C** Conjuntivite gonocócica.
- D** Obstrução de ducto lacrimal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165599](https://www.4000165599.com.br)

Questão 46 Síndrome nefrótica

Escolar, sexo feminino, 6 anos de idade, portadora de síndrome nefrótica córtico-dependente, está internada em enfermaria de pediatria há 4 dias. A paciente apresentou sintomas compatíveis com resfriado comum iniciados há 1 semana e, no dia da internação, mãe relatava redução importante da diurese e lipotímia. O peso aferido na chegada foi de 31 kg (ganho de 6 kg em relação à última consulta). Hoje, a paciente está no quarto dia de internação, recebendo dieta hipossódica, infusão endovenosa de albumina humana uma vez ao dia (última dose ontem pela manhã) e prednisona oral. Está sem novas queixas, em bom estado geral, afebril e normotensa. Seguem abaixo: a tabela com a evolução dos exames laboratoriais na internação e o balanço hídrico registrado pela enfermagem nas últimas 24 horas.

	1º Dia	4º Dia
Ureia (mg/dL)	60	20
Creatinina (mg/dL)	0,96	0,35
Sódio (mEq/L)	128	136
Potássio (mEq/L)	4,3	4,2
Hb (g/dL) / Ht (%)	16/48	13/39
Proteína total (g/dL)	4,0	5,0
Albumina (g/dL)	1,2	2,2

	Ganhos		Perdas	Anotações
Horário	Oral	Endovenoso	Diurese	
6:00	100ml		100ml	Peso: 26kg
10:00	50ml	Albumina 125ml		
14:00	75ml		300ml	
18:00	150ml		400ml	
22:00	100ml			
2:00	-		400ml	
6:00	-			Peso: 25 kg
TOTAL	600ml		1200ml	

Qual é a afirmação correta com relação à programação a ser estabelecida?

- A Segue apresentando indicação de albumina humana endovenosa diariamente.
- B Tem indicação de receber diurético de alça duas a três vezes ao dia.
- C Apresenta condições de alta hospitalar e seguimento ambulatorial.
- D Tem indicação de receber soro de manutenção basal 100ml/100kcal, restrito em sódio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165598](https://www.4000165598.com.br)

Questão 47 Reanimação neonatal Pediatria Reanimação neonatal em maiores de 34 semanas

Você está na sala de parto e recebe um recém-nascido termo (38 semanas), que nasceu com respiração irregular e tônus fraco, sendo o cordão umbilical clampeado imediatamente. O paciente foi levado para o berço com calor radiante, secado, retirado campos úmidos, e posicionado. Após esses primeiros passos, a avaliação constatou movimentos respiratórios ausentes e frequência cardíaca de 80 bpm. O próximo passo na reanimação neonatal é:

- A Infundir por via endovenosa adrenalina e expansor de volume 10 ml/kg.
- B Ventilar com pressão positiva e máscara com oxigênio a 21%.
- C Oferecer 100% de oxigênio em máscara aberta.
- D Realizar massagem cardíaca sincronizada com a ventilação.

4000165597

Questão 48 Antibioticoterapia Pediatria Tratamento do Choque Séptico

Escolar, sexo masculino, 9 anos de idade, portador de osteossarcoma, realizou último ciclo de quimioterapia há 6 dias. É trazido ao Pronto-Socorro com queixa de picos febris de até 39°C há um dia, vômitos, dor abdominal, dor anal e lesões em cavidade oral conforme imagem abaixo. Admitido na sala de emergência em mau estado geral, descorado 2+/4, FC: 180 bpm, FR: 50 irpm, PA: 70 x 40 mmHg, saturação de O₂: 98% em ar ambiente, tempo de enchimento capilar 6 segundos, pulsos finos, cateter central de longa permanência sem sinais flogísticos. Exames coletados na véspera mostram Hb: 8,2 g/dL, leucócitos 150/mm³ (sem diferencial devido à baixa celularidade), plaquetas 50.000/μL. O paciente recebeu expansão volêmica adequada, antimicrobianos e, após 30 minutos do atendimento inicial, seguia sem melhora significativa dos sinais descritos.



Qual é a alternativa que contém respectivamente o melhor esquema antimicrobiano inicial e a próxima medida a ser instituída, considerando que não houve melhora dos parâmetros clínicos após a expansão volêmica?

- A Ceftriaxona e fluconazol. Introduzir epinefrina endovenosa contínua.
- B Ceftazidima e aciclovir. Solicitar concentrados de hemácias e de plaquetas.
- C Piperaciclina-tazobactam. Solicitar concentrados de hemácias e de plaquetas.
- D Meropenem e vancomicina. Introduzir epinefrina endovenosa contínua.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000165596

Questão 49 **Emergências Pediátricas** **Pediatria**

Pré-escolar, sexo feminino, 4 anos de idade, vítima de atropelamento, foi admitida na sala de emergência em choque hemorrágico. Devido colapso circulatório, não foi possível obtenção de acesso vascular periférico, sendo indicado acesso intraósseo. Na primeira tentativa de canulação óssea, realizada na tíbia proximal direita, houve transfixação. Como a paciente apresentava fratura em tíbia esquerda, optou-se por realizar a segunda tentativa no local apontado pelo dedo indicador da mão direita na figura A. Após a canulação óssea, a agulha está firme e houve retorno do fluido mostrado na Figura B.



Figura A



Figura B

Acesse t.me/medicinalivre

Qual é a afirmação correta com relação ao procedimento descrito?

- A O local é apropriado, mas houve acidente de punção e a agulha deve ser retirada.
- B O local é inapropriado, deve-se optar pela espinha ilíaca anterossuperior.
- C O acesso obtido é apropriado para cristaloides, mas não para hemocomponentes.
- D O local é apropriado e o acesso intraósseo parece bem locado.

4000165595

Questão 50 Tratamento

Lactente, sexo masculino, 1 ano e 6 meses de idade, portador de Hemofilia A com atividade inferior a 1%, em reposição regular de fator VIII, apresentou queda da cama há cerca de 1 hora, sem perda de consciência, evoluindo com 3 episódios vômitos após a queda. Na admissão no serviço de emergência estava em bom estado geral, alerta e orientado, mas pouco colaborativo ao exame clínico, o que, segundo os pais, já é habitual em consultas pediátricas. Ao exame clínico, notado apenas hematoma de cerca de 2 cm em região occipital, sem outras alterações. Qual das alternativas abaixo contém as medidas iniciais, na sequência cronológica em que elas devem ser realizadas?

- A Sedação e tomografia de crânio; administração de fator VIII (correção 100%) se sangramento intracraniano.
- B Observação hospitalar por 6 horas; sedação e tomografia de crânio se surgirem alterações neurológicas.
- C Administração de fator VIII (correção 100%); sedação e tomografia de crânio.
- D Alta hospitalar com manutenção da reposição regular de fator VIII, porém em dose dobrada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165594](https://www.4000165594.com.br)

Questão 51 Sigilo profissional em crianças e adolescentes Parecer CFM n 25 de 2013 Sigilo profissional

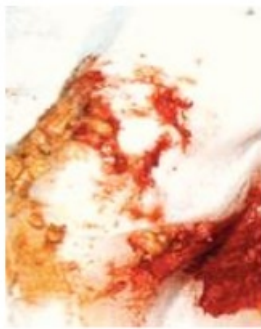
Adolescente, sexo feminino, 13 anos de idade, está internada há 6 meses para tratamento de um câncer. Ao longo dessa internação, a adolescente e seus pais iniciaram uma página na internet sobre a doença e, em pouco tempo, a família já tinha milhões de seguidores, incluindo membros da equipe médica do hospital. A adolescente era muito ativa nas redes sociais e todos os dias postava detalhes da sua rotina no hospital. A resposta ao tratamento não foi boa e o caso clínico considerado sem proposta terapêutica curativa. Imediatamente, a família foi buscar informações na internet e descobriu a possibilidade de uma nova droga, de alto custo, recém publicada para este tipo de câncer. Essa droga, no entanto, não foi descrita como eficaz para o subtipo específico do câncer desta paciente, mas a família se recusa a aceitar os argumentos médicos e imediatamente iniciou uma campanha na internet para pressionar o hospital a adquirir a medicação. Diante do conflito estabelecido e considerando o código de ética médica, qual deve ser a postura da instituição?

- A A instituição não pode divulgar dados específicos da paciente sem autorização, ainda que a mesma já os tenha tornado públicos, independente do objetivo desta divulgação.
- B Com a justificativa de prover um bem coletivo maior e evitando a desinformação, a instituição está autorizada nesse cenário a prover publicamente detalhes do caso, pois este já é público.
- C A luz do código de ética médica, não há uma definição clara quanto a obrigação da instituição em manter a privacidade sobre as informações médicas de um caso que já está público.
- D A instituição pode incentivar os membros da equipe presentes nas redes sociais da paciente, que assim desejarem, a utilizar as mesmas como canal de esclarecimento à população.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165593](https://www.4000165594.com.br)

Questão 52 Invaginação intestinal Pediatria Intussuscepção ou Invaginação Intestinal

Lactente, sexo feminino, 2 meses e 15 dias de idade, é trazida ao serviço de emergência devido a quadro de irritabilidade, vômitos e ausência de evacuação há um dia. Trata-se de criança nascida de termo, sem intercorrências perinatais, em aleitamento materno complementado com fórmula láctea de partida desde a alta da maternidade. Apresenta vacinação em dia de acordo com o calendário nacional. Ao exame clínico, está em regular estado geral, descorada 1+/4+, e apresenta episódios de choro inconsolável. Após exame de toque retal, a paciente eliminou evacuação conforme a imagem a seguir:



Qual das opções abaixo confirmará a principal hipótese diagnóstica?

- A Teste de exclusão de proteína de leite de vaca.
- B Realização de ultrassonografia de abdome.
- C Coleta de coprocultura e pesquisa de toxina de *Clostridium difficile*.
- D Realização de radiografia de abdome em posição ortostática e decúbito dorsal.

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165592](https://www.4000165592.com.br)

Questão 53 Icterícia neonatal Pediatria

Recém-nascido, sexo masculino, 5 dias de vida, está em retorno ambulatorial breve para reavaliação de icterícia. Trata-se de criança nascida de termo (39 semanas), parto vaginal, Apgar 9/9, peso de nascimento de 3.250 g, bolsa rota uma hora antes do parto. Pré-natal sem anormalidades. A tipagem sanguínea do recém-nascido e de sua mãe foram O positivo, e o teste de Coombs direto foi negativo. Evoluiu sem intercorrências na maternidade e recebeu alta hospitalar com 48 horas de vida e em aleitamento materno exclusivo. No momento, está em aleitamento materno exclusivo, pesando 2.850 g, ictérico zona III de Kramer, sendo o restante do exame clínico normal. Colhido o exame de bilirrubina indireta que foi de 11 mg/dL. A conduta recomendada neste caso é:

- A Indicar internação hospitalar para fototerapia e coleta de hemograma, reticulócitos e G6PD.
- B Solicitar ultrassonografia de abdome superior e programar biópsia hepática.
- C Orientar aleitamento materno mais frequente e reavaliação em 48 a 72 horas.
- D Substituir aleitamento materno por fórmula parcialmente hidrolisada e reavaliação em 5 dias.

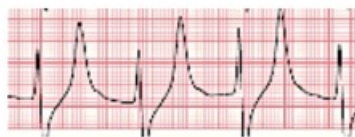
Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165592](https://www.4000165592.com.br)

Questão 54 Glomerulonefrite pósestreptocócica Pediatria

Pré-escolar, sexo masculino, 4 anos de idade, há 4 semanas começou a apresentar pequenas lesões de pele em face, que posteriormente progrediram para outras regiões do corpo. Mãe notou que a criança respira com dificuldade e está com o rosto inchado há dois dias. Trazido hoje ao Pronto-Socorro, pois está mais sonolento e sem diurese há 24 horas. Na triagem, apresenta os seguintes dados vitais: FC: 65 bpm, FR: 45 irpm e PA: 140/90 mmHg, Sat O₂: 94% em ar ambiente. Encaminhado à sala de emergência, onde se notou edema de face e ausculta pulmonar com estertores crepitantes em ambas as bases, sem outras alterações significativas. Seguem abaixo as imagens das lesões de pele do paciente e do ritmo cardíaco identificado.



Qual das alternativas abaixo apresenta as medidas necessárias para estabilização inicial do paciente?

- A Oxacilina, clindamicina e soro fisiológico 20 mL/kg.
- B Ceftriaxona, bicarbonato de sódio e soro fisiológico 20 mL/kg.
- C Ventilação com pressão positiva, seguida de compressões torácicas e atropina.
- D Gluconato de cálcio, diurético de alça e restrição hídrica.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165590](https://www.4000165590.com.br)

Questão 55 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria

Durante a consulta de um bebê de 2 meses de idade, nota-se que a mãe, ao trocar a fralda do bebê, fala com ele num linguajar infantilizado (“manhês”). Como esta atitude é considerada?

- A Desnecessária, pois nesta idade não é possível reconhecer a fala.
- B Adequada, por denotar um bom vínculo entre a mãe e a criança.
- C Prejudicial, porque é um estímulo para o desenvolvimento inadequado da fala.
- D Inadequada, porque a linguagem expressiva se manifesta próximo aos 12 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165589](https://www.4000165589.com.br)

Questão 56 Mastoidite

Pré-escolar, sexo masculino, 2 anos e 9 meses de idade, sem comorbidades prévias, está com tosse e coriza há 7 dias. Há 5 dias iniciou com febre de até 38,8°C e otalgia à esquerda. Procurou um serviço médico há dois dias, sendo feito diagnóstico de otite média aguda à esquerda, com orientação de uso de azitromicina por 5 dias. Está no segundo dia de tratamento, mantendo febre. Ao exame clínico, destacam-se as imagens abaixo. Qual é a conduta indicada?



Região retroauricular esquerda:



- A Iniciar tratamento com ceftriaxona e clindamicina endovenosas e solicitar tomografia de mastoide e crânio.
- B Manter tratamento atual e considerar escalonar antibiótico se febre persistir além de 72 horas.
- C Trocar antibioticoterapia para amoxicilina com clavulanato oral e reavaliar em 48 a 72 horas.
- D Iniciar oxacilina endovenosa e realizar a drenagem percutânea da região retroauricular esquerda.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165588](#)

Questão 57 Programa Nacional de Imunizações Pediatria

Lactente, sexo masculino, 2 meses de idade, nasceu com atresia duodenal, está internada desde o nascimento. Neste período de 2 meses, foi submetido a abordagem cirúrgica, recebeu nutrição parenteral e desenvolveu infecção de cateter central tratada com sucesso. Encontra-se agora em condições clínicas de transição para dieta oral. Como ainda não tem previsão de alta hospitalar, a equipe deseja manter a vacinação atualizada durante a internação. A criança já recebeu as vacinas de BCG e hepatite B ao nascimento. Quais são as vacinas indicadas neste momento considerando o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e os dados clínicos fornecidos?

- A Pneumocócica 10 valente, tetravalente (DPT e hemófilos B), inativada de poliomielite (VIP) e rotavírus.
- B Pneumocócica 10 valente, pentavalente (DPT, hepatite B e hemófilos B) e inativada de poliomielite (VIP).
- C Pneumocócica 10 valente, meningocócica C, rotavírus e palivizumabe.
- D Pneumocócica 10 valente, pentavalente (DPT, hepatite B e hemófilos B).

4000165587

Questão 58 Piorrite

Escolar, sexo masculino, 5 anos de idade, sem comorbidades prévias, é levado ao Pronto-Socorro por febre de até 39,5°C e claudicação dolorosa à esquerda há 2 dias. Nega trauma local. Mãe refere também que a criança apresentou quadro de tosse, coriza e odinofagia há 14 dias, já resolvido. Ao exame clínico, criança em regular estado geral, membro inferior esquerdo em flexão, abdução e rotação externa da articulação coxo-femoral (conforme imagem abaixo) com dor intensa à manipulação, membro inferior direito sem limitação funcional e sem dor à manipulação, ausência de outras alterações significativas ao exame clínico. Qual é a conduta indicada com base na hipótese diagnóstica mais provável?



- A Alta hospitalar com anti-inflamatório, orientação de sinais de alarme e reavaliação em 48 a 72 horas.
- B Coleta de FAN, fator reumatoide, anti-DNA, anti-RO, anti-LA, VHS e início de corticoterapia.
- C Realização de eletrocardiograma, ecocardiograma, anti-estreptolisina-O e prescrição de penicilina benzatina.
- D Internação hospitalar, coleta de triagem infecciosa e introdução de ceftriaxona e oxacilina endovenosas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165586](https://www.4000165586.com.br)

Questão 59 DNPM Desenvolvimento NeuroPsicoMotor Pediatria Marcos Importantes

Lactente, sexo feminino, 11 meses de vida, está em consulta ambulatorial de rotina. Trata-se de criança prematura, nascida de 35 semanas, com peso de nascimento de 2110 g, sem intercorrências durante o seguimento. Na consulta de hoje, a maior preocupação da mãe é que a criança não engatinha. Na avaliação realizada na consulta, notado que a criança imita a mãe ao bater palmas, faz movimentos de pinça para pegar objetos, reage a uma conversa como se estivesse respondendo, mas com sons incompreensíveis, sem falar nenhuma palavra. Ela fica em pé com apoio, mas realmente não engatinha quando colocada de bruços.

Qual das alternativas contempla, respectivamente, a avaliação do desenvolvimento e a conduta indicada?

- A O atraso do desenvolvimento é justificado pela prematuridade, orientar estimulação motora e retorno precoce.
- B O desenvolvimento motor está atrasado mesmo se considerada a prematuridade, encaminhar para seguimento com fisioterapia.
- C O desenvolvimento está compatível com o esperado para a idade, sem necessidade de nenhuma intervenção específica.
- D O desenvolvimento motor e de linguagem estão atrasados para a idade, iniciar investigação com eletroencefalograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165585](https://www.4000165585.com.br)

Questão 60 Febre sem sinais localizatórios FSSL Infecção do Trato Urinário Pediatria

Lactente, sexo feminino, 8 meses de idade, sem comorbidades prévias, foi atendida em Pronto-Socorro Infantil há 3 dias, com quadro de febre de até 39,5°C por 2 dias, associado a baixa aceitação alimentar. A mãe não notou nenhum outro sintoma associado. Ao exame clínico estava em bom estado geral e sem nenhuma alteração significativa. Considerado quadro de febre sem sinais localizatórios, colhida uroanálise e urocultura por sondagem vesical de alívio. Resultado da uroanálise: pH 5,5, densidade 1020, leucócitos 85.000/mm³, hemácias 15.000/mm³, nitrito negativo. Introduzido amoxicilina com clavulanato e solicitado retorno em 72 horas para

reavaliação e checagem de urocultura. Hoje, na reavaliação, mãe refere que a paciente está tomando a medicação adequadamente, evoluindo afebril há 24 horas e sem novas queixas, exceto pelo surgimento de lesões maculopapulares eritematosas, em tronco, notadas há 12 horas.

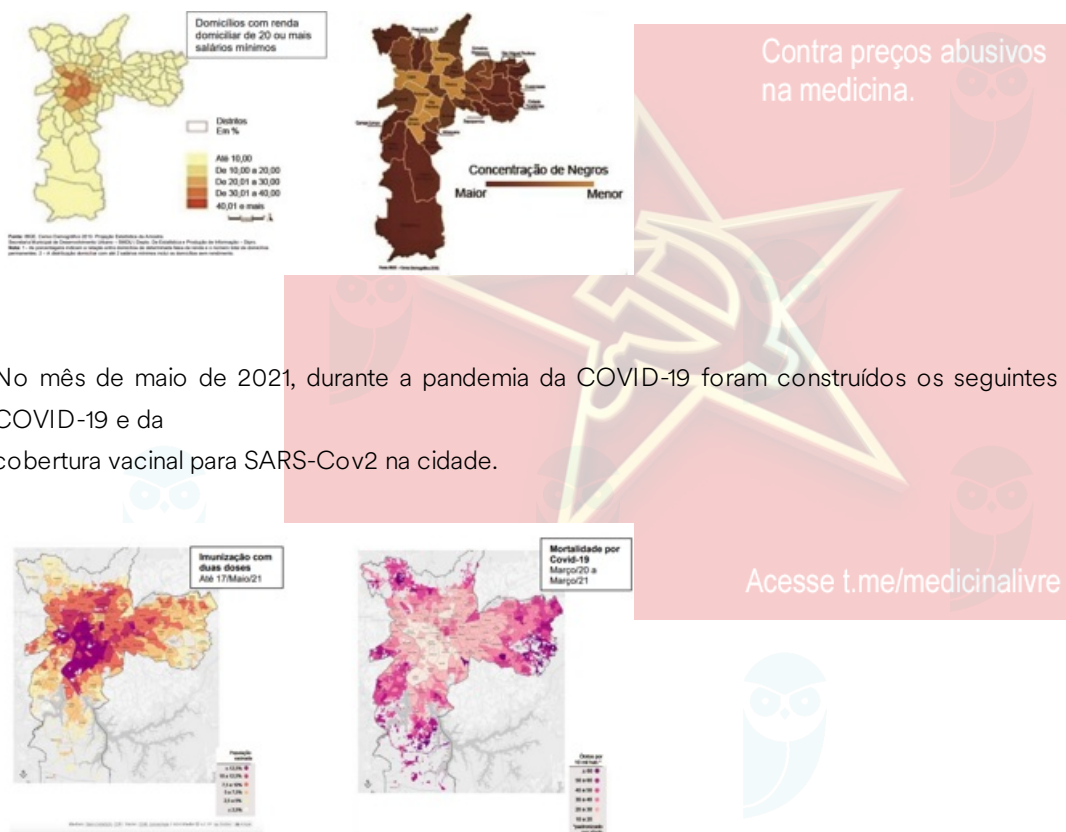
Urocultura com resultado final negativo. Qual é a conduta adequada?

- A Manter antibiótico atual e associar anti-histamínico oral de segunda geração.
- B Trocar tratamento atual para uma opção de antibiótico não beta-lactâmico.
- C Suspender antibioticoterapia e liberar sem nenhum tratamento específico.
- D Colher nova uroanálise para definir a necessidade de manter tratamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165584](https://www.4000165584.com.br)

Questão 61 COVID 19 Índice de Vulnerabilidade Social IVS

O município de São Paulo tem 12,4 milhões de pessoas e a seguinte distribuição de renda e raça entre seus vários distritos administrativos:



No mês de maio de 2021, durante a pandemia da COVID-19 foram construídos os seguintes mapas de mortalidade por COVID-19 e da cobertura vacinal para SARS-Cov2 na cidade.

Qual a afirmação possível com relação às estratégias de prevenção da COVID-19 no município de São Paulo?

- A A definição de critérios de prioridade para a vacinação baseada em idade e comorbidade contribuiu para o aumento da vulnerabilidade na dimensão programática.
- B A dimensão individual da vulnerabilidade não foi considerada nas estratégias de prevenção, uma vez que as estratégias de prevenção foram vacinas, uso de máscaras e controle de contactantes.
- C A dimensão programática da vulnerabilidade está voltada para ações de saúde que visam o seguimento das populações, como pessoas com doenças crônicas e crianças, não se aplicando a contextos de pandemia.
- D A dimensão social da vulnerabilidade relacionada à raça, renda e acesso aos serviços de saúde não foi considerada nas estratégias de vacinação da pandemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165583](#)

Questão 62 COVID 19

Médico atende na Unidade Básica de Saúde (UBS) um adolescente de 17 anos de idade com história de 4 dias de febre, cefaleia e mialgia, sem comorbidades. Ao exame físico:

Bom estado geral, febril (temperatura de 38,5°C), desidratado, eupneico.

Pressão arterial de 118 x 78 mmHg (em pé e deitado), frequência cardíaca de 90 bpm.

Saturação de oxigênio 96%.

Ausculata cardíaca e pulmonar sem alterações.

Abdome flácido, sem visceromegalias.

Ausência de edema.

Prova do laço negativa.

O teste rápido NS1 para dengue está negativo. Além de prescrever antitérmicos e afastá-lo das atividades laborais, deve-se:

- A Solicitar RT-PCR para SARS-CoV2, hidratação via oral, encaminhar para realização de hemograma no pronto-atendimento e notificar suspeita de COVID-19.
- B Solicitar teste rápido de antígeno SARS -CoV2, encaminhar para pronto-atendimento para realização de hemograma e hidratação endovenosa, notificar suspeita de dengue e COVID-19.
- C Solicitar teste rápido de antígeno para SARS -CoV2, realizar hidratação endovenosa na própria UBS e aguardar para notificar a suspeita COVID-19.
- D Solicitar RT-PCR para SARS -CoV2, hidratação via oral e notificar suspeita de dengue e COVID-19.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165582](#)

Questão 63 Medicina Preventiva Odds Ratio ou Razão de Chances

A vacinação anual contra influenza é indicada para idosos acima de 65 anos. Para analisar a possível associação entre a vacinação contra influenza e o risco de demência, foi realizado um estudo de coorte com 123.747 participantes. Com base nos resultados apresentados, assinale a alternativa correta. Tabela – Resultados (risco relativo e seu intervalo de 95% de confiança) das estimativas de associação entre vacinação contra influenza versus não vacinação e incidência de demência.

Situação vacinal	Número	Risco relativo (IC 95%)
Não vacinado	56.925	1,00 (referência)
Vacinado com 1 dose	7.228	1,04 (0,98 – 1,10)
Vacinado com 2 doses	9.041	0,99 (0,95 – 1,04)
Vacinado com 3 a 5 doses	27.358	0,97 (0,93 – 1,00)
Vacinado com ≥ 6 doses	23.195	0,88 (0,83 – 0,94)
Vacinado com pelo menos uma dose	66.822	0,86 (0,83 – 0,88)

- A Não se observou associação entre vacinação contra influenza e o risco de demência.
- B A vacinação contra influenza aumentou o risco de demência.
- C A redução do risco de demência após a vacinação não é significativa.
- D A vacinação repetida contra influenza reduziu o risco de demência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165581](https://www.4000165581.com.br)

Questão 64 Principais marcos legais do SUS Lei n 81421990 Constituição Federal CF1988

O controle social no Sistema Único de Saúde é exercido por meio de conferências e conselhos de saúde. Qual é a alternativa correta?

- A Sindicatos, conselhos profissionais e associações de pacientes não podem compor os conselhos de saúde municipais.
- B Prestadores de serviços privados conveniados ao SUS podem fazer parte dos conselhos e conferências de saúde.
- C As conferências de saúde surgiram com a Constituição de 1988 e ocorrem a cada 4 anos.
- D A composição do conselho de saúde é de um terço para cada categoria, com partes iguais entre usuários, gestores e trabalhadores da saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165580](https://www.4000165580.com.br)

Questão 65 Financiamento em Saúde Outras normativas do SUS e da Saúde em geral

O Sistema Único de Saúde (SUS) é marcado por relações entre o público e o privado tanto no financiamento das atividades e ações de saúde quanto na prestação, acesso e uso de serviços. Qual é a alternativa correta sobre a relação público-privada na saúde no Brasil?

- A As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis de Imposto de Renda de Pessoas Físicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte a médicos, dentistas e outros profissionais da saúde, mas não incluem pagamentos de mensalidades de planos e seguros de saúde.
- B Os hospitais filantrópicos, para que tenham direito ao título de filantropia e gozem de isenções de contribuições sociais, fiscais e tributárias, precisam atender exclusivamente (80% dos leitos) pacientes do SUS.
- C Pacientes usuários de planos de saúde, desde que tenham cobertura de assistência farmacêutica assegurada pelo plano, também têm direito a acessar e retirar medicamentos em unidades ou farmácias públicas do SUS se a prescrição for ratificada por um serviço do sistema público.
- D O ressarcimento ao SUS ocorre quando os atendimentos prestados aos beneficiários de planos de saúde forem realizados em estabelecimento do SUS e instituições conveniadas ou contratadas pelo SUS. São ressarcidos apenas procedimentos cobertos nos contratos dos planos de saúde com usuários.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165579](https://www.4000165579.com.br)

Questão 66 Método Clínico Centrado na Pessoa

Qual é a alternativa correta quanto ao Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP)?

- A É uma forma de organizar as consultas, que considera a expectativa dos médicos e das pessoas. É uma consulta que pode ser realizada em condições crônicas ou agudas.
- B Refere-se à atitude ética do profissional na consulta, que coloca as vontades da pessoa atendida como prioridade. É uma consulta mais longa do que a centrada no diagnóstico.
- C A primeira etapa do MCCP é compreender a pessoa como um todo, seu contexto próximo e distante. É bastante apropriada para consultas em saúde mental, sejam em consultas agendadas ou não.
- D É uma abordagem de consulta que visa descobrir a demanda oculta da pessoa. É uma consulta realizada principalmente em consultas agendadas de acompanhamento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165578](https://www.4000165578.com.br)

Questão 67 Incidência e Prevalência Medicina Preventiva

O médico responsável pela Vigilância Epidemiológica de um município foi chamado para estabelecer se está ocorrendo uma epidemia, uma vez que vem ocorrendo um grande aumento na procura aos serviços de saúde devido à ocorrência de casos de uma doença respiratória não bem definida. Após investigações iniciais, foi estabelecida a definição de caso e critérios para o diagnóstico de forma a orientar a investigação.

Uma vez que esses requisitos foram atendidos, qual instrumento metodológico é utilizado em vigilância epidemiológica para estabelecer a existência ou não da epidemia?

- A Comparação da prevalência nesse município com a de anos anteriores.
- B Comparação da incidência observada nesse município com municípios vizinhos.
- C Comparação da incidência atual nesse município com a de anos anteriores.
- D Comparação da prevalência observada nesse município com municípios vizinhos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165577](https://www.4000165577.com.br)

Questão 68 NNT

O uso regular de protetor solar evita o carcinoma espinocelular cutâneo no longo prazo, mas o efeito sobre o melanoma é

controverso. A aplicação no longo prazo de protetor solar e o risco de melanoma cutâneo foi avaliada num ensaio prospectivo, randomizado e controlado. Na Austrália, 1600 residentes foram aleatoriamente distribuídos em um grupo de aplicação diária ou um grupo de aplicação à vontade de protetor solar na cabeça e nos braços durante 4 anos. Os participantes foram acompanhados durante 14 anos para verificar a ocorrência de melanoma primário. Nesse tempo, 8 novos casos de melanoma primário foram identificados no grupo de proteção solar diária (n=800) e 16 foram identificados no grupo de proteção solar a vontade (controle) (n=800).

Quantos indivíduos precisariam utilizar o protetor solar diariamente para evitar um caso adicional de melanoma primário nessa comunidade?

- A 10.
- B 32.
- C 64.
- D 100.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165576](https://www.4000165576.com)

Questão 69 Medicina Preventiva Tipos de Estudos Epidemiológicos Odds Ratio ou Razão de Chances

A CORONAVAC é uma vacina inativada e adjuvantada contra o SARS-CoV-2, desenvolvida pela farmacêutica SINOVA. Em estudo realizado em 16 centros de pesquisa clínica no Brasil, Palácios et al demonstraram uma prevenção de infecção sintomática confirmada por RT-PCR pelo SARS-CoV-2 de 50,7% (IC95%: 36,0% - 62,0%). Em estudo clínico realizado em 24 centros na Turquia a eficácia da CORONAVAC para o mesmo desfecho foi de 83,5% (IC95%: 65,4% - 92,1%). Já no Chile, a efetividade da CORONAVAC em mais de cinco milhões de vacinados foi de 65,9% (IC95%: 65,2% - 66,6%) na prevenção de infecção sintomática laboratorialmente confirmada pelo SARS-CoV-2 (98,1% dos casos confirmados por RT-PCR e 1,9% por teste de antígeno).

Quais são as razões que poderiam explicar a diferença observada nos três estudos?

- A O delineamento e os objetivos dos três estudos são diferentes.
- B Os três ensaios clínicos não são comparáveis entre si.
- C A diferença entre os resultados não é significativa.
- D Vacinas de vírus atenuados apresentam baixo desempenho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165576](https://www.4000165576.com)

Questão 70 Medicina Preventiva Atenção Primária à Saúde APS no Brasil Abstinência de Alcool

Médico está realizando seu primeiro plantão numa Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h numa cidade com 200 mil habitantes. Essa cidade tem a seguinte rede de saúde:

100% de cobertura de Estratégia de Saúde da Família (ESF)
1 Núcleo de Apoio de Saúde da Família para cada 6 equipes da ESF, composto por fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psiquiatra, educador físico e assistente social
1 Centro de Apoio Psicossocial para adultos 24h com 6 leitos (CAPS-adulto)
1 Centro de Apoio Psicossocial da Infância e Juventude (CAPS-IJ)
1 Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS-AD)

1 Centro de Referência em Reabilitação com ambulatório de ortopedia, fisioterapia, acupuntura, fisioterapia e terapia ocupacional
1 Hospital Geral de porte secundário com 200 leitos com Pronto-Socorro e enfermaria de clínica médica, pediatria, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia vascular e ortopedia. Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade de Terapia Intensiva de Adultos e de Pediatria e uma Unidade de Neonatologia
1 Casa de Parto com enfermeiras obstetrias, parteiras e doulas
1 Centro de especialidade ambulatorial com: pré-natal de alto risco, otorrinolaringologia, oftalmologia, nefrologia, dermatologia e cardiologia.
1 UPA 24h para adultos e crianças, com sala de emergência, retaguarda com 8 leitos e ambulância.

Contra preços abusivos na medicina.

Após atender um paciente na UPA, o médico fez uma carta de contrarreferência. Qual a alternativa correta, considerando os princípios de organização das redes de saúde?

- A** Idoso com dor lombar crônica há 7 anos. Tomografia com osteófitos em coluna lombar. Realizada analgesia. Encaminhado à ortopedia e fisioterapia.
- B** Adulto em observação por abstinência alcoólica com melhora dos sintomas. Exames normais. Prescrito benzodiazepínicos. Encaminhado à Estratégia de Saúde da Família.
- C** Criança com atraso escolar e suspeita de autismo encaminhada ao CAPS-IJ. Orientação aos pais que não há urgência.
- D** Gestante primigesta, realizou diagnóstico de sífilis secundária no Pronto-Socorro. Realizada primeira dose de penicilina. Encaminhada ao pré-natal de alto risco.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165574](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 71 Estudos Ecológicos

Entre 2013 e 2018 o Ministério da Saúde implantou o Programa Mais Médicos (PMM), para aumentar a oferta de médicos da atenção básica, em áreas carentes do país. Foi realizado um estudo para investigar a associação entre o PMM e resultados de saúde infantil. Foram analisados os dados dos 5.565 municípios brasileiros ao longo de 12 anos (2007 a 2018), comparando resultados de saúde infantil (taxa de mortalidade infantil e taxa de mortalidade neonatal) entre municípios que receberam médicos do PMM e aqueles que não os receberam.

Qual é o tipo de estudo que foi realizado?

- A Coorte prospectiva.
- B Ecológico.
- C Coorte retrospectiva.
- D Transversal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165573](#)

Questão 72 Quimioprofilaxia

Homem com doença meningocócica mora com três pessoas (esposa de 34 anos, um filho de 14 anos e uma filha de 4 anos) e trabalha num escritório, 6h por dia, no mesmo ambiente, com 5 adultos. Segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, como deve ser realizada a quimioprofilaxia para prevenção de casos secundários da doença?

- A Todos os adultos e crianças, incluindo pessoas do trabalho e domicílio, com rifampicina.
- B Todas as pessoas do domicílio, com rifampicina, e bloqueio vacinal para as pessoas do trabalho.
- C Todas as pessoas do domicílio e profissionais de saúde que tiveram qualquer contato com paciente, com rifampicina.
- D Todas as crianças e adultos que moram com o paciente, com rifampicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165572](#)

Questão 73 Tratamento

Homem, 32 anos, trabalhador do sexo, procura atendimento com queixa de lesão discretamente dolorosa na região do pênis há 2 dias. Última relação sexual há 5 dias. Nega infecções sexualmente transmissíveis prévias. Sempre usa preservativo com clientes, mas não com sua esposa. Tem relação apenas com mulheres, com penetração insertiva (anal e vaginal) e sexo oral (faz e recebe). A lesão é apresentada.



O teste rápido para HIV foi não reagente. Além das sorologias para infecções sexualmente transmissíveis, qual é o tratamento e a estratégia preventiva nesse momento?

- A Ceftriaxona e azitromicina; oferecer profilaxia pré-exposição para o HIV; checar vacinas para hepatite B.
- B Ceftriaxona e azitromicina; oferecer profilaxia pós-exposição para o HIV, checar vacinas para hepatite A e B
- C Azitromicina e penicilina benzatina; oferecer profilaxia pós-exposição para o HIV; checar vacinas para hepatite B.
- D Azitromicina e penicilina benzatina; oferecer profilaxia pré-exposição para o HIV; checar vacinas para hepatite A e B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165571](https://www.4000165571.com.br)

Questão 74 Responsabilidade profissional Sigilo profissional Ética Médica

Jéssica é uma paciente que mora em uma região de baixa renda. Ela é acompanhada desde a infância na Estratégia de Saúde da Família. Hoje ela tem 23 anos e procura o médico chorosa, pois há alguns dias realizou o teste de gravidez que veio positivo. Refere atraso menstrual de 10 semanas e pretende interromper a gestação. Já entrou na internet e verificou onde conseguir as medicações. Tem apoio de uma amiga muito próxima com quem tem conversado bastante há vários dias. Está muito preocupada com medo de que sua família e seu ex-namorado, com quem já terminou o relacionamento, descubram a gravidez. Considerando as Diretrizes do Ministério da Saúde e o Código de Ética Médica, deve-se acolher Jéssica em:

- A Sua decisão e orientar sobre os riscos dos métodos, caso decida interromper a gestação.
- B Seu sofrimento e sugerir que converse com seu ex-namorado, pois é direito dele saber sobre a gravidez para tomarem uma decisão juntos.
- C Seu sofrimento, mas afirmar que pela interrupção da gestação ser um procedimento proibido pela lei, você precisa notificar a justiça.
- D Sua decisão, mas afirmar que o Código de Ética lhe impede de outras ações além disso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165571](https://www.4000165571.com.br)

Questão 75 Terminologia

Existem alguns conceitos que permitem compreender a diversidade sexual e qualificar o cuidado de pessoas LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, *queer*, intersexo e assexuais). Assinale a alternativa que apresenta a definição e exemplos corretos sobre um desses conceitos:

- A A orientação sexual se refere a com quem a pessoa tem relações sexuais. Exemplo: heterossexual, bissexual ou homossexual.
- B A identidade de gênero é autodeclarada e se refere à compreensão que a pessoa tem do seu gênero. Exemplo: homem cis, mulher trans e travesti.
- C A identidade de gênero é definida socialmente a partir de como a pessoa expressa seu gênero. Exemplo: gay, lésbica e travesti.
- D A orientação sexual é autodeclarada e se refere a como a pessoa expressa sua sexualidade. Exemplo: assexual, pansexual e intersexo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165569](https://www.4000165569.com.br)

Questão 76 Hipertensão Arterial Sistêmica HAS

Paulo é um paciente de 48 anos e está em uso de captopril 25 mg a cada 12h há 6 anos e vem à sua primeira consulta ambulatorial.

Refere que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS) no Pronto-Socorro após uma forte cefaleia e

pressão arterial de 180 x 100 mmHg, quando introduziram essa medicação. Desde então sua pressão está controlada ao redor de 130 x 80 mmHg. Realizou exames há 10 meses solicitados por outro profissional, todos normais. Ele tem muito medo de um “derrame”, pois seu pai morreu de um acidente vascular cerebral aos 72 anos e seu avô aos 78 anos. Nega tabagismo, etilismo, outras doenças ou sintomas. Qual deve ser a conduta a ser proposta para Paulo nessa consulta?

- A Manter a dose da medicação; solicitar exames de controle para HAS.
- B Suspender a medicação; fazer controle da pressão arterial.
- C Checar a adesão à medicação; solicitar exames de controle para HAS.
- D Reduzir a dose da medicação; solicitar eletrocardiograma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165568](#)

Questão 77 Epidemiologia

Qual é a alternativa correta em relação à estrutura epidemiológica da esquistossomose?

- A O ser humano infectado elimina ovos viáveis nas fezes por toda a vida.
- B As cinco espécies de *Schistosoma* que infectam seres humanos estão presentes no Brasil.
- C Envolve três espécies: o helminto, o ser humano e um vetor.
- D A infecção humana ocorre pela penetração ativa do agente através da pele íntegra.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165567](#)

Questão 78 Sigilo profissional Ética Médica Relação com pacientes e familiares

Médico que trabalha numa equipe de Estratégia de Saúde da Família e atende todos os membros de família: Jorge (pai), Tereza (esposa), Jéssica (filha, com 4 anos) e Enzo (filho, 6 anos). Tereza tem diagnóstico de transtorno depressivo maior e está disputando a guarda dos seus filhos com Jorge, de quem está em processo de divórcio. Ela solicita cópia do seu próprio prontuário e dos filhos para anexar ao processo judicial e comprovar o transtorno depressivo, os relatos de maus tratos do marido e dificuldades com a educação das crianças que ela informou em consultas anteriores. Baseado no Código de Ética Médica, qual deve ser a conduta?

- A Fornecer a cópia do prontuário de Tereza, mas a do prontuário dos filhos somente após a autorização por escrito também de Jorge.
- B Fornecer a cópia do prontuário de Tereza, mas a dos filhos apenas após a autorização judicial, por se tratar de um processo legal.
- C Fornecer a cópia do prontuário de Tereza e dos filhos, mas apenas após a autorização por escrito de Tereza.
- D Fornecer a cópia do prontuário de Tereza e dos filhos, mas apenas após consultar Jorge, por se tratar de um processo legal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165566](#)

Questão 79 Medicina Preventiva Vigilância Epidemiológica

Com o aumento das coberturas vacinais no Brasil, a partir do final da década de 1990, observou-se uma marcante redução na incidência das doenças preveníveis por vacinação. Isso não se verificou em relação à coqueluche. Na década passada (2011 – 2020) o número médio anual de casos confirmados no país foi acima de 3.000. Qual é uma das razões para este comportamento?

- A A imunogenicidade das vacinas para infecções bacterianas é baixa.
- B O predomínio de linhagens da *Bordetella pertussis* que escapam da vacina.
- C A concentração de casos em menores de um ano antes do reforço vacinal.
- D A incorporação da biologia molecular ao arsenal diagnóstico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165565](#)

Questão 80 **Tabaco**

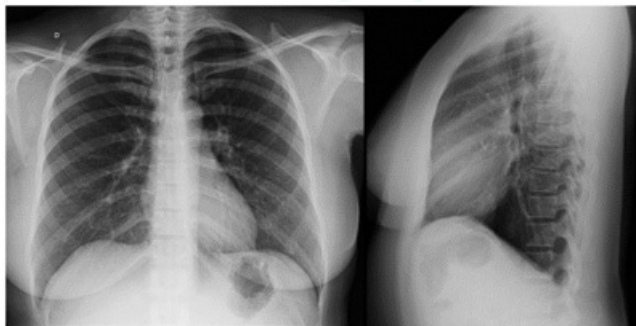
A primeira consulta de gestante de 23 anos, em situação de rua, foi realizada com 14 semanas. Nessa consulta verifica-se que ela fuma 4 cigarros por dia, o primeiro no período da tarde. A paciente afirma que até gostaria de parar de fumar, mas que não consegue, pois já tentou outras vezes e não conseguiu. Qual é a primeira abordagem recomendada pelo Ministério da Saúde para esse tipo de situação?

- A Verificar como foram as tentativas anteriores e orientar estratégias de tratamento durante a gestação.
- B Orientar sobre os riscos e encaminhar para grupo de apoio da unidade básica de saúde.
- C Registrar a dificuldade da cessação do tabagismo e encaminhá-la para o pré-natal de alto risco.
- D Avaliar o nível de dependência pelo escore de Fagerström e notificar a assistência social.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165564](#)

Questão 81 **Asma ocupacional x asma relacionada ao trabalho Asma relacionada ao trabalho Asma**

Mulher de 22 anos de idade trabalha como auxiliar de limpeza em um grande hospital há 2 anos. Hoje procura ambulatório de clínica médica pois há 6 meses apresenta episódios de tosse e, às vezes, falta de ar durante o dia, que costumam melhorar à noite. Estes episódios estão se tornando mais frequentes. Não costuma apresentar tais sintomas aos finais de semana. Não sabe referir se teve febre. Nega antecedentes morbidos relevantes e nunca fumou. Ao exame clínico presença de discretos sibilos expiratórios à ausculta pulmonar, sem outras alterações relevantes. A radiografia de tórax realizada há 15 dias é apresentada.



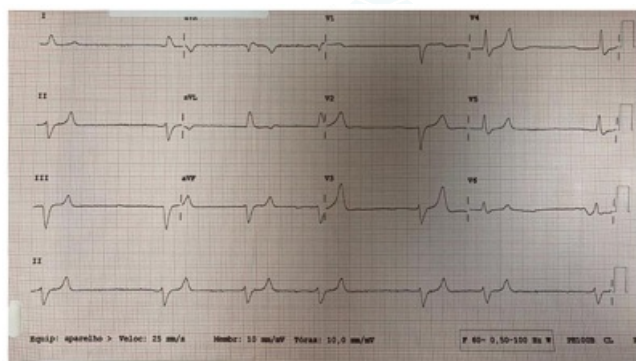
Qual é a conduta, considerando a principal hipótese diagnóstica?

- A** Solicitar que faça a medida de Pico de Fluxo no trabalho e em casa.
- B** Afastamento das atividades laborais por 1 semana e prednisona oral por 5 dias.
- C** Solicitar tomografia de tórax e iniciar broncodilatador de longa duração.
- D** Prescrever salbutamol para sintomas e orientar para mudança da área de atuação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165563

Questão 82 • Distúrbios eletrolíticos

Mulher de 66 anos de idade, diabética e hipertensa, em uso de enalapril e metformina, comparece a consulta ambulatorial com queixa de astenia e turvação visual há 2 dias. É encaminhada ao Departamento de Emergência após realizar o seguinte eletrocardiograma.



Qual deve ser a conduta imediata?

- A Atropina.
- B Marcapasso transcutâneo.
- C Gluconato de cálcio.
- D Trombólise.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165562](#)

Questão 83 Eletrocardiograma

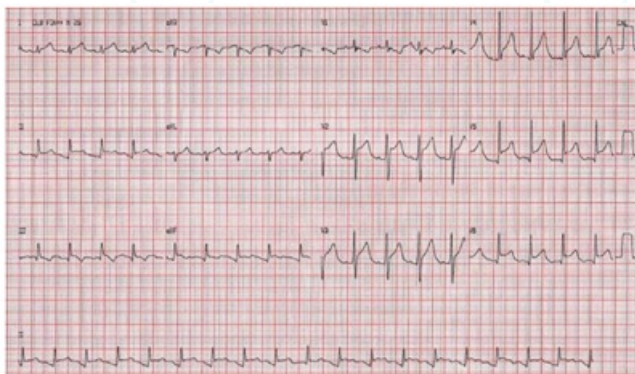
Mulher de 55 anos de idade, procura o Pronto-Socorro com queixa de dor torácica precordial de moderada intensidade, contínua, há 1

dia. A dor iniciou durante atividade física. Não notou irradiação, fatores de melhora ou de piora. Ao exame clínico apresenta frequência

cardíaca de 115 bpm, pressão arterial 130/80 mmHg em todos os membros, com pulsos simétricos. Frequência respiratória 18 irpm.

Não há alterações na semiologia cardíaca ou pulmonar. O restante do exame clínico é normal. Solicitado o eletrocardiograma a seguir.

Qual é a hipótese diagnóstica?



- A Infarto agudo do miocárdio.
- B Hipercalemia.
- C Tromboembolismo Pulmonar.
- D Pericardite.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165561](https://www.4000165561.com.br)

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Questão 84 Anatomia Embrilogia e Radiologia dos Seios Panarasais

Mulher de 35 anos de idade deu entrada no Pronto-Socorro com cefaleia e febre não medida há 5 dias. Tentou utilizar vários analgésicos sem melhora. No exame clínico apresenta T 38°C, FC 100 bpm, sem outras alterações. Foi realizada a tomografia computadorizada mostrada a seguir.



Qual é o diagnóstico?

- A Meningoencefalite.
- B Sinusite.
- C Normal para a idade.
- D Osteomielite.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165560](https://www.4000165560.com.br)

Questão 85 Ortopedia Avaliação dos Exames de Imagem

Homem de 65 anos de idade, pedreiro aposentado, vem para consulta com clínico geral referindo quadro de dor lombar há aproximadamente 2 semanas. Refere que o quadro é caracterizado por dor de forte intensidade, com irradiação para ambos os membros inferiores abaixo dos joelhos, associada a parestesias. Relata ainda dificuldade de ereção e redução da sensibilidade em região perianal. Nega alteração da intensidade da dor ao longo do dia. Ao exame clínico: Déficit motor assimétrico distal nas pernas e pés, com redução de força à dorsiflexão e flexão plantar dos pés e dos artelhos. Reflexos aquileus e patelares abolidos. Hipoestesia “em sela” na região perineal. Desencadeamento de dor irradiada à flexão de quadril a 45° com joelhos estendidos. Apresenta incapacidade de permanecer na ponta dos pés. O exame físico mostra massa em hipogástrio. Nega febre, perda ponderal, antecedente pessoal ou familiar de neoplasia maligna.

- A O quadro sugere lesão de cauda equina, devendo ser solicitada ressonância magnética de coluna lombossacra.
- B O quadro sugere lesão compressiva de medula torácica, devendo ser investigada a etiologia inflamatória ou infecciosa.
- C O quadro é característico da síndrome de Guillain-Barré (polirradiculoneurite aguda), devendo ser solicitada eletroneuromiografia e iniciada gamaglobulina endovenosa.
- D O quadro é sugestivo de neoplasia metastática intramedular em topografia de medula cervical, relacionado a possível neoplasia prostática.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165559

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Questão 86 Transtorno do Humor Bipolar THB Diagnóstico do Transtorno do Humor Bipolar THB

Transtornos do Humor

Mulher de 20 anos de idade chega ao serviço de emergência informando ter sido agredida por pessoa no ônibus. O contato inicial é difícil, pois a paciente está agitada, preocupada e falando rapidamente. Ela informa que o agressor a estava perseguindo desde o ponto de embarque. A paciente recebeu notícia sobre uma herança há quatro dias, e desde então não consegue dormir. Há três dias, pediu demissão do emprego de faxineira por achar que sua “patroa estava roubando seu dinheiro para pagar contas da casa”. Nos últimos dois dias, com a expectativa de receber o dinheiro, gastou cerca de 2 mil reais em vários pares de sapatos de 3 lojas diferentes.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso?

- A Transtorno de personalidade borderline.
- B Reação aguda ao estresse.
- C Síndrome do pânico.
- D Mania com sintomas psicóticos.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165558

Questão 87 Diagnóstico diferencial das artropatias

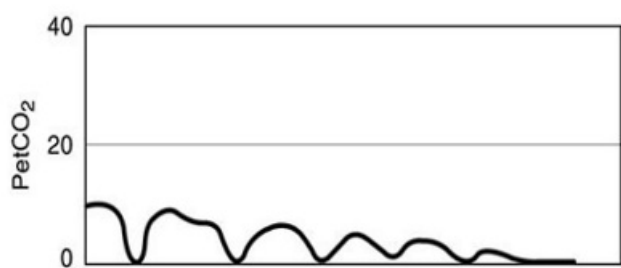
Mulher de 50 anos de idade, costureira, vem para consulta ambulatorial referindo emagrecimento não intencional e dores em articulações de mãos há aproximadamente 6 meses, contínua, com piora progressiva nas últimas 4 semanas. Relata rigidez matinal de aproximadamente 20 minutos, mas conta que as dores são piores ao final do dia após realização das suas atividades diárias. Antecedentes: Hipertensão Arterial Sistêmica, em uso de hidroclorotiazida 25mg/dia; consumo de 5 garrafas de cerveja por semana; tabagismo 10 anos-maço. Ao exame clínico: dor à palpação de interfalanges proximais de todos os dedos de ambas as mãos, e de 2ª e 3ª metacarpofalanges bilateralmente, sem edema ou eritema. O restante do exame clínico está normal. Qual é a alternativa correta?

- A O diagnóstico inicial não inclui a realização de radiografia de mãos e punhos.
- B A investigação inicial inclui a dosagem de TSH.
- C O diagnóstico de artrite psoriásica é excluído pela presença de fator reumatoide positivo.
- D A presença de rigidez matinal de 20 minutos sugere artropatia inflamatória.

4000165557

Questão 88 Capnografia Monitorização durante a PCR Capnografia

Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinalante a 15L/min, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Após a intubação orotraqueal, a capnografia mostra a seguinte curva:



Qual é o diagnóstico mais provável?

- A Intubação esofágica.
- B Pneumotórax.
- C Intubação seletiva.
- D Broncoespasmo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165555](https://www.4000165555.com)

Questão 89 Agentes Intravenosos

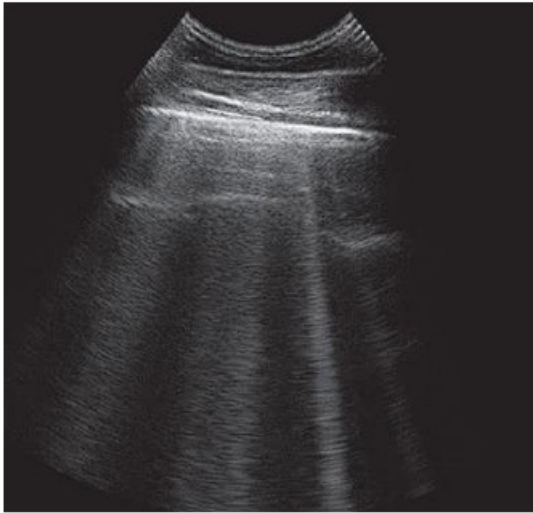
Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinalante a 15L/min, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Considerando a disponibilidade das quatro drogas abaixo, qual é a medicação de escolha para realizar a sedação deste paciente?

- A Fentanil.
- B Midazolan.
- C Propofol.
- D Etomidato.

4000165555

Questão 90 COVID 19 Ultrassonografia de tórax

Homem de 46 anos de idade com obesidade grau 3 é admitido no Departamento de Emergência. Tem febre há 10 dias, associada a dispneia progressiva e tosse nos últimos 3 dias. Ao exame clínico, apresenta-se taquipneico, com saturação de oxigênio de 84% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com raros sibilos e estertores em bases, principalmente à direita. O ultrassom pulmonar, protocolo BLUE, demonstra deslizamento pleural e a seguinte imagem nos seis pontos.



Qual o diagnóstico mais provável para a insuficiência respiratória deste paciente?

- A Pneumonia bacteriana.
- B Asma exacerbada.
- C Infecção aguda por COVID-19.
- D Infarto pulmonar por tromboembolismo pulmonar agudo.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165554
Acesse [t.me/medicinalivre](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 91 Síndrome Demencial Investigação Neurologia

Homem, 80 anos de idade, engenheiro aposentado, procura ambulatório de geriatria por estar cada vez mais esquecido há 2 anos, desde a morte de sua esposa. Apresenta tristeza ocasional quando se lembra da esposa. A filha refere que há 1 ano está morando junto com o paciente pois ele não estava se alimentando bem e estava com dificuldade de realizar os afazeres domésticos. Ao exame clínico, apresenta-se repetitivo, com dificuldade de terminar frases. Semiologia cardio-pulmonar e abdominal sem alterações. O Miniexame do estado mental é de 24/30 (normal ≥ 28).

Assinale a alternativa que relaciona os exames complementares indicados para a investigação deste paciente:

- A Dosagem de vitamina D sérica, TSH, T4 livre, sorologia para citomegalovírus e herpes simples e tomografia de crânio.
- B Dosagem de vitamina B1 e B6 sérica, glicemia, colesterol total e frações e ressonância de crânio.
- C Dosagem de vitamina B12 sérica, TSH, T4 livre, sorologia para sífilis e HIV e tomografia de crânio.
- D Dosagem de ferro sérico, hemograma, TSH, coagulograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio e ressonância de crânio.

Questão 92 **Dermatologia** **Tinea crural**

Homem de 28 anos de idade refere há 1 mês lesões pruriginosas nas virilhas. Ao exame clínico observa-se eritema e descamação nas regiões inguinais. O exame micológico direto foi positivo para hifas artrosporadas.



Qual é o diagnóstico?

- ☐ A Tínea negra.
- ☐ B Tínea crural.
- ☐ C Candidose.
- ☐ D Piedra branca.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165552](https://www.facebook.com/4000165552)

Questão 93 **Hidrocefalia de Pressão Normal** **Exames de Neuroimagem** **Quadro Clínico**

Homem de 72 anos de idade, etilista, veio ao retorno de consulta do ambulatório de geriatria. Tinha queixa de lentidão para andar evoluindo progressivamente ao longo de vários meses com dificuldade em coordenar a marcha (inicialmente falta de jeito, às vezes esbarrando nas coisas ou pessoas). Este sintoma piorou gradativamente até não conseguir andar sem um andador ou encostado nas paredes. Começou também a apresentar urgência miccional e, após passar no urologista, não foi detectado nada de anormal em sua próstata ou bexiga. Nessa época sofreu um tombo no banheiro. Foi a partir desse incidente que ficaram mais evidentes as dificuldades para se lembrar de fatos recentes assim como de encontrar a palavra adequada para se expressar. Trouxe exames laboratoriais normais e a tomografia apresentada.



Qual é a hipótese diagnóstica provável?

- A Hidrocefalia de pressão normal.
- B Pelagra.
- C Hematoma subdural crônico.
- D Síndrome de Wernicke.

Medicina Livre

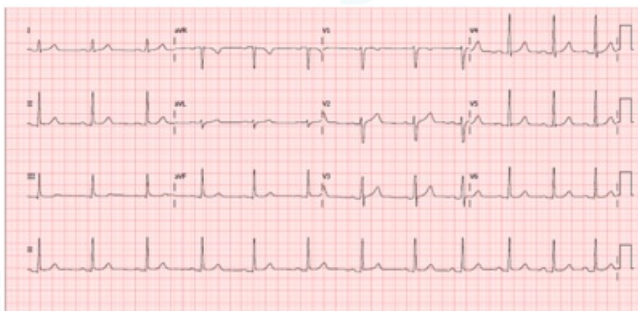
Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165551](https://www.4000165551.com)

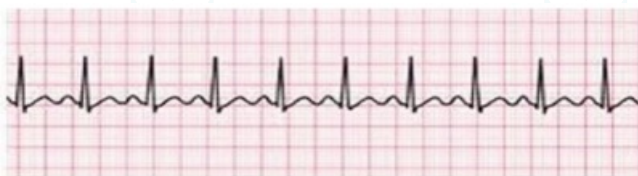
Questão 94 Transtorno de Pânico Transtornos Ansiosos

Homem de 48 anos de idade, casado, comparece em retorno de consulta ambulatorial com queixa de episódios em que seu “coração passa a bater para fora da boca, com batidas fora de hora e com a sensação que pode parar a qualquer momento”. Já procurou serviços de urgência e emergência. Porém ao chegar ao Pronto-Socorro de cardiologia a crise já passou e os médicos não acham nada alterado nos exames complementares. Refere que quando faz atividade física o coração começa a bater mais rápido. Nesse processo por vezes lhe falta ar e sente medo muito grande de que possa infartar cedo como seu pai, que faleceu aos 52 anos de idade. Está dormindo mal, fica pensando no que fazer se tiver novas crises e como pode chegar rápido no hospital para poder descobrir o que é. É ex-fumante 1 maço/dia por 15 anos (parou há 12 anos). O exame clínico está normal. Os exames complementares solicitados na primeira consulta mostram glicemia de jejum e colesterol total e frações normais. O eletrocardiograma atual é apresentado abaixo. O registro de Holter durante uma das crises referidas está representado abaixo.

Traçado do eletrocardiograma de hoje:



Traçado do Holter:



Qual é o diagnóstico provável e a conduta inicial?

- A Depressão ansiosa; introdução de ansiolítico não benzodiazepínico.
- B Angina estável; introdução de AAS, atorvastatina e nitrato.
- C Síndrome do pânico; antidepressivo serotoninérgico.
- D Taquicardia por reentrada nodal; ablação cardíaca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165550](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 95 Saúde do Idoso geriatria Distanásia Cuidados paliativos

Homem, 82 anos de idade, acamado há 10 anos por demência vascular após episódio de AVC isquêmico extenso. É totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária e não contactua com as pessoas há cerca de 1 ano. É cuidado pela filha. Há 2 anos apresenta disfagia para sólidos e há 6 meses para líquidos. Comparece ao Pronto-Socorro com história de queda do estado geral e recusa da alimentação via oral há 3 dias. No atendimento inicial, apresentava-se em mau estado geral, descorado ++/4+, desidratado +++/4+, com roncocal de transmissão, FR 30 irpm, oximetria sem captura, com respiração ruidosa, extremidades frias e mal perfundidas, FC 130 bpm e PA 72 x 40 mmHg. A equipe da sala de emergência aborda a filha sobre a compreensão do quadro atual e ela entende que o pai está próximo ao final da vida e não deseja que ele sofra, mas está muito preocupada por ele não estar conseguindo comer. Qual é a conduta com relação à alimentação nesta fase?

- A Passar sonda nasoenteral para alimentação enteral.
- B Introduzir soro de expansão e manutenção.
- C Introduzir dieta assistida por via oral.
- D Manter o paciente de jejum e sem soro.

4000165549

Questão 96 Diagnóstico

Mulher de 34 anos de idade dá entrada no Pronto-Socorro com história de cefaleia, febre e confusão mental há 3 dias, associada a episódios em que permanecia parada, olhar fixo e movimentos oromastigatórios automáticos, com duração de 2 minutos. Ao exame clínico estava confusa, febril, com rigidez de nuca, sem outros sinais localizatórios. A tomografia de crânio mostrava hipotenuação discreta e edema em lobo temporal à direita. O eletroencefalograma mostrava atividade periódica lateralizada. Qual é a principal hipótese diagnóstica e o exame confirmatório?

- A Encefalite imuno mediada, solicitar anticorpos anti-NMDA no líquido.
- B Encefalite herpética, PCR para herpes vírus no líquido.
- C Endocardite bacteriana com embolização séptica, hemocultura e ecocardiograma.
- D Neurotoxoplasmose, ressonância nuclear magnética de crânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165548](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 97 **Neurologia** **Trombólise Endovenosa** **Trombectomia Mecânica**

Mulher de 62 anos de idade, diabética e tabagista, apresentou há 5 horas e 30 minutos diminuição de força nos membros superior e inferior esquerdos e fala empastada. Na sua chegada ao Pronto-Socorro de um hospital terciário, sua pressão arterial era 160 x 100 mmHg. A frequência cardíaca era de 88 bpm, rítmico e a glicemia capilar 220 mg/dL. A ausculta cardíaca era normal. O exame neurológico mostrou hemiplegia esquerda completa, desvio do olhar para a direita e heminegligência. A pontuação na escala de avaliação NIHSS (*National Institutes of Health Stroke Scale*) foi de 16. A tomografia de crânio não mostrou sinais de hemorragia intracraniana. A pontuação na escala ASPECTS foi de 8. Qual deve ser a conduta neste atendimento inicial?

- A Realizar angioressonância arterial de crânio e vasos cervicais e, se oclusão de artéria carótida cervical, indicar trombectomia mecânica.
- B Realizar angiotomografia arterial de crânio e vasos cervicais e, se oclusão de artéria cerebral média, indicar trombectomia mecânica.
- C Realizar angiotomografia arterial de crânio e vasos cervicais e, se oclusão de artéria cerebral média, indicar trombólise intravascular.
- D Realizar angioressonância arterial de crânio e vasos cervicais e, se oclusão de artéria carótida intracraniana, indicar trombólise intravenosa.

Medicina Livre

Contra preços abusivos

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165547

Questão 98 **Tratamento no paciente adulto**

Mulher de 25 anos de idade, diabética em uso de insulina, dá entrada no serviço de emergência com queixa de náuseas, vômitos e dor abdominal. Ao exame clínico de entrada estava desidratada +++/4+, PA = 100 x 60 mmHg, FC = 120 bpm, Tempo de enchimento capilar = 6s. Restante do exame sem alterações. Foi iniciada expansão volêmica. Exames iniciais mostram:

Glicemia = 440 mg/dL

pH = 7,21

Bic = 13 mEq/L

Na⁺ = 120 mEq/L

K⁺ = 2,8 mEq/L

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Qual é a conduta com relação à insulinização neste momento?

- A Insulina regular 10 UI endovenosa em bomba de infusão.
- B Insulina regular 10 UI endovenosa em bolus.
- C Insulina regular 10 U subcutânea.
- D Não administrar insulina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000165546

Questão 99 **Características da Dor** **Enxaqueca** **Neurologia**

Homem de 28 anos de idade apresenta há 2 anos cefaleia uma vez por semana de forte intensidade, unilateral, pulsátil, com foto e fonofobia e acompanhada por náuseas. Nega fenômenos visuais ou somestésicos. Há 6 meses associou outro tipo de cefaleia quase diariamente, bilateral, de fraca a moderada intensidade, em aperto, sem outros sintomas. Faz uso diário de dipirona e cetoprofeno e nos momentos de exacerbação da dor usa sumatriptano. Quais são os diagnósticos desse paciente?

- A Cefaleia tensional e enxaqueca com aura.
- B Enxaqueca com aura e cefaleia por abuso de medicações.
- C Enxaqueca sem aura e cefaleia por abuso de medicações.
- D Cefaleia tensional e enxaqueca sem aura.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165545](#)

Questão 100 **Oftalmologia** **Retinopatia Diabética** **Retinopatia Hipertensiva**

Homem de 66 anos de idade chega à consulta referindo perda visual progressiva e indolor de olho há 06 meses. É hipertenso, diabético e dislipidêmico de longa data, com controle irregular das comorbidades. Realiza o seguinte exame.



Selecione a alternativa com os achados deste exame:

- A Microhemorragias e exsudatos duros.
- B Edema de papila e descolamento de retina regmatogênico
- C Microcalcificações e mácula em cereja.
- D Palidez de papila e exsudatos algodonosos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000165544](#)

Respostas:

1	D	2	D	3	C	4	A	5	C	6	C	7	B	8	C	9	A	10	C	11	B
12	A	13	D	14	C	15	C	16	B	17	A	18	B	19	A	20	D	21	B	22	C
23	B	24	A	25	D	26	D	27	B	28	A	29	D	30	A	31	B	32	C	33	C
34	A	35	B	36	A	37	A	38	D	39	C	40	B	41	C	42	A	43	B	44	D
45	A	46	C	47	B	48	D	49	D	50	C	51	A	52	B	53	C	54	D	55	B
56	A	57	B	58	D	59	C	60	C	61	D	62	D	63	D	64	B	65	D	66	A
67	C	68	D	69	A	70	B	71	B	72	D	73	D	74	A	75	B	76	B	77	D
78	C	79	C	80	A	81	A	82	C	83	D	84	B	85	A	86	D	87	B	88	A
89	D	90	C	91	C	92	B	93	A	94	C	95	D	96	B	97	B	98	D	99	C
100	A																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.



Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre